



Fernando Rodes Lloret
Carlos E. Monera Olmos
Mar Pastor Bravo

Vulnerabilidad infantil

Un enfoque multidisciplinar



VULNERABILIDAD INFANTIL

Un enfoque multidisciplinar

Fernando Rodes Lloret
Carlos Enrique Monera Olmos
Mar Pastor Bravo

VULNERABILIDAD INFANTIL

Un enfoque multidisciplinar



Madrid - Buenos Aires - México, D.F. - Bogotá

©Fernando Rodas Lloret, Carlos Enrique Monera Olmos, Mar Pastor Bravo,
2010

Reservados los derechos.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Ediciones Díaz de Santos
Albasanz, 2
28037 MADRID

Internet: <http://ediciones.diazdesantos.es>
E-mail: ediciones@diazdesantos.es

ISBN: 978-84-7978-950-3 (Versión papel)
ISBN: 978-84-9969-021-6 (Versión electrónica)

ÍNDICE

DIRECTORES Y AUTORES	IX
NOTA DE LOS AUTORES	XI
PRÓLOGO.....	XIII
1. La vulnerabilidad del menor (<i>Juan Bautista Martí Lloret</i>)	1
2. Vulnerabilidad al consumo de drogas (<i>José A. García del Castillo, Carmen López-Sánchez, M^a Carmen Segura Díez, Álvaro García del Castillo-López</i>)	7
3. La vulnerabilidad del niño discapacitado (<i>M^a José Juan-Vera</i>)	23
4. El síndrome del niño maltratado (<i>Susana Jiménez Moreno</i>).....	29
5. El síndrome de alienación parental. Una forma de maltrato infantil (<i>Mar Pastor Bravo</i>)	39
6. El menor frente al abuso sexual (<i>Fernando Rodes Lloret</i>).....	49
7. Actuación del Juez de Menores ante el menor infractor (<i>M^a Amparo Rubio Lucas</i>).....	63
8. Violencia en las aulas. Víctimas o verdugos. (<i>Ana Sirvent Botella, Cristina Amante García</i>).....	81
9. La vulnerabilidad del menor en las aulas escolares. Construyendo una escuela segura (<i>Silvia Martínez Amorós</i>).....	111
10. Adolescentes y jóvenes que agreden sexualmente (<i>Vicente Angel Briet García</i>).....	133

11. Nazaret, algo más que un colegio (<i>Sergio Biete Bañón, Miguel Ángel Segura Palomares</i>).....	153
12. La respuesta educativa ante el menor dependiente de la protección de servicios sociales (<i>José Luís Arias Ruiz de Somavía, Vicente Hernández Milán, Zoraida Toledo Lillo</i>).....	185
13. La educación de los menores enfermos, crónicos y/u hospitalizados (<i>Francisco Abel Garrido Ferrer, Adela García García</i>).....	197
14. El niño en el hospital (<i>Miguel Castells Molina</i>)	209
15. Estilos de vida. Anorexia y bulimia (<i>Gonzalo Pagán Acosta</i>)	219
16. Cáncer infantil: situación en los albores del siglo XXI. (<i>Gabriel Vázquez Pérez, Marina Depiaggio</i>).....	239
17. Medios de comunicación, violencia y suicidio en la infancia y adolescencia (<i>Antonio Germán Alcántara Lapaz</i>).....	269
18. El descubrimiento de la muerte en el niño (<i>Carlos Enrique Monera Olmos, M^a del Pilar Lucas Martínez</i>).....	285

DIRECTORES

FERNANDO RODES LLORET

Médico Forense. Jefe de Servicio de Clínica Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Alicante.
Profesor Asociado de Universidad.
Médico Especialista en Medicina Legal y Forense.

CARLOS ENRIQUE MONERA OLMOS

Médico.

MAR PASTOR BRAVO

Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Alicante.
Profesora Asociada de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante.

AUTORES

ANTONIO GERMÁN ALCÁNTARA LAPAZ

Médico Psiquiatra. Hospital Universitario de San Juan de Alicante.

CRISTINA AMANTE GARCÍA

Psicóloga Forense. Equipo Técnico de los Juzgados y Fiscalía de Menores de Alicante.

JOSÉ LUÍS ARIAS RUIZ DE SOMAVÍA

Director y Maestro del C. P. CAES Centro de Recepción de Alicante.

SERGIO BIETE BAÑÓN

Director Académico de Nazaret, Fundación del P. Fontova, sj.

VICENTE ANGEL BRIET GARCÍA

Psicólogo Especialista en Sexología. Responsable del Servicio de Sexología de la Universidad de Alicante (Centro de Apoyo al Estudiante; CAE).
Jefe del Departamento de Orientación de Nazaret.

MIGUEL CASTELLS MOLINA

Supervisor de Gestión de Calidad. Hospital General Universitario Alicante.
Profesor Asociado del Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante.

MARINA DEPIAGGIO

Médico especialista en Formación (MIR) en Oncología Radioterápica.

JOSÉ A. GARCÍA DEL CASTILLO

Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID). Universidad Miguel Hernández.

ÁLVARO GARCÍA DEL CASTILLO-LÓPEZ

Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID).
Universidad Miguel Hernández.

ADELA GARCÍA GARCÍA

Maestra del Aula Hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche.

FRANCISCO ABEL GARRIDO FERRER

Maestro del Aula Hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche.

VICENTE HERNÁNDEZ MILÁN

Maestro del C. P. CAES Centro de Recepción de Alicante.

SUSANA JIMÉNEZ MORENO

Profesora Titular de Medicina Legal y Forense. Universidad Miguel Hernández.

M^a JOSÉ JUAN-VERA

Profesora Asociada de la Universidad Miguel Hernández y Directora del CDIAT de la Asociación Apsa de Alicante.

CARMEN LÓPEZ-SÁNCHEZ

Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID).
Universidad Miguel Hernández.

M^a DEL PILAR LUCAS MARTÍNEZ

Médico.

JUAN BAUTISTA MARTÍ LLORET

Catedrático de Medicina Legal y Forense.

SILVIA MARTÍNEZ AMORÓS

Psicopedagoga de la Unidad de Atención e Intervención del Plan PREVI. Dirección Territorial de Educación de Alicante.

CARLOS ENRIQUE MONERA OLMOS

Médico.

GONZALO PAGÁN ACOSTA

Psiquiatra. Unidad de Trastornos Alimentarios-Servicio de Psiquiatría.
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

MAR PASTOR BRAVO

Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Alicante. Profesora Asociada de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante.

FERNANDO RODES LLORET

Médico Forense. Jefe de Servicio de Clínica Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Alicante.

M^a AMPARO RUBIO LUCAS

Magistrado-Juez del Juzgado de Menores nº 2 de Alicante.

M^a CARMEN SEGURA DÍEZ

Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID).
Universidad Miguel Hernández

MIGUEL ÁNGEL SEGURA PALOMARES

Director General de Nazaret, Fundación del P. Fontova, sj.

ANA SIRVENT BOTELLA

Fiscal de Menores de Alicante.

ZORAIDA TOLEDO LILLO

Maestra del C. P. CAES, Centro de Recepción de Alicante.

GABRIEL VÁZQUEZ PÉREZ

Médico especialista en Oncología Radioterápica.

NOTA DE LOS AUTORES

Ese libro tiene su origen en dos jornadas de estudio sobre el niño vulnerable, celebradas en Alicante los años 1999 y 2008. En ambas se abordaron diferentes aspectos de la vulnerabilidad en la infancia.

Reproducimos, por su interés, la justificación recogida en el programa de la II Jornada:

“Con una cierta dosis de incertidumbre al percibir qué lento se avanza en este campo, contemplamos, ocho años más tarde de la celebración de la I Jornada de estudio sobre el niño vulnerable, los mismos dilemas, controversias y preocupaciones que se suscitaron entonces.

Han pasado ocho años y no solo siguen manteniéndose parecidas situaciones de vulnerabilidad en la infancia, sino que, además, los espectaculares cambios en la tecnología y la divulgación de la información han generado nuevos modos de explotación al niño, como la difusión de pornografía infantil en internet, la propagación de un tipo de violencia protagonizada por menores para “colgar en la web” o transmitir por los teléfonos móviles, la manipulación del menor en los “chat”, etc.

El niño se presenta paradójicamente, por un lado como un miembro de nuestra sociedad que escasea y que por su vulnerabilidad debería ser una prioridad en las políticas de protección e inversión en el futuro, y por otro, como un ser costoso de educar, incómodo y a veces agresivo y que, para mantenerle quieto o controlado, hay que acceder a sus presiones y saciar su tirana e inmadura necesidad de gratificación rápida, incitándole al consumo y a la tele adicción.

Esta II Jornada de estudio sobre el niño vulnerable pretende ser una llamada de atención sobre aquellas situaciones que posicionan al niño y al adolescente en una situación de vulnerabilidad y de riesgo, como la posibilidad de ser explotado, abandonado, maltratado, desprotegido, olvidado, menospreciado, manipulado, excluido, utilizado, intimidado, golpeado, pisoteado, machacado, ignorado, desampa-

rado, perseguido, ultrajado, violado, despreciado, amenazado, malherido, e incluso asesinado.

No olvidemos que el niño puede ser la criatura más querida y también la más cruel del planeta, pero eso depende de los adultos.

El niño, en su ingenuidad, es rehén de la publicidad agresiva que le incita al consumo. El niño, en su debilidad, es víctima de malos tratos. El niño, en su pobreza, es explotado en algunos rincones del mundo. El niño, en su irresponsabilidad, es capaz de agredir. El niño, en su inseguridad, es inducido al consumo de sustancias nocivas para su salud. El niño, en su soledad, es acosado en su propio hogar por imágenes y mensajes virtuales que le distorsionan la realidad. Al niño, en su dolor y sufrimiento, se le incomunica en la conspiración silenciosa de los adultos. El niño, en su inanición, se prepara para la guerra. El niño, en su desesperanza, viaja en patera...”

PRÓLOGO

Los derechos de los menores y el estado de derecho

Indiscutiblemente, supone un acierto la publicación del presente libro, que abarca una problemática que, junto con el maltrato a las mujeres, se está intentando resolver desde las diferentes administraciones públicas.

En este sentido, la desprotección y el maltrato de los menores ha sido una constante a lo largo de la historia, por lo que la sociedad está apostando fuerte para que los derechos de los indefensos y marginados se puedan aplicar y que no sean una mera plasmación existente en los textos escritos.

Los ejemplos de la desprotección existente, a la que han estado sujetos los menores, se agolpan en la memoria de todos los profesionales que, de una manera u otra, han tratado esta problemática. Pero el maltrato y la desprotección no ha sido solamente física por parte de los agresores, sino que también la norma aplicable a la teórica protección de la situación de los menores ha fallado en ocasiones.

Estamos creando centros de atención a menores que optan por el camino de la delincuencia para intentar reinsertarlos en la sociedad, pero estos deben crearse bajo el prisma de la verdadera finalidad prevista en la ley de responsabilidad penal del menor, con unos medios materiales y humanos que se adapten a las necesidades reales que tienen estos menores y cuya atención valore en su justa medida las condiciones por las que ese menor ha llegado a este extremo de la delincuencia. ¿Qué ha fallado en sus casas, en su entorno familiar? ¿Qué ha fallado en la sociedad en la que ha vivido ese menor? ¿Qué parte de culpa tenemos todos y todas en que ese menor haya delinquido? Y por todo ello, ¿qué podemos hacer para arreglar esta situación?

Los parámetros de respuesta son muy difíciles, ya que en este contexto influyen muchos factores y la capacidad de respuesta para conseguir ese fin de adaptación social también lo es en tanto son muchas y distintas Administraciones, tanto en lo geográfico como en lo competencial, que se agolpan en el haz de responsabilidades. Pero si es esto cierto, también lo es que, precisamente por estas razones, deben mar-

carse respuestas pautadas que giren en torno a una unidad en todo el país para que la protección de estos derechos sea eficaz y uniforme.

Por otro lado, frente al menor sujeto activo de un ilícito que es preciso recuperar a la sociedad, también vemos al menor sujeto pasivo, que en muchos casos queda en situación de desamparo, y por ello se ha dicho, y con razón, que no es menos cierto que a la Administración, el legislador le ha trasladado una responsabilidad que debería estar depositada en la autoridad judicial; es decir, la reforma operada por la Ley Orgánica de 15 de Enero de 1996 le había transmitido a la Administración que *“cuando constate que un menor está en situación de desamparo tiene atribuida legalmente la tutela sobre el menor y tendrá que adoptar las medidas necesarias para su guarda”*. Craso error desde mi punto de vista, por cuanto la propia ley considera como desamparo la situación que se produce por el incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes. Y yo me pregunto: ¿no sería más razonable atribuirle al juez esta decisión sobre la declaración de desamparo, judicializando el procedimiento en lo que afecta a una resolución fundamental para el futuro del menor?

No puede olvidarse que la actual regulación legal olvida a la autoridad judicial en una fase de este procedimiento de importancia trascendental, por cuanto la declaración de desamparo de la Administración le atribuye directamente la tutela y, a su vez, esto lleva consigo la “suspensión de la patria potestad o tutela” de los padres sobre los menores. Esta decisión debería atribuirse a los jueces, no a la Administración, porque en ese caso no nos habríamos encontrado con esta desagradable situación por la que atravesó esta niña que, con nueve años de vida, ha cambiado ya tres veces de domicilio “y de padres”.

Un menor no es un objeto del que se puede disponer, cambiar o canjear. Los primeros años en la vida de un niño son fundamentales en su futuro inmediato y la legislación no puede permitirse el lujo de cometer errores en la regulación de situaciones que se repiten día a día. Estamos tratando con niños y niñas que sufren, sienten y padecen, pero que en el fondo de su desconocimiento sobre el porqué de la situación que viven, tampoco llegan a comprender cómo los mayores no aciertan a solucionar su problema.

A veces nos empeñamos en complicar las cosas ante hechos que deberían ser resueltos por quienes tienen atribuida, en esencia, la observancia del principio de legalidad, por cuanto, una vez haya intervenido la autoridad judicial, tendremos que dejar paso a la Administración encargada de la materia (Servicios Sociales), para que afronte la cuestión, pero no al revés, para que sean los jueces quienes, al final, tengan que determinar si el procedimiento para declarar el desamparo fue o no el correcto. Y es que, mientras se tramita ese procedimiento, como ha ocurrido en el supuesto que nos ocupa, la niña ha cumplido años —nueve—, se ha encariñado de unos padres y estos, a su vez, le han dado su amor a una niña que ahora pierden.

En este sentido, obras como la que a continuación se desarrolla actualizada tras el presente prólogo, son necesarias, ya que nunca está de más cargar las tintas con respecto a temas que nuestra sociedad repele por naturaleza. Nunca sobra poner de manifiesto que se deben afrontar problemas y cuestiones de hondo calado social y que se repiten día tras día ante nuestros ojos, siendo los medios de comunicación los que ofrecen al

ciudadano las noticias sobre estos temas, en los que se exige una respuesta inmediata por parte de los poderes públicos.

Y uno de ellos, por no decir uno de los más actuales por su proliferación casi diaria, es el de la explotación sexual de los menores, así como los atentados a la intimidad y honor de los mismos, delitos estos que han proliferado y se extienden en las mesas de jueces y fiscales en el momento de redactar estas líneas, en el año 2009 y con constatación en las cifras estadísticas de la fiscalía y juzgados. Porque cada vez son más los abusos a menores, tanto en el contexto intrafamiliar como fuera del hogar por terceros ajenos a su entorno.

Además, en una sociedad cada vez más deteriorada, giran este tipo de hechos en la depravada conducta de unos pocos que, para su satisfacción personal y económica, utilizan todos los mecanismos legales e ilegales a fin de obtener sus obtusos fines, que no son otros que utilizar a los menores para obtener importantes beneficios económicos. Y hablo de la existencia de medios legales, también, por cuanto pese a que se han ido realizando importantes esfuerzos legislativos para que la protección sea eficaz, así la Ley Orgánica 1/1982 de Protección civil del derecho al honor y a la intimidad en la que se contienen especiales garantías para los menores, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección jurídica del menor o la Ley 35/95 de 22 de Diciembre de Ayudas y asistencias a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, lo cierto y verdad es que la práctica nos viene ofreciendo importantes lagunas legislativas, que utilizan estos personajes para campar a sus anchas, amparados en la impunidad de sus acciones, como hemos podido comprobar recientemente con la difusión por medio de internet de imágenes de menores desnudos, sin que el juzgado competente pudiera adoptar otra resolución que el archivo de las diligencias por no constituir delito la acción detectada. Este ejemplo y otros que hicieron ver las lagunas legales existentes en la materia, motivaron la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de Abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre.

En cuanto a la prevención policial, sin embargo se están dando importantes avances en esta materia, ya que en la Guardia Civil se han creado equipos especializados de policía judicial dedicados a la problemática mujer/menor, y del mismo modo, en el Cuerpo Nacional de Policía, se han creado los GRUMES (grupos de menores), cuyo objetivo se centra en el menor victimizado por cualquier tipo de agresión. Los métodos de prevención y protección policial se hacen imprescindibles por el incremento incesante de este tipo de actuaciones contra la libertad sexual de los menores.

Cuando en Bélgica se comenzó a escarbar, por las autoridades, en las entrañas del complejo organigrama que se había organizado en los escabrosos casos destacados por los medios de comunicación, nunca se pudo llegar a pensar en el final que iba a deparar la búsqueda de la verdad, ante las desapariciones constantes de menores que iban cayendo en las redes del depravado criminal que había formado una organización criminal basada en la explotación sexual de menores, la corrupción y los atentados contra su libertad sexual.

En nuestro país no queremos otro caso como el que ocurrió en Bélgica. Pero para ello hay que seguir insistiendo en la plasmación de políticas que tiendan a prevenir y

evitar casos de explotación de menores, de maltrato físico y psíquico y de cualquier tipo de conductas en las que los derechos mínimos del menor puedan verse vulnerados.

Cuando los padres y redactores de nuestra Constitución establecieron la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección de la familia y de los hijos, estaban realizando una operación de futuro, a fin de que, cuando nuestra realidad social diaria pusiera ante los ojos del Estado un caso flagrante, que exigiera la protección estatal ante una vulneración de los derechos que tienen los menores a tener un desarrollo integral, se requiriera una intervención directa de éste que evitara la proliferación de las conductas que se encuentran amparadas en las lagunas que nuestro ordenamiento jurídico pudiera tener. ¿Cuáles son, pues, los motivos por los que se modificó el Código Penal en materia de atentados contra los derechos de los menores?

Pues bien, la proliferación de hechos, aparentemente delictivos, que no tenían acomodo en ningún precepto del Código Penal de 1995, estaban poniendo de manifiesto la necesidad de esta intervención estatal mediante una reforma del Código Penal que, si cabe, subsanara estas deficiencias observadas por la ciudadanía, y que desgraciadamente estaban posicionando a los menores como los auténticos sujetos pasivos de todos los “inventos” de aquellos que se aprovechaban de la impunidad de sus acciones con anterioridad a la reforma penal citada.

De esta manera, en todos los foros tenemos que aunar nuestros esfuerzos, a fin de que la protección de los menores sea real y efectiva, tratando de evitar situaciones encubiertas por las que existan personas que, amparadas en la ausencia de mecanismos correctores, se aprovechen de esta impunidad inicial para conseguir beneficios personales que, a la postre, se convierten en perjuicios colectivos. Esta es la obligación que todos tenemos. Por ello, hay que estar constantemente buscando las soluciones y obtener conclusiones que supongan un beneficio para todos, no para unos pocos. Más aún cuando de seres indefensos se trata.

Recientemente, y para incentivar el ámbito de protección de los menores víctimas, hemos elevado un informe a los responsables parlamentarios proponiendo la no necesidad de que los menores víctimas tengan que regresar a declarar al juicio oral, bajo la validez legal como prueba de su primera declaración judicial y otorgándole el valor correspondiente mediante su lectura en el plenario. No podemos victimizar más a los menores obligándoles de nuevo a declarar.

Por todo ello, nada hay más injusto que la desigualdad de derechos. Y nada hay más reprochable que la omisión en la búsqueda de actuaciones que tiendan a evitar esta desigualdad. Por ello debemos congratularnos de que en la actualidad esta omisión no exista, y de que las medidas legislativas de protección del menor se hayan adoptado con contundencia y eficacia por parte del Departamento de Justicia. Solo queda estar vigilantes e insistir en que las lagunas no salgan a flote y que el ordenamiento jurídico cubra todas aquellas situaciones en las que pueda existir un ataque a un menor.

VICENTE MAGRO SERVET

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante

Doctor en Derecho

LA VULNERABILIDAD DEL ENOR

Juan Bautista Martí Lloret

Cuando como todos los años pasaba parte de mis vacaciones estivales en la que fue casa de mis abuelos maternos, un pueblo de La Mancha, volví a ver aquella litografía, *Su majestad el niño*, que año tras año solía contemplar y que según anotación personal de mi padre, la había visto cuando por primera vez visitó esta casa en el año 1927, y que por las características del marco que representa y de sus personajes, podríamos situar a finales del pasado milenio o primeros de este.

Su majestad el niño es el título que figura en la parte inferior derecha de dicha litografía, mostrando a un niño delante de una dama, al que todos los personajes de la escena muestran sus atenciones, saludan, dan preferencia y que sin lugar a dudas pretende representar a la infancia, lo que contrasta con el tema que nos ocupa, “la vulnerabilidad del menor”.

Sin lugar a dudas, en todas las épocas y en los distintos países, el niño ha tenido unas atenciones y cuidados muy distintos en razón a la cultura, clase social, desarrollo socioeconómico y hábitos o costumbres, en muchas ocasiones muy distintas a lo que en esta litografía representa.

No olvidemos que dentro del género humano, el niño es el ser más vulnerable, como lo es cualquier ser vivo en los primeros días o años de la vida. Los propios animales cuidan de sus hijos vigilando no sean víctima de ataques de carnívoros, rapaces y carroñeros; así pues, el niño está expuesto y de hecho así sucede, a sufrir abusos de diversa índole, causándole daños físicos, psíquicos o morales, que pueden dejar huella en su vida.

El Centro Internacional de la Infancia de París, considera el maltrato infantil, “cualquier acto por acción u omisión, realizado por individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto, y todos los estados derivados de estos actos que priven a los niños de libertad o de sus derechos correspondientes y/o dificulten su óptimo desarrollo”.

Desde su nacimiento el niño necesita calor, no solo en el sentido físico sino en el afectivo.

Cuántas parejas anhelan tener un hijo y recurren a los avances de la ciencia para conseguirlo o incluso recurren la adopción a veces de niños de otros países y razas, ya que existe en alguno de ellos algún impedimento que les priva de ese fruto; por el contrario, cuántos niños vienen al mundo sin ser deseados renunciando sus padres biológicos a ellos o sometiéndoles a sufrimientos y vejaciones impropias para un ser humano.

También la sociedad y las instituciones, en ocasiones, son responsables de esa vulnerabilidad infantil, y prueba de ello es la falta de interés por su escolarización, el hacerles víctima de un estado social deplorable, el utilizarles desde la infancia como mano de obra barata (como sucede en países de Latinoamérica, África y Asia), ser víctimas de contiendas en guerras fratricidas (casos últimamente de países africanos, como Ruanda y la antigua Yugoslavia) donde ven morir a sus progenitores y familia de modo violento, ellos mismos son víctimas de matanzas o mutilaciones (minas antipersona, etc.), mueren de hambre, etc.

Otras veces son las costumbres, los rituales mal entendidos, los que dan lugar a mutilaciones, deformidades, etc., como es el caso de la mutilación sexual de las niñas, generalmente entre 4 y 14 años, y que como señala un reciente informe de UNICEF, en alguno de esos países con sus ancestrales costumbres llega a alcanzar casi el 80 de la población infantil femenina.

No digamos ya el elevado número de niños sin hogar, bien como consecuencia de las guerras, catástrofes naturales, o como es habitual en numerosos países (Brasil, México, Perú, Ghana, Chad, India, Nepal, Tailandia, etc.) donde su hogar es la calle, donde viven las veinticuatro horas, siendo en no pocas ocasiones víctimas de cuadrillas de niños de idéntica edad o de grupos que comercializan con ellos.

Cuántos niños de estos son enviados a las calles de buena mañana, por sus padres o familiares, para que al finalizar el día les aporten unas monedas u otros bienes materiales, con el riesgo de que si no lo consiguen a su vuelta sufrirán la ira y el castigo de los mayores.

Que históricamente el niño ha sufrido tratamientos distintos ya lo sabemos; así por ejemplo, en la antigua Grecia, en Esparta, se les preparaba desde pequeños para la guerra; en Atenas, por el contrario, el estado se preocupaba de la educación e instrucción.

Por otra parte, se podría decir que excepto situaciones puntuales, el niño es más aceptado que las niñas y hasta el Renacimiento las necesidades de los niños no fueron tenidas en cuenta, siendo las condiciones en que se criaban, excepto en las clases acomodadas, muy penosas.

Con la Revolución Industrial los niños de las clases trabajadoras son explotados, haciéndoles trabajar en fábricas y minas; ya en mitad del siglo XIX, son varias las naciones que se preocupan por promulgar leyes de protección a la infancia.

Tras la Primera Guerra Mundial, miles de niños pierden sus familias y hogares, siendo crítica su situación. En 1948 se acuerda, en la Declaración de Ginebra, poner

de relieve la situación y los derechos humanos, naciendo así la *Declaración de los Derechos del Hombre*, en la que también se hace referencia a algunos aspectos de la infancia.

Más tarde, la Asamblea de las Naciones Unidas, en el año 1958, proclama la *Declaración de los Derechos del Niño*. A partir de entonces, la Unión Europea, Naciones Unidas y otros organismos, aprueban Directivas, Declaraciones, etc., en defensa y protección de la infancia. En 1978 se celebra el Año Internacional del Niño, emplazando en esa fecha a los diversos países a preparar para diez años después una Convención de los Derechos de la Infancia.

En nuestro propio país, hasta hace pocos años, en zonas rurales no se escolarizaba al niño, se le enviaba a trabajar en el campo cuidando rebaños u otros quehaceres, a las niñas, si eran las mayores, se les encomendaba el cuidado de sus hermanos mientras la madre iba a trabajar, etc., responsabilizándoles de unos quehaceres impropios de la edad.

Aparte de lo anteriormente señalado, la situación del niño se agrava aún más porque también sufre actos de violencia dentro de su entorno más cercano: por parte de padres, familiares, allegados, que son desde el mero maltrato físico (golpes, traumatismos, quemaduras, etc.) hasta daños psíquicos y morales (gritos, recriminaciones, agresiones verbales), y falta de atención elemental (alimentación, higiene, etc.) y hasta agresiones sexuales.

El problema, sin lugar a duda, tiene una gran magnitud. En algunos países de nuestro entorno se estima que cada año un niño menor de seis años de cada ciento cincuenta, es víctima de malos tratos, siendo la mayor frecuencia en menores de dos años; por otra parte se acepta que en general, por cada caso de malos tratos denunciado, al menos hay otros ocho que no lo son, lo que da idea de la magnitud del problema.

La Medicina Legal como ciencia social que es, aparte de servir de apoyo y asesoramiento a la Justicia, tiene como misión el servicio a la sociedad, haciéndose eco, entre otras, de estas situaciones desde tiempos atrás. Revisando antiguos tratados de esta disciplina, donde en su mayoría los autores de siglos pasados incluían informes de diversa índole, fruto de su experiencia y actuación como peritos, hemos encontrado, entre ellos, algunos que hacen referencia al maltrato infantil, pero predominando las referencias a agresiones sexuales. Ya Domingo Vidal, autor del primer tratado de nuestra especialidad en España, *Cirugía Forense*, de finales de siglo XVIII, incluye dos informes de posibles agresiones sexuales a dos niñas, señalando que tras su reconocimiento y exploración, en la primera no hay signos de penetración aunque sí pudiera haber ciertas maniobras en órganos genitales; en la segunda sí se aprecian en la exploración signos evidentes de reciente violación.

acchia, en 1626, con motivo de la práctica de autopsias en niños, a la vista de los resultados plantea los problemas médico-legales de los malos tratos en la infancia.

Revisando algunos tratados de los clásicos franceses de finales del siglo XIX y primeros del XX Vibert, Balthazard, Lacassagne, Thoinot, etc., así como la obra de Briand, Bouis y Casper adaptada a nuestro país en 1872 por Gomez Pamo, (profesor de la Facultad de Medicina de Madrid), en todos ellas se hace referencia a los abusos

sexuales en menores de 12 años, tanto en aquellos en que no existe violación como en los que se demuestra tras el reconocimiento la existencia de desfloración y otro tipo de lesiones, siendo de destacar la estadística (1980-1905) que se incluye por Lacassagne en su obra, poniendo de manifiesto la frecuencia de esos abusos sexuales en Francia.

En cuanto a las obras de autores españoles del siglo XIX consultadas, aparte de las ya mencionadas de Domingo Vidal y García Pamo, como han sido los tratados de *Medicina Legal y Toxicología* de Orfila, Pedro Mata (2ª y 6ª ediciones) y Yañez; en los capítulos referentes a los abusos sexuales, delitos contra la honestidad y violación, también hacen referencia a los problemas de la violencia en la infancia, alguno de ellos al igual que algún autor francés de los citados anteriormente, transcribiendo informes que personalmente han realizado ante los tribunales de justicia, cabe destacar que para mayor esclarecimiento de los hechos, algún autor, principalmente Pedro Mata, aconseja el reconocimiento del inculpado.

Respecto a abusos sexuales sobre niños varones, por las consultas realizadas, se constatan menos y tan solo Thoinot en su obra comenta informes emitidos por otros autores, en que se apuntan las condenas sufridas por una maestra, una madre y dos doncellas, por los abusos sexuales cometidos respectivamente con un niño de seis años, su hijo de nueve y dos niños de once y trece; siendo el Tribunal del Sena (1842), quien condena a una de las dos doncellas por un doble abuso sexual.

Respecto a los malos tratos y agresiones no sexuales, concretamente en la infancia, excepto los casos calificados de infanticidio (que todos los autores tratan), en el *Tratado de Medicina Legal y Toxicología* de Vibert (9ª edición española), en el Informe nº VII (hay un capítulo dedicado a informes, como sucede en las obras de la mayoría autores de tratados del pasado siglo), se hace referencia al reconocimiento e informe, al Tribunal del Sena de París, de que un niño de siete años ha sufrido malos tratos, señalando textualmente: “el niño estaba, pues, sujeto a malos tratos”.

En 1879, Tardieu, en su trabajo publicado con el título *Estudio médico-legal sobre las sevicias y malos tratos ejercidos sobre los niños*, expone los resultados obtenidos en la práctica de doscientas autopsias.

En 1868 Johnson describe el cuadro de fracturas múltiples en niños, aunque no lo atribuye a los malos tratos; casi cien años más tarde (1962), se describe el “síndrome del niño maltratado”, siendo un cuadro similar al descrito por Johnson.

También, Pedro Mata y Fontanet, en su *Tratado de Medicina Legal*, señala expresamente en un informe los malos tratos infringidos por su abuela a una niña, de los que culpa a los huéspedes que tiene en casa con el fin de obtener una compensación económica.

Hay que señalar que todos los autores ponen de manifiesto, incluso se adjuntan informes, de falsas denuncias de abusos sexuales, que tras exploración del perito médico se esclarece.

Nosotros, en nuestro largo quehacer médico-legal, también, aunque en pocas ocasiones, hemos encontrado violencias en la infancia, tanto en el ámbito sexual como en el físico. Tan solo destacar el trabajo bajo el título *Aspectos radiológicos de interés*

médico-legal en el síndrome del niño apaleado publicados en la *Revista Española de Medicina Legal*, en colaboración con los doctores Ivarez Moro y Aso Puértolas, en que se estudian 16 niños ingresados al menos una vez en un centro hospitalario por presentar signos y síntomas de apaleamiento.

Para terminar, señalar que actualmente existe una gran preocupación por el tema que nos ocupa, al igual que por la violencia de ámbito familiar, y que naciones e instituciones son conscientes del problema para el que hay consenso de buscar soluciones. En nuestro país, recientemente se han creado los juzgados especiales de competencia para las denuncias de violencia familiar, lo que indudablemente puede suponer un paso más en la lucha contra la violencia a la infancia; de ahí la necesidad de que pediatras, sociólogos, psicólogos, graduados sociales, médicos forenses, y en general toda la sociedad, denuncie ante la autoridad toda acción de violencia o maltrato, y concretamente el que va dirigido al niño.

VULNERABILIDAD AL CONSUMO DE DROGAS

*José A. García del Castillo, Carmen López-Sánchez,
M^a Carmen Segura Díez, Álvaro García del Castillo-López*

INTRODUCCIÓN

Podríamos partir sin miedo a equivocarnos de que el grado de vulnerabilidad al consumo de drogas es directamente proporcional a la edad de los sujetos en el periodo crítico, por tanto a partir de edades en las que los niños empiezan a descubrir el mundo por sí solos, entre los diez y los doce años, comenzaría el periodo más crucial del desarrollo humano, en el que afrontar decisiones se convierte en algo fundamental para el futuro, desde el punto de vista del comportamiento.

La salvaguarda del seno familiar, en aquellos casos que lo es, actúa potentemente como un factor de protección insustituible ante las agresiones del mundo exterior, prácticamente en todos los ámbitos, incluido, por supuesto, el del mantenimiento de la salud. Una familia donde rijan determinadas pautas de comportamiento sano, en la que existe un celo educativo instaurado en el ordenamiento de los hijos, favorece que éstos se sientan resguardados de los problemas que posteriormente tendrán que enfrentar por sí mismos. De ahí que no solamente se tiene que hacer una labor en torno a conductas dentro del hogar, sino que tan importante o más será el imprimir esfuerzos en conseguir que tengan criterios propios y consistentes en los diversos ámbitos de la vida a los que se verán abocados en un futuro cercano.

En cualquiera de las encuestas que consultemos dentro y fuera de nuestro país, encontramos que las edades de riesgo al consumo de drogas se enmarcan en la preadolescencia, por ello los mayores recursos se vienen centrando en ese periodo de edad, para intentar paliar al máximo las repercusiones posteriores. Como veremos más adelante, las variables que inciden directamente en la conducta de consumo de los jóvenes pivotan alrededor de tres grandes bloques: de una parte las que tienen implicaciones directas con las relaciones interpersonales (tan básicas en la preadolescencia y la adolescencia), de otra, las de carácter personal (educación, formación,

expectativas, actitudes) y, por último, las relacionadas con la forma de vida familiar y social (tipo de familia, forma de convivencia comunitaria,).

En el presente capítulo vamos a intentar analizar sucintamente algunos de los elementos que consideramos fundamentales en el periodo vulnerable de los jóvenes, cómo se pueden desarrollar comportamientos de consumo y en relación a qué circunstancias o desencadenantes.

ACERCA DEL CONCEPTO DE VULNERABILIDAD

Son muchos y variados los términos que manejamos en torno a este concepto relativamente moderno en el ámbito de la salud. No podemos hablar de vulnerabilidad sin aproximarnos a otros como resiliencia, conducta de riesgo, percepción de riesgo, factor de riesgo y sus contrarias, las de protección, que aunque pueda parecer paradójico, no siempre están en sintonía. De hecho, no podemos asegurar que un comportamiento de riesgo se compense con otro de protección y viceversa.

La resiliencia, según nos la define Becoña *et al.* (2006, 89), “es la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después de sufrir un estrés intenso, una catástrofe, o experiencias traumáticas como malos tratos, violencia, etc.”. Por conducta o comportamiento de riesgo entendemos aquellas acciones, normalmente voluntarias, que pueden desencadenar un daño en nuestra salud. Asociado iría el concepto de percepción de riesgo, que se refiere a cómo entendemos o interpretamos nuestra conducta en función de la propia acción que vamos a ejecutar y las consecuencias que tendría de llevarla a término. Cuando hablamos de factor de riesgo, como veremos más en detalle, nos referimos al conjunto de variables que pueden favorecer o desencadenar un daño para la salud, entendida ésta en su sentido más amplio, psicológica, física y social. Por último, la vulnerabilidad quedaría matizada en el sentido de lo que potencialmente puede causar un problema de salud, en relación a la suma de características individuales para afrontar la vida cotidiana.

Según Burak (1999), el concepto de vulnerabilidad tendría tres momentos fundamentales:

- La vulnerabilidad, cuando es valorada, solamente refleja el momento puntual en el que se hace y para el problema que se está estudiando. Este análisis se podría seccionar en tres procesos: el *inmediato* (como vulnerabilidad aguda); el *latente* (como riesgo posible de ocurrencia a corto plazo); y el *futuro* (como riesgo de poder producir consecuencias a largo plazo).
- Debe medirse en cada ocasión que sea necesario, estableciendo el nivel de vulnerabilidad actual y el nivel de riesgo y/o daño al que se expone con esa vulnerabilidad.
- El análisis de la vulnerabilidad tiene que estar en función del daño y/o daños posibles en relación a la interacción con los factores de riesgo, los factores protectores y otros comportamientos presentes cuando se lleva a cabo la valoración de la misma.

En la actualidad, los estudios de consumo de sustancias confrontan la vulnerabilidad y la resiliencia, orientándose a la demostración de que esta última tiene un peso específico muy potente para amortiguar a la primera. De hecho, la investigación, los estudios de Dillon *et al.* (2007) se orientan hacia la promoción de la resiliencia entre los jóvenes, presentando tres aspectos fundamentales de la misma:

1. La facilidad de acceso de los jóvenes a las drogas y otras circunstancias concomitantes que pueden favorecer su consumo.
2. La decisión de los jóvenes de no consumir drogas por una o varias razones indeterminadas.
3. Poseer los jóvenes competencias sociales suficientes para hacer frente al envite de las drogas y poder rechazar su consumo.

En un estudio de García del Castillo y Dias (2007) se pudo comprobar que existen diferencias de género marcadas a la hora de medir los niveles de resiliencia, demostrándose que las mujeres jóvenes tienen un grado de resiliencia significativamente mayor que los hombres jóvenes. Estos datos nos muestran que el hecho de ser mujer actúa como factor de protección frente al de ser hombre.

RELACIÓN ACTITUD COMPORTAMIENTO

Como muy bien señalan estudiosos de las actitudes como Eiser (1989), uno de los mayores “peligros” en la estructura de la psicología social es precisamente la utilidad del concepto de actitud. El autor señala claramente que podemos llevar a cabo teorías sobre la organización de las actitudes, modelos de actuación, medidas, pero si finalmente no somos capaces de predecir lo que una persona hará a partir de todos estos conceptos, no podremos encontrar la utilidad de este constructo. Es ya bastante largo el camino en la investigación de las actitudes buscando precisamente este tipo de relación, entre la actitud y el comportamiento final del individuo, encontrando algunos estudios clásicos como el de LaPierre (1934) donde aparece una relación entre la conducta verbal y el comportamiento final. Otro estudio es el desarrollado por Kutner, Wilkins y Yarrow (1952), donde también aparecen relaciones claras entre actitud verbal y comportamiento, aunque por supuesto lejos del cien por cien de los casos.

Hay que remarcar que son muchos más los casos en los que no se ha encontrado una relación entre actitud y comportamiento que lo contrario, o por matizar un poco más, habría que decir que los resultados en la mayor parte de los casos son por lo menos “ambiguos”. Gran parte de los estudios de actitudes se han centrado en la línea de los tres componentes, definidos como:

- Cognitivo: opiniones y creencias.
- Afectivo: sentimientos evaluativos y preferencias.
- Conductual: acciones manifiestas y declaración de disposición.

Es a partir de mediados de los años setenta del pasado siglo cuando investigadores como Fishbein, Ajzen, Triandis (1977, 1980), empiezan a cambiar la concepción de la relación entre actitud y comportamiento. Entre los modelos más desarrollados podemos destacar dos: la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen (Fishbein, 1967; Fishbein y Ajzen, 1972, 1975; Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein, 1980); y la teoría de la conducta planeada de Ajzen (1985, 1988). El modelo es desarrollado inicialmente por Fishbein (1967), y con posterioridad y tras la colaboración de Ajzen, es conocido como el modelo de Fishbein y Ajzen. Gergen y Gergen (1984) califican a esta teoría como coherente e integrada entre otros atributos, y señalan que es el camino para poder “predecir” de una forma más fiable las conductas de las personas. El objetivo que persigue este modelo es la predicción del comportamiento humano a través de las actitudes y de las normas subjetivas, medidas por la intención de conducta (Figura 2.1).

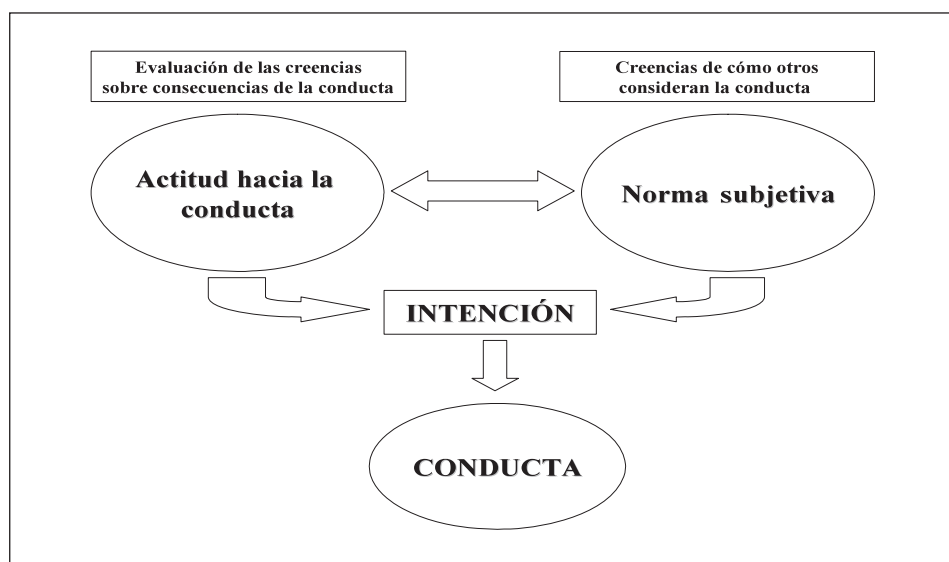


Figura 2.1 Teoría de la acción razonada. (Modificado de Ajzen y Fishbein, 1980).

Más en concreto, los autores no consideran a la actitud como algo aislado, sino que por el contrario viene determinada por la creencia y la evaluación. El objeto de la creencia puede ser prácticamente cualquier cosa, desde una persona hasta un objeto, pasando por una institución, un acontecimiento, etc., mientras que los atributos se enmarcan más en lo que se corresponde con características, propiedades, etc. Siguiendo a Becoña (1999) ante la proposición de creencia: “el tabaco es una droga”, el objeto es “tabaco”, mientras que el atributo es “droga”, por lo que en este caso el objeto sería un concepto mientras que el atributo se correspondería con una cualidad de ese objeto.

Fishbein y Ajzen (1975) plantean tres niveles de creencias:

- *Creencias descriptivas* corresponden a las que se desprenden de la observación directa.

- *Creencias inferenciales* su formación está en función de dos motivos, de una parte el razonamiento silogístico (consistencia probabilística), y de otro las que se sustentan en la atribución causal de Heider (consistencia evaluativa).
- *Creencias informativas* fundamentadas en fuentes externas y que en alguna medida puedan dar lugar a las creencias descriptivas.

Rodríguez Marín (1998) en una revisión y aplicación de las teorías de la acción razonada y la conducta planeada a la predicción de las conductas adictivas, apunta que la teoría de la acción razonada necesita identificar y medir la conducta objeto de estudio en un primer momento para predecir la conducta individual, siendo su determinante inmediato la intención que el individuo tiene de llevar a cabo (o no) tal acción. En el segundo momento descrito, la intención de un individuo presenta dos determinantes fundamentales: el primero de naturaleza personal (actitud hacia la conducta), y el segundo que refleja la influencia social (norma subjetiva). En un tercer momento, las actitudes acerca de una conducta están en función de “las creencias sobre resultados de tal conducta y de la valoración que una persona hace de tales resultados” (Rodríguez Marín, 1998, 74). Una de las críticas más importantes que se le atribuyen a esta teoría es la incapacidad que presenta para poder explicar de una forma razonable la conducta que no se encuentra bajo la voluntad del individuo.

Ajzen (1988) propone la teoría de la conducta planeada como una ampliación de la anterior. Introduce como elemento novedoso lo que denomina el control conductual percibido, que es la creencia que una persona tiene acerca de en qué medida puede controlar la ejecución de un determinado comportamiento, que junto a la actitud hacia la conducta y la norma subjetiva son predictores de la intención conductual. En algunos casos concretos el control conductual percibido puede ser predictor directo de la conducta conjuntamente con la intención (Figura 2.2).

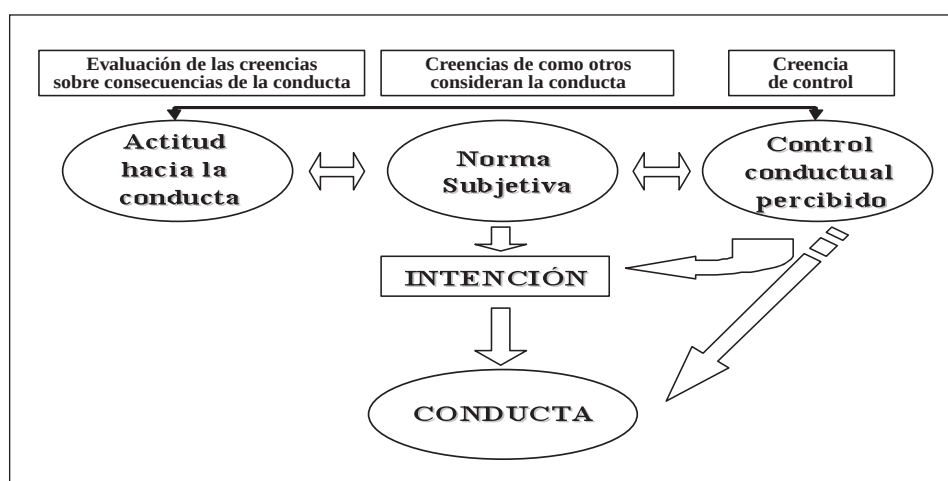


Figura 2.2. Modelo de la conducta planeada (Modificado de Becoña, 1999).

Tal y como se aprecia en la figura, puede ocurrir que el control conductual percibido actúe directamente sobre la conducta del sujeto sin tener en cuenta la intención. El control conductual percibido es definido como “la dificultad o facilidad percibida para ejecutar la conducta correspondiente” Ajzen (1987, 44). Aunque Ajzen (1988) atribuye a la teoría de la acción razonada un alto valor predictivo para aquellas conductas que son voluntarias, tiene mayor problema con aquellas en que el sujeto no ejerce un control voluntario completo. Un ejemplo representativo de este extremo es la conducta de fumar (Becoña, 1999) donde el fumador quiere dejar de fumar y tiene la intención de dejar de fumar, pero es incapaz de conseguirlo llegando a una baja relación entre intención conductual y conducta.

CAUSAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL INICIO AL CONSUMO DE DROGAS

Sabemos positivamente que el uso de sustancias es un comportamiento inherente a la propia naturaleza humana, dado que desde tiempo inmemorial existe un consumo de sustancias establecido en prácticamente todas las culturas conocidas. Cada una de ellas le ha dado un valor diferente al consumo y al tipo de sustancia, siendo el mapa tan curioso como complicado a la hora de establecer los criterios por los que cada pueblo consume una sustancia y evita o incluso “prohíbe” el consumo de otra.

No obstante, es absolutamente fundamental intentar entender las causas y factores que intervienen en la iniciación al consumo de drogas, dado que esta es la premisa donde se puede basar una estrategia de intervención preventiva desde cualquier disciplina, aunque la realidad es que en la corta trayectoria que ha recorrido la prevención, quizás esta premisa está aún muy limitada, por lo que se complica bastante la posibilidad de que las intervenciones que propongamos sean realmente eficaces. Tal y como señala Gilchrist:

“En el campo de la prevención de drogas, definir quién está en riesgo de consumo regular y frecuente es tan poco definitivo como las metas de los propios programas. La habilidad de un programa para detectar a adolescentes en riesgo se ha considerado mayoritariamente como un elemento importante a la hora de valorar el coste-efectividad de los programas. Sin embargo, todavía no ha habido una investigación etiológica que nos facilite herramientas para tasar con seguridad este riesgo. Lo que se hace normalmente en los programas de base escolar es considerar que todos los adolescentes y niños están dentro del grupo de riesgo de consumo y, por tanto, el grupo en su conjunto se constituye en objetivo de la intervención preventiva” (Gilchrist, 1995, 112).

“Ante este planteamiento, cualquier joven en mayor o menor medida, se encontraría en disposición potencial de ser consumidor de drogas, y por tanto entraría dentro del grupo de riesgo. Pero quizás sea pertinente acotar un poco más el concepto, y definir como factores de riesgo el conjunto de variables de carácter interno y/o externo que en interrelación pueden resultar facilitadoras y/o predisponen en el inicio y el mantenimiento del consumo de drogas” (Vallés, 1997).

Vemos que se encuadra en un planteamiento multifactorial, donde tienen que confluír e interactuar distintos elementos para que el riesgo de consumo se dé verdaderamente. Algunos trabajos han intentado aislar variables facilitadoras del consumo asociadas con parámetros de personalidad, con conducta antisocial o fuera de la norma social, con fracaso escolar, o con búsqueda de sensaciones (Herbert, 1983; Kandel, 1978; Pastor, 1988), sin que ninguna de ellas haya podido aportar datos concluyentes al respecto. Según García-Rodríguez y López (1998), sin hacer un análisis profundo de la cuestión, podríamos pensar que un factor bastante determinante en el consumo es la disponibilidad de adquisición de sustancias, lo que nos lleva, sobre todo en las edades más tempranas, a las drogas de uso legal (tabaco y alcohol fundamentalmente) como las de mayor índice de riesgo relativo.

A partir de aquí las clasificaciones de factores de riesgo son casi tan abundantes como autores que tratan el tema, dado que cada uno de ellos decide incorporar algún elemento diferencial en su clasificación, creando así la suya propia. No obstante, desde un punto de vista más analítico, posiblemente las diferencias entre los distintos autores se releguen únicamente a matices en cuanto a los propios factores, más que a aportaciones realmente diferentes, eso sí, sin tener en cuenta posturas como la psicodinámica, sistémica, transaccional, etc., que parten de otro tipo de postulados y desarrollan un enfoque diametralmente distinto.

Si revisamos algunas de las muchas clasificaciones sobre los factores de riesgo, vemos que Botvin y Botvin (1993), apuntan cuatro factores de riesgo evolutivo, entendiéndolo los autores como una evolución normal del sujeto (Figura 2.3):

a) *Presión de grupo*

En las etapas preadolescente y adolescente, el grupo de iguales tiene un papel representativo en cuanto a “lugar seguro” por una parte, y como una forma de protección del mundo adulto, por otra. Desde esta doble perspectiva los jóvenes tienen la posibilidad de descubrir la realidad circundante de una forma externa a la familia (que de alguna forma empieza a estar en un segundo plano) y aprender gran cantidad de papeles a través de los demás (habilidades personales y sociales). Normalmente la influencia se diversifica, de tal forma que los amigos pueden ejercer presión en cuanto a las “modas” (en el vestir, la forma de hablar, de moverse, la música, el consumo, etc.) y la familia en ámbitos más formales (pautas normativas en casa, elección de una carrera, etc.).

b) *Conformidad*

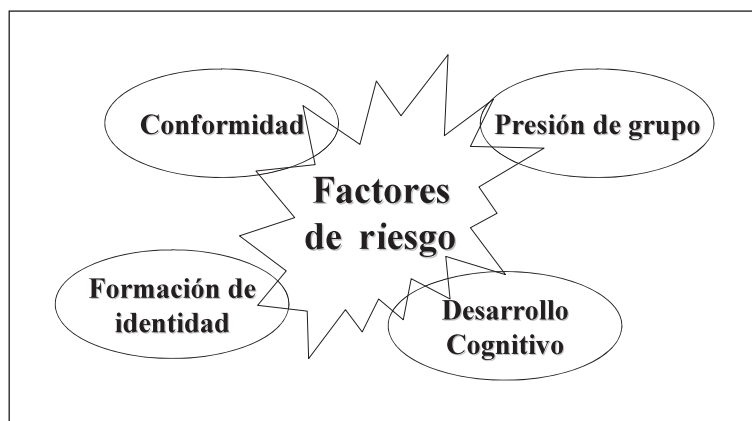
Es progresiva la dependencia que el preadolescente y adolescente va teniendo de su grupo de iguales, hasta el punto de que genera una conducta de conformidad. Este comportamiento de conformidad no implica que acepte sin discusión todas y cada una de las prerrogativas de su grupo de referencia, puede presentar una alta susceptibilidad hacia determinados valores, actitudes y comportamientos del grupo, si entran en contradicción con los suyos propios. En este caso tendrá una gran importancia la aceptación vs rechazo que el grupo tenga hacia el joven. Según Harptup (1983) a mayor dependencia y ansiedad y menor autoestima tenderán a ser más conformistas con el grupo.

c) *Desarrollo cognitivo*

El desarrollo evolutivo del adolescente experimenta grandes cambios y muy significativos, que le hacen percibir el mundo de una forma distinta. Las diferentes habilidades cognitivas que va adquiriendo el joven, le permiten enfocar los problemas con nuevas posibilidades que antes no tenían en su repertorio cognitivo, así como alternativas diferentes y aspectos normativos que le dan acceso a transgredir la norma y poder aceptarlo. Podríamos decir que las pautas morales del adolescente son menos rígidas entre lo bueno y lo malo, pudiendo añadir factores nuevos que amortig en su comportamiento.

d) *Formación de la identidad*

Una de las cuestiones fundamentales en esta etapa evolutiva, es la formación de su propia identidad, que ha de ser distinta de la de sus progenitores y demás miembros de la familia. Esta formación de la propia identidad hace que el joven consiga ser consciente de su imagen ante los demás, hecho altamente representativo en esta franja de edad. Los adolescentes pueden verse inducidos al consumo de drogas por mantener una imagen social determinada, que se puede ajustar con la que ven en otros adolescentes o en los propios adultos, y que le reportan unos “beneficios” sociales amplios o exitosos.



Fi ura Factores de riesgo evolutivos. (Adaptado de Botvin y Botvin, 1993).

La visión del riesgo por parte de Vallés (1997) aglutina tres bloques de factores (Figura 2.4):

1. *Individuales*

Que agrupa una serie de factores de carácter individual que inciden directamente en la vida de cada individuo:

- Edad.
- Características de personalidad.

- Autoconcepto y autoestima.
- Autocontrol.

2. *Relacionales*

Son aquellos que surgen de la relación existente entre el individuo y su entorno de una forma específica.

- Familia.
- Escuela.
- Grupo de iguales.

3. *Sociales*

Son aquellos factores de carácter cultural.

- Disponibilidad.
- Publicidad.

Según su autor, todos estos factores se interrelacionan entre sí formando un todo. No obstante, habría quizás que añadir a esta clasificación el hecho de que si se dan aisladamente no inducen necesariamente al riesgo, y que la proporcionalidad de su presencia aumentaría la probabilidad del riesgo al consumo de drogas.

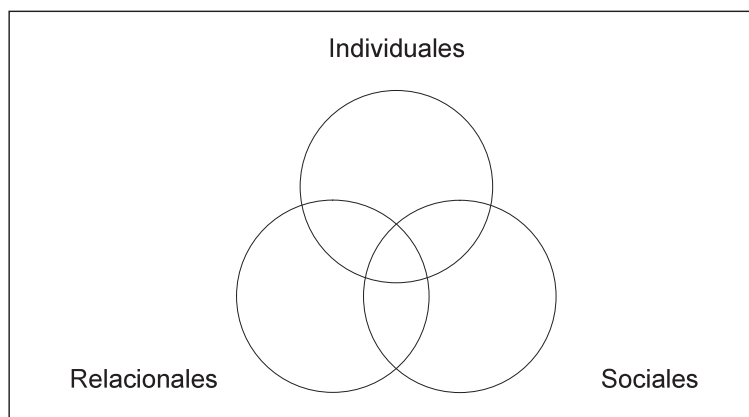


Figura 2.5 Factores de riesgo (Adaptado de Vallés, 1997).

Comparativamente con las anteriores y por formarnos una idea clara de la evolución que ha tenido el estudio de los factores de riesgo, podemos detenernos en la clasificación más clásica que nos proponen Kramer y Cameron (1975), a partir de los estudios realizados en los años sesenta, y que ellos llaman “factores desencadenantes o favorecedores” del consumo de drogas (Figura 2.5):

- a) Facilidad con que se pueden conseguir las drogas en un marco geográfico determinado (a mayor disponibilidad mayor consumo potencial de drogas).
- b) Aceptación social que tienen las drogas para favorecer el alivio de determinadas molestias o cambiar el estado de ánimo de las personas (existencia de algunos medios culturales que adoptan una actitud positiva al consumo de determinadas sustancias).
- c) La alta movilidad geográfica que tienen personas, ideas, objetos, etc. (aumento significativo de las comunicaciones y los transportes que permiten una mayor fluidez de información y de pautas de comportamiento de consumo).
- d) La influencia de la familia (puede ejercer una influencia positiva y/o negativa en función del estilo de vida y las actitudes de la misma).
- e) La influencia de los compañeros y amigos (la motivación, intereses y presión de los compañeros facilita el consumo de drogas).
- f) La influencia de los medios culturales (visión normalizada de determinados consumos, por ejemplo las drogas legales en determinada cultura).
- g) La influencia de las fuentes de información (sobre la decisión de probar por primera vez una determinada sustancia).
- h) La influencia de la calidad de la información (cuánto se ajusta a la realidad la información recibida sobre una sustancia y de qué forma le impacta esa información).

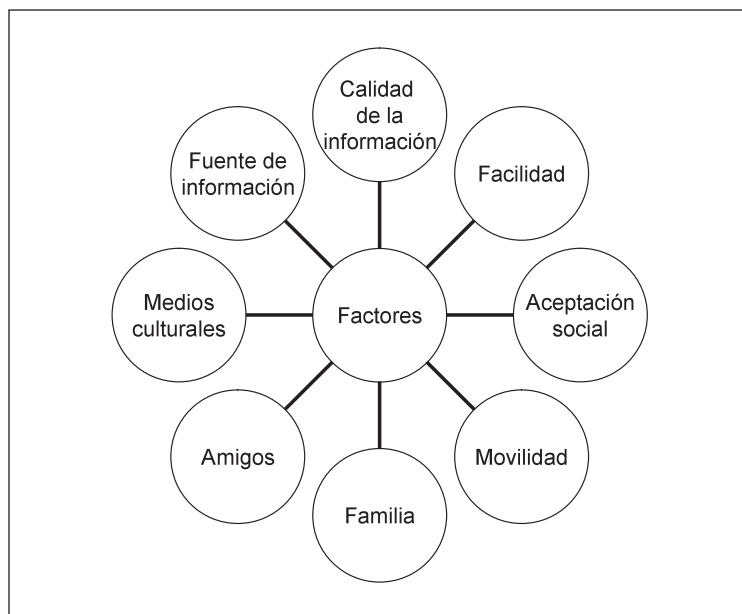


Figura Factores desencadenantes y favorecedores. (Kramer y Cameron, 1975).

Finalmente, los autores señalan que sería muy conveniente estudiar a fondo las diferencias que aparecen entre las personas que llegan a consumir drogas hasta el punto de generar adicción y las personas que solamente se asoman al consumo o bien tienen un consumo muy limitado, y las personas que rechazan totalmente la ingestión de drogas.

Una amplia revisión llevada a cabo por algunos autores (Hawkins *et al.*, 1985, 1992; Murray y Perry, 1985; Perry y Jessor, 1985) pone de manifiesto la amplitud de factores que se interrelacionan en el riesgo al consumo de drogas entre niños y adolescentes (Figura 2.6):

1. *Factores de comportamiento individual*

- Fracaso escolar.
- Conducta antisocial precoz.
- Consumo experimental precoz.
- Consumo precoz.

2. *Factores de actitudes individuales*

- Resistencia contra la autoridad.
- Compromiso bajo o muy bajo con la escuela.
- Actitudes favorables hacia comportamientos fuera de la norma social.
- Actitudes favorables hacia el comportamiento del mundo adulto.

3. *Factores psicológicos individuales*

- Autoestima baja.
- Rendimiento bajo.
- Búsqueda de sensaciones.

4. *Factores del medio familiar*

- Estilo de vida familiar de consumo de drogas y/o de comportamiento anti-social.
- Padres con escasas o nulas habilidades sociales para el manejo de la dinámica familiar.
- Tolerancia amplia de los padres hacia todo tipo de comportamientos fuera de la norma social.
- Desorganización familiar.

5. Factores del medio comunitario

- Nivel social y económico bajo o muy bajo.
- Desorganización comunitaria.
- Permisividad comunitaria hacia los comportamientos fuera de la norma social.
- Alta disponibilidad de drogas.
- Amigos y compañeros consumidores de drogas.

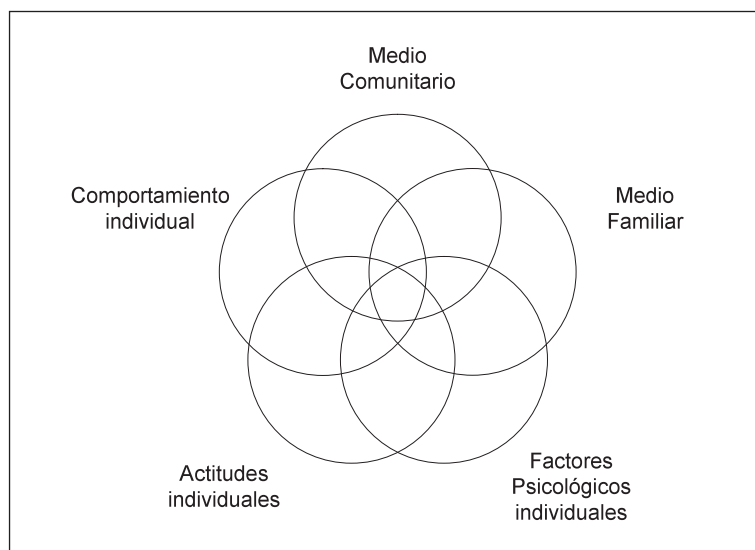


Figura Variables de riesgo para el consumo de drogas. (Adaptado de Hawkins *et al.*, 1985, 1992; Murray y Perry, 1985; Perry y Jessor, 1985).

Podemos comprobar que la gran mayoría de autores proponen factores de corte individual, donde introducen características propias de cada sujeto, actitudes y comportamientos; factores de corte familiar, dando un peso específico importante a la familia, desde su estilo de vida hasta sus pautas de socialización y consumo; factores de corte académico, donde sobresalen componentes de rendimiento, motivación y aprendizaje en general; y factores de corte comunitario que aglutinan aquellas variables que pueden llegar a determinar un comportamiento de consumo, desde la disponibilidad de las sustancias hasta las formas de permitir el consumo.

En un estudio realizado por García-Rodríguez *et al.* (1999) de una muestra de la población de escolares de Alicante ciudad, se formulan unos perfiles de iniciación al consumo de tabaco, de alcohol y de otras drogas.

El perfil del inicio al consumo de tabaco de los jóvenes alicantinos, lo podemos expresar como: *Joven que comienza a fumar o prueba por primera vez el tabaco en la calle o en una fiesta social (bautizo, comunión, boda o similar), en compañía de su*

grupo de amigos, arrastrado por la curiosidad, y que no sienten nada en absoluto o se siente decepcionado por el primer cigarrillo de su vida.

En el caso de la iniciación al consumo de alcohol tenemos que formular dos perfiles distintos, en relación a cada una de las poblaciones estudiadas:

- Población de Secundaria: *Joven que bebe alcohol por primera vez en una fiesta social o en su casa, en compañía de sus familiares, sin ningún motivo especial para probarlo o que lo prueba por curiosidad, y que no siente nada en absoluto por el hecho de probarlo.*
- Población de Bachillerato: *Joven que bebe alcohol por primera vez en una discoteca o un pub en compañía de su grupo de amigos/as, que o bien no tiene un motivo especial para probarlo o lo hace por curiosidad, y que no siente nada en absoluto cuando bebe por primera vez o siente satisfacción al hacerlo.*

El perfil de la iniciación al consumo de otras drogas se puede formular como: *Joven entre 16 y 20 años, que toma contacto por primera vez con las drogas en la calle o en una discoteca, en compañía del grupo de amigos/as, que la prueban por curiosidad y que sienten placer y/o satisfacción cuando las prueban.*

CONCLUSIONES

Tal y como apuntábamos al comienzo de este capítulo, el grado de vulnerabilidad tiene una relación importante con la edad de los sujetos. Según aseguran Robins y Przybeck (1985) la edad de inflexión para determinar si un joven puede llegar a ser o no adicto a sustancias, la establecen alrededor de los 15 años. De esta forma, aquellos que comienzan a consumir alejándose de esta edad hacia abajo tendrán doble probabilidad de ser consumidores patológicos en su edad adulta en comparación con los que se alejan de ella hacia arriba. Lo que determina que retrasar al máximo el primer contacto con las sustancias adictivas se relaciona con un uso y no con un abuso.

Pero como hemos podido comprobar, también lo tiene con otros aspectos relacionados con el estilo de vida donde se desarrolla, la familia, los factores de riesgo que se asocian al individuo y su entorno, y los elementos que pueden llegar a actuar como amortiguadores del inicio al consumo, lo que hemos llamado *resiliencia*. En principio cualquier joven en edad de riesgo puede desarrollar un consumo de sustancias de tipo experimental, que después y en función de las variables estudiadas, puede llegar a convertirse en patológico o de abuso.

Todo el conjunto de factores analizado nos permite generar amplios campos de trabajo con los preadolescentes y los adolescentes, donde cabría la posibilidad real de poder incidir directamente sobre aquellos que son susceptibles de modificar, mejorando significativamente las probabilidades a la baja de que puedan llegar a generar una adicción en el futuro. Es posible reducir la vulnerabilidad si se tiene la información suficiente en cada caso o en cada población estudiada, mediante estrategias *ad hoc* para ello.

BIBLIOGRAFÍA

- Ajzen I. From intentions to actions: A theory of planned behavior. En: J. Kulh y J. Beckmann (eds.). *Consistency in social behavior The Ontario symposium* (vol. II, 3-15). Hillsdale, NJ: LEA. 1985.
- Ajzen I. Attitudes, traits and actions: dispositional prediction of behavior in personality and social psychology. En L. Berkowitz (ed.). *Advances in Experimental Social Psychology*, Vol. 20, N.Y.: Academic Press: 1987. 1-63.
- Ajzen I. *Attitudes, personality and behavior*. Chicago: Dorsey Press. 1988.
- Ajzen I, Fishbein M. *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1980.
- Becoña E. *Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas*. Madrid: Ministerio del Interior. Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas. 1999.
- Becoña E, Míguez MC, López A, Vázquez MJ, Lorenzo MC. Resiliencia y consumo de alcohol en jóvenes. *Salud y drogas*. 2006. Vol. 6, nº 1, pp. 89-111.
- Botvin GJ, Botvin EM. Adicción juvenil a las drogas: Estrategias de prevención, hallazgos empíricos y temas de valoración. En: JA. García-Rodríguez y J. Ruiz (eds.). *Tratado sobre prevención de las drogodependencias*. Bilbao: Edex. 1993
- Burak SD. Protección, riesgo y vulnerabilidad. *Adolesc. Latinoam*. 1999. Vol.1, nº 4, pp. 222-230.
- Dillon D, Chivite-Matthews N, Grewal I, Brown R, Webster S, Weddell E, *et al*. Risk, protective factors and resilience to drug use: identifying resilient young people and learning from their experiences. London: Home Office. 2007. Disponible en línea <http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs07/rdsolr0407.pdf> (Consultado el 29 de enero de 2009).
- Eiser JR. *Psicología social. Actitudes, cognición y conducta social*. Madrid: Pirámide. 1989.
- Fishbein M. Attitude and the prediction of behavior. En: M. Fishbein (ed.). *Reading in attitude theory and measurement*. Nueva York: Wiley. 1967.
- Fishbein M. A theory of reasoned action: some applications and implications. En: M.M. Page (ed.). *Belief, attitudes and values*. Lincoln, MA: University of Nebraska Press. 1980.
- Fishbein M, Ajzen I. Attitudes and options *Annual Review of Psychology*. 1972. 32, 487-544.
- Fishbein M, Ajzen I. *Belief, attitude and behavior An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley. 1975.
- García del Castillo JA, Dias P. Análisis relacional entre los factores de protección, resiliencia, autorregulación y consumo de drogas. *Salud y drogas*. 2007. Vol. 7, nº 2, pp. 231-232.
- García-Rodríguez JA, López-Sánchez C. Consideraciones metodológicas acerca de la prevención de las drogodependencias. En: J.A. García-Rodríguez y C. López-Sánchez (eds.). *Nuevas aportaciones a la prevención de las drogodependencias*. Madrid: Síntesis. 1998.
- García-Rodríguez JA, López-Sánchez C, Estevez C, Lloret D. Evaluación de programas de prevención en la ciudad de Alicante. (Documento inédito). 1999.
- Gergen KJ, Gergen MM. *Historical social psychology*. Hillsdale: Erlbaum. 1984.
- Gilchrist LD. Definición de la intervención y de la población diana. En C.E.P.S. (ed.). *Estudios sobre investigaciones en prevención del abuso de drogas aspectos metodológicos*. Madrid: C.E.P.S. 1995.
- Harptup . Children and their friends. En: I.P. Mussen y E.M. Hetherington (eds.). *Chalmichael s manual of child psychology*. New York: Wiley. 1983.
- Hawkins JD, Lishner DM, Catalano, R.F. Childhood predictors and the prevention of adolescent substance abuse. En: C.L. Jones y R.J. Battjes (eds.). *Etiology of drug abuse Implications for prevention*. National Institute Research Monograph, 56. Washington: N.I.D.A. 1985.

- Herbert M. *Trastornos de conducta en la infancia y la adolescencia*. Madrid: Paidós. 1983.
- Kandel DB. Convergences in prospective longitudinal survey of drug use in normal populations. En: D.B. Kandel (ed.). *Longitudinal research on drug use: Empirical finding and methodological issues*. New York: Wiley. 1978.
- Kramer JF, Cameron, DC. (comp.) *Manual sobre dependencia de las drogas*. Ginebra: OMS. 1975.
- Kutner B, Wilkins C, Yarrow PR. Verbal attitudes and overt behavior involving racial prejudice. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. 1952. 47, 649-652.
- LaPierre RT. Attitudes vs actions. *Social Forces*. 1934. 13, 230-237.
- Murray DM, Perry CL. The prevention of adolescent drug abuse: Implications of etiological, developmental, behavioral, and environmental models. En: C.L. Jones y R.J. Battjes (eds.). *Etiology of drug abuse Implications for prevention*. National Institute Research Monograph, 56. Washington: N.I.D.A. 1985.
- Pastor, MA. Personalidad y adicción a la heroína. Análisis de la búsqueda de sensaciones. *Tesina*. Alicante: Universidad de Alicante. 1988.
- Perry CL, Jessor R. The concept of health promotion and prevention of adolescent drug use. *Journal of Health Education*. 1985. 12 (2), 169-184.
- Robins LN, Przybeck TP. Age of onset of drug use as a factor in drug and other disorders. En: C.L. Jones y R.J. Battjes (eds.). *Etiology of drug abuse implications for prevention*. NIDA, 56. DMHS (ADM): 87-1335. Washington: Supt. Of Docs., U.S.Gov. Print Office: 1985. 178-192.
- Rodríguez Marín J. La funcionalidad de la teoría de la conducta planeada en la predicción de las conductas adictivas. En: J.A. García-Rodríguez y C. López-Sánchez (eds.). *Nuevas aportaciones a la prevención de las drogodependencias*. Madrid: Síntesis. 1998.
- Triandis HC. *Interpersonal behavior*. Manterey, CA: Brooks/Cole. 1977.
- Triandis HC. Values, attitudes and interpersonal behavior. En: M. Page (ed.). *Belief, attitudes and values*. Lincoln: University of Nebraska Press. 1980.
- Vallés A. *Padres, hijos y drogas*. Valencia: Dirección General de Drogodependencias. Generalitat Valenciana. 1997.

LA VULNERABILIDAD DEL NIÑO DISCAPACITADO

M^a José Juan-Vera

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, nadie discute la validez o no de la Atención Temprana (Pérez-López y Brito de la Nuez, 2004), es un debate obsoleto y que recuerda las interminables argumentaciones a favor o en contra de la genética o el ambiente (Palacios, Marchesi y Coll, 2004). Pero sin embargo, la implantación de esta disciplina se ha hecho de manera irregular en distintos territorios, no solo del estado español sino también a nivel internacional.

Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, a partir de ahora CDIAT, son los que están formados por equipos interdisciplinares especializados en desarrollo infantil y que ofrecen intervención a los niños/as de entre 0 y 6 años con trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo, a su familia y a su entorno; en definitiva, son centros en los que se desarrolla la Atención Temprana.

Como ya se ha planteado, se acepta que la Atención Temprana es un recurso necesario e insustituible para la población de niños vulnerables debido a los trastornos en su desarrollo. No obstante, la creación y la evolución de los CDIAT se han desarrollado de forma paralela a otros servicios e instituciones que desde los ámbitos sanitario, social y educativo se han ido gestando en las diversas Comunidades Autónomas, por lo que no han sido iguales en todos los sitios.

Los centros deberían ser un servicio público y gratuito para todos aquellos que necesitaran el recurso, pero evidentemente no es así, por lo que el niño con trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo es más vulnerable dependiendo de la Comunidad Autónoma que haya nacido. Si partimos de la base de la igualdad de oportunidades que nos reconoce por derecho la Constitución Española (1978), y ya con anterioridad la ONU, en su artículo 1 de los Derechos del Niño, donde se explicita “Los derechos del niño serán reconocidos para todos sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición ya sea del propio niño o de su propia familia” (1959), se hace prioritario el que todos y cada uno de los niños con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades.

NIÑO CON DISCAPACIDAD VULNERABLE O FAMILIA VULNERABLE

El nacimiento de un niño siempre provoca en la familia una reestructuración a muchos niveles: biológicos, psicológicos, sociales. Y si además nace con un trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo, la crisis aumenta hasta aparecer las etapas de un duelo.

La llegada de un nuevo hijo va a suscitar en la familia, y fundamentalmente en la pareja, una serie de expectativas, ilusiones y esperanzas sobre el nuevo bebé. Pero la llegada de un niño con discapacidad va a romper de pronto todos estos sueños, de repente se truncan todas nuestras metas y aparece un túnel oscuro y sin salida. Habría que señalar que el que nazca con un síndrome, con una encefalopatía, con un megalo-virus,... no indica que la familia sufra invariablemente todas las reacciones que se han planteado. Las respuestas emocionales de los padres son diversas, aunque se repite con frecuencia las características reconocibles que siguen a una situación de crisis.

De acuerdo al modelo teórico de crisis, los padres suelen atravesar a lo largo de estos momentos por cuatro etapas diferentes (Grunwald y Hall, 1979): de shock, de reacción, de adaptación y de orientación. La duración e intensidad de éstas varía con los individuos, pudiéndose ver diferencias entre unos sujetos y otros. Sin embargo, suelen producirse todas las fases y con esta secuencia.

Hasta este momento hemos hablado de los cambios que se producen en la familia, pero, ¿y el niño? El niño, vulnerable por naturaleza, ve aumentada su desprotección debido simplemente a que ha nacido con algún trastorno; sin embargo, este niño tiene las mismas necesidades que cualquier otro, tiene necesidad de alimentarse, de cuidados higiénicos, biológicos, sociales, educativos, afectivos,... en definitiva, todo aquello que le ayude a desarrollarse como persona, aunque la mayoría de ellos sufren una desigualdad en el cumplimiento de derechos, ya que en estos momentos mientras sus padres sufren un momento de desconcierto y de angustia, el niño necesita de muchas cosas que en esos instantes la familia no puede, en la mayoría de los casos, ofrecerle. Aquí es donde se hace prioritario que se pongan en marcha mecanismos para que se cumplan los derechos de los niños. Los CDIAT deberían estar a disposición de cualquier niño y de su familia, desde el primer momento de su nacimiento, y no dependiendo del desarrollo legislativo que se hubiese llevado a cabo en cada Comunidad Autónoma.

El establecimiento de las primeras relaciones padres-hijos son fundamentales para el posterior desarrollo y que se consiga que el niño sea lo menos vulnerable posible. Para ello es imprescindible que profesionales especializados intervengan desde el momento que se detecte cualquier trastorno en el desarrollo. La Atención Temprana no es solo para el niño, sino para los padres, siguiendo los trabajos de Als (2000), Blair y

Ramey (2000) y Sly (1995), deberíamos contar con un equipo interdisciplinar que fuese capaz de desarrollar programas donde se reflejaran a los padres las conductas y capacidades reales de sus hijos, ayudarles a identificar las señales de interacción de los mismos y proponerles respuestas adecuadas, ayudarles a distinguir cuándo el niño es demasiado frágil para tolerar cualquier estimulación, informar a los padres del desarrollo evolutivo de sus hijos, reconciliar las expectativas de desarrollo de los padres con la realidad del niño nacido, mejorar la sensibilidad de los padres ante las señales que emiten sus hijos, señalar los cambios en los estados conductuales, animar a los padres en las tareas del cuidado diario: cambio de pañales, baño y alimentación, implicarles en la toma de decisiones del desarrollo evolutivo de sus hijos, enseñarles a aprovechar las oportunidades que ofrecen las rutinas diarias para mejorar la calidad de interacción,...

Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana deberán ser capaces de dotar a las familias del mayor número de estrategias para que los padres tengan la mayor participación y lo más activa posible en la interacción con sus hijos; la mejora de la relación entre todos va a tener especial relevancia en el desarrollo de los niños.

LOS CDIAT COMO PROTECTORES DE LA VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS CON TRASTORNOS EN SU DESARROLLO O RIESGO DE PADECERLOS

Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana son los encargados de poner en práctica las máximas del *Libro Blanco* de la Atención Temprana, máximo referente a nivel nacional, donde se explicita que la Atención Temprana es el:

“conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesiones de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”. (GAT, 2000, p. 13).

Según el *Libro Blanco* los CDIAT son “servicios autónomos cuyo objetivo es la puesta en marcha de la Atención Temprana”, y en las Recomendaciones Técnicas se redefine como “servicio autónomo, gratuito, interdisciplinario, participativo, descentralizado y sectorizado”(2005).

Como ya hemos comentado anteriormente, la implementación de este tipo de recursos no ha sido homogénea. Aunque existe un nexo de unión: que se intervenga con la población infantil de 0 a 6 años, con la familia y con el entorno.

Si partimos de la base de que todos los niños deben ser iguales ante la ley, este tipo de centros deberían cubrir un objetivo básico: que todos los niños vulnerables por su

discapacidad pudiesen ser beneficiarios de la atención que necesitan. Pero no es así, se discriminan simplemente por el origen geográfico de su nacimiento y dependen de las buenas voluntades de personas sensibles implicadas con estas situaciones.

Deberemos exponer algunos datos estadísticos que nos aporten una visión esclarecedora de la situación que se vive en España. Según los datos de Buigé y Lorente (2003), la prevalencia de que la población infantil, de menos de 4 años, pueda presentar de forma permanente o transitoria alguna alteración o trastorno en su desarrollo psicomotor, y por lo tanto sea más vulnerable, se sitúa alrededor del 15 %, de los niños (tengamos en cuenta, el hecho, que entre el 9 y el 10 % de los nacimientos son prematuros, según los datos a nivel nacional), y de ellos, el 15 % presenta una discapacidad permanente.

Siguiendo este planteamiento, y ubicándonos en la provincia de Alicante, debemos señalar que el año 2006 nacieron 14.639 niños en los hospitales públicos de nuestra provincia. Si a ellos añadimos los centros privados, estaríamos hablando de más de 17.000 niños. Pero solo nos situaremos en la ciudad de Alicante, con un total de 9.500 nacimientos, y si la población susceptible de recibir Atención Temprana es de aproximadamente un 12 %, los niños que tendrían derecho a recibir tratamiento en un CDIAT sería aproximadamente de 1.140 niños. Sin embargo, solo reciben atención unos 300 niños, por lo que podemos señalar que solo uno de cada cuatro niños está siendo atendido y no se encuentra desprotegido. Estos datos nos confirman la vulnerabilidad del niño con discapacidad.

CONCLUSIONES

Ante la conmemoración del 60º Aniversario de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, y en el mismo año en que ha entrado en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPCD), vemos que los derechos aprobados en la Declaración Universal comienzan el camino hacia su plena universalización; lo cual requiere no solo la adhesión pública y unánime de todos los agentes sociales, sino el compromiso de velar por el derecho de todos, para que nadie se sienta discriminado por su “discapacidad”, y se vean vulnerados en su desarrollo.

Los derechos humanos y las obligaciones de la CIDPCD requieren el desarrollo de políticas que aseguren la igualdad de derechos entre todos los seres humanos, y en este caso el de los niños discapacitados. En nuestra sociedad las discriminaciones son en algunas ocasiones muy sutiles y por lo tanto muy difíciles de erradicar. Debemos ser exigentes en el cumplimiento de medidas de protección.

La sociedad debe comprometerse en que se cumplan las normativas básicas. Los niños con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo y sus familias, deben tener pleno derecho a asistir a un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT), con el objeto de ofertarles a esos niños y a esas familias las mejores condiciones de vida.

BIBLIOGRAFÍA

- American Academy of Pediatrics Committee on Practice and Ambulatory Medicine. Recommendations for preventive pediatric health care. *Pediatrics*. 1995. 96 (2p1):373-374.
- Berger S, Thompson RA. *Psicología del desarrollo Infancia y adolescencia*. Madrid. Ed. Médica Panamericana. (1999).
- Brito de la Nuez AG. Prevención en el ámbito de las poblaciones de riesgo biológico. En: J. Pérez-López y A.G. Brito (Coord.) *Manual de atención temprana*. Madrid: Pirámide. 2004. (pp. 27-44).
- Casado Pérez D. et al. *Curso de Prevención de deficiencias: materiales de seguimiento y evaluación*. Documento de trabajo 3. Madrid. Real Patronato sobre Discapacidad, 2003.
- Ezpeleta L. Prevención en psicopatología del desarrollo. En: Ezpeleta (ed). *Factores de riesgo en psicopatología del desarrollo*. Barcelona. Masson. 2005, pp 3-20.
- Millá MG, Mulas F. *Manual de Atención Temprana*. Valencia: Promolibro. 2005.
- Pallás CR, Bértolo JC, Medina MC. *Apoyo al desarrollo de los niños nacidos demasiado pequeños, demasiado pronto*. Madrid: Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. 2000.
- Pérez-López J. Modelos explicativos del desarrollo aplicados a la atención temprana. En J. Pérez-López y A.G. Brito (Coord.) *Manual de atención temprana*. Madrid: Pirámide. 2004. (pp. 27-44).
- Pérez-López J, Brito de la Nuez AG. *Manual de atención temprana*. Madrid: Pirámide. 2004.
- Ponte Mittelbrun J. *Guía de estándares de calidad en Atención Temprana*. IMSERSO. 2004.
- Departament de Sanitat i Seguretat Social. *Protocols de medicina preventiva a la edad pediàtrica*. Barcelona. Generalitat de Catalunya. 1995.
- Sánchez Caravaca J. La eficacia de los Programas de Atención Temprana en niños de Riesgo Biológico. Estudio sobre los efectos de un programa de Atención Temprana en niños prematuros en su primer año de vida. *Tesis Doctoral*. 2006.
- Shon off JP, Marshall PC. Biological bases of developmental dysfunction. En: S.J. Meisels y J.P. Shon off y (eds.), *Handboo of early childhood intervention*. 2ª Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 1990. (pp 35-52).
- Shon off JP, Marshall PC. The Biology of Developmental Vulnerability. En: S.J. Shon off y S.J. Meisels (eds.) *Handboo of early childhood intervention*. 2ª Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 2000. (pp 35-53).
- VVAA. *La Atención Temprana en la Comunidad de Madrid*. Situación actual y Documentos del grupo Padi. Genysi. 1999.
- VVAA. *Libro Blanco de Atención Temprana*. Madrid. Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. Colección Documentos 55/2000. 2000.
- VVAA. Criterios de calidad estimular para la población infantil de 0 a 3 años. *Revista de Atención Temprana*. 2002. 5, pp 4-20.

EL SÍNDROME DEL NIÑO ALTRATADO

Susana Jiménez Moreno

INTRODUCCIÓN

La Medicina Legal y Forense, como parte de la Medicina y puente entre ésta y el Derecho, está encaminada fundamentalmente al estudio de aquellas situaciones médicas con implicaciones jurídicas. Una de estas situaciones son los cuadros producidos por el ejercicio de violencia sobre los niños, o lo que llamamos “malos tratos”.

La violencia sobre los menores es un fenómeno que se produce desde épocas muy antiguas, frente al que ha existido siempre una gran permisividad. Siendo un hecho ignorado en el ámbito social y jurídico hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Es por tanto a mediados del siglo xx cuando empiezan a abordarse los problemas de la infancia y la violencia, creándose organismos internacionales de protección a la misma y normas legislativa que intentan hacer valer sus derechos. Como ejemplo, la *Declaración universal de los Derechos del Niño* (20 de noviembre de 1959), que en su principio 9 recoge que “El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata”.

El fenómeno de los malos tratos en la infancia está considerado un problema de salud de carácter universal, reconocido por la OMS desde 1999.

Se podría decir que una de las formas más perversa de violencia ejercida sobre los menores es aquella que se produce dentro del ámbito de lo familiar, el daño intencional producido por aquellas personas que tienen la responsabilidad del menor y de las que depende absolutamente.

SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO

Hablamos de este síndrome ante aquella “Situación que acontece en niños pequeños y adolescentes, los cuales son objetos de sevicias o malos tratos físicos, psicológicos o morales, por acción u omisión por parte de sus padres, familiares o cuidadores”.

De este cuadro tenemos referencia desde hace siglos, siendo reconocido y asignándole una entidad propia, médicos forenses y pediatras, fundamentalmente.

Profesionales forenses como Paolo Accia, Tardieu, observaron en autopsias realizadas a niños, un conjunto de lesiones físicas que presentaba unas características comunes y que relacionaban con cuadros producidos por violencia intencional.

En el siglo xx, reconocidos pediatras como Caffey, Silverman o Kempe describieron este cuadro, acuñándole en un principio el nombre de “Síndrome del niño golpeado” como alusión exclusiva a las lesiones físicas observadas, y que posteriormente y en la actualidad pasó a llamarse “Síndrome del niño maltratado” al ampliarse el concepto de este cuadro.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

Hablar de de datos estadísticos con relación a los malos tratos sobre el menor es complejo, es una situación comparable a aquellos fenómenos sociales tipo “Iceberg”, sobre los cuales a pesar de su alta prevalencia se reconocen un pequeño número.

Desde distintas fuentes de estudio se reconoce que en nuestro país se denuncian entre un 10 % y un 20 % de los casos reales.



Figura 1. Fenómenos sociales tipo “Iceberg”.

El centro Reina Sofía, de la Comunidad Valenciana, para el estudio de la violencia, recoge datos que reflejan la situación de nuestro país con relación a los malos tratos infantiles; según sus estudios el 90 % de los casos de maltrato infantil se quedan fuera de las estadísticas oficiales.

La misma fuente refiere que ocho de cada 100 niños españoles sufre algún tipo de abuso, habiendo crecido en España un 150 % en los últimos cinco años.

En la tabla siguiente se muestran datos obtenidos por el Centro Reina Sofía a partir de los casos denunciados, en ellos se puede ver un aumento progresivo de los casos desde el año 2001 al 2005.

Tabla Menores maltratados en el ámbito familiar. Centro Reina Sofía (Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio de la Violencia)

Año	2001	2002	2003	2004	2005
Denuncias	2.614	4.506	4.944	5.995	6.438

CONDUCTAS VIOLENTAS EN EL SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO

Se contemplan distintas formas de ejercer la violencia sobre los menores, por lo que clásicamente diferenciamos en:

- I. Maltrato físico
- II. Maltrato psicológico o emocional
- III. Maltrato por negligencia
- IV. Abuso sexual
- V. Síndrome de Munchausen por poderes

I Maltrato físico

Definido como aquella acción no accidental de los padres o cuidadores que provoque daño físico y/o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo.

Se incluyen las conductas de castigo físico como los azotes, bofetadas, empujones, palizas.

Derivadas de la violencia física, vamos a encontrar una serie de lesiones características que hacen sospechar o nos indican la etiología intencional de las mismas. En orden de mayor a menor frecuencia se encuentran:

- a) Lesiones cutáneas y esqueléticas.

- b) Lesiones del Sistema Nervioso Central.
- c) Lesiones oculares.
- d) Lesiones musculares y nerviosas.
- e) Lesiones viscerales.

Los mecanismos de producción de estas lesiones son muy variados:

- Golpes, lanzamientos contra objetos duros, patadas, empujones.
- Quemaduras por derramamiento de líquido hirviendo, introducción de pies o manos en líquido hirviendo, quemaduras por cigarrillos, colocar sobre superficies calientes, objeto incandescente en manos o cuerpo.
- Arrancamiento de dientes, orejas, cabellos, uñas.
- Mordeduras.
- Heridas por arma blanca, objetos punzantes, cortantes, y/o por arma de fuego.
- Sacudida violenta del niño, zarandear un bebé en los primeros meses de vida para que deje de llorar.

a) Lesiones cutáneas, son las más llamativas y aparecen en el 90 % de los casos, puesto que lógicamente es en la piel donde se produce el impacto directo de la agresión.

La naturaleza de las lesiones es muy variada: hematomas, que es la lesión más frecuente (39 %), desgarros y arañazos (21 %), mordeduras, heridas, cicatrices, alopecias y quemaduras (6 %).

Los hematomas evolucionan hacia la curación pasando por fases cromáticas distintas que permiten determinar de forma aproximada el momento de su producción.

Es característico encontrar lesiones en distintos estadios evolutivos, por posibles traumatismos repetidos. Es importante igualmente estudiar la localización de las lesiones: los hematomas accidentales suelen aparecer en zonas prominentes del cuerpo como la barbilla, codos, rodillas, espinillas, y por el contrario, la aparición en algunas zonas conlleva una alta sospecha de intencionalidad en la producción de las mismas, como la cara interna del muslo, pene, nalga, espalda y otras.

En los casos de utilización de objetos, plancha, hebilla e incluso la mano, se puede observar la marca dejada por el objeto agresor.

Es necesario que el profesional sanitario sepa reconocer estas lesiones y distinguir si son de origen accidental o provocado, o producidas por alguna enfermedad del niño.

b) Lesiones esqueléticas, junto con las cutáneas son las más frecuentes. Los hallazgos radiológicos del trauma esquelético se obtienen en 1/3 de los casos, y la mayoría de las lesiones ocurren durante los dos primeros años de vida. Es importante tener en cuenta la localización, naturaleza y el aspecto multifocal de las mismas.

La localización más frecuente de la lesión son las extremidades (77 %), el cráneo (34%) y las costillas (19%). Las lesiones epifisarias-metafisarias son consideradas por muchos autores como diagnóstico de maltrato, teniendo gran repercusión en el crecimiento posterior del niño.

El trauma en la cabeza es una de las causas más frecuentes de muerte y morbilidad en niños maltratados. Un elevado porcentaje de las lesiones craneales serias, con peligro para la vida en niños pequeños, son debidas a maltrato.

Tres circunstancias son muy importantes para el diagnóstico radiológico: edad del paciente (mayor incidencia en menores de tres años), el tiempo transcurrido (la ausencia no excluye el diagnóstico) y repetición de la agresión (lesiones en distintas áreas y en distintos momentos).

c) Lesiones del sistema nervioso central, constituyen la principal causa de muerte en el SNM, sobre todo en niños menores de dos años. La muerte ocurre por hemorragia intracraneal traumática, con o sin fracturas craneales.

Se estima que un 20 % de los niños maltratados presenta lesiones del SNC. Estas pueden ser de dos tipos:

- Por traumatismo directo, al golpear al niño con un objeto o golpear la cabeza contra el suelo o una pared.
- Por traumatismo indirecto, de sacudida o de aceleración o deceleración.

Como refiere Ball, los hematomas subdurales en los primeros tres años de vida son característicos de los traumatismos craneoencefálicos provocados, no accidentales.

Caffey observó hace varias décadas un cuadro típico, formado por la presencia de hematoma subdural y fracturas de huesos largos en niños pequeños comprobando en muchos casos la ausencia de un traumatismo accidental que lo justificase, esto le llevó a asociar este cuadro, con una causa intencional. Hoy lo conocemos como “Síndrome de Caffey”, y su presencia sugiere la existencia de maltrato en el niño.

d) Lesiones oculares, un 40 % de los niños maltratados padecen traumatismos oculares. El espectro de estas lesiones es muy amplio, suelen ser lesiones bilaterales.

Algunos autores, entre ellos Giangiacomo, confirman en sus trabajos que las hemorragias retinianas en menores de tres años en ausencia de lesiones externas de traumatismo craneoencefálico, son casi específicas de maltrato.

e) Lesiones viscerales, se pueden encontrar en tórax y abdomen, no son muy frecuente pero sí son de gran importancia. Son la segunda causa de muerte por malos tratos. Se producen por golpes o compresión sobre la pared anterior del tórax o abdomen, afectando cualquier órgano: pulmón, otras vísceras, con mayor frecuencia el duodeno, páncreas y yeyuno.

Es muy importante tener en cuenta que en los casos de maltrato físico las lesiones presentan unas características específicas que cuando están presentes nos deben po-

ner en “alerta” y hacer sospechar siempre del origen intencional de las mismas, estas características son:

- Gran polimorfismo.
- Multiplicidad.
- Variada localización.
- Diferente intensidad y momento evolutivo.

II Maltrato emocional y psicológico

Se trata de aquellas situaciones en las que los adultos no son capaces de procurar el bienestar necesario en el niño para que tenga un desarrollo psíquico adecuado.

Es una forma de maltrato aún más difícil de precisar que el maltrato físico, por sus sutiles matices, donde la intencionalidad del maltrato es en ocasiones difícil de establecer.

Los padres actúan mediante el rechazo, aislamiento o castigo, amenazas, ignorando o provocando miedo, lo que conlleva importantes repercusiones físicas y comportamentales.

También los padres utilizan la hostilidad verbal habitual a través de insultos, críticas, descrédito y ridiculización.

Aunque algunos autores describen esta variedad ligada a estratos o clases mejor situadas económicamente, no existen datos que lo apoyen, de hecho se reconoce que puede darse en cualquier nivel socioeconómico.

Estas desatenciones o agresiones emocionales pueden darse en el seno de la propia familia, que somete al niño a situaciones de terror, rechazo, desaprobación continua, reproches y, en definitiva, la falta de ambiente de cariño y afecto que todo niño necesita para su equilibrio moral y psicológico.

Aunque estos casos no son fáciles de identificar al no existir lesiones traumáticas, se dan características que pueden hacernos pensar en ello, como es el hecho de que el niño se recupera de forma espectacular de su retraso psicomotor o estatura-ponderal al ser separado del medio familiar.

III Abandono y negligencia

Falta de protección y cuidados físicos mínimos al niño por parte de sus responsables, así como el abandono de sus necesidades evolutivas por falta de estimulación cognitiva. Incluye la falta de asistencia educativa y sanitaria y los peligros en el hogar.

La falta de cuidados o negligencia de carácter crónico, provoca en el niño distintos grados de déficit nutritivo (escorbuto, raquitismo), aspecto descuidado de su higiene,

limpieza, vestidos, desatención de las medidas profilácticas, escasa protección de distintos tipos de riesgo y accidentes.

Muchas veces es difícil distinguir si esta falta de cuidados, esta conducta negligente es de carácter voluntario o es el resultado de unas condiciones familiares socioculturales precarias con falta extrema de recursos o en otras ocasiones debida a la presencia de deficiencia mental de los padres.

La negligencia en la infancia ocurre en todos los periodos evolutivos, pero se cree por la mayoría de los autores que es un problema especialmente crítico en dos momentos de la vida del menor, la edad preescolar, por la gran vulnerabilidad del niño y la dependencia absoluta del adulto, y también en la adolescencia, en donde adquiere unas características especiales.

IV A uso sexual

Solo recientemente se ha llamado la atención sobre el abuso sexual en los niños como otra forma de malos tratos. Este aspecto es muy difícil de descubrir. La explotación sexual de los niños, la auténtica prostitución infantil, es junto con el incesto, otros de los muchos y graves aspectos del SNM.

Se considera abuso sexual cualquier clase de contacto o actividad sexual con un menor realizado desde la posición de poder o autoridad sobre aquel.

Igualmente, se consideran situaciones de abuso sexual aquellas solicitudes indecentes sin contacto físico, o seducción verbal explícita, actos sexuales ante el niño, etc.

V Síndrome de Münchausen por poderes

Este síndrome consiste en la simulación o la creación artificial de signos, síntomas o enfermedades por parte de los padres o responsables del menor.

El barón Von Münchausen fue un personaje que exageraba e inventaba sus hazañas militares y su nombre ha sido utilizado para describir un síndrome que caracteriza a un grupo de pacientes que simulan y fingen falsos síntomas y signos que conllevan actuaciones médicas y quirúrgicas innecesarias.

Cuando esta situación se da en niños pequeños hablamos del síndrome de Münchausen por poderes, en los que generalmente son las madres las que simulan enfermedades en sus hijos. Se trata de un maltrato infantil en el cual los padres relatan falsas historias, inducen signos, síntomas y enfermedades en los niños y los someten a numerosas hospitalizaciones y exámenes médicos, que en muchas ocasiones comportan riesgos.

El diagnóstico es a menudo difícil. Su reconocimiento es importante para prevenir que médicos y enfermeras se conviertan, sin saberlo, en colaboradores de los padres.

Ante la existencia de determinadas situaciones: enfermedad persistente y recidivante inexplicable, síntomas “raros” que “no encajan” con el estado de salud del niño, madre poco preocupada, etc., debe pensarse en este cuadro.

El agresor suele ser la madre, de edad media, apariencia normal, cooperativa con los médicos, sobreprotectora y con frecuencia tiene conocimientos de medicina o enfermería. Puede llamar la atención que se manifiesta menos preocupada de lo esperable.

El pronóstico del síndrome de Munchausen por poderes es grave y con frecuencia tiene consecuencias mortales. Es frecuente que se repita en varios miembros de la familia.

Entre las manifestaciones comunes que pueden presentar los niños e inducir a la sospecha están las hemorragias, convulsiones, envenenamientos, diarrea, vómitos, fiebre, erupciones.

DIAGNÓSTICO DEL ALTRATO INFANTIL

El diagnóstico del Síndrome del Niño Maltratado debe ser sospechado siempre que encontremos un niño, con mayor frecuencia de edad inferior a tres años, que presenta lesiones traumáticas de explicación no convincente por parte de los familiares, con aspecto descuidado en su higiene y vestidos, así como retraso estatura-ponderal, que muestra actitudes de recelo y temor, con frecuencia un niño con retraso psicomotor y en los padres podemos encontrar algunos factores de riesgos.

Aunque la época más frecuente de la vida es desde el nacimiento hasta los tres años, podemos observar casos de maltrato en toda la infancia y adolescencia.

Ya se ha comentado que el diagnóstico es muchas veces difícil, ya que con frecuencia los padres tardan en llevar al niño al centro hospitalario y es característico que las consultas o ingresos se produzcan sucesivamente en centros diferentes para no levantar sospechas.

La presencia de estos hechos en su totalidad o parcialmente debe conducir a un estudio radiológico completo, exploración neurológica, determinaciones analíticas, estudio psicosocial de la familia, que nos permita el diagnóstico definitivo y poder plantear las difíciles medidas terapéuticas y preventivas.

Los niños maltratados presentan una serie de rasgos de personalidad característicos, entre los que destacan: carácter tímido y asustadizo, ausencia de búsqueda de protección familiar, dificultad de adaptación, tendencia a la depresión y al suicidio, etc.

Respecto a los padres, no existe un perfil identificador de los mismos, aunque en la mayoría de los casos denunciados se han encontrado características comunes consideradas como *factores de riesgo* entre los que se encuentran:

- Déficit psíquico acusado en uno o en ambos padres.
- Toxicomanías graves.
- Alcoholismo en la pareja.

- Número muy reducido de conductas de vínculo y calidad afectiva en el trato del niño.
- Trastornos mentales graves.
- Elevado nivel de agresividad y violencia en la dinámica familiar.

No hay que olvidar nunca la obligación de poner en conocimiento de la autoridad los casos de malos tratos en menores, estando especialmente obligados aquellas personas que por su profesión tienen conocimiento del hecho por ejemplo los profesionales sanitarios, como recoge la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor (art. 13), o el Código de Ética y Deontología Médica de 1999 (art. 30.2).

BIBLIOGRAFÍA

- Arrubarrena I, De Paúl J, Torres B. *El maltrato infantil: detección, notificación, investigación y evaluación*. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, 2ª ed. 1996.
- Ball WS JR. Non accidental craniocerebral trauma (child abuse): MR imagin. *Radiology*. 1989. 173:609-610.
- Casado J, Díaz JA, Martínez C. *Niños maltratados*. Madrid: Díaz de Santos. 1997.
- Empe RS, Empe CH. *Niños maltratados*. Madrid: Ediciones Morata. 1996.
- Meado R. Munchausen syndrome by proxy. *Arch Dis Child*. 1982. 57:92-98.
- Milton T. Pediatric toxicology: current controversies and recent advances. *Curr Probl Pediatr*. 1986. 16:185-233.

EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL UNA FORMA DE ABUSO INFANTIL

Mar Pastor Bravo

INTRODUCCIÓN

La familia, tal y como la conocían nuestros padres y abuelos, ha sufrido un enorme cambio en las últimas décadas. Así, cada vez hay un mayor número de familias monoparentales, familias formadas por progenitores del mismo sexo, familias con niños de distintos matrimonios. Dentro de toda esta diversidad están los niños cuyos padres están separados o divorciados. Es conocido por todos que se ha producido un enorme incremento de separaciones y divorcios, que hacen necesarios instrumentos procesales por parte del ordenamiento jurídico para ir adaptándose a las nuevas realidades familiares y regular las relaciones entre los hijos de padres y madres separados.

Tras un proceso de separación/divorcio, los hijos pueden quedar bajo la custodia de uno de los progenitores, o bien puede establecerse un régimen de custodia compartida por ambos. Así viene regulado en la ley: El artículo 94 del Código Civil (CC) establece que “el progenitor no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía; el Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de ese derecho, que podrá limitar o suspender si de dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave y reiteradamente los deberes impuestos por resolución judicial”.

La Ley 15/05 de 8 de julio por la que se modifican el CC y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) en materia de separación y divorcio, en su artículo 92, establece:

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos”.

Independientemente de con quién conviva el niño, se ha de garantizar la relación con ambos progenitores tras la separación; los regímenes de visitas tienen importantes funciones psicológicas tanto para el menor dentro de su proceso de desarrollo madurativo, como para el progenitor no custodio. Así, las visitas protegen los derechos del menor de acceso al progenitor no custodio, al igual que los de este último; se protege el vínculo emocional entre el niño y sus progenitores, ya que se le proporcionan modelos de rol alternativos.

Hasta aquí todo entraría dentro de un proceso, que siendo difícil para todas las partes, no tiene por qué causar daño psíquico ni psicológico a los menores, ni secuelas a corto/largo plazo. Cuando por alguna de las partes se utiliza a los hijos como parte de la disputa y entran a formar parte del conflicto, es cuando puede dañarse la salud psíquica de los menores, llegando a aparecer un Síndrome de Alineación Parental (SAP) en casos extremos. Pueden presentar sentimientos de abandono, culpabilidad, rechazo, impotencia, indefensión, inseguridad, así como estados de ansiedad y depresión y conductas regresivas, disruptivas y problemas escolares. Pueden ponerse “de parte” del progenitor que ellos consideran como más indefenso o débil, adoptando una función de defensa que puede llevarles a rechazar a al otro progenitor.

CONCEPTO

Se exponen fragmentos de dos sentencias que recogen el concepto del SAP, desde el punto de vista práctico.

Juzgado de Primera Instancia. Sentencia 29-5-2007:

Se estima la demanda de modificación de medidas y se retira temporalmente de la menor a la madre a la par que se le prohíben las visitas y todo contacto, incluido el telefónico, hasta nuevo informe pericial a realizar en cuatro meses. Considera el Magistrado que la situación actual excede un mero conflicto de lealtades, pues la niña ha asumido casi en su totalidad las tesis maternas sobre su padre y la familia paterna como consecuencia de la prolongada manipulación de la que ha sido objeto aquella, consciente o inconscientemente. Así las cosas, en este momento la menor presenta una relación patológica en la forma de relacionarse con su familia que debe de ser corregida y ello con independencia de que la situación de la menor pueda ser calificada como de un SAP severo o moderado-severo y con independencia asimismo de que las conductas manipulativas de la madre respondan a la ejecución de un plan preconcebido o a un exceso de protección a su hija hasta extremos patológicos.

Sentencia Audiencia Provincial 6-6-2007:

Una vez acordado el divorcio, el Juzgado se pronuncia sobre el régimen de guarda y custodia de la menor, a favor de la madre en la medida que ha resultado acreditado que la niña padece cuanto menos una fobia severa hacia la madre. SAP. Los informes médicos recomiendan el acercamiento progresivo de la madre para restablecer la relación, al constatar el incumplimiento del régimen de visitas por el padre. Dispone

que la menor pase un mes en casa de los abuelos maternos y trascurrido este periodo de tiempo, a la vista del dictamen del médico especialista se decidirá sobre la conveniencia de que la menor pase al domicilio materno. Se suspenden los contactos de la menor durante al menos 6 meses con el padre y la familia paterna, por lo que este régimen de visitas queda en suspenso.

El SAP es definido por primera vez por Richard Gardner en 1985 como un desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guardia y custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno de los padres y de la propia contribución del hijo a la denigración del padre rechazado. Cuando aparece en el contexto de abuso parental real o negligencia, la animosidad del niño puede estar justificada, por lo que no sería aplicable el SAP.

En un principio Gardner consideraba que el SAP nacía por la combinación de la influencia parental y las aportaciones activas del propio niño en la campaña de denigración. Posteriormente introduce aspectos que considera necesarios para decir que estamos hablando de SAP, entre otros que se dé en el contexto de lucha por la guarda y custodia de los hijos, que haya una campaña de difamación contra uno de sus progenitores de forma injustificada y que no haya razones probadas de negligencia o maltrato real hacia el menor.

Considera que esta campaña se inicia con un “lavado de cerebro” de los niños por parte de un progenitor y que los hijos acaban haciendo suyas las manifestaciones que les han inculcado.

Otra definición sería la dada por Aguilar: “Trastorno caracterizado por un conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor”.

La alienación parental consiste en un proceso de programación psicológica realizado por uno de los progenitores y dirigido hacia los hijos, para que estos rechacen al otro progenitor sin que haya justificación alguna. El proceso produce un cambio de la percepción afectiva de los hijos hacia el padre rechazado y, consecuentemente, se da una transformación en la estructura y las relaciones familiares.

La alienación parental tiene diferentes efectos para cada miembro de la familia: para los hijos se convierte en un trastorno psicológico; para el progenitor rechazado o alienado se convierte en un ataque del que debe defenderse continuamente; para el progenitor generador del proceso o alienador representa un conflicto de fidelidades respecto a los hijos (o estás conmigo o contra mí) y un juego de poder respecto al otro progenitor.

La alienación parental no es una cuestión de un “malo” contra un “bueno”, porque un progenitor puede ser víctima y alienador al mismo tiempo, y además, un progenitor víctima puede convertirse en alienador contra el otro progenitor para desquitarse de los comportamientos sufridos. Esto podría convertirse en un círculo vicioso, con el consiguiente efecto en los niños.

COMPORTAMIENTOS ESTRATEGIAS OBSTACULIZADORAS DEL PROGENITOR ALIENANTE

Son múltiples los comportamientos que un progenitor puede llevar a cabo para impedir el contacto del menor con el otro progenitor. Estos comportamientos de manera asilada o de forma ocasional no darían lugar al trastorno. El problema surge cuando estas conductas se dan de forma continua influyendo en el comportamiento de los hijos y modificando su percepción de la realidad. Algunos de estos comportamientos serían:

- Rehusar pasar llamadas telefónicas a los hijos.
- Organizar varias actividades con los hijos durante el periodo del otro.
- Presentar al nuevo cónyuge a los hijos como su nueva madre o su nuevo padre.
- Interceptar el correo y los paquetes mandados a los hijos.
- Rehusar informar al otro progenitor a propósito de las actividades en las cuales están implicados los hijos (partidos deportivos, actuaciones teatrales, actividades escolares...).
- Hablar de manera descortés de la nueva pareja del otro progenitor.
- Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho a visita.
- Reprochar al otro progenitor el mal comportamiento de los hijos.
- “Olvidarse” de avisar al otro progenitor de citas importantes (dentista, médico, psicólogo...)
- Implicar a su entorno (su madre, su nuevo cónyuge...) en el “lavado de cerebro” de los hijos.
- Tomar decisiones importantes a propósito de los hijos sin consultar al otro progenitor (elección de la religión, elección de la escuela...)
- Cambiar (o intentar cambiar) sus apellidos o sus nombres.
- Impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y médicos de los hijos.
- Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, aunque el otro progenitor esté disponible y voluntario para ocuparse de ellos.
- Contar a los hijos que la ropa que el otro progenitor les ha comprado es fea y prohibirles ponérsela.
- Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a llamar, a escribir o a contactar con el otro progenitor de la manera que sea.

Hay cuatro criterios que permiten de manera razonable predecir que el proceso de alienación está en curso:

1. *Obstrucción a todo contacto*: la razón más alegada es que el otro progenitor no es capaz de ocuparse de los hijos, por lo que estos no se sienten bien

cuando vuelven de las visitas. También suelen alegar que los niños necesitan tiempo para adaptarse al cambio. Los mensajes suelen ser: “él/ella no es más un miembro de esta familia”, “se ha marchado porque no nos quiere”, “nos ha abandonado dejándonos tirados”, etc. El objetivo es excluir al otro progenitor de la vida de los hijos, dejando de lado el principio de que cada uno de los padres debe favorecer el desarrollo positivo de la relación entre los hijos y el otro progenitor.

2. *Reacción de miedo por parte de los hijos*: el hijo puede mostrar una reacción evidente de miedo, de desagrado o de estar en desacuerdo con el progenitor alienador, pero éste puede amenazar al hijo con abandonarlo o mandarlo a vivir con el otro progenitor, por lo que el hijo se pone en una situación de dependencia y está sometido regularmente a pruebas de fidelidad. Para sobrevivir, estos hijos aprenden a manipular, se hacen expertos prematuros para descifrar el ambiente emocional, para decir nada más que una parte de la verdad. Lo que el hijo intenta es no defraudar al progenitor con el que convive.
3. *Deterioro de la relación desde la separación*: es el criterio más decisivo, por lo que es importante el estudio de la relación parental antes de la separación y no fiarse únicamente de lo que cuentan los hijos.
4. *Denuncias falsas de abuso*: sobre todo de tipo sexual, aunque también alegan abuso emocional.

NIVELES DE INTENSIDAD DEL RECHAZO DE LOS NIÑOS AFECTADOS POR EL SAP

En función de la intensidad de la manipulación por parte del progenitor alienador, aparecerán distintos niveles de gravedad en el rechazo del menor hacia el progenitor alienado.

- **Rechazo leve**: no hay una ruptura en la relación entre el hijo alienado y el progenitor excluido, en este momento todavía se pueden llevar a cabo la dinámica familiar anterior. Se caracteriza por la aparición de algunos signos de desagrado en la relación con el padre o la madre, pero no hay evitación y la relación no se interrumpe. En este primer estadio las dificultades solo se manifiestan en el momento de las visitas, es decir, en el momento del cambio de progenitor, pero hay deseos claros en el hijo de conservar lazos afectivos y de relacionarse con el padre hacia el que se dirige la exclusión.
- **Rechazo moderado**: hay una voluntad manifiesta por parte del menor de no ver al padre o la madre alienado, junto con una búsqueda activa de aspectos negativos del progenitor rechazado para justificar su deseo de rechazo. Niega todo afecto hacia él y evita su presencia. El rechazo se generaliza a su entorno familiar y social. La relación se mantiene por obligación o se interrumpe.

- **Rechazo intenso:** lo que caracteriza este estadio es que son los propios hijos quienes llevan a cabo la alienación. Hay una postura fanática de rechazo. El niño se cree todos los argumentos negativos sobre el progenitor alienado, que de forma progresiva ha ido exhibiendo el progenitor alienador. Las visitas se hacen imposibles y la relación se hace traumática. El rechazo adquiere características fóbicas con fuertes mecanismos de evitación. Pueden a parecer incluso ataques de pánico cuando se plantea la posibilidad de estar con el otro progenitor. Todo ello suele ir acompañado de sintomatología psicosomática.

DINÁMICA DEL RECHAZO

El rechazo puede aparecer inmediatamente después de la ruptura o en periodos posteriores que pueden alcanzar varios años después, generalmente asociados a momentos concretos del nuevo ciclo evolutivo familiar. De esta manera se distinguen dos tipos de rechazo en función del momento en que aparecen: primario y secundario.

El rechazo primario es una reacción inmediata a la ruptura de pareja y el secundario aparece en separaciones más lentamente gestadas. En este último los hijos mantienen relación con el progenitor rechazado hasta que un día deciden romperla.

En ambos casos, si no se actúa de forma correcta y los progenitores continúan su proceso de descalificación mutuo, haciendo que el menor tome partido por uno de ellos, el rechazo tiende a cronificarse, con las consecuencias nefastas para el menor que se derivan de él.

SECUELAS DEL SAP EN MENORES

Existen pocos estudios acerca de las consecuencias que un SAP va a tener a corto y largo plazo en los menores, pero sí se ha podido evidenciar la aparición de síntomas, ante la simple presencia física del progenitor rechazado, de cuadros de ansiedad, crisis de angustia y miedo a la separación. Todo ello unido a alteraciones a nivel fisiológico en los patrones de alimentación y sueño, conductas regresivas y de control de esfínteres. Es una sintomatología similar a la que presentan los menores que sufren maltrato emocional.

- **Cuadros de ansiedad generalizada:** aparece agitación y preocupación sobre acontecimientos que el niño no puede controlar. Los menores viven el momento de las visitas con un fuerte estrés. Hay taquipnea, enrojecimiento de la piel, sudoración, elevación del tono de la voz, temblores, finalizando en desbordamiento emocional, no pudiendo estar delante del progenitor rechazado con serenidad y normalidad. Aparecen auténticas fobias, especialmente la fobia por separación, que se caracteriza por una ansiedad excesiva cuando el niño tiene que separarse del progenitor alienador. Esta fobia puede ampliarse, incluso al alejarse de los lugares familiares para el niño como la casa del progenitor que

tiene la custodia. Esto explica que si el cuadro avanza puede aparecer una auténtica agorafobia, ya que el niño termina por negarse a salir de casa o desplazarse a sitios desconocidos. El cuadro puede llegar a una crisis de pánico, que se caracteriza por un conjunto de síntomas y malestar intensos que se inician bruscamente de forma muy intensa. El niño vive un sentimiento extremo de vulnerabilidad, impotencia y miedo.

- **Trastornos en el sueño y la alimentación:** derivado de la situación anterior los menores pueden presentar pesadillas y problemas para conciliar el sueño o mantenerlo. También pueden sufrir trastornos alimenticios derivados de la situación que viven y que no saben afrontar, ingiriendo alimentos compulsivamente o no alimentándose.
- **Trastornos de conducta:** conllevan conductas agresivas, que en casos severos hacen las visitas imposibles, pueden aparecer problemas del control de los impulsos con agresiones verbales o también físicas. Junto con esta agresión, y como consecuencia de la negativa del niño a ver al progenitor alienado, aparecen conductas de evitación que implican en ocasiones síntomas somáticos que sirven de excusa. Entre ellos dolor de cabeza, de estómago. Además, estos niños utilizan términos judiciales que no son propios de su edad, y que ponen de manifiesto un claro reflejo de la fuerte conflictividad que viven y de la postura que han tomado en el conflicto, que es al lado incondicional del progenitor no rechazado. Como consecuencia de todo ello aparece una de las consecuencias más graves y de mayor repercusión en el desarrollo emocional del menor, un cuadro de dependencia emocional hacia el progenitor alienador. Estos menores tienen miedo a ser abandonados por el progenitor con el que conviven, ya que saben, y así lo sienten, que su cariño está condicionado. Tienen que odiar a uno para ser querido y aceptado por el otro. Todo ello crea una fuerte dependencia emocional para el menor. Como consecuencia aparece una relación patológica entre progenitor e hijo.

En los casos severos pueden darse denuncias falsas por maltrato hacia los menores, que conllevan exploraciones, que además de ser innecesarias, producen una fuerte situación de estrés. También adoptan el rol de víctimas, de algo que aunque no han sufrido toman como real, teniendo unas consecuencias devastadoras para su desarrollo psicológico.

CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR A UN NIÑO ALIENADO

- Sienten un odio implacable hacia el progenitor alienado.
- Repiten como loros lo que les dice el progenitor alienador obsesivo.
- El niño no quiere visitar o pasar nada de tiempo con el progenitor objetivo.
- Muchas de las opiniones del niño encajan con las del alienador.
- No están intimidados por los tribunales.

- No se sienten culpables sobre su comportamiento con el progenitor odiado.
- Con frecuencia, las razones que dan sobre sus experiencias personales con el progenitor odiado reflejan la influencia del progenitor obsesivo.
- No hay ambivalencia en sus sentimientos: el odio no les deja ver lo bueno que pueda haber.
- Comparten su causa con el progenitor alienador y juntos denigran al progenitor odiado.
- El odio obsesivo de los hijos se extiende a la familia extensa del progenitor odiado, sin sentimiento de culpa ni remordimiento.
- Pueden mostrarse como niños normales y saludables hasta que son preguntados por el progenitor alienado que desencadena su odio.
- Las razones alegadas para justificar el descrédito al progenitor objeto son a menudo débiles, frívolas o absurdas. El hijo da pretextos poco creíbles o absurdos para justificar su actitud (ejemplo: un niño se niega en rotundo a ver al padre porque “una vez no me dejó un folio para dibujar”).
- El niño afirma que la decisión de rechazar al progenitor objeto es exclusivamente propia, lo que Gadner llama el “fenómeno del pensador independiente”: el hijo afirma que nadie lo ha influenciado y que ha llegado solo a adoptar esa actitud.
- Se evidencian “escenarios prestados”, por ejemplo, las afirmaciones del niño reflejan temas y terminología propias del progenitor alienador (ejemplo: al preguntar al niño por qué está enfadado con uno de sus padres contesta, “porque rompió los votos del matrimonio”).

CONCLUSIONES

En los procesos de separación y divorcio, los menores se ven afectados en uno u otro grado, ya que se produce un cambio en sus vidas notorio. Dependiendo de cuál sea la actitud de los padres esta afectación causará o no malestar en los menores. A lo largo del capítulo se ha puesto de manifiesto la gravedad del SAP, así como las enormes repercusiones de tipo psíquico y psicológico que pueden tener y que pueden dar lugar a secuelas que acompañen al niño a lo largo de su vida adulta. Se recoge a continuación un fragmento de una Sentencia de 1997, en la que sin aparecer el concepto de SAP, se refiere a las consecuencias del mismo y resolvía que los intentos de uno de los progenitores para alejar a un niño del otro, son perjudiciales para el mejor interés del menor, añadiendo además que “es deber y obligación de cada progenitor fomentar y alentar el amor y respeto del niño hacia el otro progenitor, y la dejación en esta obligación es tan dañina para el niño como la dejación en proporcionales alimentación, vestido o cobijo. Quizás sea más dañino porque no importa lo bien alimentado o vestido que pueda estar un niño, éste no puede ser feliz si no se siente amado por uno de sus dos progenitores”.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar JM. *Síndrome de Alienación Parental. Hijos manipulados por un cónyuge para odiar al otro*. Córdoba. Almuzarra; 2007.
- Código Civil*. Madrid: Tecnos; 1996.
- Código Penal* de 1995. Valencia: Tirant Lo Blanch; 1995.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. *BOE* núm. 7, de 8 de enero del 2000, pp. 575-728.
- Luengo D, Coca A. *Hijos manipulados tras la separación*. Barcelona. Oxigen Viena Ediciones; 2007.
- Segura C, Gil MJ, Sepúlveda MA. El síndrome de alienación parental: una forma de maltrato infantil. *Cuadernos de Medicina Forense*. 2006. 12 (43-44): 117-128.
- Tejedor A. El síndrome de alienación parental. Una forma de maltrato. Madrid. EOS; 2007.

EL ENOR FRENTE AL ABUSO SEXUAL

Fernando Rodes Lloret

La sexualidad es bonita en todas las edades, pero a veces, las personas mayores, que pueden ser desconocidos, amigos o familiares, en lugar de vivir la sexualidad con personas de su edad, abusan de los niños. Nos pueden pedir, obligar o engañar para hacer cosas sexuales. Algunos pueden acariciar de forma especial nuestras partes más íntimas, el pene, o la vagina por ejemplo, o pedirnos que acariciemos los suyos. También pueden obligarnos a observar como se desnudan ellos. Esto se llama abuso sexual infantil, porque una persona mayor no debe hacer estas cosas con los niños o niñas.

Afortunadamente, no son muchos los mayores que hacen estas cosas, por el contrario, la mayoría de los adultos nos cuidan, nos dan cariño y nos protegen. Pero vamos a hablar del abuso sexual para aprender a defendernos en estos casos y para enseñar a esos mayores que lo que hacen no está bien

Extracto del *Manual de prevención de abuso sexual* del Centro Infanto-Juvenil “Tierra de los niños”. Nueva Imperial. Chile. (Primera Unidad: dirigida a niños de 3-6 años)

El abuso sexual en la infancia es una de las formas de maltrato infantil, junto con el maltrato físico y abandono físico, maltrato y abandono emocional y maltrato institucional.

Entendemos por abuso sexual infantil cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto. (Lopez Martín, 1996).

Para que exista abuso sexual no es imprescindible la existencia de contacto físico del adulto con el niño, aunque es frecuente, en forma de tocamientos en los genitales o incluso penetración anal o vaginal. También es abuso sexual infantil:

La utilización del niño como objeto de estimulación sexual, como ocurre cuando se induce o fuerza al niño a que realice tocamientos sobre el adulto.

Aquel realizado sin contacto físico, como mostrarse desnudo al niño, observar al niño cuando se desnuda o cuando está en el aseo, realizar el acto sexual o masturbación en presencia del niño, obligar al niño a masturbarse en presencia del adulto, mostrar imágenes pornográficas al menor, realizar fotos o videos pronográficos de él o con él, etc.

Un concepto más amplio de abuso sexual infantil es el que establece que “todas aquellas caricias que incomoden, hagan daño, o generen sentimientos de culpabilidad en el niño, pueden ser abuso sexual”. (Ontiveros, 1996).

Se han descrito tres fases en el desarrollo del abuso sexual infantil:

- 1 . *Fase de inicio* el agresor comienza a establecer contacto con el menor y se asegura de que éste no dirá nada a nadie. El niño suele estar confundido y no entiende lo que ocurre. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones el abusador es un conocido de la víctima.
- 2 . *Fase de continuidad* el agresor se ha ganado la confianza (o temor) del niño y una vez que se asegura su silencio se suceden los abusos, para ello busca ocasiones para permanecer con el niño. En esta fase, dependiendo de la edad del menor, es posible que éste trate de evitar la presencia del abusador, lo cual puede tomarse como un indicador del abuso.
- 3 . *Fase de confirmación*: cuando el abusador es sorprendido o la víctima cuenta lo que ha ocurrido. Generalmente la familia del menor reacciona violentamente contra el agresor, aunque a veces se interroga de manera incisiva al niño, situación que lo confunde más, acentuándose entonces los sentimientos de culpa.

EL PEDERASTA

El término pederastia procede del vocablo griego *paiderastía*, que a su vez proviene de *pais*, *paidos*: niño y *erastes*: amante y significa “abuso deshonesto cometido contra los niños”.

El pederasta viene recogido en las actuales clasificaciones de psiquiatría como pedófilo (DSM-IV-TR) o paidófilo (CIE-10).

Puede tratarse de un familiar directo del niño, como el padre, padrastro, hermano u otro pariente, de un conocido, como un amigo, la persona que lo cuida, un vecino, un maestro, etc., o bien de un desconocido⁴. Es importante señalar que en ocho de cada diez casos, el niño conoce a la persona.

Pedofilia

El *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (DSM-IV-TR), incluye dentro de los trastornos sexuales y de la identidad sexual, a la *Pedofilia* (302.2), estableciendo los siguientes criterios para el diagnóstico:

- A. *Durante un periodo de al menos seis meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con niños prep beres o niños algo mayores (generalmente de años o menos).*
- B. *El individuo ha satisfecho estas necesidades sexuales, o las necesidades sexuales o fantasías producen malestar acusado o dificultades interpersonales.*
- C. *La persona tiene al menos años y es por lo menos años mayor que el niño o los niños del Criterio A.*

Nota *No debe incluirse a individuos en las ltimas etapas de la adolescencia que se relacionan con personas de o años.*

Especificar si:

Con atracción sexual por los hombres.

Con atracción sexual por las mujeres.

Con atracción sexual por ambos sexos.

Especificar si:

Se limita al incesto.

Especificar si:

Tipo exclusivo (atracción solo por niños).

Tipo no exclusivo.

Este manual destaca algunos aspectos, que por su interés reproducimos a continuación:

- Los pedófilos declaran sentirse atraídos por los niños dentro de un margen de edad particular, algunos prefieren niños, otros niñas y otros ambos sexos.
- Los pedófilos que se sienten atraídos por las niñas, generalmente las prefieren entre los 8 y 10 años, mientras que los que se sienten atraídos por niños, los prefieren algo mayores.
- La pedofilia que afecta a las niñas como víctimas es mucho más frecuente que la que afecta a los niños.

El curso de la pedofilia es habitualmente crónico.

- Algunos individuos con pedofilia solo se sienten atraídos por niños (tipo exclusivo), mientras que otros se sienten atraídos a veces por adultos (tipo no exclusivo).
- El pedófilo puede limitar su actividad simplemente a desnudar al niño, a observarlo, a exponerse frente a él, a masturbarse en su presencia o a acariciarlo o tocarlo suavemente, o bien a efectuar felaciones o *cunnilingus* o penetraciones vaginales, bucales o anales con sus dedos, objetos o el pene

Estas actividades las explican con excusas o racionalizaciones de que pueden tener “valor educativo” para el niño, que el niño obtiene “placer sexual” o que el niño es “sexualmente provocador”.

Algunos amenazan a los niños para impedir que hablen, otros, particularmente los que lo hacen con frecuencia, desarrollan técnicas complicadas para tener acceso a los niños, como ganarse la confianza de la madre, casarse con una mujer que tenga un niño atractivo

Paidofilia

La *Décima revisión de la clasificación internacional de enfermedades* (CIE-10), incluye dentro de los Trastornos de inclinación sexual, la *Paidofilia* (F65.4):

“Se trata de una preferencia sexual por los niños, normalmente de edad prepuberal o de la pubertad temprana. Algunos de los afectados sienten atracción únicamente por las chicas, otros únicamente por los chicos y otros están interesados por ambos sexos.

La paidofilia se presenta raramente en mujeres. Los contactos entre adultos y adolescentes sexualmente maduros es algo socialmente reprobado, en especial si los que intervienen son del mismo sexo, pero esto no se acompaña necesariamente de paidofilia. Un incidente aislado, en especial si el que lo lleva a cabo es un adolescente, no es signo de la tendencia persistente o predominante que se requiere para el diagnóstico. No obstante, entre los afectados de paidofilia, hay varones que manifiestan una preferencia por una relación de pareja sexual adulta, pero que debido a que hay reiteradas frustraciones en sus intentos de contactos adecuados, los han sustituido de manera habitual por niños.

Los varones que abusan sexualmente de sus propios hijos prepuberales suelen abordar en ocasiones también a otros niños, pero en ninguno de estos casos hay nada más en su comportamiento que sugiera una paidofilia.”

Podríamos considerar el siguiente, como el perfil del pederasta: varón, mayor de 35 años, sin antecedentes delictivos, integrado en su entorno social, profesional cualificado o jubilado, no consumidor de alcohol u otras drogas.

No hay que olvidar, por otra parte, que en algunas enfermedades, como la demencia, se produce de forma paulatina y progresiva, una pérdida del juicio crítico y desin-

hibición, siendo frecuentes los atentados sexuales, con predilección sobre los niños, debido a la mayor facilidad de convicción de los mismos.

Suelen ser delitos sin violencia, como exhibicionismo, atentados leves al pudor, tocamientos, etc.

Estos atentados sexuales, se suelen producir en el *periodo médico-legal*, que corresponde a los primeros momentos del proceso demencial. A medida que la demencia progresa, estos enfermos son lógicamente, menos peligrosos. (Rodes, 2006)

LA VÍCTIMA

Puede ser víctima de abuso sexual cualquier niño o niña. No existe un perfil o característica específica que determine la ocurrencia del abuso en unos tipos de niños o niñas y en otros no. Se da en todas las clases sociales, religiones y niveles socioculturales y afecta a niños y niñas de diferentes edades. Sin embargo, se han identificado algunas características que constituyen factores de riesgo para el abuso sexual infantil (Arredondo, 2007):

Falta de educación sexual.

Baja autoestima.

Necesidad de afecto y/o atención.

Niño o niña con actitud pasiva.

Tendencia a la sumisión.

Baja capacidad de tomar decisiones.

Timidez, aislamiento.

EPIDEMIOLOGÍA

El abuso sexual infantil está considerado como un fenómeno mundial, que aparece independientemente del régimen social, las condiciones socioeconómicas o de otro tipo (Mateos, 1997). Ha sido y es muy frecuente, aunque en la mayoría de las ocasiones queda sin descubrir, como ocurre cuando el niño es pequeño y no se le han causado lesiones físicas.

Pese a la elevada incidencia de abusos sexuales a menores, no hay pruebas de que en la actualidad haya más casos que hace 40 o 50 años. La detección y por tanto la incidencia sí ha sufrido un aumento importante, al mejorar la formación. Además, sabemos que se conoce solo entre el 10% y el 20% de los casos reales.

Es un fenómeno antiguo. Un estudio sobre 14 delitos sobre la libertad sexual ocurridos en Lleida durante el siglo xv revela que en el 43% de los casos, la víctima era un menor o un adolescente (Camps, 1995).

Resultados de encuestas a población adulta, expresan que el 18.9% manifiesta haber sufrido abusos sexuales en la infancia, siendo las niñas de 11 y 12 años la población de mayor riesgo.

La ONG Medicus Mundi, en el dossier informativo *Los niños de la calle* (1996), recoge que el sexo forzado es una realidad cotidiana para los niños de la calle de España. Su indefensión frente a los mayores los expone a todo tipo de abusos. Tanto las niñas como los niños suelen sufrir agresiones sexuales contra las que prácticamente no pueden hacer nada. El agresor suele ser un adulto en busca de sexo o, simplemente, compañeros mayores que viven igualmente en la calle.

Según un estudio realizado por la delegación española de la ONG Save the Children, se estima que en España, el 23% de las niñas y el 15% de los niños sufren abusos sexuales antes de los 17 años, y que en el 46% de los casos, se repiten estos abusos más de una vez sobre la misma víctima.

Este estudio añade que uno de cada cuatro casos de abusos sexuales infantiles se trata de conductas muy íntimas y exigentes, como el coito vaginal o anal, el sexo oral y la masturbación. Considera como factores de riesgo: ser niña, tener entre 10 y 13 años y tener problemas familiares y concluye afirmando que el 30% de las víctimas no le cuenta sus problemas a nadie.

Los estudios prueban que se abusa más severamente y con mayor violencia en el caso de las niñas, además de que la edad de inicio del abuso también es menor.

La edad de máxima incidencia de casos de abuso, tanto en niñas como en niños, suele ser de los 6 a los 12 años.

Hay que destacar la prevalencia mayor del abuso sexual infantil entre los niños con discapacidad física o psíquica. Un niño con este tipo de características tiene tres veces más de probabilidades de sufrir un abuso sexual que cualquier otro niño.

Según la Academia Americana de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, en EEUU se denuncian anualmente 80.000 casos de abuso sexual infantil, aunque, el número de los que no se denuncian es aún mayor, ya que los niños tienen miedo de decirle a alguien lo que les pasó.

Sin embargo, estas cifras alarmantes contrastan con los datos obtenidos en estudios realizados en centros hospitalarios y en juzgados.

Bañón (2003) estudia los partes médico-legales emitidos en el Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital General Universitario de Alicante, durante 1997 y 1998. En esos dos años, se atendieron 49.828 urgencias infantiles, de las que se emitieron 235 partes al juzgado. Llama poderosamente la atención, que solo dos de ellos corresponden a abusos sexuales: en un niño de 7 años (penetración anal por el compañero sentimental de la madre) y en uno de 4 años (abuso sexual por otro menor).

(Rodes *et al.*, 1991) hemos estudiado las denuncias formuladas por malos tratos físicos en el ambiente familiar, en el Partido Judicial de Elche, durante el año 1990. De un total de 81 casos denunciados, solo cuatro correspondían a niños: de 6, 8 (dos), y 12 años, lo que supone, el 4,9% de las denuncias. Es importante señalar que ningun-

no de estos cuatro casos correspondía a abuso sexual, sino que se trataba de maltrato físico.

Ambos estudios vienen a corroborar que no todos los menores que sufren abusos sexuales son asistidos por personal médico y mucho menos son conocidos a nivel judicial.

Esto es debido a que en numerosas ocasiones el abuso sexual no produce daño físico, aunque sí psicológico en el menor, como ocurre cuando existen tocamientos, y además, con frecuencia, el niño oculta lo ocurrido por respeto o temor hacia el adulto que abusó de él.

Para algunos autores se acepta que por cada caso detectado, existen otros diez sin detectar, lo que da una idea de la magnitud del problema.

OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

La sospecha de que un menor está siendo objeto de abuso sexual debe llevar a su denuncia o por lo menos a ponerlo en conocimiento de los servicios sociales pertinentes.

Destacamos tres textos legales que hacen referencia a esto.

A) La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor establece:

Artículo 17. *Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.*

1. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

B) La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la obligación de denunciar:

Artículo 170.

Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.

Los que no cumplieren esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 171, que se impondrá disciplinariamente.

Si la omisión en dar parte fuere de un profesor de Medicina, Cirugía o Farmacia y tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 100 euros ni superior a 500 euros.

Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además, en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo.

Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad con arreglo a las leyes.

- C) El Código de ética y deontología médica, de la Organización Médica Colegial, establece:

Artículo 10.

El médico que conociere que cualquier persona, y más aún si es menor o incapacitado, para cuya atención ha sido requerido, es objeto de malos tratos, deberá poner los medios necesarios para protegerlo y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente.

TIPOS

Básicamente, se pueden resumir en cuatro los tipos de abuso sexual infantil:

Tocamientos del adulto al niño.

Tocamientos del niño al adulto.

Atentado pederástico.

Penetración vaginal.

a) Tocamientos del adulto al niño

Estos tocamientos pueden ser realizados con los dedos, el pene o incluso utilizando cuerpos extraños, y recaen casi siempre en la región genital o anal.

Dependiendo de la violencia que se utilice y de la edad de la víctima, los tocamientos podrán producir lesiones en el menor, que habitualmente son de escasa gravedad, siendo, por otra parte frecuente, la ausencia de las mismas.

b) Tocamientos del niño al adulto

No hay que olvidar este tipo de abuso sexual, en el cual el adulto obliga al niño a realizarle tocamientos sobre sus genitales, con frecuencia obligándole a masturbarle.

Evidentemente, no quedan señales físicas en el menor, pero sí psicológicas y muy importantes.

c) Atentado pederástico

Consiste en la introducción del pene a través del ano del menor.

Es una forma de abuso sexual muy frecuente y puede ocasionar lesiones anorrectales en función de la desproporción existente entre las partes y si se ha realizado de forma brusca o contando, mediante engaño, con la permisividad del niño.

d) Penetración vaginal

Es menos frecuente. Se acompaña habitualmente de lesiones graves, por la desproporción existente entre los genitales del adulto y de la niña.

Gisbert Calabuig (1998) refiriéndose a las lesiones genitales en los casos de penetración vaginal, establece que:

En las niñas *menores de seis años*, el coito es anatómicamente imposible, pues el ángulo subpúbico es aún muy agudo, constituyendo una verdadera barrera.

En las niñas de *seis a once años*, es ya posible la cópula, pero las dimensiones de los genitales son tan reducidas que la penetración del pene de un adulto lleva aparejada la rotura del periné o incluso del tabique rectovaginal.

A partir de los *once años*, se produce la rotura del himen y si existen otras lesiones genitales su gravedad varía en función de la fuerza empleada.

INDICADORES DE ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA

No hay niño preparado psicológicamente para hacer frente al estímulo sexual.

Por un lado, el niño de dos o tres años, que no sabe que la actividad sexual a que le están sometiendo es mala, desarrollará problemas como resultado de su inhabilidad para hacer frente a la sobreestimulación.

Por otro, el niño de cinco o más años, que conoce y aprecia a la persona que está abusando de él, se siente atrapado entre el afecto, lealtad o respeto que siente hacia la misma y el conocimiento de que lo que está haciendo o sufriendo está mal.

Se pueden considerar, entre otros, como *indicadores* de que un niño está siendo objeto de abuso sexual, los siguientes:

- Demuestra conocimientos o comportamientos sexuales inusuales para su edad.
Trata de evitar todo lo de naturaleza sexual.
- Tiene dificultades para sentarse o caminar.
- Depresión o aislamiento de sus amigos y familia.
Comportamiento seductor o simula tener actividad sexual con otros compañeros menores o de su edad.
- Dice que tiene el cuerpo sucio o tiene miedo de que haya algo malo en sus genitales.
Evidencia de abusos sexuales en sus dibujos, juegos o fantasías.

Agresividad excesiva.

Cambios severos en su comportamiento.

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA

Pueden ayudar a la prevención, las siguientes consideraciones:

Hablar con el menor sobre el abuso sexual en niños.

Si en la escuela tiene un programa sobre el abuso sexual, hablar con él sobre lo que ha aprendido.

- Decirle que su cuerpo y su intimidad le pertenecen: que su cuerpo es de él. Que puede tomar decisiones sobre quién y de qué forma le puede acariciar o besar.

Enseñarle que los adultos no tienen derecho a besarle y acariciarle siempre que quieran, por el hecho de ser mayores.

Enseñarle cuáles son las partes privadas del cuerpo (las partes cubiertas por un traje de baño) y los nombres de esas partes.

Enseñarle a gritar “no” o “déjeme” a cualquier persona que le amenace sexualmente.

Escucharle cuando trate de decir algo, especialmente cuando se le haga difícil expresarlo.

El niño debe saber que está bien denunciar si alguien intenta tocarlo de una manera que le haga sentir incómodo, independientemente de quien sea el abusador.

- Decirle que puede tener confianza en nosotros y que no nos enfadaremos si nos dice algo.

Conocer a los adultos y los niños que pasan tiempo con el niño.

EXAMEN PERICIAL

El examen que el perito médico deberá efectuar sobre un menor que ha sido maltratado sexualmente, reúne unas características propias.

En primer lugar, hay que ganarse la confianza del niño. Es un ser que ha sufrido mucho y quizá sea reacio a ser reconocido.

Se debe examinar la región genital con detenimiento para buscar señales que evidencien las agresiones sufridas, aunque el examen no debe limitarse solo a esa región, sino que debe extenderse al resto del organismo: región mamaria, cara, etc.

Región anal

La existencia de lesiones en esta región, como hemos comentado anteriormente, está en función de dos factores:

La desproporción de volumen entre el objeto agresor (habitualmente el pene) y el esfínter anal.

La violencia empleada.

Se pueden encontrar lesiones anorrectales como excoriaciones, desgarros o grietas de la mucosa anal, pérdida de la disposición radiada del esfínter anal, e incluso llegar a la parálisis del mismo.

Es frecuente la existencia de escozor o dolor al andar y sobre todo al defecar, lo que da lugar en algunos niños a un estreñimiento pertinaz.

Las lesiones descritas evolucionan, por lo general, en un plazo muy breve, de ordinario menor de cinco días.

Aunque en ocasiones, cuando el niño es mayor y no ha existido violencia, sino que la penetración ha ido precedida de tentativas lentas o incluso utilizando alguna sustancia lubricante, puede no encontrarse ninguna lesión que delate el atentado cometido. En estos casos es de extrema importancia la toma de muestras en la región anal.

El tacto rectal permite explorar la tonicidad muscular y comprobar si existe una parálisis del esfínter.

Región vaginal

Puede haber una vulvovaginitis traumática, que consiste en una inflamación vulvovaginal tras tocamientos con los dedos. Existirá en este caso: dolor, tumefacción, enrojecimiento y en ocasiones flujo purulento, pudiendo incluso llegarse a producir desgarros en el himen con los dedos del agresor.

En los casos más graves, habrá lesiones importantes, como desgarros del periné o incluso del tabique rectovaginal.

Región bucal

Lo habitual es la inexistencia de lesiones a este nivel.

Es muy importante aquí, la toma de muestras.

Otras regiones (lesiones a distancia)

Hay que examinar, además de las regiones mencionadas, el resto del organismo, buscando lesiones en muslos, escroto, región mamaria, cuello, etc.

Podremos encontrar lesiones en la cara, sobre todo, alrededor de la boca, en un intento del agresor de silenciar los gritos de la víctima.

TO MA DE MUESTRAS

Desde una perspectiva médico-legal, hay que destacar la gran importancia de la toma de muestras en este tipo de agresiones.

En ocasiones, una correcta toma de muestras procedente tanto de la víctima como del presunto agresor, permitirá confirmar o descartar la autoría del mismo.

Siguiendo las “*Normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto de Toxicología*” (BOE 23/12/96)²¹, en los casos de abuso sexual, se realizarán:

1. Tomas vaginales, anales y bucales para estudio de restos de semen.
con hisopos secos y estériles;
– mediante lavado con suero fisiológico estéril.
2. Recogida de manchas de semen y pelos del agresor en las prendas de la víctima.
3. En ocasiones se recogerán muestras de sangre de la víctima y del agresor para estudio de ADN y comparar su perfil genético con el de los restos de semen.
4. Toma vaginales, anales y bucales para estudio de enfermedades de transmisión sexual.

Estas muestras deberán remitirse en recipientes adecuados y por el medio más rápido posible al laboratorio. Asimismo, también es importante que se acredite en todo momento la observación de la “Cadena de custodia” desde la toma de muestras hasta su recepción en el laboratorio.

Cuando el abuso sexual ha consistido en tocamientos del niño al adulto, o de este hacia el niño y no ha existido eyaculación, difícilmente la toma de muestras proporcionará resultados satisfactorios.

BIBLIOGRAFÍA

- American Psychiatric Association. DSM-IV-TR. *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. Barcelona: Masson, 2002.
- Arredondo V. *Guía básica de prevención del abuso sexual infantil*. ONG Paicabí. 2007.
- Bañón E. Urgencias de interés médico-legal asistidas en un hospital infantil de la ciudad de Alicante (1998). *Tesis Doctoral*. Alicante: UMH. 2003.
- Camps M, Camps M. Los delitos contra la libertad sexual en Lleida en el siglo XV. *Orfila*. 1995. 7; 87-103.
- Gisbert JA. *Medicina Legal y Toxicología*. 5 ed. Barcelona: Salvat. 1998.

- Ley de Enjuiciamiento Criminal*. Madrid: Civitas. 1997.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
- López E. *Maltrato infantil*. URL: <http://...um.es/facpsi/maltrato>. 1996.
- Mateos R. La violencia como generadora de problemas de la salud infanto-juvenil. *ARCH Argent. Pediatr*. 1997. Vol. 95.
- Medicus Mundi. *Los niños de la calle*. URL: <http://www.med.unex.es/medmund/infomundi/ncalle.html>. 1996.
- Normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto de Toxicología. BOE nº 308, de 23-diciembre-1996.
- Ontiveros J. *Maltrato infantil, entre la inocencia y el dolor*. URL: <http://www.debate.com.mx/reportajes/maltrato.htm>. 1996.
- Organización Médica Colegial. *Código de ética y deontología médica*. Madrid: Organización Médica Colegial; 1999.
- Organización Mundial de la Salud. CIE-10. (Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades). *Trastornos mentales y del comportamiento*. Madrid: Meditor, 1992.
- Rodes F. *Enfermedad mental Aspectos médico forenses*. Madrid: Díaz de Santos, 2006.
- Rodes F, Giner S, Martí Lloret JB, Moreno A, Jiménez S. Malos tratos en el ámbito familiar. *Acta Medicinae Legalis et Socialis*. 1991. vol XLI, pp 181-192.

ACTUACIÓN DEL JUEZ DE MENORES ANTE EL MENOR INFRACTOR

M^a Amparo Rubio Lucas

La importancia de la jurisdicción de menores es evidente, no solo por su finalidad educativa, como intento de dar al menor que ha cometido una infracción penal una respuesta social diferente y especializada, alejada de fines retributivos o de prevención general, sino también porque no puede negarse que cumple un papel de prevención especial, puesto que trata de evitar la reproducción de conductas delictivas futuras del menor al intentar su resocialización. De todas formas, aunque se quiera defender retóricamente la ausencia en el ámbito penal de menores de la finalidad de prevención general, no puede olvidarse que la intervención judicial se sustenta en que el menor ha cometido una infracción penal y que la ley penal no deja de ejercer una intimidación genérica sobre todas las personas.

El juez y todas las partes que intervienen en el proceso están sometidos a la observancia de un dificultoso equilibrio entre la salvaguarda de todos los derechos y garantías que deben ser aplicados en el procedimiento y la actuación tendente a conseguir el interés del menor.

No estamos hablando de un derecho penal de autor, sino de un derecho penal de hecho, más objetivo y por ello más cercano a la seguridad jurídica, en el que, sin embargo, se tiene en cuenta, de forma decisiva, la personalidad o circunstancias del menor a lo largo de todo el proceso y de cara a la determinación de la medida que, en su caso, se adopte respecto de él.

El menor infractor es el centro de la actuación de la justicia de menores y supone un principio inspirador e interpretativo de todas las disposiciones y actuaciones relacionadas con ella.

Esto quiere decir que cuando un menor es acusado de un hecho delictivo, la justicia penal de menores no se va a poner en marcha en todas las ocasiones como en el caso de los adultos, sino que la influencia del principio de oportunidad, concedido al Fiscal, va a implicar que éste valore la necesidad o no de incoar un expediente al me-

nor, siempre que esté denunciado por una falta o un delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas, para que, de esa forma, no tenga ni que pasar siquiera por las instancias judiciales, si estima que ello podría producirle más perjuicio que ayuda y, en todo caso, una vez iniciado el procedimiento el Fiscal tiene varias posibilidades de solicitar al Juez que no continúe adelante, solicitándole su archivo (sobreseimiento) o proponiendo al menor la realización de una reparación extrajudicial, en determinadas condiciones.

Además, la medida que se proponga para el menor, si se llega a la fase final de enjuiciamiento, conjugará la gravedad del delito cometido con la situación personal, familiar, escolar y social del menor, a efectos de intentar una actuación realmente educativa respecto de él. La conformidad del menor con esta medida, o al menos su falta de oposición frontal a la misma, será muy importante de cara a su éxito.

Expuesto lo precedente, comenzaré con el examen de la competencia de los Jueces de Menores: La regla general de competencia objetiva viene proclamada por el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM): “Los Jueces de Menores serán competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para hacer ejecutar las sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autónomas respecto a la protección y reforma de menores”. Añade en su apartado 2º que “Los Jueces de Menores serán asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente Ley”.

La competencia territorial, de conformidad con el apartado 3º del mencionado artículo, corresponde al Juez de Menores del lugar de comisión del hecho delictivo. En todo caso, las dudas acerca de la competencia territorial se resolverán siempre a favor de la competencia del Juez del lugar de domicilio del menor. Cuando un menor hubiere cometido hechos delictivos en varios territorios, si alguno de estos coincidiese con el lugar de su domicilio, la acumulación por conexidad se hará en favor de la Fiscalía o Juzgado de dicho domicilio. Solo si todos los hechos se hubieren cometido fuera de su lugar de domicilio tendrá aplicación directamente el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr).

En casos de coparticipación de menores en varios hechos delictivos conexos, si el domicilio de dos o más menores radicara en partidos judiciales distintos en los que hubieren sido cometidas infracciones penales, la determinación del Juzgado de menores competente por conexidad atenderá al lugar del domicilio de aquel de los menores en el que primero concurra alguno de los criterios establecidos sucesivamente en el artículo 18 de la LECr.

La instrucción del expediente de reforma de menores se encomienda al Ministerio Fiscal (exceptuándose las medidas cautelares, las diligencias restrictivas de derechos fundamentales, la declaración de secreto y la preconstitución de prueba) con el fin de que el Juez de Menores limite su actuación a ejercer la garantía última del respeto a los derechos fundamentales afectados por la investigación y a efectuar en su momento el enjuiciamiento final de la causa sin perjuicio ni sospecha de parcialidad. La participación de la autoridad judicial en esta fase del procedimiento se halla sujeta a impor-

tantes restricciones que procuran preservar su imparcialidad manteniéndolo alejado de las labores de investigación material, desplazándose la tutela judicial efectiva sobre las vicisitudes acaecidas en el desarrollo de la investigación a una fase ulterior del proceso, tras la presentación del correspondiente escrito de alegaciones de la defensa.

Llegados a este punto procede abordar el estudio de los cuatro supuestos exceptuados a que he hecho referencia con anterioridad y que suponen la intervención del Juez de Menores en la instrucción del Expediente de reforma como Juez de Garantías.

El Ministerio Fiscal o la acusación particular solicitarán del Juez, cuando lo estimen procedente, la adopción de alguna de las *medidas cautelares* previstas en la Ley: internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Para ello es necesario que concurran en el menor indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima. Así pues, se fundamentan en el *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*. Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos, valorando también las circunstancias personales y sociales del menor, la existencia de un peligro cierto de fuga, y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza.

El Juez de Menores, por lo tanto, no puede acordar de oficio medida cautelar alguna si no es instada previamente por el Ministerio Fiscal o la acusación particular. Solo pueden acordarse en caso de delitos, no de simples faltas.

En cuanto al procedimiento para su adopción, difiere según el tipo de medida que se persiga. Tratándose de internamiento, el Juez de Menores resolverá, a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, en una comparecencia a la que asistirán también el letrado del menor, las demás partes personadas, el representante del equipo técnico y el de la entidad pública de protección o reforma de menores, los cuales informarán al Juez sobre la conveniencia de la adopción de la medida solicitada en función de los criterios anteriormente expuestos. En dicha comparecencia el Ministerio Fiscal y las partes personadas podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Tratándose de medidas de libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, no se exige la celebración de una comparecencia, pero sí la preceptiva audiencia del Letrado del menor, del Equipo Técnico y de la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, audiencia que podrá verificarse por trámite escrito.

Una vez adoptada una medida cautelar de libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, podrá mantenerse hasta que recaiga sentencia firme. El tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de seis meses, y podrá prorrogarse a instancia del Mi-

nisterio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y mediante auto motivado, por otros tres meses como máximo. El Juez podrá en cualquier momento alzar la medida si entiende que han cesado los supuestos que la justificaban sin previa solicitud de parte.

Como he señalado anteriormente, las diligencias restrictivas de derechos fundamentales no pueden ser practicadas por el Fiscal y exigen la autorización del Juez de Menores mediante auto motivado, justificándose su intervención por la necesidad de dispensar sin demora una tutela efectiva de los derechos fundamentales, cuya restricción se halla constitucionalmente condicionada a la previa autorización judicial: la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 de la *Constitución*), el secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 de la *Constitución*) y la integridad e intimidad personal en ciertas actuaciones de exploración corporal (artículos 15 y 18.1 de la *Constitución*).

También se debe excepcionar de la regla general *la práctica de prueba anticipada*, por la necesidad de inmediación judicial en su producción. Por aplicación supletoria de la LECr. (Disposición Final primera de la LORPM), especialmente de sus artículos 448 y 449, las partes podrán dirigirse al Juez para anticipar cualquier prueba que por razones ajenas a su voluntad no pueda previsiblemente ser practicada en la audiencia.

Se debe acudir al Juez en fase de instrucción para solicitar, si es el caso, *la declaración de secreto de las actuaciones*. El auto judicial resultante debe ser motivado y fundarse en una necesidad acreditada de verificar la instrucción sin conocimiento inmediato del Letrado del menor, lo que convierte a esta medida en verdaderamente extraordinaria, potencialmente lesiva del derecho de defensa, y en consecuencia de uso muy restringido.

El auto habrá de efectuar una ponderación de los intereses en conflicto, de una parte el interés de la sociedad en la realización de la justicia frente a posibles maniobras del menor inculcado o de otras personas de su entorno encaminadas a ocultar o dispersar elementos de prueba; de otro, el derecho fundamental del menor a ejercer una defensa efectiva de su interés en la fase de instrucción del Expediente.

Determinadas diligencias de instrucción restrictivas de derechos, como la Intervención de comunicaciones, exigirán la simultánea declaración judicial de secreto instructorio, por lo que procede que los Fiscales soliciten dicha declaración en el mismo escrito en que insten del Juez la adopción de la diligencia restrictiva de derechos.

El propio menor o a su familia también podrán solicitar el secreto interno de las actuaciones frente a los perjudicados.

Siguiendo con la fase de instrucción, la misma se inicia con el Decreto de Incoación del Expediente de Reforma. El Fiscal debe dar traslado inmediato del mismo al Juez de Menores, incoándose las oportunas diligencias en el Juzgado de Menores. El Ministerio Fiscal requerirá al menor y a sus representantes legales para que designen Letrado en el plazo de tres días, advirtiéndoles que, de no hacerlo, aquél le será nombrado de oficio de entre los integrantes del turno de especialistas del correspondiente Colegio de Abogados. Una vez producida dicha designación, el Fiscal la comunicará al Juez de Menores.

Recibida por cualquier vía la *notitia criminis*, se incoarán en todo caso en la Fiscalía de Menores Diligencias Preliminares, las cuales pueden concluir mediante Decreto de archivo, de desistimiento de la incoación del Expediente o de incoación del Expediente de reforma.

En esta fase de Diligencias Preliminares se habrá de valorar la concurrencia de los presupuestos necesarios legalmente para acordar la incoación del Expediente de reforma, que son, desde el punto de vista fáctico, la verosimilitud de los hechos denunciados y la determinación de la identidad y edad de los partícipes en su ejecución y desde el punto de vista normativo, la tipicidad penal de la conducta denunciada.

La instrucción tiene por objeto, además del esclarecimiento de los hechos, el estudio de la personalidad del menor para alcanzar una comprensión suficiente de sus características personales, carencias educativas y necesidades de integración social. Con este fin se constituye el Equipo Técnico integrado por especialistas en las diversas ciencias del comportamiento que, bajo dependencia funcional del Ministerio Fiscal, elaboran un informe expresivo de las circunstancias psicológicas, familiares y educativas del menor, entorno social en el que vive y sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la Ley.

El informe del Equipo Técnico constituye para el Fiscal una fuente de información de uso imprescindible —aunque no vinculante— para adoptar las oportunas decisiones sobre prosecución del proceso y selección de medidas. Dicho informe participa de la naturaleza del dictamen de peritos, en cuanto emanado de un órgano imparcial al servicio de la Administración de Justicia y presenta una eficacia legal reforzada por su carácter preceptivo. Tan pronto lo reciba el Fiscal, lo debe remitir al Juez de Menores, y mediante copia, al Letrado del menor.

Se ha de incoar un Expediente por cada hecho delictivo, con independencia de que en dicho hecho haya participado un menor o varios. En este último caso el Expediente alcanzará a todos los copartícipes.

La instrucción concluye tan pronto como el Fiscal ha conseguido reunir los datos de hecho y elementos de juicio precisos para resolver sobre la prosecución del procedimiento mediante la formulación de un escrito de alegaciones, escrito que se justifica en un doble juicio de valor:

- Que la participación del menor en los hechos punibles denunciados aparezca suficientemente justificada en relación al número y calidad de las diligencias de investigación reunidas.

Que las circunstancias personales y sociales del menor aconsejen la imposición de alguna de las medidas educativas previstas en la Ley.

Si el juicio de valor sobre el fundamento fáctico de la imputación es negativo, el Fiscal, agotadas infructuosamente las posibilidades de la instrucción, ha de remitir el Expediente al Juez de Menores acompañado de propuesta de sobreseimiento y archivo en función de alguna de las causas formalizadas en los artículos 637 y 641 de la LECr.

Si lo que falla es el juicio sobre la oportunidad o necesidad de imponer al menor alguna de las medidas de corte educativo-sancionador previstas en la Ley, el Fiscal está autorizado para decretar anticipadamente la conclusión del Expediente y su remisión al Juez con solicitud de sobreseimiento y archivo, derivando hacia vías alternativas o externas al proceso la realización del fin educativo y resocializador.

El desistimiento del ejercicio de la acción lo regula el artículo 19.1 de la LORPM que autoriza al Fiscal a desistir de la continuación del Expediente cuando el hecho imputado constituya delito menos grave o falta, atendiendo en particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, siempre y cuando, de manera alternativa:

El menor se haya conciliado con la víctima.

El menor haya asumido y cumplido un compromiso satisfactorio de reparación del daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito.

El menor se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el Equipo Técnico en su informe.

A estos tres supuestos de desistimiento, el artículo 27.4 incorpora otros dos, a propuesta del Equipo Técnico:

- Que no resulte conveniente al interés del menor la continuación del Expediente por haber sido expresado suficientemente el reproche social que merece su conducta a través de los trámites ya practicados.

Que por el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos resulte inadecuada para el interés del menor cualquier intervención.

Estos supuestos de desistimiento implican renuncia a la audiencia y a la imposición de medidas de contenido sancionador-educativo en sentencia, pero no abandono de la necesaria intervención educativa que se procurará articular por medios de naturaleza extraprocesal.

El Fiscal acordará mediante Decreto la conclusión del Expediente, notificándosela al Letrado del menor y a las restantes partes personadas, y ordenará la remisión del mismo al Juez, junto con las piezas de convicción y demás efectos, y un escrito de alegaciones en el que constará la descripción de los hechos, la valoración jurídica de los mismos, el grado de participación del menor, una breve reseña de las circunstancias personales y sociales de éste, y la proposición de alguna de las medidas previstas en esta Ley, con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen y, en su caso, la exigencia de responsabilidad civil.

La recepción por el Juez de Menores del escrito de alegaciones del Fiscal, junto al Expediente, las piezas de convicción y efectos del delito, constituye uno de los presupuestos procesales necesarios para la apertura de la fase intermedia o trámite de audiencia. El Expediente remitido por el Fiscal ha de incorporarse a las diligencias abiertas con anterioridad por el Juez que, como he indicado con anterioridad, ha de iniciar aquéllas a raíz de la comunicación llevada a cabo por el Fiscal. El Expediente

ha de ser incorporado sin exclusiones, ni siquiera la de aquellos aspectos del Expediente que carecieran de toda significación procesal.

El secretario judicial dará traslado simultáneamente a quienes ejerciten la acción penal y la civil para que en un plazo común de cinco días hábiles formulen sus respectivos escritos de alegaciones y propongan las pruebas que consideren pertinentes. Evacuado este trámite, el secretario judicial dará traslado de todo lo actuado al letrado del menor y, en su caso, a los responsables civiles, para que en un plazo de cinco días hábiles formule a su vez escrito de alegaciones y proponga la prueba que considere pertinente. Así pues, la defensa del menor ha de elaborar en el plazo de cinco días el escrito de alegaciones —que habrá de comprender los mismos extremos que el escrito del Fiscal— y puede proponer la prueba que considere pertinente. Cabe la posibilidad alternativa de que ese escrito de alegaciones sirva de vehículo a la defensa para expresar su conformidad con la medida solicitada por el Fiscal, siguiendo en tal caso el trámite previsto en el artículo 32 de la LORPM. La propuesta probatoria de la defensa no conoce en el escrito de alegaciones un momento preclusivo, de suerte que puede ser reiterada en el acto de la vista, siempre que pueda ser practicada en ese momento y, claro es, previa declaración de pertinencia.

El escrito de alegaciones del Fiscal, y las alegaciones del Letrado de la defensa (y, en su caso, las alegaciones de la acusación particular, actor civil y responsables civiles) conforman con carácter provisorio los términos del debate y definen los elementos a ser tenidos en cuenta por el Juez de Menores para decidir acerca del desenlace de la fase intermedia. Las posibilidades son varias:

- El sobreseimiento del Expediente, que puede también ser acordado por el Juez de Menores pese a que por el Fiscal se haya formulado escrito de alegaciones, mediante auto motivado. El camino que conduce al sobreseimiento del Expediente puede presentar, pues, diversas direcciones. De un lado, puede tener por fundamento la petición del Fiscal (artículo 31), tanto por algunos de los supuestos previstos en la LECr, como por alguna otra de las causas contempladas por la LORPM. La resolución de sobreseimiento puede ser también consecuencia de una decisión jurisdiccional que no cuente con la petición del Fiscal en tal sentido. Forma parte del ámbito funcional reservado al Juez de Menores el control de la solidez del escrito de alegaciones del Fiscal. En tales casos, el Juez, a la vista de ese escrito de alegaciones, del escrito que contenga, en su caso, la valoración y propuesta probatoria de la acusación particular y, en fin, del escrito de alegaciones de la defensa, puede optar por cerrar las puertas de la audiencia, decretando el sobreseimiento.
- La remisión por el Juez de Menores de las actuaciones al órgano judicial competente, siempre que considere que no le corresponde el conocimiento del asunto.
- La resolución jurisdiccional también puede contener la decisión acerca de la práctica de las pruebas propuestas por el Letrado del menor y que hubieran sido denegadas por el Fiscal durante la instrucción, siempre que no puedan

celebrarse en el transcurso de la audiencia y el Juez estime que son relevantes a los efectos del proceso.

- La celebración de la audiencia. El mismo auto que decreta la apertura de la audiencia ha de contener el juicio de pertinencia acerca de las pruebas propuestas por el Fiscal, la defensa del menor y la acusación particular, en su caso, en los respectivos escritos de alegaciones.

La celebración de la audiencia constituye el momento más relevante en el procedimiento llamado a exigir responsabilidades penales al menor de edad.

Asistentes a la audiencia: aunque no existe una prohibición expresa del juicio en ausencia del menor, lo más deseable es que la escenificación de la audiencia se lleve a cabo con la presencia, entre otros, del infractor, no siendo posible la celebración de la audiencia en ausencia del menor en aquellos casos en que la petición del Fiscal en el escrito de alegaciones se refiera a una medida, cualquiera que fuera su naturaleza, de duración superior a un año y ello por aplicación supletoria del artículo 793.1 de la LECr.

La presencia del Letrado del menor constituye otro de los presupuestos indispensables para la válida celebración de la audiencia. Su exigencia es fácilmente justificable a la vista de la necesidad de posibilitar al menor de edad un adecuado ejercicio de su irrenunciable derecho de defensa.

El representante del Equipo Técnico que haya dictaminado acerca de las condiciones psicológicas, sociales y educativas del menor también ha de hallarse presente en el momento de celebración de la audiencia.,

Por lo que se refiere a los representantes legales del menor, la regla general de carácter facultativo es la de que aquellos podrán acompañar al menor, si bien el Juez podrá acordar que se excluya esa presencia, decisión que impone al Juez, con carácter previo, oír al Fiscal, al Letrado del menor y al representante del Equipo Técnico.

El acusador particular deberá acudir a la audiencia asistido de letrado. Podrán ejercer la acusación particular las personas directamente ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales si fueran menores de edad o incapaces, no siendo posible el ejercicio de la acción popular en sentido estricto.

El actor civil también deberá acudir a la audiencia. Hay que tener en cuenta que el acusador particular normalmente ejercitará la acción penal y la civil simultáneamente, pero puede ocurrir que el perjudicado o la víctima decida no personarse como acusación particular y sin embargo, al ser llamado por el Juez de Menores para ofrecerle las correspondientes acciones civiles, decida mostrarse parte en el procedimiento ejercitando dichas acciones, en cuyo caso elaborará su escrito de alegaciones solo en relación con los extremos relativos a la responsabilidad civil, y respecto de ellos acudirá a la audiencia y allí deberá limitar su informe a aquella únicamente.

También podrán asistir a la audiencia los responsables civiles. Además del menor acusado del delito, en este procedimiento van a existir otros responsables civiles que, por aplicación del artículo 61.3 de la LORRPM, son los padres o tutores del menor en

cuanto que responden solidariamente por los daños o perjuicios que haya podido causar el menor, aunque con una posible moderación. En todo caso, también podrían ser otras personas diferentes según resulte de la investigación. La inasistencia injustificada de los responsables civiles no suspenderá la audiencia.

Para que la presencia en la audiencia del representante de la entidad pública de protección o reforma de menores sea requerida, ha debido intervenir en las actuaciones de la instrucción y ello sucederá en los casos en los que con anterioridad se hayan acordado medidas cautelares o definitivas respecto del menor, con lo que se supone que tienen conocimiento del mismo y de su evolución y pueden aportar datos de interés en la audiencia.

En cuanto a la vigencia del principio de publicidad durante la celebración de las sesiones:

- La publicidad de las sesiones puede ser restringida por el Juez, no solo en interés del menor imputado sino también de la víctima.
- La LORPM (apartado 2 del artículo 35) excluye la posibilidad de que los medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor ni datos que permitan su identificación. Ello es congruente con el conjunto de textos que proclaman el derecho del menor a la intimidad. Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de menores, aprobadas por la Asamblea General el 29 de noviembre de 1985, e incluidas en el Anexo de la Resolución 40/33, en su principio general 8, apuntan que “... para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad”, añadiendo el apartado segundo que “... en principio, no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un menor delincuente”. En similar línea se expresan el artículo 16 de la Convención de Derecho del Niño de 1989 o la Recomendación R (87) 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

La conformidad del menor con los hechos que le imputa la acusación, con la medida que se le solicita y con la responsabilidad civil se puede producir en dos momentos diferentes, según se formule en el escrito de alegaciones del letrado, que preciará de la celebración de la comparecencia regulada en el artículo 36 LORPM, o al iniciarse el acto de la audiencia regulada en el artículo 37 de la citada ley, en cuyo caso se deben seguir los trámites previstos en esta comparecencia.

En el primer supuesto, el secretario judicial informará al menor expedientado, en un lenguaje comprensible y adaptado a su edad, de las medidas y responsabilidad civil solicitadas por el Ministerio Fiscal y, en su caso, la acusación particular y el actor civil, en sus escritos de alegaciones, así como de los hechos y de la causa en que se funden. El Juez seguidamente preguntará al menor si se declara autor de los hechos y si está de acuerdo con las medidas solicitadas y con la responsabilidad civil. Si mostrase su conformidad con dichos extremos, oídos el letrado del menor y la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil, el Juez podrá dictar resolución de conformidad.

Si el letrado no estuviese de acuerdo con la conformidad prestada por el propio menor, el Juez resolverá sobre la continuación o no de la audiencia, razonando esta decisión en la sentencia. Si el menor estuviere conforme con los hechos pero no con la medida solicitada, se sustanciará el trámite de la audiencia solo en lo relativo a este último extremo, practicándose la prueba propuesta a fin de determinar la aplicación de dicha medida o su sustitución por otra más adecuada al interés del menor y que haya sido propuesta por alguna de las partes. Asimismo, en el supuesto de que se haya personado en forma en el expediente un acusador particular, el menor y su letrado deberán conformarse con la medida más grave de las solicitadas en los escritos de alegaciones y de ahí que el acusador particular deba ser citado a esta comparecencia, sin perjuicio de que el menor pueda manifestarse en ella de acuerdo con los hechos y no con la medida solicitada respecto de ellos por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular, en su caso, con lo que deberá celebrarse la audiencia que se referirá únicamente a la medida a imponer al menor. Cuando el menor o la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil no estuvieren conformes con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciará el trámite de la audiencia solo en lo relativo a este último extremo, practicándose la prueba propuesta a fin de determinar el alcance de aquélla.

Cuando proceda la celebración de la audiencia, el Juez invitará al Ministerio Fiscal, a quienes hayan ejercitado, en su caso, la acción penal, al letrado del menor, y eventualmente y respecto de las cuestiones que estrictamente tengan que ver con la responsabilidad civil al actor civil y terceros responsables civilmente, a que manifesten lo que tengan por conveniente sobre la práctica de nuevas pruebas o sobre la vulneración de algún derecho fundamental en la tramitación del procedimiento o, en su caso, les pondrá de manifiesto la posibilidad de aplicar una distinta calificación o una distinta medida de las que hubieran solicitado. Dichas cuestiones previas son de lo más heterogéneo, puesto que unas pueden conducir a la nulidad de lo actuado si han producido una radical indefensión que atente contra un derecho fundamental y otras pueden desembocar simplemente en el acuerdo de la práctica de una nueva prueba que no se pudo llevar a cabo con anterioridad.

En concreto esas cuestiones serían:

- A) La vulneración de un derecho fundamental en la tramitación del procedimiento. El legislador no especifica a qué tipo de vulneración de derechos fundamentales se refiere, pero cabe entender que serán aquellos que puedan tener algún género de influencia en el desenlace del juicio, pues de otro modo no tendría ningún sentido denunciarlos en la vista. Más en concreto, la ley parece estar pensando en pruebas que pretenden hacerse valer en el juicio, obtenidas conculcando algún derecho fundamental. Y también aquellas actuaciones del instructor que hayan generado indefensión en el acusado y, consecuentemente, hayan perjudicado sus posibilidades de defensa en el juicio.
- B) La realización de manifestaciones sobre la práctica de nuevas pruebas, o sobre las ya practicadas. Las pruebas que se soliciten para su práctica en ese momento han de ser pruebas que, salvo circunstancias muy excepcionales, sean factibles de practicar en el acto del juicio oral, tal como determinó la sentencia del Tribunal Supremo 347/1994, de 16 de febrero.

La suspensión de la audiencia debe acordarse solamente cuando las pruebas propuestas en ese momento del inicio del juicio oral no pudieron serlo con anterioridad en los escritos de proposición de prueba o de calificación por motivos ajenos a la voluntad de las partes y siempre que la denegación de la suspensión y consiguiente imposibilidad de práctica de la prueba de descargo propuesta en dicho acto, pueda ocasionar indefensión.

- C) Cuestiones relativas a la competencia del órgano judicial, declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción del delito, amnistía e indulto, las cuales suponen, en caso de ser apreciadas, verdaderas objeciones a la admisibilidad del juicio.
- D) Causas de suspensión relativas al desarrollo del procedimiento o al fondo del asunto. Se regulan en los artículos 744 a 749 de la LECRIM.

Cuando se alegue por las partes alguna de estas cuestiones previas, el Juez acordará la continuación de la audiencia o la subsanación del derecho vulnerado, si así procediere. Si acordara la continuación de la audiencia, el Juez resolverá en la sentencia sobre los extremos planteados.

Si el Juez resuelve en ese momento procesal porque entiende que la audiencia no puede seguir adelante a la vista de la entidad de la cuestión previa planteada, debe hacerlo a través de un auto razonando y resolviendo las cuestiones planteadas, mientras que si entiende que debe continuar la audiencia realizará una sucinta motivación que se reflejará en el acta de la audiencia, sin perjuicio de que en la sentencia se recoja una argumentación más compleja y elaborada.

Seguidamente se iniciará la práctica de la prueba propuesta y admitida y la que, previa declaración de pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto, oyéndose, asimismo, al equipo técnico sobre las circunstancias del menor. A continuación, el Juez oirá al Ministerio Fiscal, a quien haya ejercitado en su caso la acción penal, al letrado del menor y al actor civil y terceros responsables civilmente respecto de los derechos que le asisten, sobre la valoración de la prueba, su calificación jurídica y la procedencia de las medidas propuestas; sobre este último punto, se oirá también al equipo técnico y, en su caso, a la entidad pública de protección o reforma de menores. Por último, el Juez oirá al menor, dejando el expediente visto para sentencia.

En la fase del juicio oral, llamada audiencia en el proceso penal de menores, rigen de forma acusada los principios de contradicción y de igualdad entre las partes, ya que tanto el Ministerio Fiscal como el letrado del menor o el acusador particular, en su caso, están en la misma situación a la hora de hacer alegaciones y proponer y practicar las pruebas. A su vez, el principio acusatorio implica la imposibilidad de que el Juez pueda aportar de oficio pruebas al proceso ni alterar los hechos que son el objeto del proceso.

Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictará sentencia en un plazo máximo de cinco días.

La sentencia contendrá todos los requisitos previstos en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, y en ella, valorando las pruebas practicadas, las razones expuestas

por el Ministerio Fiscal, por las partes personadas y por el letrado del menor, lo manifestado en su caso por éste, tomando en consideración las circunstancias y gravedad de los hechos, así como todos los datos debatidos sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y social del menor, la edad de éste en el momento de dictar la sentencia, y la circunstancia de que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza, resolverá sobre la medida o medidas propuestas, con indicación expresa de su contenido, duración y objetivos a alcanzar con las mismas.

La sentencia será motivada, consignando expresamente los hechos que se declaren probados y los medios probatorios de los que resulte la convicción judicial.

En la misma sentencia se resolverá sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta, con el contenido indicado en el artículo 115 del Código Penal.

También podrá ser anticipado oralmente el fallo al término de las sesiones de la audiencia, sin perjuicio de su documentación con arreglo al artículo 248.3 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Juez, al redactar la sentencia, procurará expresar sus razonamientos en un lenguaje claro y comprensible para la edad del menor.

Las medidas que se pueden imponer en Sentencia, ordenadas según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes:

- a) Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.
- b) Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro.
- c) Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.
- d) Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en el artículo 7 de la LOR-

PM. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

- e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en el artículo 7 LORPM. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

Ya se trate del internamiento terapéutico o del tratamiento ambulatorio, se contemplan dos posibles actuaciones claramente diferenciadas. Por un lado, el tratamiento de anomalías o alteraciones psíquicas y, por otro, el tratamiento de las adicciones a las bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas. En el primero de los casos, la propia patología cognitiva y volitiva obliga a prescindir de la opinión del menor —que es incapaz de prestar un verdadero consentimiento— para poder imponerle una medida de naturaleza terapéutica.

Distinto es el caso, sin embargo, del tratamiento de deshabituación a las adicciones anteriormente mencionadas, que requieren para resultar eficaces el concurso voluntario del menor en el programa de deshabituación. Por ello dispone la Ley que “cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias”.

No hace ninguna mención la Ley acerca de cuál es el momento en el que el menor puede manifestar este rechazo, y más concretamente si está contemplando una actitud de rechazo que se produzca antes de dictar sentencia o posteriormente en fase ya de ejecución. El primer supuesto es el deseable, ya que evitaría el inicio de una ejecución que finalmente ha de verse frustrada y es más respetuoso con el principio de legalidad, al ejecutarse la medida que se ha impuesto en sentencia sin tener que acudir al Expediente de modificación de medida previsto en el artículo 13 de la LORPM.

En el supuesto de rechazo sobrevenido ya en fase de ejecución, incluso una vez ya iniciado el tratamiento, éste no podrá seguirse coactivamente, habrá de ser suspendido y sustituido por otra medida.

- f) Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.
- g) Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia.

- h) Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socioeducativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes:
- 1ª Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.
 - 2ª Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.
 - 3ª Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
 - 4ª Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa.
 - 5ª Obligación de residir en un lugar determinado.
 - 6ª Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
 - 7ª Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas obligaciones implicase la imposibilidad del menor de continuar conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996.
- i) La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. Esta medida impedirá al menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal,

impedirá al menor establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996.

Si el alejamiento supone prohibición de acercarse al centro educativo donde el menor cursa estudios, debe remitirse testimonio a la Delegación de Educación, a fin de que se adopten las medidas oportunas para la escolarización del menor. Como pauta general, se adoptará conjuntamente con una medida de libertad vigilada pues, además de velar por la protección de la víctima, es necesario captar la orientación educativa de las medidas en el Derecho Penal de Menores y articularse dentro del Programa de Intervención. Si se tratara de alejamiento puro (no integrado como regla de conducta en la libertad vigilada), desde el punto de vista de control de la medida, es necesario que el Juez oficie a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin que sea necesario —dada la ausencia de contenido educativo de la medida— requerir a la Comunidad Autónoma para que lleve a efecto su ejecución y control.

- j) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el periodo de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización.

Esta medida parece carente de cualquier contenido retributivo o sancionador, y por esta razón se revela como muy apropiada —sobre todo en su modalidad de convivencia con una familia— para satisfacer posibles carencias familiares o afectivas del menor, pareciendo a simple vista más una medida de protección que de naturaleza sancionadora. Precisamente por ello, puede resultar aconsejable, en aquellos casos en que se imponga esta medida y una vez cumplido el tiempo de duración de la misma, instar de la entidad competente que acuerde la prosecución de la convivencia familiar como medida de protección, transformando la situación en un supuesto de acogimiento familiar, previsto en el artículo 173 del Código Civil.

- k) Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.
- l) Realización de tareas socioeducativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

- m) Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.
- n) Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, respectivamente.
- ñ) Inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos; así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la medida.

Las medidas de internamiento constarán de dos periodos: el primero se llevará a cabo en el centro correspondiente; el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. El equipo técnico deberá informar respecto del contenido de ambos periodos, y el Juez expresará la duración de cada uno en la sentencia.

Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo flexible, no solo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma de menores cuando éstas hubieran tenido conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con anterioridad. El Juez deberá motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma, a los efectos de la valoración del mencionado interés del menor.

El Juez podrá imponer al menor varias medidas de distinta clase por un solo hecho y una sola medida por varios hechos, pero no podrán imponerse varias medidas de la misma clase ni cuando se condene por la comisión de un hecho ni cuando se condene por varios.

Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores cabe recurso de apelación ante la correspondiente Audiencia Provincial, que se interpondrá ante el Juez que dictó aquélla en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, y se resolverá previa celebración de vista pública, salvo que en interés de la persona imputada o de la víctima, el Juez acuerde que se celebre a puerta cerrada. A la vista deberán asistir las partes y, si el Tribunal lo considera oportuno, el representante del equipo técnico y el representante de la entidad pública de protección o reforma de menores que hayan intervenido en el caso concreto. El recurrente podrá solicitar del Tribunal la práctica de la prueba que, propuesta y admitida en la instancia, no se hubiera celebrado, conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. A los Jueces de Menores les corresponde el control de dicha ejecución.

Para ejercer el control de la ejecución corresponden especialmente al Juez de Menores las funciones siguientes:

- a) Adoptar todas las decisiones que sean necesarias para proceder a la ejecución efectiva de las medidas impuestas.
- b) Resolver las propuestas de revisión de las medidas.
- c) Aprobar los programas de ejecución de las medidas.
- d) Conocer de la evolución de los menores durante el cumplimiento de las medidas a través de los informes de seguimiento de las mismas.
- e) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas para la ejecución de las medidas.
- f) Acordar lo que proceda en relación a las peticiones o quejas que puedan plantear los menores sancionados sobre el régimen, el tratamiento o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a sus derechos fundamentales.
- g) Realizar regularmente visitas a los centros y entrevistas con los menores.
- h) Formular a la entidad pública de protección o reforma de menores correspondiente las propuestas y recomendaciones que considere oportunas en relación con la organización y el régimen de ejecución de las medidas.
- i) En relación con el régimen disciplinario, resolver los recursos formulados por los menores internados o sus letrados contra las resoluciones sancionadoras.

BIBLIOGRAFÍA

Circular 1/2000, de 18 de diciembre, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores.

Circular 1/2007, sobre criterios interpretativos tras la reforma de la legislación penal de menores de 2006.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Ornosa M R. *Derecho Penal de Menores*. Madrid: Bosch. 2007.

VIOLENCIA EN LAS AULAS VÍCTIMAS O VERDUGOS

Ana Sirvent Botella, Cristina Amante García

INTRODUCCIÓN

Concepto

ué se entiende por VIOLENCIA ESCOLAR desde el ámbito judicial

Cuando estudiamos el fenómeno de la violencia escolar, observamos que cada autor o especialista elabora un concepto distinto, más o menos amplio, de qué entiende por violencia escolar, desde su propio ámbito de actuación, y es por ello que existen tantos conceptos como autores. Cuando revisamos las actuaciones en otros países para prevenir o paliar el problema, encontramos distintas realidades sociales que pueden o no extrapolarse a la nuestra propia, pero todos ellos toman como punto de partida el determinar con claridad de qué estamos hablando, qué causas lo provocan, cómo y desde qué instancias debe ser abordado, qué medidas deben tomarse tanto para prevenir la violencia como para paliarla, y qué agentes intervienen o deben intervenir en todo el proceso.

Todos estos estudios y propuestas nos enmarcan el problema dentro de un espectro más amplio que el estrictamente circunscrito a las aulas o la comunidad escolar. No podemos obviar que vivimos en una sociedad cada vez más violenta. En vez de desarrollarnos en un entorno de pacífica convivencia, como correspondería a una comunidad desarrollada y civilizada, sin embargo vemos cómo a lo largo de los últimos años y de forma cada vez más rápida y alarmante, aumentan los actos de violencia y cada vez más hablamos de distintos aspectos de la misma realidad. Así, nos referimos a la “violencia doméstica o de género”, “violencia entre iguales”, “violencia escolar”, “acoso laboral”, “acoso sexual”, “acoso escolar”, para hablar de un fenómeno cada vez más enraizado, de múltiples formas pero con un denominador común: vivimos, lo queramos ver o no, en una sociedad en la que nuestros niños y jóvenes normalizan e interiorizan la violencia como una parte más de su vida diaria, entorpeciendo su

adecuado desarrollo y condicionando su comportamiento en su forma de relacionarse con los demás, no solo con sus iguales, sino con sus padres, sus maestros y todo lo que represente “la autoridad” para ellos.

Los autores indican que existen unos factores externos (exógenos) de naturaleza socioeconómica, referidos a la intensificación de las exclusiones social, racial y de género, así como la falta de puntos de referencia entre los propios jóvenes, el crecimiento de los grupos y de las pandillas, el consumo y tráfico de drogas y el colapso de la estructura familiar (Candau, Lucinda y Nascimento, 1999; Guimar es, 1998; Belintane, 1998; Artz, 1998; Peignard, 1998; Payet, 1997; innec er, 1998). Entre las variables internas (endógenas), la literatura pone énfasis en factores como los sistemas de normas, así como en los proyectos político-pedagógicos (Hayden y Blaya, 2001; Ramogino y otros, 1997), la falta de respeto por parte de los profesores en relación con los alumnos, y de estos con aquellos, la baja calidad de la enseñanza y la escasez de recursos (Sposito, 1998; Feldman, 1998; Blaya, 2001).

Si hacemos un estudio comparativo de la realidad en otros países, coincidimos en los mismos factores, pero se incide más en una u otra realidad social. Así, Miriam Abramovay expone que la violencia escolar en América Latina está siendo identificada como un ejemplo de los fenómenos de desigualdad y de exclusión social que existen en el mundo. Los jóvenes latinoamericanos, y de manera destacada los de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, constituyen la franja de población que está más expuesta a la violencia, ya sea como víctimas, ya sea como agentes. Además de tener efecto sobre la calidad de la enseñanza y sobre el desarrollo académico, la “atmósfera violenta” de la escuela afecta el ejercicio profesional del equipo técnico-pedagógico. Ese ambiente influye en la percepción que los alumnos tienen del espacio físico de la escuela, lo que modifica la idea que ellos se hacen de la comunidad escolar y, también, la de sus impresiones sobre los propios compañeros. Un ambiente escolar hostil perjudica las relaciones entre las personas que componen la escuela (profesores, alumnos y padres, profesores y administración, alumnos y alumnos, y alumnos y administración).

Coincidimos plenamente con esta autora en que, de la violencia, todos somos víctimas. De una u otra forma, nuestras vidas cotidianas se ven alteradas y, por ese motivo, es del todo necesario fijar la atención en las experiencias que tienen la capacidad de estimular la promoción de nuevas formas de cambio y de transformación global.

En España, Juan Manuel Moreno Olmedilla, profesor titular de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, realiza un estudio que nos puede aclarar los conceptos.

Según el mentado profesor, el hecho de que las escuelas estén apareciendo más a menudo en las páginas de sucesos de los periódicos que en la sección de educación y cultura, está preocupando seriamente a todos los miembros de la comunidad educativa. En efecto, los episodios de violencia en los centros educativos parecen tener una gran capacidad de atraer a la atención pública, causando lo que hoy en día se ha dado en denominar una alta “alarma social”, con lo que la aparentemente nueva lacra de la violencia escolar se añade a las ya innumerables fuentes de demanda y presión social con que nuestros centros educativos y nuestro profesorado deben enfrentarse.

Juan Manuel Moreno se plantea, por tanto, en primer lugar, la necesidad de establecer *de qué estamos hablando exactamente cuando decimos “violencia escolar”*. El autor llega a la conclusión de que una de las primeras dificultades a las que nos enfrentamos al comenzar a analizar los fenómenos de supuesta violencia en la escuela es la de la imprecisión en el lenguaje. En efecto, no podemos considerar dentro de la misma categoría un insulto u otra falta más o menos leve de disciplina que, por ejemplo, un episodio de vandalismo o de agresión física con un arma. No obstante, existe una clara tendencia en la opinión pública y tal vez entre muchos profesores a “meter todo en el mismo saco” y a entender, de manera simplista, que se trata de manifestaciones distintas de un mismo sustrato violento que caracterizaría a los niños y jóvenes de hoy.

A pesar de ello, puesto que muchos fenómenos no pueden considerarse propiamente como violentos, entiende el referido profesor, como más inclusiva y adecuada, la expresión de comportamiento o conducta antisocial en las escuelas. Así, en su opinión, son seis los tipos o categorías de comportamiento antisocial entre los que debemos diferenciar:

- A) Disrupción en las aulas.
- B) Problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado).
- C) Maltrato entre compañeros (*bullying*).
- D) Vandalismo y daños materiales.
- E) Violencia física (agresiones, extorsiones).
- F) Acoso sexual.

La *disrupción en las aulas* constituye la preocupación más directa y la fuente de malestar más importante de los docentes. Su proyección fuera del aula es mínima, con lo que no se trata de un problema con tanta capacidad de atraer la atención pública como otros que veremos después. Cuando hablamos de disrupción nos estamos refiriendo a las situaciones de aula en que tres o cuatro alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando al profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden. Aunque de ningún modo puede hablarse de violencia en este caso, lo cierto es que la disrupción en las aulas es probablemente el fenómeno, entre todos los estudiados, que más preocupa al profesorado en el día a día de su labor, y el que más gravemente interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría de los alumnos de nuestros centros.

Las faltas o *problemas de disciplina*, normalmente en forma de conflictos de relación entre profesores y alumnos, suponen un paso más en lo que hemos denominado disrupción en el aula. En este caso, se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia —desde la resistencia o el “boicot” pasivo hasta el desafío y el insulto activo al profesorado—, que pueden desestabilizar por completo la vida cotidiana en el aula. Se trata de agresiones que “anuncian” problemas aún más graves, en el caso futuro de no atajarse con determinación y tomarse “medidas ejemplares”.

El término *bullying*, de difícil traducción al castellano con una sola palabra, se emplea en la literatura especializada para denominar los procesos de intimidación y victimización entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros de aula o de centro escolar (Ortega y Mora-Merchán, 1997). Se trata de procesos en los que uno o más alumnos acosan e intimidan a otro —víctima— a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, etc. Si bien no incluyen la violencia física, este maltrato intimidatorio puede tener lugar a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima.

El *vandalismo* y la *agresión física* son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso, contra las cosas; en el segundo, contra las personas. A pesar de ser los que más impacto tienen sobre las comunidades escolares y sobre la opinión pública en general, los datos de la investigación llevada a cabo en distintos países sugieren que no suelen ir más allá del diez por ciento del total de los casos de conducta antisocial que se registran en los centros educativos. No obstante, el aparente incremento de las extorsiones y de la presencia de armas de todo tipo en los centros escolares, son los fenómenos que han llevado a tomar las medidas más drásticas en las escuelas de muchos países.

El *acoso sexual* es, según este autor, como el *bullying*, un fenómeno o manifestación “oculta” de comportamiento antisocial. Son muy pocos los datos de que se dispone a este respecto. En países como Holanda (Mooij, 1997) o Alemania (Fun , 1997), donde se han llevado a cabo investigaciones sobre el tema, las proporciones de alumnos de secundaria obligatoria que admiten haber sufrido acoso sexual por parte de sus compañeros oscila entre el cuatro por ciento de los chicos de la muestra alemana y el 22 por ciento de las chicas holandesas.

La intervención desde la jurisdicción de menores su subsidiariedad

Esta breve introducción nos sitúa sobre lo que comúnmente se llama “violencia escolar”, sin embargo, desde el punto de vista de la tipificación jurídico legal de las conductas “violentas” de los menores hacia sus compañeros y su abordaje desde la Fiscalía de Menores de Alicante, no todo es “acoso escolar” aunque sí sea “violencia escolar”.

Esta intervención está definida, desde el punto de vista de actuación de los Fiscales de Menores, por la Instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre el acoso escolar del año 2006 y en ella se manifiesta que el primer nivel de lucha contra la violencia escolar *debe estar liderado por los profesores del centro educativo*, y que ellos deben ser los primeros destinatarios de la puesta en conocimiento del problema. El abordaje debe ser conjunto, y preferentemente desde los niveles básicos de intervención: *padres, profesores y comunidad escolar*.

El tratamiento debe ser fundamentalmente preventivo, e incluso una vez detectado un caso, cabrá adoptar distintas respuestas, en ocasiones desde el ámbito estrictamente académico. En muchos casos la reacción dentro del centro docente es suficiente para tratar el problema: medidas sancionadoras internas en el propio centro, reflexión con

el propio alumno y/o el grupo, reuniones con la familia, cambio de la organización de aula, etc.

No debe caerse en la tentación de sustraer el conflicto de su ámbito natural de resolución nos aconseja dicha Instrucción. La comunidad escolar es, en principio, y salvo los casos de mayor entidad, la más capacitada para resolver el conflicto. Por lo demás, muchos de los victimarios no habrán alcanzado los catorce años, *conditio sine qua non* para la intervención del sistema de justicia juvenil.

En cualquier caso, y desde el papel subsidiario y reactivo que a la jurisdicción de menores ha de asignarse en la lucha contra este fenómeno, se ha de partir del aparentemente elemental o superficialmente obvio principio de que ningún acto vejatorio de acoso escolar debe ser socialmente tolerado y de que los mismos, una vez conocidos por el fiscal, han de tener una respuesta adecuada desde el sistema de justicia juvenil. Desde luego, y como principios generales, ha de convenirse en que mientras “las manifestaciones más graves de acoso justifican sobradamente la intervención de la jurisdicción de menores, las derivaciones de acoso soterrado (exclusión social, poner motes, hablar mal de un compañero, esconderle cosas) tienen su campo de resolución generalmente más adecuado dentro del propio ámbito educativo escolar y familiar”.

En la Instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre el acoso escolar se indica que incluso las denuncias que hagan referencia a hechos en principio leves (faltas de amenazas, coacciones o vejaciones injustas), si se cometen con la nota de habitualidad o reiteración en el tiempo, deben dar lugar, como regla general, a la incoación de un expediente de menores, no siendo adecuado en estos casos utilizar sin más la facultad de desistimiento prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Nadie debería nunca —y menos el fiscal— ignorar o minimizar el miedo, el dolor y la angustia que un menor sometido a acoso sufre. Esencial para lograr dar una respuesta eficaz a las manifestaciones de este fenómeno ha de ser la “fluidez en la circulación de información entre las instancias con competencia en la materia: Ministerio Fiscal y responsables del centro docente”.

Aunque el artículo 3 LORPM solamente prevé la remisión de testimonio a la entidad pública de protección de menores cuando los hechos que lleguen a conocimiento del Fiscal tengan indiciariamente como *autores a menores de años*, *procederá remitir testimonio de lo actuado a la dirección del centro* donde se están produciendo los abusos, para que dentro de sus atribuciones adopte las medidas procedentes para poner fin a los abusos denunciados y proteger al menor que los está sufriendo. Por tanto, dice la Instrucción:

“No deberá el Fiscal nunca limitarse a archivar las Diligencias incoadas una vez comprobada que el menor infractor no alcanza los 14 años. Antes de tal archivo el Fiscal habrá de remitir la copia de la denuncia y documentación complementaria al centro y comprobar que el mismo ha acusado recibo.

Debe recordarse que según la mayoría de los estudios, la mayor incidencia del maltrato entre iguales se produce en el primer ciclo de secundaria, entre 12

y 14 años y, por consiguiente, en gran parte fuera del ámbito de intervención de la jurisdicción de menores.

También en los supuestos en los que se inicien actuaciones por el Fiscal y se compruebe que el menor o los menores implicados están dentro del ámbito de aplicación de la LORPM será necesario comunicar a la dirección del centro la denuncia interpuesta a los efectos internos procedentes. No cabe duda que la dirección del centro tiene mecanismos poderosos para evitar que la situación se mantenga durante la tramitación del expediente de menores”.

A estos efectos debe tenerse presente que no es infrecuente que los menores víctimas denuncien directamente ante la policía o en Fiscalía, lo que, debido a la presión ambiental y el temor a represalias, no han comunicado a sus profesores o a la dirección del centro.

Desde luego, el hecho de que se inicie un expediente en el ámbito del proceso penal juvenil no quiere decir que los responsables del centro puedan inhibirse y declinar su responsabilidad en las autoridades judiciales. Es a los centros docentes durante las horas lectivas a quienes corresponde reconducir la conducta.

8.1.3. Tipificación

Cuando con anterioridad hemos expuesto el concepto de acoso o violencia escolar que nos ofrece la literatura académica, nuestra intención era tomar conciencia de un fenómeno social que tiene múltiples caras y formas, pero en ningún modo conceptualizar el acoso escolar, desde el punto de vista jurídico penal, que nos ofrece nuestra legislación, y que es al que los Fiscales debemos atenernos. Dicho concepto, en ocasiones coincidirá con lo que coloquialmente entendemos como una situación de acoso y en otras no.

No existe ningún delito que castigue específicamente “el acoso escolar” sino que su calificación jurídica se encuentra en el artículo 173.1 Código Penal (CP) que castiga “al que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral.”

Se trata de un tipo residual que recoge todas las conductas que supongan una agresión grave a la integridad moral. Consiste en someter a la víctima, de forma intencionada, a una situación degradante de humillación e indignidad para la persona (Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 1218/2004, de 2 de noviembre). El artículo 173, menciona la Circular de la Fiscalía General, operaría como un “tipo de recogida” o “tipo de arrastre”, en el sentido de que viene a constituir una forma subsidiaria de todos los delitos en que existe como modalidad de comportamiento, un ataque contra el mismo bien jurídico protegido, que entra en juego cuando la conducta enjuiciada no pueda subsumirse en otras figuras más específicas del Código Penal que impliquen también un atentado contra la dignidad moral de otros, de las que existen numerosos ejemplos en otros títulos del Código (Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de Sevilla, sec. 41 n.º 150/2004, de 4 de marzo).

Para la STS n 81912002, de 8 de mayo, el delito del artículo 173 representa el tipo básico de las conductas incluidas dentro del Título VII del Libro 11 del Código Penal, requiriendo para su apreciación de la concurrencia de un elemento medial (“infligir a una persona un trato degradante”), y un resultado (“menoscabando gravemente su integridad moral”).

Deben concurrir tres elementos para que una conducta encaje en dicho precepto penal:

1) EL ELEMENTO MEDIAL (INFLINGIR UN TRATO DEGRADANTE)

En lo que hace al trato degradante, desde el punto de vista de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cabe señalar que en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) de 18 de enero de 1978 (caso Irlanda contra Reino Unido) se considera que el concepto de malos tratos o tortura estipulado se refiere *solo a los casos que revisten una cierta gravedad*, y que esta gravedad mínima ha de estimarse de acuerdo con las circunstancias del caso y de la víctima.

El trato en sí mismo no será degradante, salvo que la persona afectada haya sufrido, ya a los ojos de los demás, ya en sus propios ojos, humillación o degradación alcanzando unos niveles mínimos de severidad. Por tanto, integran este tipo tanto las conductas aisladas que, por su naturaleza, tienen entidad suficiente para producir un menoscabo grave de la integridad moral de la víctima, cuanto de aquellas otras que, si bien aisladamente consideradas no rebasarían el umbral exigido para este delito, sin embargo en tanto que reiteradas o sistemáticas, realizadas habitualmente y consideradas en conjunto, terminan produciendo dicho menoscabo grave.

2) EL RESULTADO (MENOSCABO GRAVE DE LA INTEGRIDAD MORAL)

Cuando no estamos ante un menoscabo grave, atendidas las circunstancias de cada caso, estaremos ante la falta del artículo 620.2º CP: “los que causaren a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta”, pero no ante el delito del artículo 173.1 CP, siempre que no sean reiteradas por las exigencias de tipicidad, y por los principios de *lex certa* y *lex stricta*, teniendo presente el carácter fragmentario del derecho penal.

El resultado típico debe ser un menoscabo de la integridad moral, como bien jurídico protegido por la norma, que se configura como valor autónomo, independiente de otros derechos (STS n 1218/2004, de 2 de noviembre), en especial del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad o al honor, radicando su esencia en la necesidad de proteger la inviolabilidad de la persona (STS n 819/2002, de 8 de mayo).

3) INTEGRIDAD MORAL

En lo referente al concepto de integridad moral, ha de delimitarse, fundamentalmente, desde la idea de la *inviolabilidad de la personalidad humana en el derecho a ser tratado como uno mismo, como un ser humano libre y nunca como un simple objeto, o si se prefiere, podría hablarse de la incolumidad personal o de su inviolabilidad*.

En cualquier caso, no se requiere que este quebranto grave se integre en el concepto de lesión psíquica, cuya subsunción se encuentra en los tipos penales de las lesiones.

A pesar de todo lo expuesto desde el punto de vista legal, no podemos olvidar dos cuestiones: la primera es que el tipo penal al que nos referimos (artículo 173 CP) se encuentra incluido dentro del título “de las torturas y de otros delitos contra la integridad moral”, por lo que la entidad de las acciones debe ser grave y persistente; pero, por otra parte, tampoco debemos obviar que estaremos ante víctimas y agresores menores de edad y que la vivencia de las primeras y la percepción de los segundos será muy distinta a la que nos encontraríamos si en ambos casos estuviéramos ante personas adultas.

atálo o de conductas

En este sentido se ha considerado incluido en el tipo descrito en el artículo 173 CP el *acoso telefónico, escrito y personal* que excede con mucho la gravedad del injusto que puede ser abarcada por la falta del artículo 620.2 CP, ni siquiera con el carácter de continuada.

También nos encontramos en la Fiscalía de Menores, con más frecuencia, supuestos en que, dado el dominio de la *informática* por parte de los menores, fotografían a la víctima, distorsionan su imagen y la “cuelgan” en Internet, para escarnio de la misma y burla del resto del mundo que tiene acceso a ella. Las manipulaciones suelen tener contenido sexual, frases insultantes, y en estas acciones, intervienen tanto chicos como chicas.

Las *grabaciones* en móvil y publicación de las mismas, bien sean de agresiones o de actos vejatorios.

La *novatada* que incluya actos humillantes.

Todo ello, además de las conductas que conlleven la reiteración de actos vejatorios como insultos, aislamiento, agresiones continuadas, que pueden encajar en el tipo penal descrito anteriormente.

Debemos tener en cuenta que conforme al artículo 177 CP, si además del atentado a la integridad moral penado en el artículo 173.1 CP, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente por los delitos o faltas cometidos, excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley.

Con frecuencia nos encontramos con que los menores lo que cometen son acciones que encajan en el delito de *robo con intimidación o violencia del artículo 172 CP*, al solicitar bajo amenazas o con agresiones físicas la entrega de distintas cantidades de dinero, el móvil, el bocadillo, el bonobús u otros efectos. En estos supuestos no estamos ante un supuesto de acoso escolar, ya que no es la intención del menor humillar a su víctima, o al menos no fundamentalmente, sino que lo que quiere es sacar un beneficio con su acción.

En la mayoría de las denuncias que tienen entrada en la Fiscalía de Menores de Alicante, estamos ante agresiones físicas o verbales y otro tipo de acciones puntuales entre alumnos, dentro y fuera de las aulas, que tienen su encaje jurídico penal en otras infracciones penales, pero no en el delito de “tratos degradantes”.

Aparte de los delitos y faltas de lesiones, que son los más frecuentes, también existen conductas que se dan en el ámbito escolar o entre iguales y que integran un ilícito penal, como pueden ser:

- FALTA O DELITO DE AMENAZA

Artículo 620 1º y 2º CP

Artículo 169 CP

“El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico serán castigados.”

Se entienden estas conductas agravadas cuando se exige cantidad o se impone condición, aunque no sea ilícita y se consiga su propósito y cuando se hacen por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o reproducción.

- DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN

Artículo 197 CP

“El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, grabación, o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación...”

- FALTA O DELITO DE DAÑOS: Artículo 625 y artículo 263 CP

- INDUCCIÓN AL SUICIDIO

La Circular de la Fiscalía General sobre el acoso escolar también estudia de forma diferenciada este tipo penal. Así, menciona expresamente el artículo 143.1 CP que castiga “al que induzca al suicidio de otro”. No es desgraciadamente descartable, refiere la circular, que los supuestos graves de acoso escolar puedan desembocar en el suicidio de los menores acosados. Sin embargo, para mantener una acusación y fundamentar una sentencia condenatoria por este tipo delictivo, no será suficiente con que pueda llegar a demostrarse la relación de causalidad entre los actos de acoso y el resultado suicidio. La acción del inductor ha de incidir sobre alguien que previamente no está decidido a cometer la infracción.

Por tanto, no integra este tipo penal la conducta consistente en “forzar al suicidio”, y así el que fuerza cometería un delito de *homicidio o de asesinato*

del artículo o CP, y si no es imputable tal acción a título de dolo, podrá ser castigado como *homicidio imprudente del art CP*

Es decir, si una persona no tiene la intención de suicidarse, el hecho de que finalmente cometa tal acto y que ello sea debido al acoso escolar que haya venido sufriendo no deriva en que los autores de dicho acoso sean autores de una inducción al suicidio, sino que, si con sus acciones han forzado a su víctima al suicidio, serían responsables de un delito de homicidio doloso u imprudente, si pudieron prever que su grave conducta desencadenara el suicidio de la víctima.

En la Fiscalía de Menores de Alicante no nos hemos encontrado con esta situación “forzar al suicidio”, aunque no es infrecuente que las víctimas hayan precisado de tratamiento psicológico y psiquiátrico con episodios de autolisis.

cciones de los menores acia los ro esores

Como hemos hecho referencia con anterioridad, la violencia escolar influye en toda la comunidad escolar y por tanto también los profesores pueden y de hecho son, víctimas de “acoso” por parte de los alumnos.

Estas conductas podrían encajar en el mismo tipo delictivo del artículo 173.1º CP. Los hechos denunciados suelen ser daños en bienes propios del profesor, amenazas, llamadas telefónicas, campañas de desprestigio..., pero cuando se trata de una agresión de un menor hacia un profesor estamos ante un delito de ATENTADO.

ART C LO CP “los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios p blicos o empleen fuerza contra ellos, les intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.

Como se deriva del precepto legal, no solo las agresiones físicas, sino la intimidación o la resistencia grave tienen su encaje en este tipo penal.

Consideramos no solo a los docentes, sino también a los conserjes de los centros escolares o públicos y a todo a aquel funcionario que en el ejercicio de sus funciones es sujeto pasivo de estas conductas cometidas por los menores.

utor a

En la mayoría de los supuestos de violencia escolar el autor actúa en grupo:

- El *acosador* es el que toma la iniciativa y adopta un papel activo.
- El *seguidor*: no toma la iniciativa pero adopta un papel activo, uniéndose al anterior.
- El *seguidor pasivo*: apoya el acoso, pero no adopta un papel activo.
- El *que lo aprueba*, pero no lo dice abiertamente.

Los tres primeros son autores del delito: ya que aunque no se realice la acción directa, todos refuerzan, solo con su mera presencia, el que se consiga el resultado. Actuando en grupo todos sus componentes están de acuerdo, aprueban la acción y la refuerzan.

Por último, no podemos olvidar a “los espectadores”, que son también víctimas al observar las acciones violentas o degradantes dirigidas a sus compañeros, vivirlas como tales, y “normalizarlas”.

REALIDAD DE LA FISCALÍA DE MENORES DE ALICANTE

Datos

delitos

Los datos relacionados con el acoso escolar que constan en la Fiscalía de Menores y referidos todos ellos a los años 2007 y 2008 se exponen a continuación. Para entender la magnitud o no del problema, se realiza en primer lugar una comparativa general por tipos de delitos. Solo queremos hacer una llamada de atención: si se observan todos los delitos en los que se emplea cualquier manifestación de la violencia, se concluye que el porcentaje de estos es mayoritario (lesiones, violencia doméstica y de género, violencia escolar, delitos contra la libertad sexual, delitos de robo con violencia o intimidación). Ello nos confirma la reflexión, sin más pretensiones, que realizábamos con anterioridad. No puede abordarse la violencia escolar como un fenómeno aislado sino que se integra dentro de la violencia con mayúsculas en la que los menores, sean sujetos activos o pasivos de la misma, se ven inmersos y de la que al final todos ellos son víctimas, y además ese fenómeno no se mantiene ni disminuye sino que se incrementa año tras año.

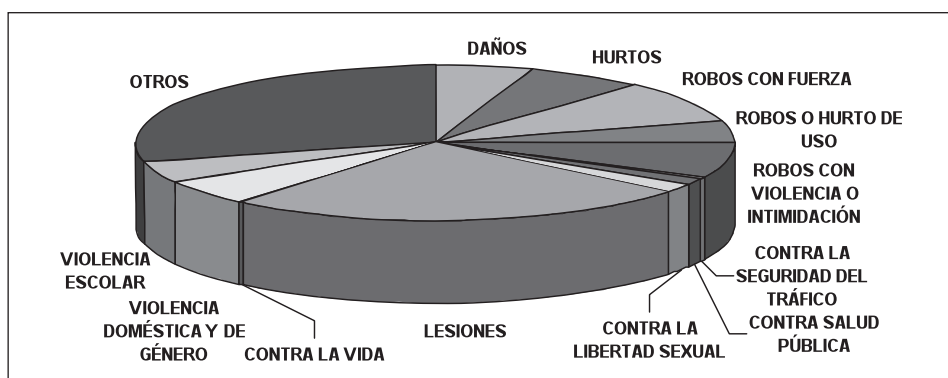
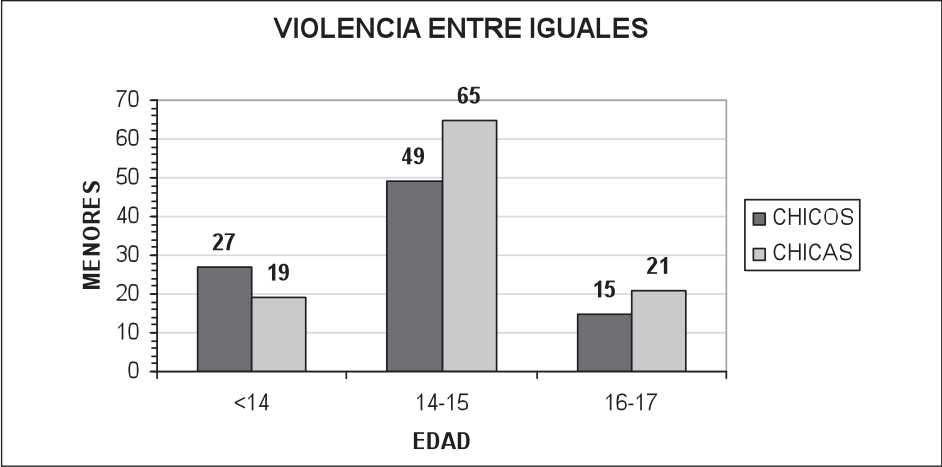


Figura Comparativa general por tipos de delitos del año 2008.

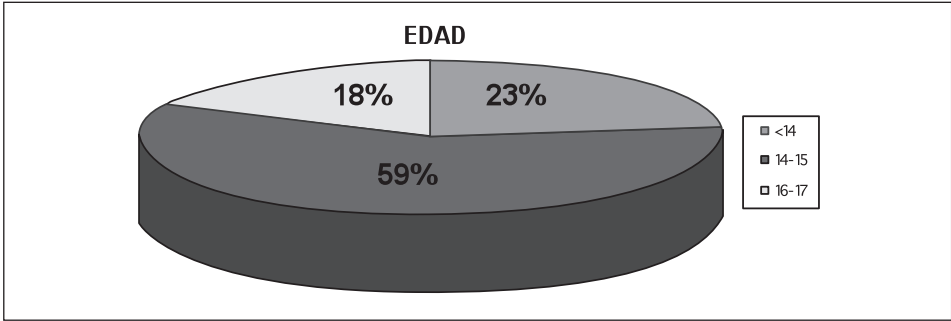
Si realizamos un análisis en el tiempo en la Jurisdicción de Menores de Alicante, lo que nos encontramos es un incremento de delitos violentos y de la violencia en los delitos.

Específicamente en casos sobre violencia entre iguales y violencia doméstica y de género, las cifras de la Fiscalía de Menores de Alicante, son las siguientes:

Ta la Porcentaje de delitos de violencia entre iguales por sexo y edad.



El rango de edad menos conflictivo es el de 16 a 17, siendo el más violento el de 14 a 15 años, es decir, decrece la violencia entre iguales con la edad. El 23 de los delitos de violencia entre iguales son cometidos por menores de 14 años (inimputables) y derivados para intervención a instancias protectoras.



Fi ura Porcentaje de delitos de violencia entre iguales por edades.

Existe un aumento en los últimos meses de asuntos protagonizados por chicas, contradiciendo las cifras de anteriores años, y la norma general de mayor presencia de chicos expedientados, actuando mayoritariamente en grupo. Hasta ahora veíamos que la violencia empleada por chicos y chicas presentaba características diferentes. Las chicas solían ser más sutiles (violencia verbal y a través de rumores o Internet) y los chicos más directos, empleando la violencia física. Sin embargo, este aspecto ha dejado de ser “típico”, ya que la agresividad de las menores se iguala hasta superarla, como puede observarse en el siguiente gráfico.

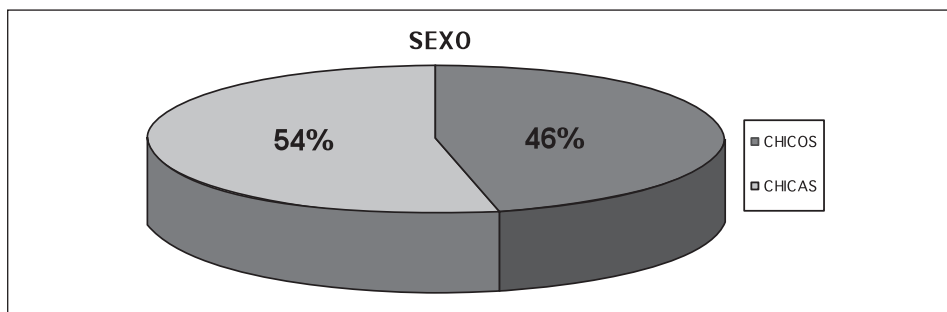


Figura 1. Porcentaje de delitos de violencia entre iguales por sexo.

Problemática detectada

Nuestro planteamiento de trabajo surge en un caldo de cultivo muy concreto, cuyos ingredientes son:

La sensación de impunidad que presentan nuestros menores está generando consecuencias cada vez peores. De hecho, la modificación de la LORPM, la Ley Orgánica 8/2006, responde en parte a la “alarma social” que han producido los incidentes protagonizados por menores en los últimos tiempos y por la “sensación de impunidad” que presentan ante sus conductas antisociales. Están prescribiendo expedientes por “ser leves” y no disponer de recursos suficientes para atenderlos. Si no actuamos en estos asuntos de una forma inmediata, de tal manera que no prescriban antes de ser juzgados, la sensación de “impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentes cometidas por estos menores” seguirá creciendo, sobre todo porque el menor “ve que no pasa nada”, sigue cometiendo hechos y cuando se le llega a juzgar, tiene tal historial delictivo que, atendiendo a la reincidencia, probablemente se le imponga un internamiento como primera medida. Si tiene suerte, se irá con una medida de Libertad Vigilada, que probablemente no iniciará por estar en lista de espera y al cabo del tiempo se reforzará de nuevo la sensación de impunidad, haciendo la creencia más fuerte e interiorizada, reincidiendo de nuevo.

Todo ello va en detrimento del “interés superior del menor”, que es el principio inspirador de la Ley de responsabilidad penal del menor, salvo en los supuestos que señala el artículo 10, en el que se aplican reglas especiales por tratarse de delitos graves (homicidio, agresión sexual del artículo 179 y 180, y delitos de terrorismo y cualquier otro que tenga señalada pena superior a 15 años), o cometidos por bandas, en los que la medida es retributiva, punitiva además de ser educativa, ya que en estos supuestos necesariamente el Fiscal de Menores debe solicitar medidas de internamiento en régimen cerrado y el Juez de Menores debe imponerla, limitándose su discrecionalidad.

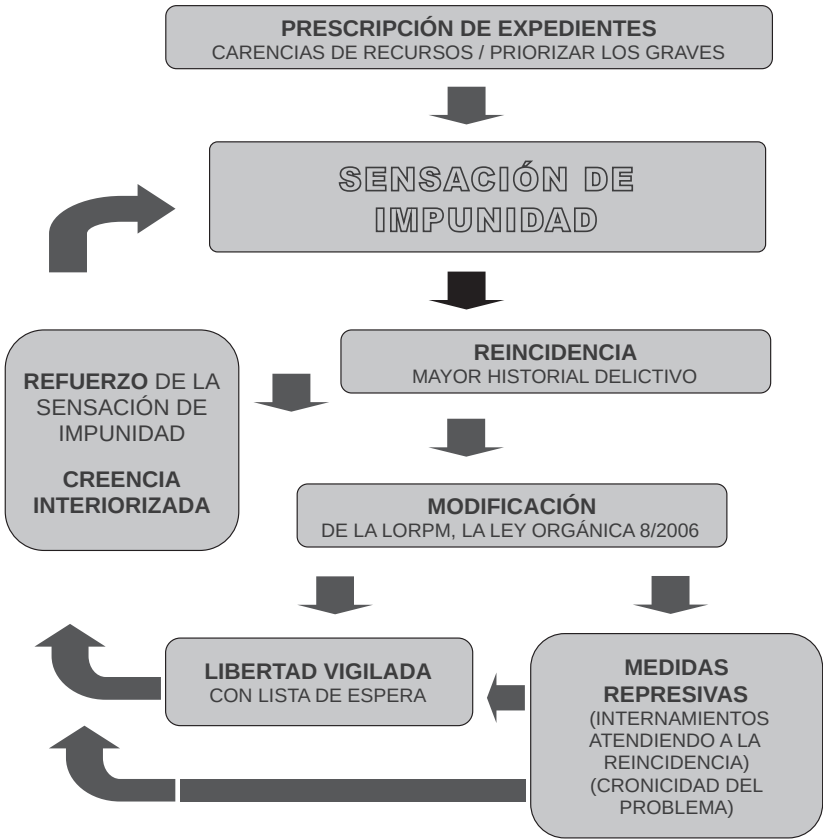
En Justicia Juvenil de Alicante nos encontramos, además, con un incremento de conductas violentas de menores en todos los ámbitos de su vida: en el escolar (compañeros y profesores), en el familiar (parejas y padres/hermanos), con el grupo de iguales, e inevitablemente aunque de forma indirecta, hacia sí mismos.

Pero lo que más nos preocupa es el *aumento de violencia* en los delitos.

A su vez, existe un incremento desmesurado de denuncias a nivel general y en particular de acoso (tratos degradantes) y de maltrato (familiar y de género). Están llegando denuncias “preventivas” de hechos puntuales, pero que, por miedo de los padres a que se trasformen en agresiones continuadas, “por si pudiera convertirse en algo habitual”, lo denuncian. La cultura de la denuncia ayuda y es aprendida a través de los medios, “todo se resuelve en los Tribunales”.

En caso de acoso escolar en concreto, lejos de plantearse enseñar a los niños a resolver los conflictos mediando entre ellos, se procede a la exigencia de la “judicialización del agresor”, no ayudando a que todos los que han intervenido en el conflicto asuman la responsabilidad que les corresponda sobre lo ocurrido. A su vez, los menores acosados se convierten en acosadores, aumentando la violencia en sus acciones. Les estamos enseñando algo a las víctimas.

Y a los agresores, ¿les estamos enseñando algo?



Fi ura Diagrama de flujos de la retroalimentación de la impunidad.

En casos de violencia intrafamiliar, la primera opción de los padres es la denuncia, delegando la responsabilidad en un tercero, el juez. ¿Le estamos enseñando algo al agresor?



Figura 1. Relación entre la impunidad y el aumento de la violencia.

PLANTEAMIENTO DE TRABAJO

8.3.1. Reorganización en equipos fiscales

Sobre el mes de julio de 2006, la Fiscalía de Menores de Alicante decide reorganizarse en Equipos Fiscales. Esto significa un cambio radial en el funcionamiento de los Equipos Técnicos.

Cada fiscal cuenta, a lo largo de todo el proceso judicial, con su Equipo Técnico (ET) (o parte de él, pero siempre el mismo), compuesto por un psicólogo, un trabajador social, y si hay suerte, por un educador. Es decir, los Equipos Fiscales comparten guardias y unifican agendas. Esto posibilita:

- *trabajo en equipo* partimos de un trabajo interdisciplinar y multiprofesional, no solo porque los Equipos Técnicos estén compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y/o educadores, sino también porque intervienen otras figu-

ras profesionales, que deben seguir el mismo criterio de intervención, para no generar actuaciones contradictorias e incoherentes que faciliten una involución en el cambio del menor. Fue necesario, por tanto, la definición de funciones, la diferenciación de criterios, jurídicos y educativos, y la unificación de filosofía de intervención y metodología de trabajo.

- *na intervención inmediata* la posibilidad de asistir permanentemente al fiscal durante la guardia posibilita un trabajo educativo inmediato al hecho delictivo, no solo en los casos urgentes por la gravedad de los hechos (medidas cautelares), sino también en los casos leves que por su pronta prescripción requieren de dicha intervención. Esto se vería beneficiado si las guardias fueran de 24 horas.

8.3.2. Implicación y filosofía de los profesionales

Es importante hacer referencia a la actitud del profesional ante el problema, porque “lo que pensamos condiciona lo que hacemos”. En este sentido, señalar que partimos de las siguientes premisas:

- *Creemos en el carácter educativo de la ley.* La línea de intervención psicoeducativa del ET siempre ha sido el que el menor llegue a asumir su responsabilidad en el hecho protagonizado, y que se establezcan, en la medida de lo posible, las causas que generaron la comisión del mismo. Con este objeto, abogamos por las llamadas medidas alternativas, como son, tareas socioeducativas, reparación de daños o conciliación con la víctima. Medidas estas recogidas en la Ley que rige nuestra intervención. Subyace, por tanto, el criterio pedagógico de la *responsabilización, ser consciente y responsable de los actos propios y de sus consecuencias, para sí mismo y para los demás*. Haciendo valer dicho criterio, la Mediación está contemplada en la LO 5/2000 para ser utilizada.
- *Creemos en lo que hacemos y luchamos por ello.* Hemos buscado alternativas a las dificultades.
- *Creemos que la educación es el medio para conseguir el cambio.* Educación no solo para los chavales, sino también para el resto de la sociedad, incluidos todos nosotros: profesores, padres, profesionales y políticos...

Desde el Equipo Técnico pensamos que no podemos caer en la simplificación de reducir el abordaje de los menores mediante medidas puramente represivas, y menos aún a su tratamiento centrado en la jurisdicción de menores, pues este enfoque simplista puede llevar a un enquistamiento del problema.

El abordaje de la conducta violenta y delincencial de los jóvenes debe ser global, y preferentemente desde *los niveles básicos de socialización*. No podemos olvidar que la Mediación es uno de los posibles sistemas de resolución de conflictos, que permite la LO 5/2000, abogando por una justicia restaurativa.

Ta la Comparativa entre justicia restaurativa y justicia tradicional.

usticia REACTIVA	usticia PREVENTIVA
Delito VIOLACIÓN NORMA	Delito EXPRESIÓN CONFLICTO
Respuesta RETRIBUTIVA	Respuesta RESPONSABILIDAD
CASTIGA	COMPENSA, REPARA
IMPONE	MEDIA
EXCLUYE	REINTEGRA
PRINCIPIO LEGALIDAD	PRINCIPIO OPORTUNIDAD, INTERVENCIÓN JUDICIAL MÍNIMA

La LORPM y el RLORPM encargan al Equipo Técnico de la Fiscalía y Juzgados de Menores las funciones de mediación.

Nuestra responsabilidad: la reorganización en Equipos Fiscales nos permite actuar de forma inmediata al conflicto-delito, es decir, atender en el momento de la guardia las faltas y delitos más leves y valorar entonces las condiciones generales para valorar la viabilidad de llevar a cabo una mediación. Lo ideal sería que el menor saliera de nuestra entrevista con la actividad socioeducativa, o la reparación directa o indirecta definida (la conciliación tiene otro tratamiento por tener una naturaleza distinta). Para ello es necesario:

- Conocimiento y acceso a recursos en la misma localidad que vive el menor, que fueran susceptibles de ser utilizados de forma rápida y acorde a los delitos cometidos.
- Seguro de responsabilidad civil de los chavales.

Aquí entra la responsabilidad compartida con los municipios, *niveles básicos de socialización*.

Ya desde la *Constitución Española* o el Estatuto de Autonomía se les atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad y funciones en cuanto a la reinserción social y la intervención con menores, entre muchas otras.

Distintas leyes se desarrollan para dar cobertura, como por ejemplo, la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, donde su artículo 24 refleja que “el Ayuntamiento tiene competencias en la prestación de Servicios Sociales de promoción y reinserción social” o según el artículo 22 de la Ley 5/97,

de 25 de junio, por la que se regula el sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se articulará un sistema de servicios sociosanitarios para la prevención y tratamiento de todo tipo de drogodependencias y la reinserción social.

Concretamente, en el ámbito de las drogodependencias, según el Decreto 1/2003, 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, en su artículo 2 g), la prevención es el conjunto diverso de actuaciones encaminadas a eliminar o modificar los factores de riesgo asociados al consumo de drogas o a otras conductas adictivas, con la finalidad de evitar que éstas se produzcan, se retrase su inicio o bien, no se conviertan en un problema para la persona o su entorno social. En su artículo 3.1) señala, a su vez, como principios rectores de la actuación en materia de drogodependencias, entre otros, *la responsabilidad p blica y la coordinación institucional de actuaciones*.

En su artículo 4 define como medidas preventivas entre otras, informar sobre las sustancias y conductas que pueden generar dependencia, sus efectos y las consecuencias de su consumo; modificar actitudes y comportamientos, intervenir en los factores de riesgo individuales familiares y sociales; educar a las personas consumidoras.

En su artículo 43 establece que son *competencias de los Ayuntamientos*, entre otras: la aprobación y ejecución de un Plan Municipal sobre Drogodependencias, elaborado en coordinación y de conformidad con los criterios establecidos en el Plan Autonómico sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, que incluya programas de prevención e inserción social; la información, asesoramiento y motivación de drogodependientes; y la coordinación de los programas preventivos y de reinserción social que se desarrollen en su municipio.

Por otra parte, los BENEFICIOS que aporta este tipo de medidas a los municipios son:

- Intervención inmediata en los asuntos judiciales de menores. Tanto desde Justicia juvenil (mayores de 14), como en los casos cometidos por menores de 14 años, cuando acompañan a mayores, en colaboración con los Equipos Sociales de base (SS.SS.).
- Disminución y eliminación de la sensación de indefensión en la población en general.
- Disminución y eliminación de la sensación de impunidad en la población infanto-juvenil.
- Responsabilización de nuestros jóvenes en los hechos cometidos.
- Prevención de la violencia juvenil, tanto primaria como secundaria.
- Optimización de recursos municipales.
- Entre otros...

Con ello se consigue:

- Una respuesta rápida y efectiva ante la conducta desadaptada (en menos de un mes se resuelve el expediente).
- Una respuesta acorde y educativa (caso de Cruz Roja).
- Que no pasen a Audiencia asuntos que pueden resolverse de forma extrajudicial.
- Descongestionar Juzgados, medio abierto y centros.
- Optimizar los pocos recursos existentes, haciéndolos eficaces y eficientes.
- Y lo más importante, que se asuman las responsabilidades desde los niveles básicos de socialización.

Coordinación con el PREVI

Con todo ello y ante la existencia del Plan para la Prevención de la Violencia escolar de la Comunidad Valenciana, se tuvo un encuentro con la Dirección Territorial de Educación, cuyos planteamientos eran coincidentes con los nuestros. Además de prevenir, lo deseable era una coordinación entre todos, para abordar el problema, llegándose a un acuerdo de colaboración cuyo esquema de actuación es el siguiente:

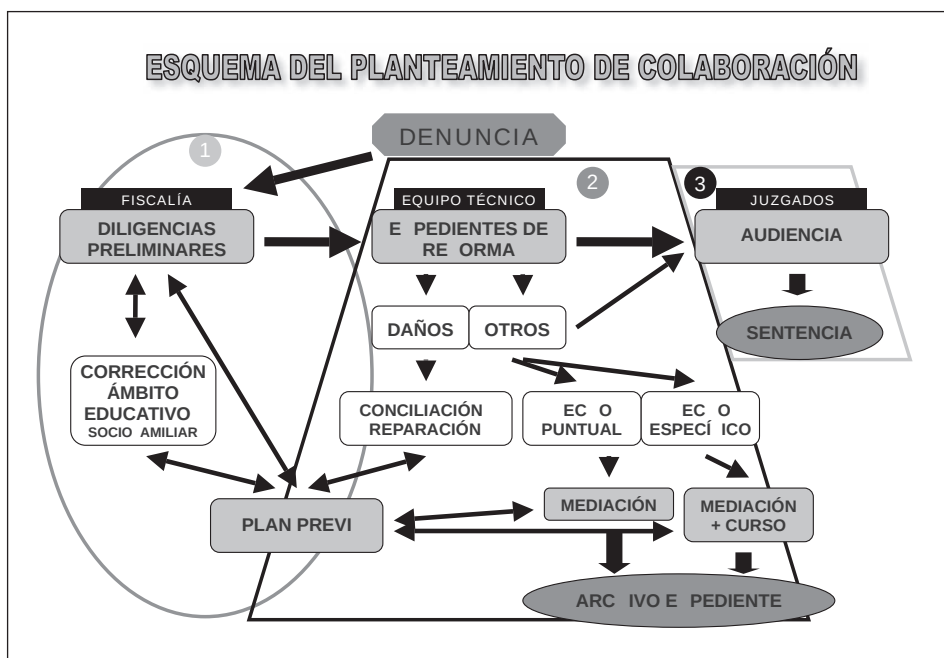


Figura Esquema de la metodología de trabajo en la Fiscalía de Menores.

Nos encontramos con los tres grupos de casos, que podemos denominar:

1. DILIGENCIAS PRELIMINARES. Desistimientos del artículo 18 LRPM.
2. EXPEDIENTES DE REFORMA. Desistimiento del artículo 19 LRPM.
3. AUDIENCIA. Enjuiciados.

8.3.4. La intervención en las distintas fases procesales

La forma de actuar es la siguiente:

- Cuando se recibe una denuncia por hechos en los que el conflicto se da entre escolares, sea en el propio centro escolar o fuera del mismo, pero entre compañeros:

se incoan las correspondientes Diligencias Preliminares (a efectos únicamente de poder efectuar un seguimiento de los asuntos de esta naturaleza se registran siempre como delito de “tratos degradantes”, aunque finalmente la correcta calificación de los hechos sea un delito o falta de amenazas o de lesiones, daños...

se da traslado a la Dirección Territorial de Educación (DTE) a través del Plan PREVI para que tenga conocimiento de los hechos denunciados;

se solicita igualmente informe al centro escolar sobre las medidas adoptadas si las ha habido;

se recibe exploración a todos los implicados, siempre que sean mayores de 14 años y menores de 18 años;

en el supuesto de que sean menores de 14 años, se procede a la misma notificación al centro escolar y a la DTE, remitiendo a ésta el decreto de archivo. También se remite testimonio de las actuaciones a la entidad pública y se valora la conveniencia de incoar expediente de protección.

- En el supuesto de que sea un hecho puntual no grave: tras recibir el informe anterior:
 - Si se ha actuado y resuelto el conflicto desde el ámbito escolar, se procede al desistimiento de las Diligencias preliminares incoadas, según el artículo 18 LRPM, notificando a los implicados.

En caso contrario se incoa Expediente, y se intenta una mediación desde el Equipo Técnico de la Fiscalía y si es satisfactoria, también se desiste de la continuación del Expediente, según el artículo 19 y 27 LO 5/2000

- En ambos casos se comunica el archivo a la DTE.

Así, una vez recibido el informe del centro escolar o del Plan PREVI sobre la *resolución positiva* del conflicto, o aquello denunciado, y tras la exploración realizada en la Fiscalía de Menores de Alicante de la víctima y del menor expedientado, el Fiscal se plantea el *desistir o no incoar* el expediente. Para ello es necesaria una coordinación estrecha con el Plan PREVI, para dar mayor celeridad a los asuntos y trabajar la intervención preventiva y desjudicialización de asuntos.

- En caso de no conseguirse la mediación o cuando los hechos son graves y necesitan de intervención y de respuesta, se realiza el informe por el Equipo Técnico, que orientará la medida más educativa para el menor.

Para aclarar la forma de actuación conviene saber a qué nos referimos cuando hablamos de

1. *Diligencias preliminares.* Los artículos 18 y 19 de la LORPM conceden muy amplias facultades al Ministerio Fiscal para no incoar el expediente o para el archivo del expediente. Así, puede desistir de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar (artículo 18).
2. *Expedientes de reforma.* Existen una serie de denuncias en que, si bien son delitos o faltas, los menores reúnen las condiciones necesarias para poder llevar a cabo una mediación: actividades socioeducativas, reparación o conciliación. En estos casos, el Ministerio Fiscal ha decidido incoar expediente y nos solicita informe al Equipo Técnico. Esta solicitud se hace en el momento de guardia, cuando se valora que existen las condiciones para poder realizar una mediación. Es decir, probablemente han pasado escasos días desde la comisión del hecho. En este grupo de casos nos podemos encontrar tanto hechos tipificados como daños (pintadas, destrozos...), como lesiones (hecho puntual), como tratos degradantes o acoso leves, como violencia de género o maltrato familiar... Es importante separar el hecho puntual del acoso, así como distinguir las peleas de las agresiones. Es también muy importante aquí la colaboración con el Plan PREVI, puesto que habrán casos que sean *devueltos de nuevo al medio escolar, para la realización de dicha mediación* tras la valoración del Equipo Técnico del Juzgado, *devolviéndoles con ello la autoridad perdida y el control* sobre lo sucedido, necesario para poder seguir haciendo educación.

En ocasiones *no se consigue la resolución* del caso en su medio natural, el *centro escolar* y se “necesita un punto judicial” para zanjarlo. Normalmente son los padres los que se empeñan en judicializar el asunto, y es con ellos con los que tenemos que trabajar para poder realizar adecuadamente la mediación, puesto que sus hijos son capaces de asumir la responsabilidad que les corresponde sobre lo sucedido y tienen disposición para “reparar el daño”, dándoles, en muchas ocasiones, *una lección de resolución de conflictos a sus padres.*

A su vez, el curso sobre valores que en ocasiones se valora conveniente como complemento a la mediación realizada, se hace en colaboración con el Plan PREVI, utilizando su material, aunque en la actualidad lo imparten varios me-

nores que tienen como actividad educativa la realización de dicho taller y la exposición ante sus compañeros. Una vez *finalizada la mediación*, ya sea en el medio escolar como en la antesala del judicial, la fiscal puede *sobreseer y archivar* el expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima (artículo 19).

3. *Audiencia*. Por otra parte, los casos en los que realmente existe una conducta violenta y tipificada como delito, con una escasa o nula concienciación de responsabilidad, es ineludible y necesaria la intervención judicial, poniendo en marcha todo el proceso hasta la Audiencia e imponiendo medida educativa al efecto. La *individualidad en la valoración del caso* es lo destacable en el diagnóstico, es decir, se ve cada caso en concreto, viendo los factores de riesgo y de protección que presenta. Cada figura profesional, de la que consta cada Equipo Técnico de Fiscalía y Juzgados de Menores, realiza la valoración en su área que corresponden en grandes rasgos a las tres áreas o sistemas del menor (familiar, educativo/social y psicológica) y posteriormente se realiza un diagnóstico conjunto, con objetivos educativos concretos: *orientación de medida*. Es entonces cuanto intervienen, a través de la *educación*, los Educadores de Medio Abierto si la medida impuesta es en medio abierto o el Equipo Técnico del centro en el caso de que se adopte una medida de internamiento.

Por su parte, la Dirección Territorial de Educación solicitó nuestro compromiso a dar charlas a los escolares, sobre todo a los de Educación secundaria, en los propios centros, y se ha realizado durante el primer semestre del año 2007, con resultado satisfactorio. También a iniciativa del Equipo Técnico se han dado estas charlas en las escuelas de padres, siendo en este caso muy escasa la participación de los mismos, aunque satisfactorias las que se realizaron. En este caso se entregó una documentación a los padres, consistente en un estudio realizado por la miembro del Equipo Técnico y psicóloga forense D. Cristina Amante, en la que se abordan los factores de riesgo de los menores, sean agresores, víctimas o espectadores; cómo abordar el problema desde la familia, la escuela, la sociedad y desde el ámbito de la justicia juvenil.

Igualmente se solicitaba por parte de la DTE que se les comunicara, en el caso de que recayera sentencia firme, el contenido de la misma, aunque su interés recaía principalmente en los supuestos de mayor gravedad o en los que además la agresión hubiera sido a un docente. Respecto de este aspecto, se informa únicamente si la sentencia ha sido condenatoria o absolutoria.

Por último, debemos decir que este modelo de actuación solo ha podido llevarse a cabo por uno de los siete equipos que integran la Fiscalía de Menores (cada uno lo forman: un Fiscal, un Equipo Técnico compuesto solo de un psicólogo y un educador o un trabajador social y dos funcionarios) con un resultado muy satisfactorio, en el ámbito de la prevención de este tipo de conductas, teniendo un elevado índice de éxito en las mediaciones realizadas por el Equipo Técnico referido. Igualmente, con esta actuación inmediata se han podido detectar factores de riesgo del menor, tanto en agresores como en víctimas, que no se circunscriben únicamente a los actos de violencia que dieron motivo a nuestra intervención, sino a otros ámbitos, actuando entonces

siguiendo el Expediente de Reforma y/o incoando el correspondiente Expediente de Protección, remitiendo a la entidad pública el mismo para que adopte las medidas oportunas e informe de su resultado.

Con esta forma de intervenir se consigue:

- una respuesta acorde y educativa;
- una respuesta rápida y efectiva ante la conducta desadaptada (en menos de un mes se resuelve el expediente en el grupo de casos 2);
- disminuir la sensación de impunidad y por tanto la reincidencia;
- que no judicialicen asuntos que pueden resolverse de forma extrajudicial;
- descongestionar juzgados, medio abierto y centros;
- optimizar los pocos recursos existentes, haciéndolos eficaces y eficientes;
- y lo más importante, que se asuman las responsabilidades, por parte de todos.

Recursos utilizados para llevar a cabo las posibilidades del artículo 19, relacionados con Educación

- Convenios de coordinación para llevar a cabo soluciones extrajudiciales (conciliaciones, actividades educativas, reparaciones directas o indirectas en colegios e institutos o recursos pertenecientes a educación. Protocolo de colaboración con el Plan PREVI.
- Utilización de programas de educación en valores, derechos humanos, educación sexual, habilidades sociales, resolución de problemas, expresión de emociones, educación vial, alfabetización: aprender a leer y escribir, formación de mediadores juveniles
- Tutores de víctimas (agresor que defiende a su víctima) nombrados desde Fiscalía de menores.
- Menores expedientados, imparten talleres de educación en valores, conducta asertiva y derechos humanos, drogas, etc., a otros menores, como medida educativa o actividad previa.

ACTUACIONES PREVENTIVAS

Nos quedamos cortos si solo nos preocupamos por la avalancha de denuncias. Tenemos varios frentes en los que actuar:

MENORES: en la sensación de impunidad en los menores. En el vacío moral. En el aumento de delitos violentos. En el aumento de la violencia en los delitos. En la regresión a valores machistas (caldo de cultivo de violencia de género)

PADRES: en la psicosis con respecto a los jóvenes que presentan, los padres y la sociedad en general. En la cultura de la denuncia: padres obcecados en judicializar asuntos, padres no mediadores. En la sensación de indefensión en los adultos. En la deserción de responsabilidades. En el incremento desmesurado de denuncias, preventivas o no.

- **MEDIOS DE COMUNICACIÓN:** punto muy importante por ser *transmisores de la ideología dominante* que refleja valores y actitudes de individualismo, consumismo y pasividad. Existe un gran conformismo, una falta de espíritu reivindicativo, fomentando la psicosis con respecto a los jóvenes y responsabilizando al otro de lo que está pasando en la sociedad, no asumiendo la que le corresponde.

PROFESORES, la escuela, en general, como importante agente socializador que es, suele reflejar los valores predominantes en la sociedad, proporciona a los menores no solo la madurez intelectual, sino también el ajuste al contexto social. Si no se da una relación adecuada de los menores con la escuela, no será posible ni el desarrollo intelectual ni una integración social activa. Tenemos que *motivar y responsabilizar, asesorar y apoyar.*

- **PROFESIONALES QUE INTERVENIMOS EN MENORES:** *unificación de criterios* seguir el mismo criterio de intervención, para no generar actuaciones contradictorias e incoherentes que faciliten una involución en el cambio del menor.

Por lo tanto, es necesario trabajar en la misma línea, unificando la filosofía de intervención. A fin de cuentas es lo que pedimos a los padres en la educación de sus hijos.

Nuestra función aquí es, por tanto, unificar criterios a través de congresos, cursos o jornadas.

4.1. Actuaciones puestas en marcha

arlas a menores

Estas charlas se imparten en los colegios o institutos de la provincia, en sesiones organizadas a través del Director o Jefe de estudios del centro educativo.

Informativa de la LORPM 5/2000.

Preventivas de violencia de género.

Valores, empatía y conducta asertiva.

Drogas.

Charlas a padres

Estas charlas se incluyen en las escuelas de padres organizadas por las APAs de los colegios e institutos.

Charlas cursos a profesores

Estos cursos se realizan en los CEFIREs, centros de formación del profesorado.

Preparación de jornada de reflexión sobre justicia juvenil, en la provincia de Alicante. Constitución de comisiones técnicas.

5. INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Hemos referido con anterioridad que cada país y su legislación posee sus propios estudios y realidad social y debemos atenernos a la nuestra propia, y es por ello que entendemos interesante *el Informe del Defensor del Pueblo sobre acoso escolar en España*, realizado en el año 2007 y referido a los datos obtenidos en el año 2006. Este informe se realiza respecto de todas las Comunidades Autónomas y con intervención tanto de alumnos como de profesores, resultando muy ilustrativo para entender a qué nos enfrentamos y, sobre todo, si sus conclusiones coinciden con las que nuestras. En él se ponen de manifiesto “todo conflicto entre iguales”. En resumen, las conclusiones a las que se llegan son las siguientes

1. En cuanto a la NATURALEZA E INCIDENCIA DEL MALTRATO. A partir de los datos proporcionados en 2006 por los 3.000 estudiantes que participaron en el estudio, puede afirmarse que todos los tipos de maltrato por los que se ha indagado tienen lugar en los centros docentes de secundaria españoles, si bien cada uno de ellos con un nivel de incidencia muy distinto. Así, de acuerdo con la incidencia estimada por las alumnas y alumnos que se declaran víctimas de las diferentes modalidades de maltrato, el porcentaje más alto corresponde a los abusos por agresión verbal, seguido de la exclusión social y de las agresiones efectuadas a través de las propiedades (en este caso, esconderlas). Con menores porcentajes de incidencia se sitúan las conductas de robo y de amenazas para intimidar, seguidas de las agresiones físicas directas (pegar) y de los destrozos de material. Un porcentaje de escolares menor al 1 por 100 alude a los chantajes (obligar a otro a hacer cosas que no desea), al acoso sexual y a las amenazas con armas.

Ahora bien, el que las formas más graves de maltrato sean las menos frecuentes no puede inducirnos a pensar que el problema del abuso escolar carece de importancia en España. Por una parte, todas las formas de maltrato tienen consecuencias negativas para quienes las sufren, y son muy numerosos los alumnos que las padecen de alguna manera. Además, todas las formas de maltrato se dan

en mayor o menor medida en todos los centros educativos estudiados y aunque se aprecie una relativa disminución porcentual, más intensa en las conductas menos graves, estamos muy lejos aún de erradicar de las aulas el fenómeno de la violencia entre iguales.

Estas formas de acoso escolar se producen en términos similares en todas las comunidades autónomas españolas, sin diferencias apreciables entre los centros ubicados en zonas rurales y los ubicados en zonas urbanas.

Con respecto al género, hay más chicos que chicas que mencionan que “se les pega” y que “reciben mote ofensivo”, o, a quienes se “rechaza a la hora de participar”, mientras que son más las chicas de las que “se habla mal a sus espaldas”. En el resto de acciones hay tantas víctimas femeninas como masculinas. Sin embargo, es mayor el porcentaje de agresores varones en casi todas las modalidades, excepto, una vez más, en la maledicencia.

La titularidad del centro parece una variable significativa, en relación con ciertas formas de maltrato mediante exclusión y sobre todo de “maledicencia”.

Esta se ejerce y sufre más en los centros privados o concertados que en los públicos, mientras que en los concertados hay más estudiantes que señalan que “no se les deja participar” y hay más que dicen “ignorar” a otros. En el trabajo del Centro Reina Sofía (Serrano e Iborra, 2005) se ha encontrado que el porcentaje de quienes se consideran víctimas es mayor en los centros privados que en los públicos y concertados, y que estos últimos son los que registran menores frecuencias de maltrato.

Ser de origen extranjero es un factor relevante desde la perspectiva de las víctimas y los testigos, pero no desde la de los agresores, si bien ello ocurre en algunas de las modalidades de maltrato. Así, el porcentaje de estudiantes de origen inmigrante ya sean de primera o de segunda generación- que son ignorados por las compañeras o compañeros duplica el de estudiantes autóctonos.

2. En relación con las CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES DEL MALTRATO, se pone de manifiesto que los malos tratos están protagonizados mayoritariamente por compañeros de la misma clase que el agredido, con la única excepción de las “amenazas con armas”, que ejercen tanto los compañeros de clase, como los de otros cursos para todos los cursos estudiados. Más de la mitad de la muestra señala que “hay bandas que se meten con un compañero o compañera”, y en un porcentaje algo menor, que “se meten con grupos de chicos”.
3. EL ESCENARIO DEL MALTRATO: el aula sigue erigiéndose como el escenario más repetido de agresiones. A diferencia de lo que opina el profesorado, que tiende a situar en el patio los episodios de maltrato, para el alumnado es la clase cuando no está presente el profesor, pero a veces también en su presencia, el escenario privilegiado para casi todas las modalidades de maltrato excepto el “no dejar participar”, los “chantajes” y las “amenazas con armas”, conductas éstas todas ellas más situadas en el patio.

4. **LO QUE SIGUE A LA AGRESIÓN: PEDIR Y RECIBIR AYUDA.** Las conclusiones referentes a la petición y recepción de ayuda en los casos de maltrato permiten ser, al menos, moderadamente optimistas. Cuando se comparan las reacciones que tienen lugar tras los episodios de maltrato en los estudios de 2000 y 2006, se puede concluir que ha disminuido el porcentaje de alumnas y alumnos que no lo comunican a nadie. Sigue siendo preocupante ese algo más del 10 por 100 de las víctimas que no lo comunican a nadie, aunque, en el estudio anterior era más del 15 por 100. Las agresiones más graves son las que con menos frecuencia se comunican, lo que resulta preocupante.

Las “víctimas” mencionan más la intervención del profesorado que de las familias en todos los tipos de maltrato, a excepción de las amenazas-chantaje sin armas y del acoso sexual.

5. **LOS CONFLICTOS ENTRE DOCENTES Y ALUMNADO.** La incidencia de estos conflictos no ha aumentado ni disminuido en los últimos siete años. Tampoco ha variado la frecuencia relativa con la que, según los jefes de estudios, se producen estos conflictos. Por lo que respecta al comportamiento de los estudiantes hacia el profesorado, lo más frecuente son los insultos. La “agresión física indirecta” (destrazo de enseres de los docentes) y los “rumores dañinos” son también conductas que los jefes de estudios identifican con bastante frecuencia. Los “robos” y la “intimidación mediante amenazas” lo son menos, y las “agresiones físicas directas” son poco frecuentes.
6. **LA RESPUESTA DE LOS DOCENTES Y LOS CENTROS ANTE EL MALTRATO Y OTROS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA.** Los centros están poniendo en marcha un modelo integrado de mejora de la convivencia, en el que se combinan medidas sancionadoras con actuaciones dirigidas a mejorar las relaciones interpersonales y también se refleja que ha aumentado significativamente el porcentaje de centros que se han implicado en este tipo de programas.

CONCLUSIONES

Del estudio, cuyas conclusiones hemos transcrito, parece desprenderse que no existen unas diferencias notables entre el informe realizado por el defensor del pueblo en el año 2000 y el realizado en el año 2007, sin embargo la realidad, que desde la Fiscalía de Menores de Alicante se detecta, es que la violencia entre iguales, sea de la naturaleza que sea, ha aumentado de forma preocupante, que se denuncian muchos más casos año tras año, y que las menores y los menores tienen una intervención por igual en los distintos supuestos de “acoso”, e incluso superior de las niñas como autoras. Es más que preocupante para nosotros el que sea vea una “regresión en los valores” de las menores, y una alta agresividad en su forma de relacionarse, por eso no podemos compartir las conclusiones del estudio, pues en él se refleja que el tipo de acoso que protagonizan las menores de forma mayoritaria es el “hablar mal, insultar o amenazar, hacer el vacío”, es decir, “no violento”, ya que en la Fiscalía de Menores de Alicante se han incoado más

diligencias en las que el autor es una menor, actuando en grupo o no, y además cada vez se incoan más expedientes por hechos protagonizados por niñas, no solo por acoso escolar, sino por lesiones graves, maltrato familiar o delitos contra el patrimonio, siendo en general menores pertenecientes a familias “aparentemente normalizadas”, en los que no cabe ninguna de las soluciones extrajudiciales, tanto en el ámbito escolar como desde el Equipo Técnico, ya que además de la gravedad de los conflictos existen otros factores de riesgo que deben ser abordados desde el ámbito de la jurisdicción de menores. Además, hubo un aumento considerable de denuncias interpuestas en el 2007 respecto al año 2006, y estas han disminuido en el año 2008, aunque no de forma significativa. Sin embargo, el número de expedientes que se han concluido y respecto de los cuales se ha celebrado Audiencia y se ha dictado sentencia, ha sido mayor en el año 2008 (44) que en el año 2007 (33), y ello debido por una parte a la mayor gravedad de los hechos, y por otra parte, a que no se ha podido llevar a cabo una resolución extrajudicial del conflicto. Igualmente, la implicación de los profesores y centros escolares ha sido muy significativa, y por tanto se ha llegado a la resolución del conflicto en el ámbito educativo en muchos más supuestos. Por último mencionar que la mayoría de denuncias por acoso escolar son en realidad agresiones físicas puntuales, de mayor o menor entidad y el lugar o escenario de las mismas es el patio, pero sobre todo las inmediateces del centro escolar a la salida de las horas lectivas.

Por todo ello nuestro planteamiento de trabajo en la violencia escolar y en la resolución de otros tipos de conflicto consiste en intervenir de forma inmediata reduciendo la sensación de impunidad, previniendo de forma secundaria (es decir, evitar la reincidencia), descongestionar a los equipos de medio abierto y probablemente en re/socializar.

Se consigue dar mayor celeridad a la resolución extrajudicial de los asuntos y acoplar cada recurso al caso concreto, hacer partícipe a los municipios en la prevención de la violencia juvenil y responsabilizar a nuestros menores de sus actos.

Conseguimos neutralizar las denuncias “preventivas” una vez llegan a Fiscalía de Menores y restablecer cierto orden en la resolución de conflictos en el medio escolar.

Pero nos queda mucho por hacer.

La violencia que están aprendiendo de la sociedad y viendo los niños a través de los medios de comunicación acrecienta este tipo de comportamiento violento.

¿Estamos asumiendo nosotros la responsabilidad que nos corresponde sobre lo que está pasando?

¿Utilizamos todas las posibilidades técnicas del articulado (herramientas) que nos proporciona la Ley, para llevar a cabo los planes de intervención con los menores?

¿Existe una verdadera coordinación de los recursos implicados en la acción psico-socioeducativa y judicial de un menor?

¿La urgencia de dar “trámite” al expediente y el dejarse llevar nos marca el trabajo?

¿Es todo esto educativo?

Creemos en la educación “No hay violencia juvenil, hay violencia”.

BIBLIOGRAFÍA

Es muy útil la información recogida en la Conferencia Europea sobre iniciativas para combatir la intimidación en las escuelas, en la que varios expertos exponen su visión y soluciones en sus respectivos países: *Conferencia Europea sobre iniciativas para combatir la intimidación en las escuelas* en la que participaron:

Rob Limper (Netherlands)

Mona O Moore (Irlanda)

Erling Roland (Noruega)

Programa Noruega de 1996 para la Prevención y Tratamiento de la Intimidación en las Escuelas

Jacques Pain (Francia)

Igualmente, es muy interesante el informe del Defensor del Pueblo del año 2007 en el que se estudian y revisan las distintas investigaciones realizadas en las diferentes comunidades autónomas y los protocolos de actuación, conclusiones y recomendaciones.

Ballarín, DP. Violencia sexista en nuestro sistema educativo. En: Fernández, A. (ed.): *Educando para la paz. Nuevas propuestas*. Granada: Universidad de Granada, 38-49. 1994.

Cerezo F, Esteban M. La dinámica bully-víctima entre escolares. Diversos enfoques metodológicos. *Revista de Psicología* *universitas Tarraconensis*. 1992. Vol. XIV, 2; 131-145.

Debarbieux E. La violencia en la escuela francesa: Análisis de la situación, políticas públicas e investigaciones. *Revista de Educación*. 1997. 313; 79-94.

Díaz-Aguado MJ, Royo P. Educar para la tolerancia. Programas para favorecer el desarrollo de la tolerancia a la diversidad. *Infancia y Aprendizaje*. 1995. 27-28;248-259.

Díaz-Aguado MJ. *Programa para favorecer la tolerancia en contextos étnicamente heterogéneos*. Madrid: MEC. 1992.

Díaz-Aguado MJ. *Programas de educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 1997.

Eslea M, Smith, P. If anybody bites you bite them back Parent and pupil attitudes towards bullying in primary schools. Ponencia presentada en la decimocuarta reunión del ISSBD. Québec. 1996.

Fernández I. *Violencia en la escuela y en el entorno social. Una aproximación didáctica*. Madrid: CEP de Villaverde. 1991.

Funke J. Violencia escolar en Alemania, *Revista de Educación*. 1997. 313;53-78.

Gargallo B, García R. La promoción del desarrollo moral a través del incremento de reflexividad. Un programa pedagógico. *Revista de Educación*. 1996. 309;287-308.

Hazle, R. Bystanders: an overlooked factor in peer on peer abuse. *The Journal for the Professional Counsellor*. 1996. 11;2;11-21.

Macleod M, Morris S. *My home* London: Childline. 1996

Melero J. *Conflictividad y violencia en los centros*. Madrid: Siglo XXI, 1993.

Menesini E, Fonzi A, Genta M-L. Bullying behaviour and attitudes among Italian school children. Ponencia presentada en el Congreso Europeo sobre Investigación Educativa (ECER), Sevilla, Septiembre. 1996.

Mooij T. Por la seguridad en la escuela. *Revista de Educación*. 1997. 313;29-52.

Moreno JM, Torrego JC. Trabajar en los márgenes: una experiencia de asesoramiento en un centro del sur metropolitano de Madrid. En: Lorenzo, M. y Bolívar, A. (Eds.): *Trabajar en*

- los márgenes: Asesoramiento y formación en contextos educativos problemáticos. Granada: ICE de la Universidad de Granada, 5-32, 1996.
- Moreno JM. The dark side of the school: policy and practices on anti-social behaviour in Spanish schools, ponencia presentada a la Conferencia Europea Safe at school, Utrecht, Presidencia Holandesa de la Unión Europea. 1997.
- Moreno JM. *Los exámenes Graduación secundaria y acceso a la universidad en seis países occidentales*, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- Morita Y. Bullying as a contemporary problem in the context of increasing societal privatization in Japan. Prospects, XXVI, 2 de junio de 1996. (Open file: Violence in the school. Guest editor: T.Ohsa o).
- Naylor P, Coie H. The effectiveness of peer support systems in challenging bullying in schools (La eficacia de los sistemas de compañerismo para hacer frente a la intimidación en las escuelas): Una explicación preliminar de las conclusiones de una encuesta realizada en el Reino Unido. Informe preliminar, *The Prince's Trust Project Peer support as a challenge to school bullying* (Compañerismo para hacer frente a la intimidación en la escuela). School of Psychology and Counselling, Roehampton Institute, London. 1998.
- Ortega R, Mora-Merchán J. Agresividad y violencia. El problema de la victimización entre escolares. *Revista de Educación*. 1997. 313;7-28.
- Ortega R, Mora-Merchán J. El aula como escenario de la vida afectiva y moral. *Cultura y Educación*. 1996. 3;5-18.
- Ortega R. El proyecto Sevilla anti-violencia escolar. Un modelo de intervención preventiva contra los malos tratos entre iguales. *Revista de Educación*. 1997. 313;143-158.
- Ortega R. Las malas relaciones interpersonales en la escuela: estudio sobre la violencia y el maltrato entre compañeros en segunda etapa de EGB. *Infancia y Sociedad*. 1995. 27-28;192-215.
- Ortega R. Violence in schools. Bully-victims problems in Spain, en Vth European Conference on Developmental Psychology. Sevilla, *Libro de Actas*. 1992. p. 27.
- Ortega R. Violencia interpersonal en los centros educativos de enseñanza secundaria. Un estudio sobre maltrato e intimidación entre compañeros, *Revista de Educación*. 1994. 304; 253-280.
- Pérez C. La mejora del comportamiento de los alumnos a través del aprendizaje de normas. *Revista de Educación*. 1996. 310;361-378.
- Revista de Educación. *Monográfico sobre violencia en los centros educativos*, nº. 313, Madrid: MEC, 1997.
- Rigby , Slee P. Bullying among Australian school children: reported behaviour and attitudes to victims. *Journal of Social Psychology*. 1991. 131; 615-627.
- Salmivalli C, Lagerspetz , Björqvist , Osterman , Kaukianen A. Bullying as a group process: participant roles and their relations to social status within the group *Aggressive Behaviour*. 1996. 22 (1) 1-15.
- Trianes MV, Muñoz A. Prevención de la violencia en la escuela: una línea de intervención. *Revista de Educación*. 1997. 313; 121-142.
- Trianes MV, Muñoz A. *Programa de Desarrollo Afectivo y Social en el aula*. Málaga: Delegación de Educación, 1994.
- Trianes MV. Educación de competencia para las relaciones interpersonales en niños de compensatoria. *Infancia y Sociedad*. 1995. 27-28;262-282.

LA VULNERABILIDAD DEL MENOR EN LAS AULAS ESCOLARES CONSTRUYENDO UNA ESCUELA SEGURA

Silvia Martínez Amorós

Imaginemos que estamos en la playa tranquilamente debajo de nuestra sombrilla, un día de agosto en los que hay mucha gente y de los que hace un sol abrumador. De momento alguien se nos acerca y nos pide de forma grosera que le demos nuestra sombrilla porque tiene mucho calor. En principio no le hacemos caso y empieza a insultarnos, nos intentamos resistir y sigue insultándonos a la vez que nos quita la sombrilla. En ese momento empezamos a defendernos intentado coger nuestra sombrilla y chillando pero la otra persona es más fuerte y va acompañada de otros dos y consigue llevársela. Mientras, el resto de gente no hace caso a lo que ha pasado aunque todos han sido testigos y la persona nos roba finalmente la sombrilla. ¿Verdad que es difícil de imaginar que esto pueda pasar? Ya que seguramente alguien intervendría para intentar aclarar la situación, o para ayudarnos frente al que nos quiere robar lo que es nuestro. Sin embargo, los menores en los centros educativos pueden llegar a sufrir situaciones similares a las descritas en la institución escolar diariamente sin que nadie intervenga, quizá porque son vistas como algo normal entre niños, porque ocurren lejos de la vista de los adultos, etc. Ello hace que el menor pueda verse en situaciones de vulnerabilidad en muchas ocasiones ya sea porque está siendo objeto de actuaciones intimidatorias hacia su persona y nadie actúa para pararlas, ya sea porque las realiza y nadie está presente para corregir su conducta.

Es, por tanto, que en el presente capítulo nos centraremos en explicar los problemas de violencia escolar que los menores pueden vivir en los centros docentes, donde pasan de forma obligatoria al menos diez años (de los 6 a los 16) vitales en su desarrollo, centrándonos especialmente en el acoso escolar también llamado *bullying*. Por ello, nos gustaría exponer dos cuestiones: cuál es la situación actual de la convivencia en los centros escolares, cómo podemos detectar los posibles casos en los que el menor esté en una situación de vulnerabilidad (entendiendo vulnerabilidad cómo que puede ser dañado física o moralmente) para poder prevenirlos. Para ello explicaremos los factores de riesgo para ser posible víctima de acoso escolar, que nos servirán como posibles indicadores de detección, y a continuación analizaremos las actuaciones más

adecuadas que deben realizarse tanto en el aspecto preventivo como en la intervención específica en las situaciones en las que el menor esté en una situación de riesgo de sufrir acoso escolar o *bullying*. Finalmente describiremos el Plan PREVI que desde la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana se ha implantado en los centros escolares para favorecer la convivencia en los mismos y prevenir la violencia escolar.

LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES

Una de las cuestiones más complejas de analizar en el ámbito escolar es la situación de la convivencia en los centros docentes. Compleja por distintos aspectos: en primer lugar, porque es difícil describir qué entendemos por convivencia escolar, ya que la mayoría de las definiciones son bastante abstractas, sin llegar a concretar cuestiones más objetivas que podamos observar y estudiar. En segundo lugar, porque los vertiginosos cambios que estamos viviendo en la sociedad española actual han configurado un panorama educativo donde nuestros menores conviven de forma muy distinta a cómo lo hacían hace apenas quince años y debemos entender la convivencia y las estrategias para mejorarla dentro de este nuevo panorama y no desde fórmulas aplicables hace un par de décadas. Y finalmente, porque los distintos estudios que sobre la convivencia escolar se han desarrollado son muy diversos, analizando cada uno las cuestiones sobre convivencia desde ópticas, conceptos y teorías distintas, y ofreciendo datos muy diversos de unos estudios a otros.

Es por ello que en el presente punto vamos a ir desgranando algunos de estas cuestiones para ir posteriormente analizando los datos publicados de los distintos estudios sobre la convivencia escolar en el país y en la Comunidad Valenciana.

Por tanto, en primer lugar vamos a clarificar el concepto de convivencia. Entre las distintas definiciones que se dan de convivencia hemos elegido la siguiente, porque recoge la esencia de lo que queremos lograr para las escuelas en las sociedades modernas: “es el arte de vivir en paz y armonía con las personas y el medio que nos rodea, basado en el ejercicio de la libertad y el respeto a la diferencia y la capacidad de los integrantes de una comunidad para elegir y responder por las consecuencias de sus acciones”. Es decir, desde esta definición vamos a entender la convivencia en los centros docentes desde las siguientes ideas básicas:

- “vivir en paz y armonía con las otras personas en el medio que nos rodea” entendiendo vivir en paz y armonía como la capacidad de resolver los conflictos pacíficamente desde la defensa de los derechos personales y la no agresión a los derechos de los demás;
- “ejerciendo la propia libertad y a la vez el respeto a la diferencia”;
- “con capacidad para elegir y responder por las consecuencias de nuestras acciones”.

Desde esta concepción se entenderían los problemas de convivencia en los centros, como aquellas situaciones en las que algunos miembros de la comunidad educativa no pueden ejercer su propia libertad ya que ven vulnerados sus derechos por otras personas (por ejemplo, las situaciones de agresión o acoso escolar, las situaciones de disrupción continua en el aula, donde se ven vulnerados los derechos de los alumnos a recibir una enseñanza, o los derechos del profesorado a impartir la docencia, etc.), o aquellas situaciones en las que las personas dentro de la comunidad escolar no sienten respeto a su diferencias (por ejemplo, aquellos alumnos que pueden ser acosados por ser distintos, aquellos alumnos que no son atendidos o respetados en su diversidad, provocando distintas situaciones conflictivas en los centros...)

Es por ello que básicamente los estudios sobre la convivencia escolar se han centrado en tres cuestiones fundamentales:

- la investigación de la disrupción en las aulas;
- el análisis sobre la resolución de las situaciones conflictivas en la institución escolar, desarrollando toda una disciplina de estudio centrada en la mediación como estrategia que favorece la convivencia en la resolución de conflictos escolares;
- el estudio del acoso escolar.

Explicaremos a continuación distintos datos sobre cada una de las tres líneas de investigación, centrándonos a lo largo de nuestro capítulo, especialmente en las situaciones de acoso o bullying, dado que son en las que el menor está en una mayor situación de riesgo y en las que se encuentra más vulnerable.

La disrupción en las aulas

Respecto a la disrupción en las aulas, los distintos estudios nos dicen que es el problema que más preocupa al profesorado (Lucena, 2004) y que además éste percibe que esta disrupción en las aulas ha aumentado significativamente. Los datos arrojados por el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, en su “Estudio Estatal sobre la convivencia escolar en la Educación Secundaria Obligatoria” (2008) reflejan que el 21,6% del profesorado percibe que el problema más frecuente y extendido es el comportamiento disruptivo (molestar e impedir dar la clase). Sin embargo, solo un 4,1% del alumnado reconoce participar en este tipo de situaciones con frecuencia. Los datos recogidos por el Defensor del Pueblo tanto en los estudios del 2001 como en sus estudios de 2008 reflejan que los problemas de disrupción en las aulas es un factor que influye en el clima de convivencia del centro.

Una aula o centro donde los problemas disruptivos son altos es un factor de riesgo significativo para que se vivan situaciones donde se vulneren los derechos de los menores, ya que se recoge en los estudios que las aulas donde hay más disrupción suele haber más situaciones de agresiones entre iguales además de verse vulnerado el derecho al estudio de los alumnos.

9.1.2. Estudios sobre la resolución de conflictos en la institución escolar

Los estudios sobre las situaciones conflictivas en la institución escolar, van muy relacionados con todas las investigaciones sobre la situación de la convivencia en la escuela. Esta rama de la investigación se ha centrado en los métodos y estrategias más adecuadas para favorecer un clima de centro armonioso que dé respuesta de forma pacífica a los posibles conflictos que puedan surgir. Dentro del estudio de estos métodos y estrategias, encontramos que la investigación sobre la *mediación escolar* centra la mayoría de la producción científica en este campo.

La mediación escolar se concibe como un *método de resolución de conflictos pacífico*, ya que concibe que la resolución del conflicto se tiene que realizar de forma voluntaria entre las distintas partes implicadas y de manera que éstas queden satisfechas con la solución encontrada por ellos mismos. Así lo recoge leimann (2005), que define la mediación como “una técnica de resolución de conflictos interpersonales, por la que las partes, asistidas por un tercero neutral, buscan una solución de sus diferencias, a través de un acuerdo que convenga a ambos”.

Desde las teorías sobre la mediación escolar se concibe que para poder llegar a que los alumnos sepan resolver los conflictos de forma pacífica (que a la vez son normales en las relaciones humanas) deben aprender a desarrollar una serie de habilidades y estrategias que favorezcan el éxito de esta técnica. Es por ello que se establece que la institución escolar no tiene que velar porque los conflictos no aparezcan, es decir, no tiene que trabajar por la prevención de los conflictos, sino que tiene que favorecer la *provención* (término acuñado por Burton en 1990 y utilizado por Cascón en 2004) que consiste en trabajar por proveer a los alumnos de las estrategias y herramientas adecuadas para resolver los conflictos. Es decir, el que las escuelas asuman la provención llevará a que desarrollen una formación adecuada para que los alumnos sepan identificar los conflictos en sus primeras fases, sepan analizarlos y conozcan qué cambios deben realizar. Para ello tendrán que tener una serie de habilidades adquiridas como el diálogo, la escucha activa, el desarrollo de las habilidades sociales, de la empatía, del análisis, comprensión profunda de las situaciones, etc.

Las investigaciones concluyen que los programas que más beneficios aportan para la mejora de la convivencia en los centros son aquellos que abordan la gestión democrática de la convivencia, el afrontamiento del conflicto y la educación en emociones, sentimientos y valores (Ortega, Del Rey, 2001). Es por ello que la mediación se concibe como uno de los programas que más efectividad tienen en la mejora de la convivencia, ya que todos estos elementos están presentes en los programas de mediación (Ortega, Del Rey, 2006). La mediación lleva a crear escuelas más seguras, donde se fomentan las relaciones y la convivencia, minimizando las posibilidades en las que el menor pueda estar en una situación de vulnerabilidad.

A continuación pasaremos a abordar la problemática del acoso escolar, tema central del desarrollo de este capítulo.

El acoso escolar

El acoso escolar empezó a ser estudiado por el psicólogo noruego Dan Olweus (1983). Sus investigaciones han sido la base de otras realizadas en Europa y en España. En España, Ortega (1997, 2001), Cerezo (2004), el Defensor del Pueblo (2000, 2007), y así hasta 42 investigaciones (Garaigordobil y Oñederra, 2008) recogen que el acoso escolar está presente en todos los centros educativos.

Pero antes de entrar a explicar los datos recogidos en las distintas investigaciones sobre la incidencia del acoso en las aulas, debemos pasar a explicar qué entendemos por acoso escolar. Para poder definir el acoso escolar primero tenemos que aclarar la definición de violencia escolar, ya que el acoso escolar es un tipo de violencia escolar. Bien, definimos la violencia escolar, como aquella acción u omisión *intencional* que dirigida a las personas tiende a causarles daño físico, psicológico, sexual o económico, y dirigido a objetos y animales tiende a dañar su integridad. Cuando esta violencia se produce en el centro educativo, en los alrededores del centro originada por alumnos/as vinculados al centro o en las actividades extraescolares, y va dirigida hacia los alumnos/as, profesores o propiedades es violencia escolar. (*Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia* 2006). Los tipos de violencia escolar que encontramos son: maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, abuso sexual, maltrato económico y vandalismo. Dentro de estos encontraríamos el acoso escolar o *bullying*.

¿Pero qué diferenciaría el *bullying* de otro tipo de violencia? Según Olweus (1998), considerado padre de este concepto, el acoso escolar sería el tipo de violencia en el que un alumno es sometido a un comportamiento dañino, intencional y repetido por otros compañeros y en el que tiene dificultad para defenderse". Es por ello que la mayoría de los investigadores y profesionales del tema aceptan que los criterios para poder afirmar que existe una situación de acoso escolar serán:

1. Es una situación de maltrato entre compañeros.
2. Es reiterado en el tiempo.
3. Existe un desequilibrio de fuerza física psicológica o social entre agresor y víctima.
4. La víctima se siente intimidada e incapaz de defenderse.
5. Suele ocurrir lejos de la mirada de los adultos.
6. Además, la víctima se siente cada vez más excluida.

Para que podamos hablar de una situación de acoso escolar es necesario que se den al menos los cuatro primeros criterios.

incidencia del acoso escolar

Como hemos dicho anteriormente, los estudios epidemiológicos tanto españoles como los realizados en todo el mundo vienen a concluir que el *bullying* o acoso es-

colar es un fenómeno que se da en todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, y se produce tanto en la educación primaria como secundaria, aunque con matizaciones diferentes.

Estos amplios y diversos estudios, aunque muestran una falta de homogeneidad en los datos presentados debido a los diferentes instrumentos de evaluación utilizados, las diferencias en las características de las muestras, en los diseños, análisis estadísticos, etc., evidencian sin excepción la existencia del acoso escolar en todos los centros escolares y apuntando un porcentaje medio aproximado de victimización grave entre el 3% y el 10% y porcentajes de estudiantes que sufren conductas violentas entre el 20% y un 30% (Garaigordobil y Oñederra, 2008)

Tipos de acoso escolar

Los distintos tipos de acoso siguiendo la clasificación de Sullivan, K.; Sullivan, G.; Cleary, M. (2006) son:

1. Acoso físico: es la forma más obvia de *bullying*, y tiene lugar cuando una persona sufre daños físicos al ser mordida, pegada, pateada, golpeada, arañada, escupida, zancadilleada, por tirarle del pelo o por cualquier otro ataque físico.
2. Acoso no físico: (también conocida como exclusión social) puede ser verbal o no verbal:

Acoso verbal: incluye las burlas, los insultos, los moteos, las amenazas, las ridiculizaciones, extorsiones, la difusión de rumores falsos y malintencionados, el lenguaje sexualmente ofensivo, comentarios crueles, etc.

Acoso no verbal: los gestos groseros, y las caras de desprecio, que intentan mantener el control sobre alguien y para intimidarle y recordarle que en cualquier momento puede ser el escogido.

Acoso no verbal indirecto: incluye, de manera premeditada y normalmente sistemática, el ignorar, excluir, aislar, enviar notas ofensivas de forma anónima y fomentar que los demás estudiantes sientan aversión hacia alguien.

Consecuencias del acoso escolar

Los distintos estudios sobre las repercusiones del acoso escolar coinciden en apuntar que el ser víctima de situaciones violentas reiteradas en la escuela tiene efectos dañinos y destructivos en el menor. Pero cuando se produce una situación de acoso escolar no solo va a tener consecuencias negativas para la víctima sino también para los espectadores y para los mismos agresores.

Las distintas investigaciones señalan que las víctimas de acoso escolar tienden a tener unos niveles bajos de autoestima, suelen sentirse deprimidas, inseguras, ansiosas, hipersensibles, cautelosas y reservadas. Se muestran más temerosos y preocupados ante las situaciones nuevas y más encerrados en sí mismos. Tienen mayor

riesgo de abandonar los estudios y son menos felices en la escuela. Presentan mayores problemas de salud mental como fobias, depresión, dependencias... y pueden llegar a desarrollar ideas suicidas (Sullivan, Sullivan y Cleary, 2003; Olweus, 1995; Rigby, 2000).

Respecto a las repercusiones del acoso escolar en los acosadores, tenemos que reflejar que ciertas investigaciones revelan que los niños que han sido acosadores tienen más riesgo cuando son adultos de tener problemas con la justicia y conductas agresivas.

Además, si no se actúa ante el *bullying* suelen concebir las agresiones o conductas intimidatorias como adecuadas para conseguir lo que quieren y para aumentar su poder en el grupo.

En cuanto a los espectadores, el *bullying* también tiene sus efectos negativos. Estos efectos son varios. En primer lugar aprenden que la conducta violenta e intimidatoria es válida para conseguir ciertos objetivos y que además da un estatus frente al grupo. Por otra parte, lleva a que el alumno se desensibilice ante las consecuencias del maltrato, ya que concibe como algo normal que algunos miembros del grupo deban ser víctimas de situaciones violentas, produciéndose una habituación. En otros alumnos puede causar un efecto de hipersensibilización, llevando a desarrollar conductas de escape y evitación para no ser ellos el objeto del *bullying* o generando pensamientos y conductas de miedo al centro escolar que pueden provocar fobias, ansiedad, etc., ya que se concibe éste como un lugar inseguro con alto riesgo para ser objeto de situaciones intimidatorias.

FACTORES DE RIESGO PARA SER VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR

La práctica nos dice que cualquier menor puede ser objeto de una situación de intimidación o acoso escolar, ya que éste se da en los distintos contextos y puede desencadenarse por múltiples causas. Sin embargo, las investigaciones recogen ciertos perfiles de niños que suelen ser más vulnerables a ser objeto de situaciones de *bullying*.

Además de que existen otro tipo de factores externos al menor que pueden incidir en aumentar la probabilidad de ser acosado. A continuación describiremos los factores personales, familiares y escolares más significativos.

factores de riesgo o individuales

Respecto a los factores de riesgo individuales, encontramos que hay un gran cuerpo de investigaciones sobre los factores de riesgo individuales en la violencia juvenil en general (Farrington, 1998) pero la mayor parte de la investigación sobre factores de riesgo individuales de la violencia escolar se ha preocupado por el acoso escolar. Es de este nutrido cuerpo de investigación de donde recogemos los factores individuales que pueden funcionar como factores de riesgo para sufrir acoso escolar.

Pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los estudios son transversales en vez de longitudinales, de forma que no podemos identificar bien si estos factores funcionan como causa o como consecuencia del acoso escolar. Lo que sí pretendemos explicar es qué factores están relacionados y por tanto determinar en cuáles tendremos que actuar, ya sea de forma preventiva ya sea en una intervención terciaria, es decir, cuando haya surgido el problema.

Ol eus (2006) establece que los alumnos que sufren acoso escolar son más sensibles, tranquilos, reservados e introvertidos y tímidos. Que además, presentan mayores niveles de ansiedad, inseguridad, baja autoestima e infelicidad. Son más depresivos y presentan mayor tendencia a la ideación suicida que sus iguales. Normalmente tienen pocos amigos. Algunas de estas características, como por ejemplo la inseguridad y el autoconcepto negativo, pueden ser aumentadas por el acoso sistemático sufrido por el alumno.

En los estudios de Bond *et al.* (2001) se vio que las víctimas de acoso escolar tienen a ser ansiosas y depresivas y a tener una baja autoestima y que la victimización puede causar depresión y problemas de salud mental posteriormente (Rugby, 2003).

Con respecto a las habilidades sociales, Hésela *et al.* (2003) y Nansel *et al.* (2001) verificaron en sus estudios que las víctimas de acoso tienden a ser impopulares y a tener dificultades para hacer amigos fácilmente, a estar marginadas o desatendidas por parte de sus compañeros y a estar solos o tener pocos amigos.

Anteriormente se han analizado indicadores similares en las consecuencias del acoso.

actores amiliares

Respecto a los factores de riesgo familiare, se han estudiado algunas cuestiones como los estilos educativos familiares.

Baldry y Farrington (1998) encontraron en un estudio que el estilo autoritario predecía una mayor implicación en comportamientos de acoso, bien como agresor o como víctima.

Perry *et al.* (2001) encontraron que los mecanismos de afrontamiento desarrollados por los padres preocupados y/o debilitados cuando se combinan con la sobreprotección, control psicológico o control físico coercitivo por parte de los progenitores, predicen un comportamiento de víctima.

Las investigaciones de Bo ers, Smith y Binney (1992, 1994) encontraron que las víctimas mostraban una implicación alta y positiva con el resto de miembros de la familia y relaciones muy cercanas con los hermanos, lo que parecía indicar una familia protectora o inmiscuyente.

Ol eus (1993) investigó que la sobreprotección de las madres predecía a la victimización de los hijos. Además, encontró que otra práctica de crianza negativa era el caso en que el padre tuviera una conducta negativista hacia el hijo. Por lo tanto, para Ol eus las prácticas de crianza sobreprotectoras de las madres y los padres muy crí-

ticos y distantes que no constituyen un modelo masculino satisfactorio junto a niños con carácter tranquilo, prudente y sensible, tienen más probabilidad de llevar a los niños a situaciones de victimización.

Para concluir, se puede determinar según las investigaciones que el riesgo de convertirse en víctima es mayor cuando existe sobreprotección por parte de los padres.

actores de riesgo escolares

Dentro de los factores escolares encontramos en las diferentes investigaciones que aquellas escuelas más seguras son las que incluyen prácticas contra el acoso escolar, no solo desde un nivel informativo sobre qué es el *bullying* y las situaciones de intimidaciones sino desde un nivel formativo, donde un buen clima de centro y una sensibilización ante la violencia escolar son necesarias.

A continuación apuntaremos a algunos de los factores escolares que se han estudiado que correlacionan con el acoso escolar.

Se ha demostrado en algunas investigaciones (Mayer, 1992; Olweus, 1992; Funkenstein, 2001) que tener un sistema de gestión de la disciplina punitivo, unas reglas y expectativas poco claras y aplicar incoherente e irregularmente las normas disciplinarias, son factores en el incremento de los comportamientos agresivos, del absentismo y del vandalismo en la escuela. Respecto al tema de la aplicación de la disciplina, otras investigaciones recogen que la gestión de la disciplina es más eficaz cuando se incluye a los alumnos en la elaboración del sistema que se va a seguir en la escuela (Olweus, 1993).

El tratamiento que hacen los centros sobre los temas de violencia es fundamental para la prevención de la misma. Por lo tanto, la inclusión de temas sobre resolución de conflictos, mediación, formación para la prevención del acoso escolar, etc., ayudan a reducir las tasas de violencia escolar y de acoso en los centros. Besag (1984); Coie y Sharp (1998) han comprobado que si se incluyen en el currículum los temas sobre el acoso escolar y se incrementan las competencias sociales de los protagonistas practicando ejercicios como los “círculos de calidad”, se ayuda a luchar contra el maltrato entre iguales. La inclusión de medidas como los programas de mediación y de ayuda entre iguales también resultan efectivos (Torrego, 1999; Fernández 2003).

Por otra parte, una atención a la diversidad adecuada se ha recogido como uno de los factores de protección frente a los temas de violencia escolar. Así lo recogen algunas investigaciones como la de Sprague, Smith y Tieber (2002), que recogen que las altas expectativas de rendimiento académico por parte de los docentes y la adaptación del currículum a los progresos y capacidades de los alumnos es un aspecto fundamental para prevenir la violencia escolar y, por tanto, las situaciones de intimidación.

Otra cuestión es el fomentar en los alumnos un sentimiento de pertenencia al centro. Este factor fue estudiado por Blaya (2001) quien recoge que la participación en actividades extra-curriculares, que permita valorar otras habilidades de los alumnos además del éxito académico y la creación de relaciones entre los docentes y los jóvenes fuera del entorno del aula son circunstancias que tienen efectos positivos tanto para los adultos como para los alumnos/as.

Otra de las variables hacen referencia a la estructura del centro y a su tamaño. Felson en 1994 estudió que las escuelas con edificios grandes, varias entradas y escaleras, favorecen que se produzcan más altercados de violencia escolar que los que están en edificios pequeños y con menos alumnos. Dentro del tamaño y la estructura del centro, cabe destacar los sistemas de vigilancia. Olweus en 1993 investigó que el aumento en medidas organizativas simples y concretas como la supervisión de espacios como pasillos, patios, aseos, comedores..., disminuían la victimización entre los alumnos. Smith *et al.* (1994) y Debarbieux (1998) recogieron que la mayoría de estudios sobre la prevalencia del fenómeno de la violencia escolar y sobre todo del acoso escolar, muestran que ésta se mantiene con frecuencia escondida por falta de vigilancia. Este aspecto genera un sentimiento de impunidad para los agresores y un sentimiento de abandono y falta de reconocimiento para las víctimas.

Tras analizar los factores de riesgo para ser víctima de acoso escolar se clarifica algunas cuestiones que debemos trabajar en los centros para minimizar la posibilidad de que se produzcan situaciones de acoso escolar y para intervenir una vez que se han producido. Ese será el objeto del siguiente punto, donde analizaremos aquellas estrategias más adecuadas para prevenir e intervenir frente al acoso escolar que ya han sido apuntados en este apartado. Posteriormente analizaremos el plan PREVI de la Comunidad Valenciana, que es un paquete de medidas dirigidas a mejorar la convivencia en los centros escolares.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR

La intervención ante el *bullying* se debe realizar de forma preventiva. Es por ello que los centros deben adoptar medidas para evitar que ocurra el acoso, y si sucede tener previstas las actuaciones más adecuadas y rápidas para la intervención. Es por ello que clasificaremos las estrategias de intervención ante el acoso escolar en tres niveles: primario, secundario y terciario. En el *nivel primario* recogeremos las estrategias que se utilizan para prevenir que surjan las conductas de acoso. Tienen como objetivo desarrollar un clima adecuado de centro y que los alumnos desarrollen una serie de habilidades prosociales para mejorar sus relaciones interpersonales y el desarrollo personal. En el *nivel secundario* analizaremos las estrategias que se aplican con los grupos de riesgo donde vemos que existen problemas de conducta que pueden llevar a que se desarrollen situaciones de intimidación entre iguales. Finalmente, en el *nivel terciario* estableceremos la intervención que se ha de seguir cuando podemos confirmar que existe un caso de acoso escolar. Esta intervención tiene como objetivo principal ayudar a la víctima y restablecer las relaciones y el clima de centro.

Actuaciones a nivel primario

El objetivo a plantear en este nivel es el de crear una escuela segura a través de un modelo de convivencia armónico y pacífico. En este nivel vamos a clasificar las actuaciones en cuatro tipos, siguiendo los criterios que utiliza R. Ortega (2004):

Enfocadas al cambio de orientación escolar están basadas en la idea de que el centro es un sistema general de convivencia que hay que dinamizar de forma que facilite las relaciones positivas e impida, en la medida de lo posible, las negativas. Aquí destacamos:

- Sensibilizar a la comunidad educativa en los temas de acoso.
- Creación de una Comisión Anti-acoso dentro de la Comisión de Convivencia
- Mostrar a los alumnos/as una forma coherente de gestionar las relaciones interpersonales basadas en el diálogo, la cooperación y el enriquecimiento mutuo.
- Introducir en el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas temas de educación para la convivencia de forma específica y de forma transversal, como la educación para la paz, educación para el desarrollo moral y cívico, educación sobre los Derechos Humanos, etc.
- Establecer en el Reglamento de Régimen Interior la tolerancia cero a las situaciones de violencia y acoso escolar.
- Aumentar la supervisión de aquellas zonas donde se da el acoso y la violencia con más frecuencia (patios, entradas y salidas, pasillos, comedores, etc.).
- Informar, formar, asesorar e implicar a las familias.
- Creación de la comisión de delegados de alumnos/as: dentro de la cual se podrá crear una comisión anti-violencia donde se traten los problemas de acoso.
- Creación de un grupo de mediación en el centro.

Enfocadas a la formación del profesorado es necesario que el profesorado tenga unos conocimientos mínimos sobre cómo fomentar la convivencia y prevenir los actos violentos y el acoso escolar en general. Por lo tanto, las estrategias dentro de esta categoría las podríamos resumir en:

- Formar al profesorado para la detección de las señales que pueden indicar que un alumno puede estar siendo víctima de acoso.
- Fomentar que diseñen estrategias de actuación que dinamicen las relaciones en el aula y fomenten la convivencia.
- Formar en estrategias para el tratamiento pacífico de los conflictos.
- Desarrollar grupos de reflexión, discusión y trabajo en el centro para intercambio y análisis de los problemas más comunes y desarrollo de las estrategias de intervención.
- Creación de un documento de centro donde se establezca un protocolo de actuación ante las situaciones de acoso.

Enfocadas al desarrollo de actitudes en el aula son aquellas que pretenden intervenir directamente en el desarrollo de conductas prosociales en los alumnos con el fin de prevenir las actitudes violentas. Aquí debemos destacar:

- Favorecer un clima de clase armónico y la cohesión grupal, a través de dinámicas de grupo de conocimiento, cohesión, confianza, cooperación.
- Evaluar las relaciones entre los estudiantes y el clima de clase a través de sociometrías y cuestionarios para poder conocer qué alumnos pueden estar aislados o rechazados dentro del grupo de iguales.
- Introducir en el curriculum metodologías de carácter cooperativo.
- Trabajar las normas de clase a través de la asamblea de aula.
- Fomentar la tutoría individual y grupal donde se trabajen temas de convivencia.
- Desarrollar actividades de educación en valores, de educación emocional, actividades de estudio de dilemas morales y actividades para desarrollo de la empatía a través de *role-playing* y la dramatización.

Enfocadas al desarrollo de actividades dirigidas a la participación de los alumnos/as. Son estrategias generales de centro dirigidas al fomento de la participación de los alumnos/as en la resolución de los conflictos y en la creación de un sentimiento de pertenencia al centro. Aquí podemos encontrar:

- *Círculos de calidad*: un grupo de alumnos se reúne para analizar, investigar un problema y proponer una serie de soluciones. Este círculo de calidad puede plantearse en el aula o en el curso, ciclo, etapa, centro. El círculo de calidad también implica la realización de reuniones entre un grupo de alumnado y algún adulto para revisar y dialogar sobre la convivencia en el centro. Es una forma participativa de resolver los problemas.
- *Comisión de delegados de alumnos/as*: todos los delegados de todas las clases forman una comisión de delegados, donde se les puede asignar como función proponer estrategias para evitar los problemas de acoso y actuaciones concretas para cuando surjan estos problemas.
- *Actividades comunes positivas*: se trata de fomentar con el alumnado y con la implicación del profesorado y los padres actividades como excursiones, acampadas, fiestas o bailes organizados para que el alumnado se relacione entre sí en otros contextos y de otra forma.
- *Creación de un grupo de alumnos/as mediadores*: para la resolución de conflictos.

Actuaciones a nivel secundario

Cuando estimamos un riesgo claro para que las situaciones de intimidación se produzcan, hay que intervenir de manera directa y específica sobre casos y climas de clase concretos. De esta forma se pretende bajar el nivel de riesgo de aparición, y si aparecen, que duren lo menos posible. Las estrategias son:

- Evaluación de la situación de acoso en el aula: evaluar especialmente las exclusiones y agresiones verbales. Instrumentos: BULL-S (Cerezo, F), Sociogramas, etc.
- Acciones de tutoría individualizadas con aquellos alumnos que puedan tener un perfil tanto de víctima como de agresor, y actuaciones de tutoría grupal para fomentar un clima positivo de la clase y del centro.
- Facilitar la integración de los alumnos/as que puedan estar más marginados o puedan ser más fácilmente víctimas de acoso.
- Entrenar a los alumnos/as en sistemas de ayuda entre iguales como:
 - Alumnos supervisores de un grupo de estudiantes.
 - Tutores de otros chicos/as.
 - Ayudantes de los alumnos/as de primer curso y recién llegados a la escuela.
 - Ayudantes de recreo.
- Coordinación con distintas instituciones del entorno y la comunidad.
- Charlas informativas dirigidas a toda la comunidad educativa.
- Desarrollar un buzón anónimo de denuncias o una dirección de correo electrónico donde los alumnos se puedan dirigir para contar de forma confidencial lo que les pasa...
- Utilizar la mediación, los círculos de calidad, las comisiones de delegados de alumnos, y todas las técnicas utilizadas anteriormente para resolver los conflictos y las rencillas que pueda haber entre alumnos/as antes de que se produzcan las posibles situaciones de acoso.

Actuaciones a ni el terciario

En este nivel vamos a diferenciar tres tipos de actuaciones:

Actuaciones de urgencia consisten básicamente en velar por la protección de la víctima. Las estrategias son:

- Comunicación y valoración inicial: utilización protocolos del Plan PREVI de la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana u otros instrumentos como el “Test AVE” de Oñate, A. y Piñuel, I. de aplicación individual o el test Bull-S de Cerezo, F. de aplicación colectiva.
- Comunicación a las familias alumnos/as implicados (víctimas y agresores), Comisión de Convivencia, equipo de profesores, Inspector/a del centro, otras instancias externas, en casos graves denuncia de la situación.
- Incrementar la supervisión de los lugares donde se da la situación de acoso

- Establecer un clima de seguridad y confianza para que el alumno acuda sin miedo a contar lo que está pasando.
- Evitar que se queden solos la víctima y los presuntos agresores.
- Crear una red de apoyo para la víctima, que le acompañe y le ofrezca seguridad y confianza.
- Realizar cambios de grupo, si fuera necesario.
- Si es un incidente aislado y no existe un desequilibrio de fuerzas, se puede realizar una negociación o una mediación.
- Llevar a cabo las medidas cautelares dirigidas al presunto agresor.

Actuaciones generales para cambiar la dinámica social son actuaciones específicas para erradicar las actitudes violentas y cambiar la dinámica del acoso, ya que ésta se da en las relaciones sociales entre los alumnos.

- *Círculo de amigos* fortalecer los vínculos con los que el chico/a tiene relación e intentar ampliar la red de relaciones.
- *Tutoría entre iguales* un alumno que pueda ser líder positivo de la clase se le puede dar la responsabilidad de que ejerza una tutoría de acompañamiento con el alumno acosado. Se puede encontrar un desarrollo de cómo aplicar esta técnica en el libro de Sullivan, J., Sullivan, G. y Cleary, M.: *Bullying en la enseñanza secundaria* citado en la bibliografía.
- *Enfoque de ninguna culpa o Método de no inculpación*: intervención realizada por el orientador o por el tutor, donde se reúne a un grupo de 8-10 alumnos/as entre los que hay que incluir a los implicados en el acoso (agresores y espectadores), a personas líderes positivos del grupo donde se ha dado el acoso, y a amigos o personas cercanas a la persona acosada. Se plantea como un grupo de resolución de un problema donde todos tienen que aportar soluciones e implicarse en ayudar a la persona víctima del acoso. La persona víctima del acoso explica en una carta o en un dibujo cómo se siente en la situación que está viviendo. Esta carta es leída por la persona que dirige el grupo al mismo, y a partir de ésta se trata el tema. Se busca que los miembros del grupo empaticen con la víctima, se solidaricen con ella y se comprometan a ayudarla. También se puede encontrar un desarrollo de cómo aplicar esta técnica en el libro de Sullivan, J., Sullivan, G. y Cleary, M.: *Bullying en la enseñanza secundaria* citado en la bibliografía.
- *Método Pi* es muy similar a la técnica anterior, consiste en una intervención por parte del tutor o del psicopedagogo con las personas implicadas en la situación. Se trata de transmitir la preocupación por un alumno a un grupo de personas entre las que se encuentran los agresores. Se puede encontrar un desarrollo de esta técnica en el libro citado en la bibliografía de Avilés, J.M. *Bullying, intimidación y maltrato entre iguales*.

- *Actuaciones en la tutoría grupal:* utilización de programas de prevención del acoso escolar como: “Un día más” de la Comunidad de Madrid, los medios audiovisuales de la Carpeta de Formación para la Convivencia para el profesorado de educación secundaria y para el de educación primaria del Plan PREVI, editado por la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana, etc., con el fin de sensibilizar a los alumnos sobre qué es el acoso escolar, las consecuencias que tiene para las víctimas y para las agresoras. El objetivo es desarrollar una actitud crítica a las actitudes de abuso y concienciar sobre el problema. Se trata de concienciar a los espectadores de que rompan la ley del silencio, es decir, que denuncien y comuniquen aquellas situaciones que les puedan estar pasando a ellos o a compañeros suyos.

3. Actuaciones específicas: la dinámica del acoso escolar tiene repercusiones negativas en los diferentes agentes implicados: víctimas, agresores, espectadores. Por lo tanto, es necesario realizar actuaciones específicas en cada uno de los implicados para paliar estos efectos negativos.

a) Con la víctima

- Realizar la evaluación de los factores personales, familiares, escolares y sociales del alumno/a que puedan estar incidiendo y retroalimentando la situación.
- Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.
- Programas y estrategias específicas sobre:
 - Autoconcepto y autoestima, ya que seguramente pueden haber quedado dañados.
 - Técnicas de relajación y manejo del estrés: algunas técnicas de relajación podrían ser: la respiración diafragmática, la visualización, la relajación autógena, etc.
 - Entrenamiento en autoconocimiento y automotivación.
 - Habilidades sociales para mejorar su integración en el grupo y desarrollar un patrón de reacción asertivo frente a las agresiones (es decir, aprender a defenderse sin agredir a los demás).
 - Autocontrol en el caso de las víctimas provocativas, ya que nos encontramos en algunas ocasiones a alumnos/as que tiene comportamientos provocativos ante los demás, generando ser objeto de las agresiones.
 - Desterrar sentimientos de culpa y mecanismos de victimización.
 - Fomento de la resiliencia: entendida como la capacidad de superación de las adversidades saliendo fortalecido y transformado positivamente por la experiencia (Rutter, 1993). Incluye la capacidad de sobreponerse a los efectos nocivos de la adversidad, convirtiéndolos en factores de crecimiento personal y utilizándolos como revulsivo para mejorar la capacidad de afrontamiento de futuros contratiempos. Es necesario trabajarlo de forma preventiva, pero básico cuando un alumno ha sufrido las consecuen-

cias de ser maltratado por sus compañeros. El entrenamiento en resiliencia permite aumentar la invulnerabilidad y la capacidad de recuperación ante vivencias traumáticas siempre y que se sigan unas condiciones mínimas: empezar con una fase de mentalización previa que cree una disposición favorable, realizarlo convergentemente desde la familia y la escuela y, finalmente, si es posible, iniciar el entrenamiento antes de que pasen las adversidades. Algunas estrategias para trabajar la resiliencia, siguiendo a Vaello (2005):

- Exposición gradual a las situaciones problemáticas.
 - Despreocuparse: ayudar a estar por encima de las adversidades.
 - Hacerse invulnerable: la vulnerabilidad se puede aminorar mediante el convencimiento de que uno puede controlar cuánto le debe afectar una situación, como si estuviera protegido por una capa que le hace insensible.
 - Esperar a relajarnos: hacernos conscientes de que la tensión no dura toda la vida.
 - Abrir horizontes: visualización de éxitos futuros: las dificultades presentes se abordan mejor cuando se visualizan futuros éxitos y satisfacciones.
 - Ocuparse mejor que preocuparse: enseñar a tomar decisiones sobre cómo actuar en vez de preocuparse.
 - Desdramatizar: cuando la situación lo permita, el humor y el desenfado ayudan a afrontar los contratiempos.
 - Buscar vías de desfogue a través de la distracción.
 - Cultivar un estilo atribucional interno y controlable.
 - Plantear ante cada fracaso o problema un plan.
 - Abordar los problemas en compañía: tener el apoyo incondicional de una persona significativa dentro de la familia y otra dentro de la escuela ayuda a plantear los problemas.
 - Redimensionar: supone poner las cosas en su sitio, sobre todo aquellas insignificancias magnificadas que nos provocan malestar.
 - Practicar el surfing emocional: es un entrenamiento de la invulnerabilidad, es decir, aprender a que los problemas nos afecten lo mínimo imprescindible.
 - Visualización de situaciones sociales.
- Derivación a especialistas si fuera necesario (Salud Mental, Servicios Sociales, etc.).

b) Con los agresores

Algunas de las intervenciones a seguir más adecuadas con estos alumnos son:

- Evaluación de los factores personales, familiares, socioculturales, escolares, psicopatológicos, factores antecedentes, predisponentes y mantenedores de la conducta violenta.
- Medidas sancionadoras recogidas en el Reglamento de Régimen Interior.
- Programas específicos de modificación de conducta.
- Derivación a especialistas o a otras instituciones.
- Talleres específicos que pueden ser desarrollados de forma individual o en grupo:
 - Autocontrol: es necesario trabajar las distorsiones cognitivas que suelen presentar estos alumnos respecto a su estilo atribucional, ya que suelen percibir a los alumnos víctimas como culpables de lo que les pasa. Véase Serrano, A. (2006) *Acoso y violencia en la escuela: Cómo detectar, prevenir y resolver el bullying*. Ed. Ariel. Para trabajar las distorsiones cognitivas es necesario trabajar: Un estilo atribucional interno y controlable.
 - Empatía.
 - Habilidades sociales.
 - Recuperación de la autoestima.
 - Resolución de conflictos.

c) Con los espectadores:

El acoso tiene también efectos muy negativos para los espectadores. Por lo tanto, las intervenciones a llevar a cabo serán:

- Evaluación de los distintos roles de los espectadores.
- Intervenciones para romper la ley del silencio.
- Desarrollar mecanismos para la denuncia de las situaciones de acoso que viven.
- Actuaciones para desarrollar la empatía con las personas víctimas de acoso.
- Explicación de las consecuencias negativas que tiene la no actuación en estas situaciones.

d) Con la familia de la víctima

- Orientaciones sobre indicadores de atención y detección.
- Informaciones sobre posibles apoyos externos.
- Orientación familiar en pautas educativas para aumentar la autoestima y desarrollar las habilidades sociales.

- Pautas educativas para desarrollar estilos educativos democráticos que fomenten la autonomía del menor junto con el afecto y la comunicación.

e) Con la familia del agresor

- Orientaciones sobre indicadores de detección.
- Colaboración en las actuaciones conjuntas con el centro en la aplicación de las medidas sancionadoras y educativas.
- Orientación en pautas educativas democráticas donde se establezcan normas, se exijan responsabilidades y se fomente la comunicación y el afecto.
- Información sobre posibles apoyos externos.

Tras analizar de forma exhaustiva las estrategias y orientaciones sobre la intervención para la prevención y la actuación ante el acoso escolar, pasaremos a describir el Plan PREVI desarrollado por la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana.

EL PLAN PREVI DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA

En noviembre de 2005, la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana diseña y difunde el Plan PREVI: Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia. Este plan fue concebido para dar respuesta a las necesidades derivadas de los problemas de convivencia, detectadas por la propia comunidad educativa y contempla tres tipos de medidas:

- medidas de Prevención Dirigidas al Sistema Educativo para que se pueda intervenir con instrumentos sencillos y operativos y lograr que todos se sientan seguros. Dentro de estas medidas encontramos entre otras:
 - Registro Central: es un registro de incidencias *on-line* a través del cual los centros notifican los problemas de convivencia a su Inspector de centro, a la Dirección General de Innovación, Evaluación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional y a la Unidad de Atención e Intervención de la provincia correspondiente.
 - Los protocolos de detección precoz: es una herramienta de fácil aplicación que recoge los criterios para diagnosticar una posible situación de acoso dirigida a los alumnos/as víctimas y a sus familias.
 - Las carpetas de formación del profesorado: se han elaborado dos carpetas: una dirigida a los centros de secundaria, que incluye cuatro cortometrajes, además de información referente a cuestiones de convivencia para la formación de toda la comunidad educativa. La otra, dirigida a los centros de primaria, con dos cortometrajes y contenidos para trabajar en las tutorías, además de distinta información también para las tutorías.

- La elaboración de planes de convivencia por parte de los centros: desde la Consellería de Educación se reguló a través de la Orden de 31 de marzo de 2006 la obligación de los centros de elaborar un plan de convivencia que recogiera al menos tres tipos de medidas: medidas preventivas para favorecer el clima del centro, medidas dirigidas a los alumnos con alteraciones conductuales leves y un modelo de actuación ante las situaciones de acoso o *bullying*.
 - Convocatoria de buenas prácticas: todos los años se publica una convocatoria de premios para aquellos centros que realicen prácticas que fomenten la convivencia.
 - Congresos y Jornadas: se han realizado distintos congresos y jornadas dirigidos a la formación de equipos directivos y profesorado en general, sobre temáticas relacionadas con la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia.
 - Distintas publicaciones: se han elaborado cinco publicaciones dirigidas algunas al profesorado y otras a las familias con el fin de dar algunas herramientas sencillas para trabajar la convivencia. Estas son:
 - “Estrategias educativas para las familias”.
 - “Influencia de los videojuegos en niños y jóvenes”.
 - “Estrategias educativas para el profesorado”.
 - “Convivencia escolar: casos y soluciones”.
 - “Influencia de la televisión en niños y jóvenes”.
 - Página web orientados: en esta página web encontramos múltiple información sobre convivencia y acoso escolar en tres itinerarios: uno dirigido a las familias, otro dirigido al alumnado y otro al profesorado.
- medidas de prevención concretas dirigidas a la población en riesgo. Con ellas se pretende que todo alumno que pueda sufrir alguna situación de violencia se sienta inmediatamente atendido. Entre estas medidas destacamos:
- Protocolo de Actuación ante Situaciones Graves: se ha creado un protocolo específico sobre el procedimiento a seguir en casos de especial gravedad.
 - Unidades de Atención e Intervención: son unas unidades formadas por parte de un inspector/a y un psicopedagogo/a en cada una de las direcciones territoriales de educación de la Comunidad Valenciana, que tienen como finalidad intervenir en casos de especial gravedad, asesorar a centros y familias y sensibilizar a la comunidad educativa ante los problemas de convivencia.
 - Asistencia jurídica al profesorado: con el fin de apoyar al profesorado en su labor docente, se ha creado un protocolo para que éste, cuando sea objeto de una acción ilícita contra su persona por el desempeño de sus funciones, pueda denunciarlo y hacer uso de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana.

- Servicio de Asistencia Psicológica Externa: es una medida dirigida al alumnado, familias o docentes que requieran de una intervención especializada en psicología clínica derivada de un problema de convivencia.
- medidas de prevención y sensibilización dirigidas a toda la sociedad ya que para mejorar la convivencia toda la sociedad ha de verse implicada.

El PREVI pretende trabajar en un mismo plano con los docentes para proporcionarles herramientas y recursos que les ayuden a desempeñar sus funciones dentro de las aulas y en los centros, con un sentimiento de competencia, de capacitación y de eficacia, no solo en sus materias académicas, sino también en la gestión de su aula y las relaciones que en ella se dan.

Toda la información sobre las medidas explicadas en este apartado las podemos encontrar en la siguiente página web: www.edu.gva.es/eva/es/previ.htm

CONCLUSIONES

A lo largo del presente capítulo se ha pretendido analizar los problemas de convivencia que se pueden encontrar en los centros educativos, centrándonos especialmente en los problemas de acoso escolar, para posteriormente, pasar a describir una serie de técnicas, estrategias y recomendaciones que ayuden a los centros educativos a mejorar la convivencia y a prevenir las situaciones en las que los menores puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad, además de exponer la intervención más adecuada cuando nos encontramos ante casos de acoso escolar. Estas técnicas son una sugerencia que no tendrá ninguna efectividad si se aplican de forma descontextualizada sin un trabajo de centro donde la Comunidad Educativa esté cohesionada y donde el proyecto educativo haya sido consensuado, teniendo claros los objetivos basados en la mejora de la convivencia.

Es, por tanto, el primer paso que se debe realizar desde los centros: hacer un análisis y evaluación de la forma de funcionar del mismo como Comunidad Educativa, papel que no solo lo tiene que desempeñar el equipo directivo, sino que éste debe ser impulsor de un proceso de reflexión profundo. Para ello deberá encauzar una serie de vías de comunicación y participación donde todos los agentes (profesores, padres, alumnado) puedan aportar sus diferentes concepciones sobre las problemáticas del centro y cómo mejorar esas situaciones.

Como hemos planteado con anterioridad a lo largo del capítulo, es necesario construir escuelas seguras donde el menor se sienta protegido y donde la mejora de la convivencia se recoja como indicador de calidad educativa (así lo establece la nueva Ley Orgánica de Educación LOE) y esto solo es posible si se plantea una nueva pedagogía que revise ciertas prácticas no preventivas y en muchas ocasiones propiciadoras de conflicto escolar y de las situaciones de acoso.

Para ello, el profesorado deberá hacer uso del concepto de formación permanente, necesario en el nuevo mercado laboral del siglo XXI, y solicitar a la Administración su

derecho a poder llevarlo a cabo, y a las Universidades y a los centros de investigación el aporte de teorías con una sólida fundamentación científica para poder actualizar sus conocimientos pedagógicos, de forma que se adecuen mejor a la nueva realidad de su trabajo.

Además, es necesario hacer reflexionar a la sociedad de forma general y a los principales agentes socializadores junto con la escuela de forma particular (familias y medios de comunicación) que el trabajo de la institución escolar requiere de un acompañamiento en prácticas educativas en estos medios acordes con las prácticas desempeñadas por ella, de forma que estos agentes socializadores compensen y refuerzan la actividad escolar para que no ejerzan una fuerza descompensadora.

BIBLIOGRAFÍA

- Avilés JM. *Bullying: Intimidación y maltrato entre el alumnado*. Alava: STEE-EILAS. 2003.
- Beane, A. *Bullying Aulas libres de acoso*. Barcelona: Grao. 2006.
- Cascón F. *Educación en y para el conflicto*. Barcelona: Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos. Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB. 2004.
- Del Rey R, Ortega R. La mediación escolar en el marco de la construcción de la convivencia y la prevención de la violencia. *Revista Avances de Supervisión Educativa*. 2006. Nº 2. Enero.
- Defensor del Pueblo. Informe sobre violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria. Madrid. 2000.
- Defensor del Pueblo. Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria 1999-2006. Madrid. 2007.
- Del Rey R, Ortega R. *Construir la convivencia*. Barcelona: Edebé. 2004.
- Fernández I, Villaoslada E, Funes S. *Conflicto en el centro escolar: el modelo de alumno ayudante como estrategia de intervención educativa*. Madrid: Catarata. 2002.
- Garaigordobil M, Oñederra JA. Estudios epidemiológicos sobre la incidencia del acoso escolar e implicaciones educativas. *Revista Informació Psicològica*. 2008. 94, 14-35.
- Jiménez D, Martínez S. Análisis de los estilos educativos de los alumnos víctimas de acoso y agresores escolares. En: R. Roig. (ed.) *Investigación e innovación en el conocimiento educativo actual*. Alcoy: Marfil. 2008.
- Lucena C. *Bullying el acoso escolar*. Madrid: Ed. Asociación Mujeres por la Paz. 2006.
- MEPSYD. *Estudio estatal sobre la convivencia escolar en la educación secundaria obligatoria*. Madrid: Ministerio de Educación Política Social y Deporte. 2008.
- Oléus D. *Conductas de acoso y amenaza entre escolares*. Madrid: Morata. 1998.
- Ortega P, Minguez R, Gil R. *La tolerancia en la escuela*. Barcelona: Ariel. 1996.
- Piñuel I, Oñate A. *El acoso escolar en España*. Madrid: IIEDDI. 2007.
- Serrano A. *Acoso y violencia en la escuela. Cómo detectar, prevenir y resolver el bullying*. Barcelona: Ariel. 2006.
- Sullivan G, Sullivan J, Cleary M. *Bullying en la Educación Secundaria*. Barcelona: Ed. CEAC, Educación. 2005.
- Torrego JC. *Mediación de conflictos en instituciones educativas*. Madrid: Narcea. 2000.
- Vaello J. *Resolución de conflictos*. Madrid: Santillana. 2004.
- Vaello J. *Las habilidades sociales en el aula*. Madrid: Santillana. 2005.
- Worrell, J. *Bullying el acoso escolar*. Barcelona: Oniro. 2005.

ADOLESCENTES JÓVENES Y AGRESIONES SEXUALES

Vicente Angel Briet García

INTRODUCCIÓN

Debemos ser conscientes de que uno de los más importantes descubrimientos del primer proyecto de “Save the children” (Alonso, J.M; Horno, P. 2004) y de diferentes investigaciones sobre el abuso sexual y los delitos contra la libertad sexual, es que muchos agresores adultos inician su comportamiento desviado cuando son adolescentes y han llevado a cabo conductas de carácter ofensivo durante muchos años. Uno de cada dos ofensores sexuales adultos comenzó su comportamiento abusivo siendo adolescentes (Knight y Prentiss, 1993). Así mismo, se estima que aproximadamente un 20% de las violaciones las realizan menores de edad y el 50% de los agresores cometen su primer abuso antes de la edad adulta (Abel, Mittelman y Becker, 1985; Groth, Longo y MacFadin, 1982). La estimación es que un 30% de los abusos son cometidos por menores de edad, pero seguramente existe una subestimación del problema dado que estos datos solamente son la punta de un iceberg que progresivamente alcanza mayores dimensiones. En Estados Unidos se estima que los jóvenes son responsables de más de la quinta parte de las violaciones y de la mitad de los casos de ofensas sexuales a niños (Hunter, 2000).

Si nos atenemos a las cifras de incidencia y prevalencia, debemos de ser conscientes de que los estudios son relativamente recientes y es, a partir de los años ochenta, cuando comienza dicha investigación. De los datos aportados por Becker (1999) observamos que se estima que al menos un tercio de las agresiones sexuales son responsabilidad de adolescentes y jóvenes. No obstante, hay que ser conscientes de que muchas de las mismas no son detectadas o comunicadas por razones de negación y minimización del problema. Aunque la mayoría de los casos suelen pertenecer al género masculino, son varios los estudios clínicos que nos señalan la presencia tanto de mujeres adolescentes y prepúberes que manifiestan comportamientos abusivos.

Todos estos argumentos justifican sobremanera la necesidad de atender lo más tempranamente posible estas circunstancias para evitar que estos jóvenes se conviertan en adultos agresores. Hay que ser conscientes que estamos anulando un derecho fundamental de la infancia y es el derecho a la salud. En su artículo 24, la Declaración Universal de los Derechos del Niño dice “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”, y esto incluye a la salud sexual. Un menor que abusa, ofende o agrede sexualmente no es un menor sano y tiene todo el derecho a recibir apoyo, orientación y tratamiento para rehabilitar un aspecto que resulta disfuncional en su desarrollo personal, emocional y social. Llevar a la práctica un programa rehabilitador, promueve la posibilidad real de romper el ciclo del abuso, el acoso o la agresión.

Además necesitamos mejores herramientas en la detección y el diagnóstico para evaluar si las agresiones son básicamente sexuales y si los jóvenes sometidos a una medida concreta son ofensores reales y/o potenciales y determinar el tratamiento correcto. En la actualidad se adolece de modelos de intervención específicos en el campo del menor que permitan abordar de manera eficaz dichos tratamientos y el seguimiento que se ofrece a los jóvenes agresores en las centros de menores es inadecuado y en el enfoque actual se tiende a criminalizar a los menores agresores con el convencimiento de ser la medida más adecuada.

Si atendemos a la ley que regula la responsabilidad penal de los menores, comprobamos que su objetivo principal es el educativo, y sin embargo en cuestiones de esta índole el panorama es de un significativo abandono. El trasfondo de la ley que regula la responsabilidad penal de los menores promueve como objetivo central la educación y la rehabilitación, pero las medidas reales son fundamentalmente represivas y sancionadoras.

Esta capítulo está enfocado a reflexionar sobre la importancia de ofrecer un modelo de intervención adecuado para el trabajo con los menores, adolescentes y jóvenes infractores sometidos a una medida judicial en medio abierto, que tenga relación con la comisión de algún delito contra la libertad sexual tipificado como agresión sexual, abuso sexual o acoso sexual. Hay que ser conscientes de que muchos de los programas desarrollados hasta la fecha se han basado en enfoques destinados a intervenir sobre adultos desatendiendo cuestiones relacionadas con las peculiaridades y necesidades tan características del periodo evolutivo relacionado con la adolescencia y la juventud.

U ENTENDE OS POR AGRESORES SE UALES ADOLESCENTES UVENILES

Un agresor sexual joven o adolescente es una persona cuya edad oscila entre los 12 y los 18 años y que comete cualquier acto de tipo sexual contra la voluntad de la víctima, sin su consentimiento o de una manera agresiva, explotadora o amenazante. Muchas definiciones usan como criterio definitorio de abuso sexual, la diferencia de edad entre la víctima y el agresor, pero hay que tener presente lo inadecuado de este criterio si tene-

mos presente que aproximadamente un 30 % de los abusos se producen entre menores. Resulta por lo tanto más adecuado usar como criterio la presencia del poder y el control (en el sentido de “asimetría” que propone López, 1995), que el de la edad.

EL ARCO LEGAL ESPAÑOL

El marco legal de referencia en el cual se tipifican los delitos contra la libertad sexual es el Código Penal Español. Ley Orgánica 10/95, de 23 de Noviembre. En palabras de Noguerol (2005), “la libertad sexual, como bien jurídico protegido, es una parcela de la libertad en general, por lo que, en principio puede identificarse con el derecho a decidir en qué condiciones o circunstancias y con qué personas se realizan se reciben actos de naturaleza sexual”.

El Código Penal define abuso sexual como todo acto que atente contra la libertad o indemnidad sexual de otro, realizado sin el consentimiento de éste y sin que medie violencia ni intimidación. Se considera que el abuso sexual es sin consentimiento cuando se realice entre menores de trece años, en personas que se hallen privadas de sentido o con trastorno mental. También se considera viciado el consentimiento cuando se obtiene por el prevalimiento de una situación de superioridad en la que se cercena la libertad de la víctima. Puede darse abuso sexual cuando, aún contando con el consentimiento de la víctima, ésta es mayor de trece años y menor de dieciséis, pero el agresor se ha valido del engaño para viciar el consentimiento del menor.

El Código Penal establece la diferencia entre el abuso y la agresión sexual en que, en los abusos (Art.181), no puede mediar violencia ni intimidación, mientras que la agresión sexual está caracterizada por el uso de la violencia o la intimidación en la vulneración de la libertad o indemnidad sexual (Art. 178). A su vez, éste código define la violación (Art. 179) como el acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal o la introducción de objetos por alguna de las dos vías primeras, o miembros corporales y define exhibicionismo y provocación sexual como ejecutar o hacer ejecutar a otros, actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces (Art.185; L.O.; 15/2003). Y para finalizar, considera “acoso sexual”, solicitar favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, en el ámbito de la relación laboral o docente provocando en la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante, agravándose la penalidad si el acoso se comete prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas, así como cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación. (Noguerol, 2005).

ETIOLOGÍA

Para aproximarnos brevemente a los posibles factores causales y correlacionales asociados al problema, podemos prestar atención a una serie de elementos entre los que incluimos la historia de maltrato infantil, los factores relacionados con el estilo

de vida familiar, los factores relacionados con las habilidades sociales, los factores de aprendizaje y de socialización sexual, así como los factores relacionados con la salud mental y el consumo de sustancias tóxicas.

a La historia de maltrato

El papel que juega el maltrato infantil en la etiología del comportamiento ofensivo sexual parece notablemente complejo y los estudios que han tratado de dar luz en este fenómeno tienden a coincidir en que las tasas de victimización sexual, la precocidad en la experimentación de las conductas de tipo abusivo y la gravedad de las mismas suelen ser mayores en los adultos ofensores sexuales. Parece existir consenso en que la transmisión intergeneracional del abuso está presente en una proporción significativamente mayor que el resto de población.

Los estilos de vida familiar

Los elementos relacionados con el estilo de vida que más comúnmente se encuentran en los ofensores sexuales tienen que ver con la desestructuración de los núcleos de convivencia. Los perfiles familiares de riesgo son aquellos donde el menor ha experimentado la separación física y/o emocional de uno o ambos padres, ya sea por la inestabilidad familiar, la separación o el divorcio o por estar sujeto a una medida de protección o desamparo que lleve a un internamiento en las residencias de menores de la red de servicios sociales. Así mismo, si nos centramos en los aspectos relacionales propios de las familias desestructuradas, observamos que los modelos de comunicación intrafamiliar suelen ser bastante negativos y predomina la violencia en los mismos, la crítica excesiva, la desvalorización y la humillación como métodos disciplinarios.

En el plano de los afectos podemos hablar de una dificultad para encontrar fuentes de apoyo emocional, que suele traducirse en los menores en problemas para establecer vínculos emocionales y además son frecuentes las referencias de los menores a la distancia y la inaccesibilidad emocional de sus progenitores. Si prestamos atención a los modelos de socialización sexual paterna, comprobamos que el haber sido objeto de abuso sexual o la exposición a sus propias experiencias sexuales son experiencias que vive con más frecuencia quien manifiesta un comportamiento ofensivo en su adolescencia y juventud.

Cantón Cortés (1997) sugiere que el modelado ofrecido en las prácticas anteriores es un mecanismo de aprendizaje que puede intervenir en la conducta de los agresores sexuales.

c Las habilidades sociales

Son múltiples las investigaciones que nos ofrecen correlaciones entre los déficits en habilidades sociales y los problemas en el comportamiento sexual donde prevalecen las pobres relaciones con compañeros y el aislamiento social (Becerra, 1990, Knight y Prentiss, 1993, Feherenbah, 1986, Miner y Crimmins, 1995). La ansiedad social y el miedo a

las interacciones heterosexuales suelen a su vez estar patentes (Gatz, 1990). La capacidad para construir apegos está más disminuida y eso deriva en un pobre ajuste social que repercute en una propensión a las conductas sexualmente abusivas y agresivas.

d El aprendizaje y la socialización sexual

En este apartado aludiremos a las experiencias de aprendizaje que pueden condicionar una sexualidad disfuncional futura. Tal y como consideran Echeburúa y Gerricaechevarría (2000), la aparición reiterada de fantasías sexuales disfuncionales, asociadas, por ejemplo, al placer de la masturbación, especialmente en la pubertad y en la adolescencia, pueden facilitar que se condicione una atracción sexual disfuncional. No hay que olvidar además, que el sexo puede ser tanto fuente de placer como elemento reductor del malestar y la ansiedad emocional. Si un adolescente utiliza este mecanismo como un liberador de la angustia o la rabia contenida, no podemos olvidar el poderosísimo efecto reforzador que brinda el orgasmo, de manera que estas pautas de comportamiento sexual disfuncional queden fijadas ostensiblemente.

En referencia a la socialización, aludimos la falta de asunción de normas y límites en cuanto lo sexualmente saludable y lo que no. En este sentido las pautas educativas recibidas quizás hayan adolecido de crecimiento moral y/o hayan estado incorrectamente formadas, sin olvidar el modelado como fuente de aprendizaje.

e La salud mental y la personalidad

A pesar de no existir patología grave en los menores que agraden sexualmente, sí que son frecuentes los diagnósticos de trastornos del comportamiento y los rasgos de personalidad antisocial (Gavoussi, Kaplan y Becker, 1988; Miner, Siebert y Acland, 1997). Así mismo, los problemas de control de impulsos o la baja autoestima que frecuentemente ponen al menor en una posición que Echeburúa y Gerricaechevarría (2000) denominan “vulnerabilidad psicológica”. Cuando el menor presenta un vínculo inseguro con sus padres, puede desarrollar una visión negativa de sí mismo y sobre los demás y favorecer la pobre autoestima, las dificultades en la resolución de problemas, el escaso control de la ira o los pensamientos intrusivos. Además, Knight y Prentiss (1993) observaron que algunos factores característicos de los niños abusados sexualmente (empatía reducida, incapacidad para reconocer emociones apropiadas en otros e incapacidad para captar la perspectiva de otra persona) pueden tener relevancia para aquellos que agraden sexualmente. Las distorsiones cognitivas (culpar a la víctima, racionalizar el hecho abusivo) suelen también estar presentes en el pensamiento de estos menores.

f El consumo de sustancias tóxicas

Los estudios que valoran la relación entre el comportamiento sexual agresivo y el consumo de sustancias tóxicas varían ampliamente. Lightfoot y Barbaree (1993) encontraron cifras que oscilaban entre el 3,4% hasta el 72%. Es claro el potencial desinhibidor que puede presentar una pauta de abuso de sustancias tóxicas, pero plan-

tearnos que el consumo de drogas puede considerarse como responsable último del comportamiento abusivo, vulnera uno de los principios básicos de la intervención terapéutica con este tipo de problemática y que supone la asunción de responsabilidad. De otro modo, tal y como dice Noguerol (2005) “significaría fomentar las justificaciones y las minimizaciones que están en la base de muchas de estas conductas”.

INTERVENCIÓN

El tratamiento para los agresores sexuales es muy variado y puede ir desde el internamiento en régimen cerrado, hasta programas de carácter ambulatorio como el que más adelante vamos a detallar a modo de ejemplo. No existen demasiados estudios que reflejen la diferencia entre un enfoque de carácter ambulatorio y otro en régimen de internamiento. Uno de los estudios que mejor refleja la comparación entre ambos enfoques nos lo ofrecen Borduin, Henggeler, Blas e y Stein (1990). En este estudio los resultados obtenidos reflejaban que aquellos jóvenes que participaron de un enfoque “multisistémico” reincidían un 12,5 % para los comportamientos de tipo sexual y un 25 % para las ofensas no sexuales, mientras que los jóvenes que recibieron un tratamiento individual reincidieron un 75 %.

Todo programa terapéutico debería contemplar como objetivo principal ayudar a los menores a incrementar su control sobre el comportamiento abusivo, incrementar sus comportamientos prosociales, prevenir la victimización y detener la progresión en el desarrollo de problemas psicosexuales. Los formatos pueden ir desde la intervención individualizada hasta el formato de carácter grupal y la asistencia a las familias.

Aunque la terapia de carácter grupal se erige como el tratamiento de elección, falta evidencia empírica que demuestre la efectividad superior de este enfoque. El trabajo grupal sin embargo puede facilitar que emerjan vivencias, pensamientos y emociones en un entorno protegido con un problema común compartido y actuar como catalizador de procesos individuales, así como la participación activa.

Son varios los autores que argumentan que los programas enfocados exclusivamente en las conductas de carácter ofensivo, son de un valor limitado y proponen una visión más global (Goocher, 1994). Algunos enfoques han procurado una intervención interdisciplinar que incluyera el soporte farmacológico con fármacos inhibidores de la recaptación de la serotonina (ISRS) por su potencial reductor del deseo sexual, pero es todavía poca la investigación al respecto y habría que ser muy precavido en el análisis de que sujetos serían candidatos idóneos para someterse a tal enfoque complementario y en que dosis (Hunter y Lexier, 1988).

Cuando existe una excitación sexual muy desviada de los parámetros que dicta los criterios de salud sexual, resultan eficaces las técnicas de modificación de conducta tales como la sensibilización encubierta y otras de carácter aversivo que pretenden bajo los principios del condicionamiento conductual, reducir la excitación a base de establecer asociaciones entre dichos estímulos desviados y las posibles consecuencias futuras de carácter negativo. La investigación sobre esta cuestión es limitada (sobre todo en adolescentes) aunque parece que puede resultar más efectiva

en jóvenes que son sexualmente excitados por niños pequeños (Feinrott, Riggan y Frothingham, 1997).

Además, no hay que olvidar el importante papel que puede jugar el apoyo familiar de cara a reducir el riesgo de recidiva. Parece demostrado (Rasmussen, 1999) que ésta es una variable relevante en el pronóstico de reincidencia, y es que aquellos casos en los que se logra el adecuado apoyo familiar se incrementa la efectividad de los mismos.

En adelante vamos a presentar un programa tipo que podría ser un ejemplo de lo prioritario a trabajar en esta área de intervención tan específica y la vez importante y necesaria. Centrándonos en el programa propuesto y el contexto en el cual se ubicó, procedemos a detallar las características del mismo.

Nuestro programa se ubicó en un escenario de trabajo sobre la infancia y la juventud en situaciones de riesgo y donde se hace patente la vulnerabilidad de los menores. Este escenario es la fundación Nazaret. Desde el año 1993, uno de los recursos que ofrecemos en dicha Fundación es el abordaje de las problemáticas que manifiestan los menores de la ciudad de Alicante entre 14 y 18 años que han cometido delitos y se les ha impuesto una Medida Judicial en Medio Abierto. Se les presta la atención socioeducativa necesaria para facilitar su integración en la vida comunitaria, se potencian sus capacidades, se media en sus circunstancias conflictivas y se les posibilitan oportunidades de crecimiento.

Para ello Nazaret dispone de un equipo de educadores cuya metodología de trabajo se basa en conseguir ser un referente significativo para el/la menor y establecer una relación basada en el respeto, confianza, cercanía y empatía. Intervienen en los diferentes factores que inciden en la realidad del/la menor, y llevan acciones planificadas en todos los ámbitos de su vida: individual, familiar, socio-cultural, formativo-laboral, grupal y comunitario y que sustenta el convencimiento de apostar por un enfoque de carácter “multisistémico” al que antes aludíamos.

Son ejes básicos de la intervención la inserción laboral y la prevención a través del trabajo con grupos. Desde hace cuatro años se realizan en Nazaret talleres sobre formación laboral en mensajería, prevención del consumo de drogas, prevención de la violencia de género, educación vial, preparación del Graduado Escolar, alfabetización, educación en valores, vídeo forum y actividades deportivas, y además se ha creado un departamento de Inserción Laboral que se comparte con los otros programas. También lo son el apoyo y orientación a las familias, la mediación con los recursos comunitarios (informando de los recursos existentes, capacitando y mediando para su acceso e integración), y el trabajo con las pandillas.

Se coordinan las intervenciones sociales, jurídicas, sanitarias y educativas en un plan integral común. Se realiza un trabajo educativo en la calle y de red en los barrios con el fin de abrir puertas. Las razones que fundamentan la necesidad de una atención más especializada en el contexto de las agresiones y las situaciones de violencia de tipo sexual son fundamentalmente el incremento de situaciones de agresión sexual que cada vez son más denunciadas y que necesitan de un abordaje más especializado y a la vez desde una perspectiva ecológica y global, y que va más allá de las medidas de libertad vigilada o internamiento. Fruto de la satisfacción de esa necesidad nace esta aproximación teórico-práctica.

Fundamentación teórica del programa

La fundamentación teórica de un “programa de control de la agresión sexual” puede basarse en varios modelos que expliquen la problemática de la agresión sexual. En nuestro caso nos hemos decantado por el modelo del ciclo del abuso (Lane, 1991) para explicar la génesis de dicha problemática y acudimos al modelo de Carnes para explicar su mantenimiento: el modelo adictivo en el abuso sexual realizado por niños o adolescentes (Carnes, 1983), tiene su base teórica en la teoría del aprendizaje, considera el orgasmo como un poderosísimo reforzador, e hipotetiza que este refuerzo puede ser el resultado de la conducta de abuso sexual o de la fantasía sobre la ejecución de esa conducta de abuso antes de llevarla a cabo. Puesto que toda conducta sexual compulsiva responde a un ciclo adictivo bien organizado, resulta de importancia que el agresor lo conozca

Así mismo, acudimos al modelo explicativo de la delincuencia sexual de Marshall y Barbaree (1989) con especial atención a la confrontación de los patrones cognitivos prodelictivos, así como en el modelo de estilo de vida criminal del G.D. alters (1989) y en el modelo de prevención de recaída de Pithers (1987;1988).

Supuestos que fundamentan el programa

Son varios los supuestos que deben fundamentar cualquier intento de intervención sobre la agresión sexual en menores. En nuestro caso optamos por entender este fenómeno desde los siguientes:

- La adolescencia es un periodo de alta receptividad para lograr cambios significativos en una intervención reeducativa de cualquier índole y más específicamente la sexual.

El abuso sexual no se cura con el paso del tiempo

El tratamiento temprano puede evitar la transición a adulto agresor sexual.

El acto de cometer una agresión sexual es el resultado de comportamientos, sentimientos y pensamientos que se convierten en patrones predecibles.

Los agresores son un grupo heterogéneo. Ello deriva en la necesidad de ajustar el tratamiento de manera idiosincrásica.

La evaluación precisa detectará los aspectos comunes y diferenciales para el plan de intervención integral.

La puesta en práctica de programas promueve el avance en la evaluación, el diagnóstico diferencial, los modelos explicativos y el tratamiento específicos del campo del menor.

Los estudios sobre la reincidencia avalan la tesis según la cual aquellos sujetos que han recibido tratamiento obtuvieron sistemáticamente mejores pronósticos de no reincidencia que aquellos que no lo habían recibido o lo habían rechazado (Garrido, Stangeland y Redondo, 2006).

Criterios de participación en el programa

Optamos por la inclusión de algunos criterios para la inclusión de los menores en el programa de intervención dado que se hace necesario poder establecer unos mínimos elementos sobre los que establecer la idoneidad o no de su participación en el programa. Estos fueron:

Tener entre 14 y 18 años.

Tener un nivel madurativo y de inteligencia mínimo que no invalide su participación.

- Que la sentencia o medida proponga el tratamiento específico de la agresión sexual cometida.

Permeabilidad al cambio. Tras un periodo oscilante entre uno y tres meses de evaluación, valoración del reconocimiento y empatía, se valora su idoneidad para tratamiento (entre 6 meses a 1 año).

Datos relativos a la composición del grupo tratado

Los siguientes datos tienen que ver con el perfil de los componentes del grupo que tratamos en el programa atendiendo a criterios tales como edad, tipo de delito y tipo de medida impuesta por el juez.

	Su eto	Su eto	Su eto	Su eto	Su eto
Edad	15	15	17	16	14
Tipo de delito	Acoso sexual	Acoso sexual	Agresión sexual	Agresión sexual	Abuso sexual
Tipo de medida	Libertad vigilada (cautelar)	Libertad vigilada (cautelar)	Libertad vigilada (cautelar)	Libertad vigilada (cautelar) Internamiento en régimen cerrado	Libertad vigilada (cautelar)

Evaluación

Para la evaluación “general” optamos por seguir parte del modelo ofrecido por Garrido y Beneyto (1995) donde se propone la autobiografía como instrumento de evaluación de las primeras sesiones y que divide la evaluación en la profundización de las siguientes áreas, a saber: general, familiar, social, sexual y delictiva y sobre el

que hemos efectuado modificaciones para adaptar las preguntas al contexto del menor y más específicamente a un perfil de menores en situación de exclusión social, que en definitiva ha sido el porcentaje mayoritario de menores atendidos, donde las características cognitivas e intelectivas a veces están tan empobrecidas que dificultan la comprensión de las preguntas a efectuar. En cualquier caso, hay que ser conscientes de que existen escasos recursos evaluativos adaptados a población adolescente y joven.

Para la evaluación “específica” de la agresión cometida optamos por seguir el protocolo de explotación de datos de Advocacy (Save The Children, 2004) en el que se valoran cuatro ejes perceptivos:

Eje I: percepción con relación a la víctima y daño infringido a ésta.

Eje II: percepción con relación a él mismo como sujeto de la acción ofensiva y con relación a su sexualidad.

Eje III: percepción con relación al Apoyo / Rechazo de la familiar nuclear- y/o familia extensa, y/o tutores/cuidadores.

Eje IV: percepción con relación al Apoyo / Rechazo del contexto social, instituciones, servicios, vecindario...).

A su vez, optamos por añadir la evaluación de las distorsiones cognitivas (desde un punto de vista cualitativo) y donde resulta de interés complementarla con el esquema que nos brinda el análisis funcional del comportamiento. Para la evaluación de la personalidad nos hemos apoyado en los instrumentos que nos brinda la evaluación psicológica en el campo de la adolescencia (CDS, HSPQ, AD o el cuestionario de autocontrol infantil y adolescente, por mencionar algunos).

Sobre la evaluación, debemos comentar que existen problemas para evaluar el riesgo de reincidencia. No obstante, para valorar la misma hemos seguido como criterio-guía los elementos aportados por los siguientes instrumentos:

SVR- . Esta guía es una valoración (con formato de listado de chequeo de 20 ítems) de factores de riesgo de violencia sexual, que contempla tres áreas que son el funcionamiento psicosocial, los delitos sexuales y los planes de futuro, y que se puede aplicar en poblaciones de delinquentes sexuales jóvenes y adultos. El resultado de la valoración permite la calificación de tres niveles de riesgo de violencia sexual (bajo, moderado y alto). El grado de validez predictiva es de 0.83 sobre 1.

Perfiles de riesgo de la conducta abusiva (Vazquez Rosoni y otros, 2005) donde se establecen diferentes criterios basados en las siguientes áreas: ambiente familiar, historia sexual y ajuste, reconocimiento de responsabilidad, problemas de comportamiento y nivel de fuerza y agresión física a la víctima. El resultado de la valoración permite la calificación de tres niveles de riesgo de conducta abusiva (bajo, moderado y alto).

Los componentes de dichos criterios son los siguientes:

Riesgo bajo:

primera ofensa,
admisión total o parcial de responsabilidad,
familia que apoye,
ausencia de historia de consumo de drogas,
relaciones y sentimientos adecuados hacia amigos y compañeros,
ausencia de violencia,
ausencia de comportamiento sexual agresivo,
ausencia de fantasías de carácter violento.

Riesgo moderado:

más de una ofensa sexual,
historia de otras conductas criminales,
minimización o negación del hecho,
proyección de responsabilidad en la víctima,
inapropiado apoyo familiar,
presencia de consumo de drogas,
destrezas pobres en las habilidades sociales,
baja autoestima o autoimagen distorsionada,
no percibir su comportamiento como problema,
la ofensa es más seria.

Riesgo alto:

comportamiento sexual predatorio,
fantasías y comportamiento violento,
ofensas serias, despersonalización de la víctima, violencia sádica, ritualista o extraña,
culpa a la víctima,
uso de amenazas o fuerza,
familia que no responde a las necesidades afectivas/básicas del joven,
historia severa de abuso,
rechazo al tratamiento,
ofensas múltiples,
víctimas infantes o discapacitadas.

En la actualidad la ausencia de medidas de evaluación fiables y válidas, así como diseñadas específicamente para este momento evolutivo tan peculiar, condicionan sobremanera cualquier intento de análisis específico y supone uno de los actuales retos de cualquier intervención sobre menores. No obstante, existen algunas escalas para adolescentes referidas a aspectos cruciales tales como:

La empatía: escala de empatía con la víctima para adolescentes (Becerra y Kaplan, 1991) el cual consta de 10 ítems para la valoración de la actitud empática del agresor durante la comisión de los hechos.

Las distorsiones cognitivas: escala cognitiva de adolescentes (Becerra y Kaplan, 1984).

Así mismo, podemos aproximarnos a escalas no específicamente diseñadas para menores pero que pueden resultar de utilidad para valorar actitudes de corte machista y con garantías psicométricas suficientes. Pueden resultar de utilidad las siguientes:

Double Standard Scale (DDS) (Caron *et al.*, 1993) el cual permite valorar la doble moral sexual.

Rape Supportive Attitude Scale (RSAS) (Lottes, 1991) que mide la actitud favorable hacia la violación.

Tratamiento

El enfoque terapéutico ha estado diseñado tomando como referencia las intervenciones con más de una base empírica dentro del campo de la delincuencia juvenil (tal como el enfoque multisistémico) que pueden resultar efectivas. En este caso, el compendio de áreas trabajadas nace de la convicción de su necesidad de trabajo una vez evaluados los perfiles de los menores integrantes del programa y siempre tomado éste como complemento al enfoque multisistémico ofrecido por nuestra institución.

reas de trabajo

Reconocimiento del problema y tomar responsabilidad con respecto sus acciones

La responsabilización de la acción cometida es la primera piedra de la prevención de la reincidencia. No obstante, y a pesar de que los menores presentan un reconocimiento inicial de su comportamiento superior al de la población adulta, este es uno de los principales escollos iniciales que debemos de superar. Las razones residen principalmente en el conceptualizar el programa en un contexto judicial. Si esto ocurriera en un contexto de carácter clínico, presuponemos que el adolescente se sentiría más libre para confrontar el reconocimiento de su problema.

La mayoría de los agresores sexuales que reciben tratamiento lo hacen de forma obligada, por requerimiento judicial, y por ello no suelen estar motivados para el cambio, por lo tanto el primero de los objetivos es que asuman su comportamiento como un problema y que como tal pueda ser modificado. Los fenómenos más frecuentes que solemos encontrar durante este proceso y que operan a modo de mecanismos defensivos son:

La *negación*: afirman que no ha sucedido ninguno de los hechos imputados o que la víctima miente.

La *minimización*. Reconociendo una pequeña parte de los hechos denunciados, atribuyendo el resto a mentiras, exageraciones o a la interpretación de terceras personas.

El *reconocimiento parcial* pero restando importancia a las consecuencias o minimizando las consecuencias de la agresión.

En este estadio inicial se hace conveniente intervenir sobre las justificaciones y excusas sobre los que se asienta la negación de su conducta, que suelen producirse para mantener su implicación en el abuso sexual sin experimentar ansiedad, culpa o depresión, si es el caso de haber sido en el pasado víctima de abuso.

Como terapeutas nos debemos enfrentar de manera directa pero a la vez empática, indicándole sus errores y confrontando con el máximo de información recabado a través de la sentencia y los datos aportados por terceras personas (educador responsable y familiares fundamentalmente).

Otras posibles dificultades relacionadas con el reconocimiento residen fundamentalmente en:

- La dificultad para diferenciar emociones y comunicarlas, así como para diferenciar emociones de pensamientos. En este plano es especialmente importante el manejo de la rabia.
- El déficit de aprendizaje emocional básico que está en la base de la falta de empatía que los agresores muestran hacia la víctima.

El primer paso que contribuye a la modificación del comportamiento es el reconocimiento del abuso, no solo desde el ámbito cognitivo, sino con coherencia emocional y comprensión ideo-afectiva de lo vivido por la víctima.

En el caso de un no reconocimiento inicial puede resultar aconsejable ir avanzando progresivamente en su reconocimiento, marcándonos aproximaciones sucesivas al mismo para ir aumentando a compromisos más complejos que ayuden a mitigar las resistencias iniciales. En ese sentido, la intervención se centra en incrementar la educación sexual y trabajar aspectos relacionados con la socialización, el respeto y las normas de convivencia centradas en lo sexual, incrementar sus habilidades sociales y de comunicación, su capacidad de resolver problemas, sin olvidar en todo momento el objetivo de que el agresor reconozca los hechos. Sabemos que en muchos casos esto ocurre en estadios avanzados. Si y solo si existe reconocimiento pasaremos a la fase posterior. En

caso contrario el programa de educación sexual y el enfoque terapéutico multisistémico que brinda el área de “medidas judiciales” se mantendrá hasta agotar la medida.

Conciencia emocional y empatía

Nos referimos en este sentido al trabajo relativo a la identificación de los sentimientos, pensamientos y situaciones que lo exponen a repetir el acto abusivo. Además, en el déficit en el aprendizaje emocional básico está la base de la falta de empatía que los agresores suelen mostrar hacia las víctimas.

Por empatía no debemos entender solamente la capacidad cognitiva de comprender e identificarse con el punto de vista del otro, sino que han de enfatizarse los componentes cognitivos, afectivos y comportamentales.

Para ello resulta conveniente que los menores efectúen un análisis de las consecuencias negativas (daño causado) que provocan el abuso desde el punto de vista de los sentimientos, pensamientos y comportamientos a partir de historias de abuso reales y ficticias. Los juegos de cambio de rol (reales o por escrito) y el diálogo socrático son estrategias eficaces para incrementar el entrenamiento en empatía.

Reestructuración de las distorsiones cognitivas

Partimos del análisis efectuado en la evaluación individualizada (mediante las escalas diseñadas al efecto y la entrevista) para detectar las distorsiones cognitivas y las creencias erróneas más arraigadas y modificarlas mediante educación sociosexual.

Educación y socialización sexual

El objetivo fundamental de esta área supone distinguir comportamientos sexuales abusivos de los no abusivos, distinguir muestras de afecto de comportamiento abusivo, analizar los mitos y creencias erróneas en torno al abuso, para acabar construyendo una definición de abuso entre los participantes, partiendo de historias e imágenes que estimulen el análisis y la reflexión, así como la toma de conciencia de las repercusiones legales y personales que conlleva el abuso.

Aludimos a la socialización sexual, donde nos planteamos como objetivos fundamentales los siguientes:

Distinguir los comportamientos sexuales ofensivos de los que no lo son.

Distinguir que son muestras de afecto de ofensas.

Analizar mitos y creencias erróneas en torno a las ofensas.

Tomar conciencia de las repercusiones legales y personales que conlleva el comportamiento ofensivo.

Reparación del daño

En las etapas finales del proceso se hace necesario contemplar el análisis y la puesta en práctica acciones reparatorias imaginadas o reales (en los casos que lo indiquen)

en beneficio de las víctimas. Los juegos de rol, la redacción de cartas son las estrategias de elección para esta área.

6°. Modificación de la secuencia de sucesos

Aludimos con ello al análisis sobre la secuencia de pensamientos, sentimientos y situaciones que pueden llevar a un menor a cometer un abuso. Una vez que una persona conoce su propia secuencia de sucesos, puede aprender otras formas de reaccionar a los sucesos identificados en la secuencia.

En dicha secuencia resulta conveniente identificar los factores de bajo, moderado o alto riesgo. Cada individuo tiene su propia secuencia, y aunque existen elementos comunes a los menores integrantes del programa, se hace conveniente efectuar un análisis individualizado de los eslabones de cada secuencia y aprender pasos alternativos e incompatibles, así como estrategias de afrontamiento a los elementos identificados con algún grado de riesgo. El análisis de las necesidades que satisfizo la agresión sexual y satisfactores alternativos a la misma también se contempla en esta área.

Plan para una vida libre de abusos la prevención de recaídas

Generalmente los comportamientos abusivos no son conductas impulsivas sino que de una u otra manera obedecen a una planificación. En ese sentido el objetivo prioritario de esta área de trabajo supone analizar las situaciones de riesgo de reabuso y desarrollar actividades eficaces para prevenirlos.

Aquí se hace necesario que los menores adquieran destrezas para:

Reconocer las decisiones y las condiciones que sitúan a los menores en riesgo de reincidencia.

Planear, desarrollar y practicar un abanico de respuestas de enfrentamiento a las situaciones y elementos identificados como de alto riesgo.

- Manejar las dificultades en el control de la excitación sexual mediante estrategias de corte conductista (saciedad, control de estímulos, aversión encubierta).

Desarrollar estrategias para reducir la probabilidad de que un fallo provoque de manera inmediata una recaída.

- Realizar modificaciones del estilo de vida que promuevan la abstinencia continuada en el caso de coexistir patrones de uso o abuso de sustancias tóxicas.

Enfrentarse a su medio en relación a lo profesional, en las destrezas de relación social y en la capacidad de autocontrol frente a situaciones estresantes.

Durante el transcurso del programa así como a la finalización del mismo fijaremos unos criterios de evaluación-consecución de la eficacia del mismo y que se traducen en los siguientes indicadores:

En el área emocional:

que los menores reconozcan emociones en sí mismos y en los demás,

que desarrollen empatía hacia las víctimas,

- que identifiquen las señales que pudieran desencadenar el patrón personal de conducta abusiva.

En el área cognitiva:

- que superen las distorsiones cognitivas que justifican o minimizan el abuso,
- que identifiquen los pensamientos que pongan al menor en riesgo de repetir el patrón abusivo.

Y en el área conductual:

que reconozcan la agresión sexual con coherencia ideo-afectiva,

que desarrollen habilidades sociales para satisfacer necesidades que antes lo fueron por el abuso sexual,

- desarrollar habilidades para resolver conflictos y enfrentar la sexualidad sin dañarse ni dañar a otros,

la no reiteración de conductas violentas en el área sexual u otras.

LAS RECIDIVAS

Hay muy pocas características que realmente tengan una asociación empírica con la recaída. Según einrott (1998) se incluyen las siguientes: la psicopatología, la excitación sexual desviada, las distorsiones cognitivas, el absentismo escolar, una ofensa sexual previa (conocida) culpar a la víctima y el uso de la fuerza o la amenaza. Contrario a la creencia común, factores como los déficits en habilidades sociales, la falta de empatía o la negación de la ofensa o intento sexual no han sido empíricamente asociados con la recaída o simplemente no han sido investigados. No obstante, el sentido común dicta que esta debe ser la línea de trabajo a desarrollar terapéuticamente y en el plano de la investigación.

Los datos referidos por los estudios sobre las tasas de reincidencia son muy variables, puesto que las variaciones metodológicas de los estudios en aspectos como la definición de reincidencia (un nuevo arresto o una nueva sentencia) o la duración del seguimiento (Prent y *et al.*, 2000) alteran los tantos por ciento de los estudios. El rápido desarrollo y cambio que se produce durante esta etapa motiva que se deban distinguir los cambios que ocurren de manera natural, a los ocurridos con motivo del tratamiento. Además, tras haber sido acusados (reciban tratamiento o no) factores como la disuasión, la humillación, la falta de oportunidad, el incremento de la vigilancia pueden entre otros alterar unos datos (oscilan entre 8 al 54 de reincidencia según los estudios) que generalmente muestran tasas bajas de reincidencia (einrott, 1996).

CONCLUSIONES

Se hace necesario el diagnóstico diferencial caso a caso antes de cualquier intervención para efectuar un tratamiento adaptado al campo de la adolescencia y la juventud. Aunque toda intervención sobre agresiones sexuales presente elementos comunes que requiere de un mismo enfoque, la tipología de la agresión (si es acoso, abuso o agresión) requiere de un trabajo más específico o incluso menos profuso. No todos los jóvenes agresores requieren de un tratamiento prolongado. Una historia de abuso sexual no elaborada obviamente requiere de mayor duración en la intervención.

Coincidiendo con las conclusiones del estudio de Richardson y Graham, (1997), al efectuar la evaluación descubrimos aspectos que resaltan las diferencias significativas con los ofensores sexuales adultos y que condicionan poderosamente cualquier intervención terapéutica, a saber: el conocimiento sexual es más pobre en los adolescentes. El papel de la fantasía como precursora del abuso está menos claramente comprendido y a su vez parece menos significativo que en los adultos, y así mismo las conductas de los menores están mucho menos fijadas. El papel de la familia es mucho más crítico con los adolescentes. Las estrategias de perpretación son menos sofisticadas y consistentes en los menores, pero los factores situacionales y de oportunidad parecen constituirse más como factores precursores de los comportamientos ofensivos.

Los factores cognitivos operan como precursores con menor frecuencia que en los adultos y las distorsiones cognitivas están menos desarrolladas. A diferencia con los adultos, los adolescentes viven en un mundo social con diferentes valores, creencias y expectativas, y tienden a ser emocionalmente más inestables. El papel que desempeña la familia en los más jóvenes es mucho más crítico y no debemos olvidar que su personalidad todavía está en proceso de desarrollo. Muchos adolescentes que abusan han sido abusados sexualmente, pero están temporalmente más próximos a estas experiencias abusivas que los adultos. Así mismo, suelen presentar muy pocos incidentes de conducta abusiva y los más jóvenes suelen anticipar grados de control externo de su conducta por los padres y educadores, y los contextos éticos y legales son significativamente distintos entre ellos y los adultos.

ELEMENTOS DETERMINANTES PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO

Más importante que asistir a un número determinado de sesiones, resulta relevante el compromiso y la conexión emocional y cognitiva de los menores. Esta es más factible, cuanto menor sea el perfil antisocial del menor. Lograr la involucración familiar en el proceso favorece la implicación y el avance en el logro de los objetivos, aunque el problema fundamental reside en la alta proporción de familias desestructuradas que se esconden tras este tipo de problemáticas.

El avance en la identificación de los factores de riesgo mejorará el mejor indicador de la eficacia de un programa: la no reiteración de las conductas violentas en el área

sexual. Las dificultades de evaluar estos aspectos a medio y largo plazo dificultan la posibilidad de testar la eficacia de las intervenciones.

El formato clínico de cualquier programa y su desvinculación parcial de contexto judicial se convierte en un marco idóneo que permite proyectar sobre los jóvenes, que el escenario de la intervención se convierta en un contexto más seguro para que asuman su responsabilidad con respecto a los hechos y eso permita la continuidad de la intervención.

Respecto a las intervenciones, hay que tener presente siempre una evaluación individualizada una vez analizados los factores de riesgo. Tras esa evaluación, todo programa debería sostenerse en un análisis periódico que contemple objetivos medibles, con cambios observables y donde se pueda acreditar una capacidad demostrada para aplicar los cambios efectuados en situaciones cotidianas.

Ya para terminar, no debemos olvidar que sería deseable que incluso el lenguaje que utilizamos para describir este fenómeno fuera menos determinista e incluyera referencias en términos de comportamiento y no en términos de categorías diagnósticas. Un lenguaje que ponga el acento en el comportamiento y no tanto en la persona puede ayudar a reducir la probabilidad de aparición del fenómeno de la “profecía que se autocumple” y permite que la persona sea más que su propio pasado.

La estigmatización que sobre este fenómeno produce la sociedad, puede llevar a mantener una asunción de verdad y una inmutabilidad en el comportamiento del menor. Si a lo largo del capítulo nos hemos referido en estos términos (ofensor sexual, agresor sexual, abusador sexual...) es por facilitar la aproximación de los lectores a la conceptualización de esta problemática, pero siempre siendo conscientes del impacto que el lenguaje puede provocar y con el ánimo de operar cambios en este sentido, los cambios necesarios para que describamos el fenómeno desde el comportamiento y no desde la categorización que disminuya las opciones al crecimiento. Nunca debemos que olvidar que son menores.

BIBLIOGRAFÍA

- Abel GG, Mittelman MS, Becer JV. Sex offenders: Results of assessment and recommendations for treatment in clinical criminology. En: *The assessment and treatment of criminal behavior*, Ontario: Clarke Institute of Psychiatry. 1985.
- Alonso JM, Horno P. *Save the Children: Una experiencia de buena práctica en intervención sobre abuso sexual infantil: Advocacy, construcción de redes y formación*. 2004.
- Becer JV, Kaplan MS. *Cognitive scales for adolescents*. Tucson: Department of Psychology. University of Arizona. 1984
- Becer JV, Kaplan MS. Cognitive behavioral treatment of the juvenile sex offender. En: H.E. Barbaree, J.L. Marshall, S.M. (eds.). *The Juvenile Sex Offender*. Hudson, New York: Guilford Press. 1993
- Becer JV. Treating adolescent sexual offenders. *Professional Psychology: Research and Practice*. 1990. Vol 21.
- Becer R. Evaluation of adolescent sexual abusers. En: Masson, H. Erooga, M (eds.). *Children and young people who sexually abuse others*. New York, Routledge books. 1999

- Borduin CM, Henggeler S , Blas e DM, Stein RJ. Multisystemic treatment of adolescent sexual offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. 1990. Vol 34.
- Cáceres J. *Tratamiento de parafilias y violación*. Madrid: Síntesis.
- Carnes P. *Out of shadows: understanding sexual addiction*. CompCare. Minneapolis. 1983.
- Caron SL, Davis CM, Halteman A, Stic le M. Predictors of condom-related behaviours among first –year college students. *Journal of Sex Resesarch*. 1993. Vol 30.
- Diaz Morfa J. Ofensores sexuales juveniles; Aspectos psicosociales de la violencia juvenil; *Revista de Juventud*. 2003. N°62.
- Echeburúa E. *Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores*. Barcelona: Ariel. 2005.
- Echeburúa E, Gerrickachevarría C. *Abuso sexual en la infancia: Víctimas y agresores. Un enfoque clínico*. Barcelona: Ariel. 2000.
- Fehrenbach PA, Smith , Monasters y C, Deisher R . Adolescent sexual offenders: Offender and offense characteristics. *American Journal of Orthopsychiatry*. 1986. Vol 56.
- Garrido V, Beneyto MJ. *El control de la agresión sexual*. Valencia: Cristóbal Serrano Villalba. 1995.
- Garrido V, Stangeland P, Redondo S. *Principios de criminología*. 3 ed. Valencia, Tirant Lo Blanc. 2006.
- Gray AS, Pithers D. Relapsed prenvencion ith sexually aggressive adolescents and children: Expanding treatment and supervision. En: H.E Barbaree, . L. Marxhall, S.M Hudson (eds.) *The juvenile sex offender*. Ne Yor , Guilford Press. 1993.
- Goocher BE. Some comments on the residential treatment of juvenile sex offenders. *Child and Youth Care Forum*. 1994. Vol 23.
- Groth NA, Longo RE, McFadin JB. Undetected recidivism among rapists and child molesters. *Crime and Delinquency*. 1982. Vol 28.
- Guimon J. Controversias en el tratamiento de los agresores sexuales. *Avances en salud mental relacional*. 2007. Vol 6, n° 3.
- Hayes S, Barbouttis F, Hayes C. Anti-libidinal medication and people ith disabilities-long-term follo -up of outcomes follo ing third party consent to medication for problematic sexual behaviour. Centre for Behavioural Sciences, Department of Medicine -University of Sydney, Ne South ales. 2002.
- Holam . Save the Children; Tratamiento de jóvenes agresores sexuales; posibilidades y retos. España. Save the Children. 2000.
- Hunter JA. Understanding juvenile sex offenders: Research findings and guidelines for effective management and treatment. Juvenile justice fact sheet. Charlottesville, VA: Institute of La , Psychiatry, Public Policy, University of Virginia. 2000.
- Hunter JA, Lexier LJ. Ethical and legal issues in the assessment and treatment of juvenile sex offenders. *Child Maltreatment*. 1998. Vol 3.
- Ida Dickie BA. An information processing approach to understanding sympathy deficits in sexual offenders; tesis of departament of Psychology Carleton University. 1998.
- atz RC. Psychosocial adjustment in adolescent child molesters. *Child Abuse and Neglect*. 1990. Vol 14.
- avoussi RJ, aplán M, Bec er JV. Psychiatric diagnoses in adolescent sex offenders. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. 1988. Vol 27.
- night RA, Prent y RA. Exploring characteristics for classifying juvenile sex offenders. En: H.E. Barbaree, .L. Marshall, and S.M. Hudson (eds.). *The juvenile sex offender*. Ne Yor , NY: Guilford Press. 1993.
- Lane S. The sexual abuse cycle. En: Ryan G. D. Y S. Lane (eds.). *Juvenile sexual offending: causes, consequences, and correction*. Lexington, D. C. Health. Massachusetts. 1991.

- Lightfoot LO, Barbaree HE. The relationship between substance use and abuse and sexual offending in adolescents. En: H.E. Barbaree, J.L. Marshall, S.M. Hudson (eds.) *The juvenile sex offender*. New York, NY: Guilford Press, 1993.
- Lopez F. Prevención de los abusos sexuales a menores y educación sexual. Amarú. Salamanca. 1995.
- Lottes IL. Rape Supportive Attitude Scale. En: CM Davis, L. Yarber, R. Bauserman, G. Sherer y SL Davis (eds.) *Handbook of sexuality-related measures*, Londres: Sage. 1998.
- Marshall J.L., Barbaree HE. Outcome of comprehensive cognitive-behavioral treatment programs. En: J.L. Marshall, D.R. Laundy, and H.E. Barbaree (eds.) *Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender*. New York, NY: Plenum Press. 1990.
- Modelo de prevención, detección y monitoreo de situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes*; Costa Rica: Aldeas infantiles SOS. 2007.
- Miner MH, Crimmins CLS. Adolescent sexoffenders: Issues of etiology and risk factors. En: B. J. Schartz and H.R. Cellini (eds.). *The sex offender: Vol. 1. Corrections, treatment and legal practice*. Kingston, NJ: Civic Research Institute. 1995.
- Miner MH, Siebert GP, Ackland MA. *Evaluation: juvenile sex offender treatment program*, Minnesota Correctional Facility—Sau Centre. Final report—Biennium (1995-1997). Minneapolis, MN: University of Minnesota, Department of Family Practice and Community Health, Program in Human Sexuality. 1997.
- Noguerol V. *Agresiones sexuales*. Madrid: Síntesis. 2005.
- Pithers. J.D. Relapse prevention of sexual aggression. En: Pithers, J.D., Ashima, J.M. Cumming, G.F. Beal, L.S. Buell, M.M. (eds.) *Vermont treatment program for sexual aggressors*. Vermont Department of Corrections South Burlington, Vermont 05403.
- Prentiss R, Harris B, Frizzell J, Righthand S. An actuarial procedure for assessing risk in juvenile sex offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*. 2000. Vol 12.
- Rasmussen LA. Factors related to recidivism among juvenile sexual offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*. 1999. Vol 11.
- Redondo S, Pérez M, Martínez M. El riesgo de reincidencia en agresores sexuales: investigación básica y valoración mediante el SVR-20; *Papeles del psicólogo*. 2007. Vol 28.
- Richardson G, Graham F. Relapse Prevention. En: Hoghugh, M., Bhate, SR; Graham, F. (eds.) *Working with sexually abusive adolescents*. London, Sage Publications. 1997.
- Sierra JC, Rojas A, Ortega V, Martín JD. Evaluación de actitudes sexuales machistas en universitarios: primeros datos psicométricos de las versiones españolas de la Double Standard Scale (DSS) y de la Rape Supportive Attitude Scale (RSAS). *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*. 2007. Vol 7, Nº 1.
- Urra J. *Agresor sexual, casos reales riesgo de reincidencia*. Madrid: EOS. 2003.
- Vázquez O. Justicia juvenil, programa socio-educativo para el control de la agresión sexual, Chile. Ed. Corporación Opción. 2005.
- alters GD, White T. A Cognitive Model of Lifestyle Criminality. *Criminal Justice Research Bulletin*. 1989. Volume: 4 Issue: 4.
- einrott M. Recidivism among juvenile sex offenders: Are favourable outcomes only favourable when therapy matters? Handout from Empirically-based treatment interventions for juvenile sex offenders. Presentation sponsored by the Child Abuse Action Network and the State Forensic Service, Augusta, ME, August 1998. 1998.
- einrott M. *Juvenile sexual aggression: a critical review*. Boulder, CO: University of Colorado, Institute for Behavioral Sciences, Center for the Study and Prevention of Violence. 1996.
- einrott M, Riggan M, Frothingham S. Reducing deviant arousal in juvenile sex offenders using vicarious sensitization. *Journal of Interpersonal Violence*. 1997. Vol 12.

NAZARET ALGO MÁS QUE UN COLEGIO

*Sergio Biete Bañón,
Miguel Ángel Segura Palomares*

INTRODUCCIÓN

Muchas son las causas que convierten al niño en un ser vulnerable, pero seguramente, una de las más graves es la carencia de afecto, el maltrato y el abandono de los adultos más cercanos (de los padres), en las primeras etapas de la vida.

Nazaret se creó en Alicante, hace más de cincuenta años, para intentar paliar las consecuencias negativas de esas carencias y abandonos. Su fundador, el Jesuita Francisco Javier Fontova, trató de cambiar la historia personal de muchos niños de la calle, hijos de la pobreza y la inmigración, fruto de los últimos coletazos de una larga posguerra. Ofreció hogar y formación a quienes sus familias no podían, o no sabían dárselos.

Su proyecto se inspiró en varias fuentes. Así, en un principio adoptó la denominación de Traperos de Nazaret, a imagen de los Traperos de Emaús que l' Abée Pierre había creado en Francia. Más tarde fue la Ciudad de los Muchachos del padre Flanagan la que dio lugar a su homónima, aquí en Alicante. También, las Aldeas Infantiles SOS que tras la Segunda Guerra Mundial acogieron en Austria y Alemania a los numerosos huérfanos que la contienda había dejado, animaron a crear una Aldea Infantil en el recinto del Nazaret de finales de los sesenta, que sirviera de hogar a los más pequeños, y permitiese permanecer juntos a los grupos de hermanos y hermanas (hay que tener en cuenta que en aquel entonces el internado era solo para chicos). Distintos fueron los modelos, pero todos compartían la misma base: la convicción de que una experiencia positiva y afectiva de vida en familia, y la formación en un oficio, hacía a estos chicos menos vulnerables a la hora de incorporarse a la sociedad.

El paso del tiempo, las corrientes desinstitucionalizadoras de los años sesenta y setenta del pasado siglo, críticas con el concepto de “institución integral” (no solo en el mundo de los menores, sino también en salud mental), los avances de la psicología social y la pedagogía, y la necesidad de dar respuestas más adecuadas a las nuevas ne-

cesidades y demandas que presentaban los niños y jóvenes, van provocando sucesivos cambios en la estructura y la organización de Nazaret.

Lo que antaño fue un colegio con internado para niños empobrecidos y con problemas familiares, hoy se configura en torno a cuatro recursos diferenciados (cuatro “sectores” en nuestra terminología interna) que tratan de hacer frente a cuatro bloques de necesidades también diferentes entre sí, aunque compartan numerosas características.

Ante la situación de desamparo que provoca una familia incapaz de ofrecer los mínimos cuidados y las atenciones básicas, o unos adultos maltratadores, por acción o por negligencia, nuestra respuesta es el *Centro de Vida*. Un conjunto de seis pisos repartidos por la ciudad, donde ofrecerles, a través de la “normalidad” de la vida cotidiana, un estilo de vida (en el sentido que la Psicología Social le da al término) más adaptativo, y que les sirva de alternativa a la que han experimentado en sus familias. Un estilo de vida que les permita introyectar pautas alimenticias e higiénicas más saludables, modelos comunicativos más ricos y eficaces, formas de disciplina, o de resolución de conflictos más coherentes, que ofrezcan modelos de adulto viables, positivos y aceptables socialmente. Cada piso acoge a seis menores que conviven con sus respectivos educadores (36 en total), que son apoyados por un equipo de dos trabajadoras sociales y dos psicólogas.

Otros dos pisos más están destinados a aquellos chicos y chicas que al alcanzar la mayoría de edad se les acaba la tutela de la Administración, y carecen por completo de respaldo familiar. Con una capacidad para cuatro jóvenes cada uno, estos “pisos de transición” cuentan con el seguimiento a distancia de nuestros educadores, y ofrecen el soporte imprescindible hasta alcanzar unos mínimos de autonomía e independencia personales.

Ante la situación de fracaso, y sobre todo de fuerte rechazo escolar (en muchas ocasiones reactivo al que ellos mismos han sentido desde la escuela) nuestra respuesta es el *Centro de Día*. Un proyecto educativo basado en hacer, no una escuela distinta, sino algo distinto a la escuela. Que prioriza el adaptar la organización escolar a las características cognitivas y reactivas de los alumnos. Para ello se centra en tres grandes objetivos: 1) evitar rechazos y abandonos prematuros del sistema escolar; 2) hacer un esfuerzo serio de prevención para evitar la aparición y desarrollo de posteriores problemas de inadaptación social y conductas anómicas o agresivas; 3) preparar a estos menores, personal y técnicamente para una integración laboral positiva.

Estos objetivos se materializan en unos principios de actuación que son los siguientes: 1) La personalización de la acción educativa que permita la máxima adaptación a las características personales y sociales de estos menores; esto supone partir de sus esquemas y capacidades, priorizar la relación personal con el adulto, y trabajar con grupos reducidos. 2) Nuclearización de la tarea académica en torno a unos talleres, que se conviertan en el centro motivador y de interés, en torno al cual se articulen las otras actividades formativas y académicas. 3) “Desacademización” del proceso formativo que libere a la experiencia de las connotaciones más negativas que para estos menores tiene lo escolar. Para ello se suprimen elementos como “aula”, o “curso”, siendo sustituidos por otros tipos de espacios, o de agrupamientos en función de criterios madurativos o de afinidad. 4) Atención preferente para el trabajo en equipo del colectivo de educadores (profesores, tutores, monitores de taller y de actividades), para el que hay que dar posibilidades, formación, tiempo y estructuras de funcionamiento.

Este modelo, aprobado formalmente por la administración educativa correspondiente con la denominación de Centro de Acción Educativa Singular (CAES), atiende a unos 170 chicos y chicas de Enseñanza Primaria y Secundaria.

Los otros dos sectores surgen a mediados de los noventa, como respuesta a las carencias y retos que nuestra propia experiencia nos planteaba.

Los Programas de Juventud se centran en la aplicación de las medidas judiciales de medio abierto con los jóvenes infractores de la ciudad de Alicante. Este programa nos permite subrayar la faceta educativa en el tratamiento de los delincuentes juveniles, ofreciendo una oportunidad de recuperación a muchos de estos jóvenes. La ejecución de la medida (en su mayor parte “libertades vigiladas”, o “prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad”) supone el inicio de una relación personal con el joven, y muchas veces también con su familia, que se basa en la confianza y el “no juzgar” a la persona, aunque sí desaprobamos el hecho cometido. Desde esa premisa de apoyo incondicional al sujeto, se intenta reconstruir los entramados personales, relacionales y potenciar capacidades (formativas o laborales) que les permitan reincorporarse a la vida social. Un equipo de 10 personas actúa sobre más de 300 jóvenes en la ejecución de más de 400 medidas anualmente.

Por último, los *Programas de Familia* (Educación Familiar, Perinatales y Desarrollo y Organización Familiar), nacieron de la necesidad de actuar en la prevención para evitar el deterioro familiar que desemboca en la desprotección y el desamparo de los hijos, del que tanta experiencia teníamos en el Centro de Vida. Destinado a familias con grave deterioro, pero en las que la convivencia no se ha roto del todo, las educadoras intervienen en el seno de la familia, de cada familia, ayudando en el cambio de actitudes educativas y relacionales, facilitando alternativas para la resolución de conflictos. En el caso del programa de “Perinatales”, que está pensado para madres jóvenes con graves carencias personales para la crianza, y ausencia de apoyo familiar o de otro tipo, la prevención se lleva al extremo, pues el acompañamiento a la joven comienza prácticamente desde el nacimiento del bebé, y a veces antes. Este seguimiento individualizado garantiza los mínimos básicos de alimentación, higiene y seguimiento médico de la criatura, y ayuda a la muchacha a desarrollar otras facetas afectivas y educativas en su nuevo papel de madre. Seis educadoras atienden a más de cien mujeres (e inciden sobre más de trescientos niños), entre los distintos programas, que están implantados en la ciudad de Alicante y otros dos municipios cercanos.

Las limitaciones de espacio y la propia estructura del documento hacen imposible extendernos y abarcar en su totalidad cada uno de los cuatro sectores. De ahí que nos centraremos en la explicación detallada del recurso de Centro de Día, dejando para otra ocasión el resto de sectores. Previamente se comentarán las características socio-familiares y las de los propios menores que asisten al Centro de Día.

Concluiremos con un breve apartado que recoge lo que, a nuestro parecer, son los retos que nos plantea el futuro en esta parcela de la infancia en situación de riesgo y desprotección. Y como apéndice se añade un “cuadro resumen” de los sectores que forman Nazaret.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MENORES

La realidad no se puede percibir desde un solo lado, sino que es necesario entender a la marginación de una forma global. La perspectiva del modelo interaccional permite observar y comprender la realidad de una manera interactiva dentro del proceso de socialización del menor. Por ello, a la hora de analizar las características del menor, no se puede obviar los tres elementos claves: el contexto sociofamiliar en el que viven, el menor y su propia conducta.

A) Características sociofamiliares.

Las características sociofamiliares del alumnado se pueden ver a dos niveles: las objetivas que son las que se derivan directamente de la posición social del individuo dentro de la estructura de la sociedad en la que vive (sociológicas y demográficas); y las funcionales que son aquellas formas de conducta y aquellos estilos de vida que resultan más económicos, en términos de posibilidades de placer-displacer.

La problemática socioeconómica y familiar de los menores de este centro se refleja en el siguiente cuadro:

Problemática		
Familia	Familias monoparentales con ausencia de padre	10,2
	Familias reconstituidas	18,1
	Presencia de ambos padres	53,3
	Acogimiento con familia extensa	18,4
Vivienda	Viviendas sociales	45,8
	Viviendas en alquiler o propiedad	34,9
	Viviendas en condiciones límites de habitabilidad o compartida	19,3
Ingresos	Ingresos por pensiones, ayudas o paro	23,9
	Empleo estable e inestable	21,7
	Sin ingresos o ingresos por trabajos marginales	54,4
Educación	Analfabetismo padre y/o madre	27,5
	Saben leer y escribir un poco el padre o la madre	68,3
	Graduado Escolar de padre y/o madre	4,2
Salud	Problemas de alcoholismo/drogadicción	12,6
	Enfermedad mental o física padre o madre	17,5
Otros aspectos	Padre y/o madre en Instituciones Penitenciarias	13,5
	Dificultades en la atención a necesidades básicas	26,5
	Dificultades educativas graves hacia sus hijos	21,8

Nota En casi la totalidad de los casos la problemática es múltiple, dándose una media de 4 o 5 circunstancias por familia.

Los ingresos por definición y sin necesidad de establecer límites o comparaciones son siempre, en este medio social, reducidos, inciertos e insuficientes para cubrir las necesidades básicas. El trabajo remunerado que realizan se caracteriza sobre todo por el hecho de ser manual y nada cualificado. En los últimos tiempos que corren y con la presencia de la crisis muchas familias se han quedado sin trabajo y están buscando otro empleo. Además, hay un colectivo de padres que tienen trabajos de supervivencia, que suelen estar al margen de lo legal.

La vivienda es reducida, con escasez de útiles del hogar, y que no puede facilitar espacios de índole mínimamente personales. La ubicación de este tipo de viviendas se encuentra en las zonas suburbanas o en los barrios donde se les concede las viviendas, que suelen concentrar a todos en zonas muy caracterizadas de la ciudad por su deficiencia y carencia de servicios. La unidad familiar suele componerse de un elevado número de hijos, unido con frecuencia a la presencia de abuelos y, a veces, hijos de los hijos. Esta característica combinada con el reducido tamaño de la vivienda da unos índices de hacinamiento notables que acentúa la falta de espacios personales y la conflictividad intrafamiliar. En la medida en que el medio social inmediato al alumno está formado en gran parte por personas adultas, tiene de referencia las pautas de funcionamiento habitual de esos adultos.

Otra característica es el nivel de instrucción de los adultos que rodean al niño: el analfabetismo y los bajos niveles de escolarización y capacitación laboral de los miembros de la unidad familiar y del contexto barrial. Estas características influyen tanto en la limitación de las posibilidades de empleo como en la percepción y la motivación hacia la escuela, que transmiten a sus hijos.

Las variables funcionales, o modo de funcionar en un medio social deprimido, se derivan en buena parte de las características objetivas de ese mismo entorno. Pero, a su vez, funcionar de esa manera contribuye a seguir viviendo en ese medio social y a ser considerado por los demás. Al mismo tiempo, es la única forma de sobrevivir con las posibilidades que allí se dan. Aquí se puede apreciar la influencia mutua entre las características objetivas y las funcionales, y la dificultad para facilitar la promoción social desde dentro.

La alimentación, la higiene y la sanidad vienen mediatizadas por las circunstancias económicas y de instrucción de los padres, pero junto a estos determinantes básicos se asocian otras variables funcionales como las que incluimos en el grupo de "concepción de vida", como creencias mágicas, planificación, rechazo a las instituciones o en el de comunicación familiar. Las consecuencias más evidentes se aprecian en la relación peso y talla, pero también en los déficits sensoriales, auditivos y visuales, por falta de higiene y por enfermedades, con frecuencia sencillas pero mal curadas. En cuanto a la maduración del sistema nervioso, se pueden constatar repercusiones en la psicomotricidad fina y en el desarrollo del lenguaje (inmadurez, dislalias, dislexias, etc.). Lo importante de la influencia directa de estas variables funcionales en el organismo es que con ellas se crea un circuito corto de interacción entre medio social, el organismo y la conducta, donde las variables cognitivo-reactivas no quedan entre el medio social y la conducta sino directamente entre el organismo y la conducta.

Las restantes características de funcionamiento en un medio social desfavorecido tienen su influencia en la conducta y en el organismo a través de las variables cognitivo-reactivas. Entre ellas, las primeras que resaltan son las relativas a la organización del medio familiar, el estilo de disciplina imperante en ese medio social y las peculiaridades de la comunicación intrafamiliar.

La organización del medio familiar es poco flexible en un contexto social como el descrito antes. La forma que suelen tener de organizarse es la extremadamente rígida e inflexible o la anómica. La disciplina suele ser rígida, basada en el refuerzo físico (castigo físico) y con mucha frecuencia asociada a la incongruencia del criterio de aplicación. Por la acción de un día el chico recibe una paliza, al día siguiente la repite y no ocurre nada, o incluso se le ríe la gracia, o es el mismo adulto quien la realiza.

La comunicación intrafamiliar suele resumirse en un código lingüístico peculiar, de vocabulario reducido, poco abstracto y poco matizado, con predominio de la frase afirmativa e imperativa. En cambio, la comunicación no verbal es rica por la frecuente exteriorización de las emociones, siendo por lo general explosiva tanto en formas como en intensidad.

El medio social en el que viven selecciona forzosamente la gama de experiencias que va a poder vivir intensamente. Esta selección de experiencias tiene lógicamente su origen en las posibilidades que le ofrece el medio, tanto físico como social. Entresacando solo algunas se tiene: predominio de las experiencias de manipulación de objetos frente a la difícil manipulación de palabras y conceptos; abundancia de experiencias de fuerza y de convivencia con el mundo animal; en otro plano, también, experiencias de ser rechazado y experiencias de frustración; los modos de gratificación inmediatos que se emplean marcan en el presente y en el futuro su forma habitual de establecer metas e incentivos, así como sus mecanismos de autovaloración y recompensa. Como por ejemplo, conductas aparentemente absurdas, como la de esa familia que tras un golpe de suerte en los “ciegos”, o tras unos ingresos obtenidos en un trabajo eventual, emplean ese dinero en la adquisición de un televisor en color o un coche, sin reparar en otras necesidades mucho más perentorias o de previsión de futuro.

Otro grupo de características funcionales es el denominado como concepción de vida: hay una gran abundancia de creencias mágicas de todo tipo, marcadas supersticiones y una forma muy elemental de religiosidad; en el plano de la acción hay escasa posibilidad y utilidad de la planificación a medio o largo plazo.

Ahora bien, los modelos de identificación y aprendizaje que encuentra el alumno de nivel social inferior son los de su entorno más los que la sociedad ofrece a través de los medios de comunicación. Así pues, se aprecia fácilmente que entre unos modelos y otros se dan claras contradicciones. En unos modelos la fuente de atracción es el afecto y en los otros es el prestigio. La resultante de conducta que puede surgir tras estos procesos contradictorios de modelado no debe extrañar que sea, cuando menos, confusa, ambivalente y desconcertante.

B) Características del alumnado

Explicar las características del alumnado se pueden entender desde una óptica más interactiva, aunque no como causa efecto de las características sociofamiliares.

En cuanto a los aspectos cognitivos, se destacan las siguientes:

El pensamiento es concreto: razona sobre elementos cercanos, reales, tangibles; le cuesta abstraer y generalizar.

Tiende a un razonamiento intuitivo sin comprobar los matices y elementos complementarios.

Sus aptitudes verbales suelen ser de código restringido y no utilizan palabras abstractas, ni pluralidad de adjetivos y adverbios para matizar ni tampoco frases largas o de subordinación.

Tiene una amplia comunicación no verbal.

La curiosidad intelectual es pragmática: le interesa más el cómo y el para qué de un fenómeno sin preguntarse el qué y el porqué del mismo.

Desarrollo notable de la psicomotricidad gruesa y de las habilidades de rapidez, fuerza y equilibrio; la motricidad fina, en cambio, la desarrolla de forma tardía e imprecisa.

Se mueve por necesidades inmediatas y útiles; las metas son a corto plazo.

Su campo de interés está circunscrito a las experiencias que ha vivido más que a las expectativas.

En cuanto a las características reactivas se resaltan las siguientes:

- Sus reacciones suelen ser primarias, impulsivas, rápidas; la reflexividad le cuesta.

Muestra una fuerte expresión emocional, tanto de los sentimientos positivos como de los negativos; lo que desconcierta es la intensidad del mismo.

Suele mostrar dureza de carácter y ante determinadas situaciones es capaz de no mostrar sentimientos por estar habituado a ellas, es más, puede herir la sensibilidad de otras personas.

Se caracteriza por una baja resistencia a la frustración: se hunde fácilmente y le cuesta encontrar soluciones.

La expresión de la agresividad es frecuentemente física y la verbal es directa.

El control de la vida y de su propia actuación lo sitúa en fuerzas personales o impersonales ajenas a él, en ocasiones recurren al azar o fuerzas ocultas; tarda más que otros en llegar a ver que él puede controlar parte de su vida y de sus acciones.

EL CENTRO DE DÍA DE NAZARET

La concepción de Nazaret en su sentido amplio es algo más que un colegio, porque con las características del alumnado se ha de ofrecer una escuela diferente y además una atención que vaya más allá de lo académico para poder atender lo afectivo y en muchos casos cuestiones materiales (pantalones, zapatos, alimentos, etc.). El equipo educativo de Nazaret no solo desempeña funciones docentes sino que también se implica afectivamente en las trayectorias, en las vivencias y en las necesidades de los menores. Por las tardes, cuando finaliza la jornada escolar, se amplía la atención hasta las 20 horas para un grupo de 24 menores que por diversos motivos necesitan esta atención añadida. Los criterios para ser atendidos por las tardes son los siguientes: menores que viven en núcleos familiares con dificultades de atención personalizada hacia sus hijos; menores cuyas características de personalidad, muestran claros signos de desestructuración; y núcleos familiares con incompatibilidad de horario por motivos de trabajo. Por ello, Nazaret se puede decir que es un Centro de Día, donde una de sus actividades es el Colegio.

En el curso 2003-2004 vimos reconocido nuestro esfuerzo del día a día, a nivel nacional. El Ministerio de Educación realizó la tercera convocatoria de los Premios para los centros docentes que desarrollan programas educativos dirigidos a la compensación de desigualdades en educación. Estos premios pretenden ser un reconocimiento al trabajo que se está realizando en los centros docentes no universitarios, sostenidos con fondos públicos, que mediante la mejora continua de sus procesos, logran una educación de calidad para todos. En dicha convocatoria Nazaret obtuvo el tercer premio de la modalidad C (categoría de Centros Concertados). Este premio es una gran satisfacción para el equipo educativo y un aliciente para seguir mejorando nuestro proyecto educativo.

Principios pedagógicos de actuación

A principios de los noventa se llevó a cabo una reflexión para dar un nuevo rumbo a la escuela y ofrecer una mayor calidad educativa de acorde a la tipología del alumnado que estaba asistiendo al centro. De aquellas reflexiones se obtuvieron una serie de principios pedagógicos que siguen en vigor porque las características de los alumnos son las mismas pero en algunos casos más marcadas que antes por la dureza de sus contextos familiares, de sus vivencias y de sus conductas. Estos principios son los siguientes:

1. La personalización de la acción educativa y adaptación a las características psicológicas y sociales de estos menores. Esto implica:
 - a) partir de sus esquemas de valores, capacidades y aptitudes,
 - b) priorización de la acción tutorial,
 - c) grupos reducidos como estructura básica de funcionamiento.

2. La nuclearización de la tarea académica en torno a unos talleres que, aparte de su valor formativo preprofesional, sean un elemento motivador y centro de interés en torno al cual se articulen otras actividades formativas y de tiempo libre.
3. La “desacademización” del proceso formativo. Esto supone la inclusión de áreas, como educación para la salud, taller para la vida y la convivencia, actividades deportivas y de relación con el exterior; y por la implantación de una evaluación cualitativa y autorreferente.
4. El aprendizaje se basa en lo visual, en lo oral y en lo manipulativo. Los sentidos son el punto de arranque del aprendizaje y desde ahí pueden iniciar la verbalización de los procesos. Posteriormente es cuando se aporta la explicación.
5. El aprendizaje vicario permite que se superen a nivel instrumental y que soluciones determinados conflictos gracias a la presencia de otro compañero que le ayuda o simplemente le sirve de modelo o referencia positiva.
6. Se potencia la participación de los alumnos con sus visiones y afirmaciones globales o intuitivas, que suelen ser incompletas o imperfectas, porque luego se completa con la participación del resto de compañeros y con la del profesor.
7. Los planteamientos didácticos se procuran que sean dinámicos, activos, no solo participativos. Es necesario un aula, pero no como único lugar de aprendizaje. El alumno debe sentir que aprende de la vida.
8. La evaluación del proceso de aprendizaje (tanto en contenidos como en actitudes) es diaria y siempre acompañando los aspectos negativos de los positivos. Con el aumento de la edad se va introduciendo la autoevaluación. Se tiene muy presente que las mejoras que hace el alumno no son dadas por sus capacidades únicamente sino por su esfuerzo, valorándose este último de forma especial.
9. En las ejecuciones positivas se valora a la persona. En cambio, en las realizaciones negativas se analiza el hecho y no a la persona.
10. El proceso de aprendizaje parte de lo que el alumno ya sabe hacer. Es preferible fraccionar un aprendizaje en procesos más simples, que no rebajarlo de nivel.
11. Se establecen momentos y espacios para dar cauce a la expresión de la agresividad física: de manera directa (deporte, o similar) o simbólica (dibujo, modelado, etc.).
12. Se da una atención preferente al trabajo en equipo del colectivo de educadores que anime la experiencia (tutores-profesores-monitores de taller), a su integración con el equipo multiprofesional de apoyo (psicología, pedagogía, trabajo social) y a su propia formación permanente, con tiempos asignados para ello en el horario.
13. Cuando algún niño/a supera algunas de las carencias fundamentales por las que ha sido escolarizado en nuestro colegio, y está en condiciones de mantener una escolarización normalizada, procedemos a su escolarización en un centro público de su zona.

Un aspecto por el que se hizo y se sigue haciendo mucho hincapié es la financiación y el reconocimiento público de la experiencia, no solo por la necesidad del proyecto sino como signo del carácter público y abierto de la oferta y como manifestación del compromiso de la Administración Pública con los menores en situación de riesgo social.

11.3.2. Objetivos generales y específicos del proyecto educativo

A) Objetivos generales

Dar una respuesta educativa y socializadora a los alumnos de Nazaret que necesitan una repuesta educativa adecuada a sus carencias socioeconómicas y afectivas.

Desarrollar procesos educativos con una visión integral de la persona “herida” para potenciar las capacidades y habilidades de los alumnos, y a su vez procurando ser una alternativa escolar ante el fracaso, el absentismo, la descolarización y la inadaptación al sistema escolar normalizado.

Capacitar a estos menores, en lo personal y en lo profesional, para una inserción laboral positiva a partir de los 16 años, en recursos ajenos a nuestra Institución.

B) Objetivos específicos

Desarrollar todas las actividades necesarias para que los alumnos adquieran los aprendizajes básicos de acorde a su proceso madurativo y de consolidación de los mismos.

Fomentar en los alumnos los sentidos de autoestima, seguridad en sí mismos y de responsabilidad.

Potenciar al máximo su nivel de relación social: saber estar en grupo entre ellos y con adultos.

Adquisición de hábitos positivos de trabajo, de convivencia, de constancia, de gusto por el trabajo bien hecho y acabado, de respeto por las personas y por las cosas.

Iniciación al mundo de la formación profesional y laboral, cuidando especialmente la orientación y la apertura a la vida.

La etapa de Primaria

La educación en la etapa inicial de un niño es fundamental tanto en la adquisición de habilidades sociales como en la asimilación de contenidos académicos. Sin embargo, en menores donde la ausencia de hábitos de trabajo en favor de la libertad abso-

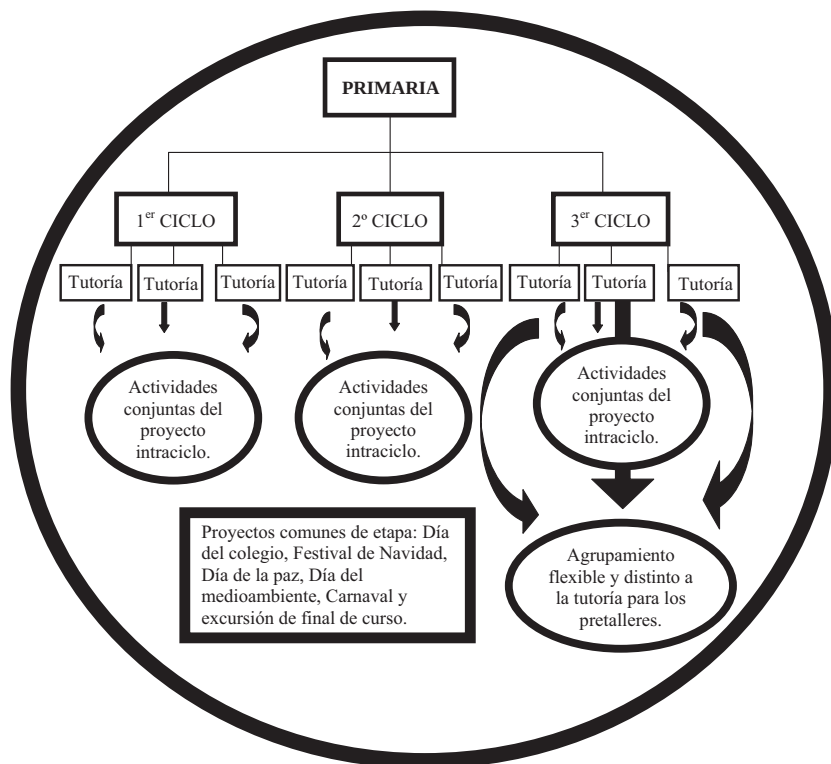
luta en sus quehaceres supone un choque frontal en su incorporación en la escuela. En primer lugar por la presencia de unas normas muy claras y definidas a asumir; en segundo lugar por la presencia de una persona desconocida, el maestro/a, que asume el rol de autoridad; en tercer lugar, por el tiempo que han de permanecer en un aula desarrollando las actividades sin opción a hacer lo que les apetece; en cuarto lugar, por estar con compañeros totalmente desconocidos en su primera etapa con los que tienes que encontrar su rol; y por último, enfrentarte al mundo de las letras y de los números, algo que antes eran simple garabatos. La etapa de Primaria en estos alumnos es fundamental, puesto que lo que no han adquirido en ella es muy difícil que lo adquieran posteriormente.

Para visualizar lo dicho, describo un hecho real: un menor de 17 años de etnia gitana que no tuvo motivación por aprender, porque en casa tampoco se preocuparon por esta faceta de su persona aunque sí de otras, que en el colegio de Primaria al que iba ya se encontraba raro, una veces iba y otras no, y acabó su etapa de Primaria sin apenas saber leer y escribir. En junio de aquel año le mandaron al Instituto de Secundaria, un edificio grande con miles de alumnos, muchos profesores, sus problemas de aprendizaje, su vergüenza y el miedo hicieron que asistiera nada más que al día de la matriculación. Posteriormente, estuvo dos años sin asistir al Instituto, con consentimiento de la familia. La reflexión de la familia es “si con los años que ha estado yendo al colegio y no sabe nada, para qué seguir estudiando”. Finalmente, la inspección nos deriva el alumno, ya tenía 13 años. Su incorporación fue difícil, había estado mucho tiempo fuera del mundo de la educación, pero poco a poco ve que el centro es pequeño, que los profesores le atienden a él de forma distinta que en sus anteriores colegios, que se le enseña no al ritmo de los demás sino desde donde él se quedó y que recibe apoyo de otros profesores para asimilar el proceso lectoescriptor. La poca motivación del alumno en su primer año se fue convirtiendo en un “voy a intentarlo”, al menos acabó su etapa en secundaria, leyendo aunque con poca fluidez y escribiendo aunque sin redacción libre.

Estos casos, y otros quizás más escandalosos, porque al final el último siempre acaba superando al anterior, hacen que la etapa de Primaria sea clave en el proceso formativo de los menores en general, pero en especial en los menores que reúnen las características descritas en el punto anterior.

La estructura de la etapa de primaria

Primaria está organizada en tres ciclos, las modalidades de agrupamiento que se efectúan en dichos ciclos es altamente flexible y se constituyen en función de los niveles curriculares que tienen los alumnos y la relación que tienen entre sus compañeros, la excesiva conflictividad entre alumnos impide el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y endurece el proceso de adquisición de las habilidades sociales. De cada ciclo se crean tres tutorías para poder atender mejor y de forma individualizada las dificultades de aprendizaje de los menores. De una forma gráfica la estructura de Primaria es la siguiente:



Fi ura Organización de la Etapa de Primaria.

La tutor a

El proyecto educativo de Nazaret está concebido como un recurso que trata de dar respuesta a aquellos chavales que requieren de un recurso especializado, que sea capaz de potenciar el desarrollo de su personalidad y ofrecer a la vez un modelo educativo adaptado a sus necesidades educativas. Los chicos que vienen a Nazaret necesitan posiblemente más que cualquier aprendizaje académico, la posibilidad de poder desarrollar su personalidad, poder madurar en lo afectivo, en estima, en relación y conocimiento del otro.

No se debe perder de vista que es cada vez más frecuente que nos encontremos menores que por sus especiales características presentan unas significativas dificultades a la hora de aprovechar los recursos que les brinda el proyecto e incurrir en comportamientos disruptivos. Por ello el Proyecto Educativo contempla la tutoría como un aspecto muy significativo de nuestra tarea educativa. Es por ello que el Plan de Acción de Tutorial es fundamental y una de las condiciones para su mejor desarrollo en Primaria es disponer de tutorías con bajo número de alumnos/as.

Así, el Plan de Acción Tutorial recoge:

- a) La estructura organizativa del aula.
- b) El área psicosocial (se compone de actividades propias y de material de editoriales o programas del Ayuntamiento).
- c) El área de higiene y aseo personal.
- d) El área de hábitos de trabajo.
- e) Interrelación entre el tutor y diferentes departamentos del centro: dirección, jefatura de estudios, psicología y trabajo social.

El tiempo de tutoría que se establece es de cuatro horas semanales, pero además todos los objetivos que se marcan se desarrollan en otras áreas, porque están todo el día con el mismo profesor, su tutor, exceptuando cuando tienen educación física y música. Las tareas que se suelen hacer en ese tiempo de tutoría se pueden englobar en las siguientes tareas:

- a) Tomar el pulso a la situación, orientar la jornada individual y retomar las situaciones que se vayan planteando a lo largo del día.
- b) Dar cohesión a la experiencia educativa del Proyecto.
- c) Fomentar la convivencia y relación interpersonal y social.
- d) Facilitar la apertura personal y grupal de las situaciones de conflicto.
- e) Facilitar experiencias de conocimiento y relación interpersonal y social.
- f) Ofrecer un marco de autorreflexión y autocrítica de los comportamientos personales, grupales e institucionales.
- g) Trabajar los proyectos de aseo e higiene personal.
- h) Desarrollar el proyecto de activación de la inteligencia.
- i) Potenciar las habilidades sociales a través de talleres vivenciales.

Destacando algunos de las actividades que se realizan en Tutoría, serían los siguientes:

- A) Proyecto vida más sana, vida mejor. Uno de los ejes que contempla nuestro proyecto educativo es la educación para la salud, porque dentro de las necesidades prioritarias de este alumnado reside la de aprender unos hábitos de higiene y unas pautas de vida saludables, que les permitan aprender un estilo de vida más saludable, ser más autónomos y, en definitiva, mejorar su calidad de vida. Este proyecto implica también un adecuado uso de las instalaciones que ofrece el centro (aseos y duchas) y de una adquisición de hábitos de higiene de forma autónoma, de manera que se trasladen a otros contextos (casa y lugares públicos). Otra parte del proyecto se completa con la campaña municipal “Ningún niño sin saber nadar”, donde además de aprender a nadar también aplican los hábitos de higiene y aseo en otras instalaciones. Además, en este proyecto se incluyen los desayunos y las meriendas, con carácter anual y diario, cuyo objetivo es la formación de hábitos de alimentación sana. Se realiza en diferentes espacios del centro, tanto en el aula como en el patio.

A primera hora desayunan aquellos que no lo han podido hacer en casa, y por la tarde, antes de irse a casa, merienda en el Colegio.

- B) Proyecto Brújula. Es un programa municipal sobre prevención de drogodependencias destinado al alumnado de Primaria, en el centro se aplica dicho programa como un material externo que se inserta dentro del Plan de Acción Tutorial de la Etapa.
- C) Proyecto de Activación de la Inteligencia (PAI). Trata de despertar una forma de razonar en los niños y niñas de las primeras edades, con el fin de que aprendan a resolver problemas y relacionar lo que van aprendiendo con lo que ya conocen. En definitiva, el objetivo fundamental del PAI es que cada alumno aprenda a aprender, siendo protagonista de su propio aprendizaje.
- D) El desarrollo del hábito de trabajo, que es una labor continua del tutor, empezando por las pequeñas cosas como saber sentarse en la silla o coger el lápiz de forma adecuada, hasta los grandes aspectos como que el esfuerzo es un valor de la persona y que las cosas se obtienen no por la fuerza sino por el trabajo del día a día. El potenciar los hábitos de trabajo se empieza con seis años y no termina con el fin de la Etapa, sino que en Secundaria se continúa trabajando en esta dimensión.

Además de las actividades que se plasman en el proyecto, también se participa en las actividades que cada año ofrece el Ayuntamiento de Alicante, a través de sus distintas Concejalías.

En el centro existen otros proyectos que complementan la actividad del Plan de Acción Tutorial y que no lo desarrolla el tutor, como son el Proyecto de desarrollo psicosocial desde la música y el programa Mus-e.

- A) El Proyecto de desarrollo psicosocial desde la música pretende utilizar a ésta como una herramienta válida para trabajar otros muchos aspectos como las relaciones interpersonales o la autoestima. A todos les gusta que les canten; les gusta escuchar la música que se les presenta; muchos ya se deciden a bailar y cantar; les gustan los instrumentos *¿a quién no le gustan los bongoes o el cajón gitano*. El conocimiento y la realización de instrumentaciones, canciones, audiciones y cualquier actividad musical, les ofrece también alternativas prosociales a los juegos y a las formas que tienen de relacionarse. Este proyecto persigue favorecer el desarrollo de la autoestima, ofrecer una forma para canalizar agresividad, potenciar conocimientos y habilidades específicamente musicales, facilitar la integración en el grupo, posibilitar la realización de actividades de desarrollo grupales y desarrollar el autocontrol.

Los grupos se elaboran a partir de las propuestas del especialista y del departamento de orientación, con la conformidad del tutor de los alumnos implicados. A partir del listado de alumnos para acceder al proyecto se elaboran grupos en los que los alumnos tengan necesidades similares o en los que el estar juntos les pueda ayudar en su desarrollo personal.

Este proyecto ha sido premiado con el Primer Premio de la categoría de Educación Infantil y Primaria en el IX Premio de Experiencias de Innovación Educativa Ciudad de Alzira 2007.

- B) Programa Mus-e. Desde el curso 1999-2000 hasta 2007-2008 se ha llevado a la práctica el programa Mus-e (Fundación Yeduhi Menuhin) en sus diferentes modalidades artísticas con nuestros alumnos. Dicho programa consiste en promover la integración social, prevenir la violencia, el racismo y la xenofobia a través de las artes en colegios de población desfavorecida y en los que existe riesgo de exclusión social.

Diferentes artistas en sus diversas especialidades (teatro, música, danza, artes plásticas) han desarrollado diferentes talleres con una periodicidad trimestral o anual según el curso, exceptuando la música, que al ser impartida por la maestra de nuestro centro ha tenido una periodicidad anual, donde bajo un mismo programa conjunto cada año se han potenciado los objetivos desde centro de intereses concretos: el año del circo, el mundo del cine, etc., temas próximos a ellos para captar su atención y desarrollar las actividades.

Este curso escolar no se ha llevado a cabo por decisión de la Consellería de Educación, que asume dicho programa bajo su tutela con el nombre de EDUCARTE.

retalleres en el tercer ciclo

Los alumnos del centro desarrollan, por el medio en el que viven, cierta destreza en lo manipulativo, y conforme se van haciendo mayores, la motivación hacia todo aquello que se puede construir se incrementa. De ahí que en el tercer ciclo de Primaria se inserten al final de la jornada vespertina los pretalleres. La finalidad de los pretalleres es establecer un previo a los talleres que se desarrollan en Secundaria, por ello solo se imparte en el último ciclo de Primaria.

Los objetivos generales que se persiguen con los pretalleres son los siguientes:

- a) Potenciar las destrezas manipulativas.
- b) Fomentar la interrelación entre todos los alumnos/as del ciclo.
- c) Adquirir habilidades manipulativas y sociales.
- d) Favorecer el sentimiento de ofrecer y recibir ayuda de y a los demás.
- e) Desarrollar el gusto por las cosas bien hechas.
- f) Favorecer el cuidado y respeto de los instrumentos utilizados.
- g) Iniciar el desarrollo de los pretalleres para continuarlos más a fondo y específicos en Secundaria.
- h) Desarrollar hábitos de trabajo.

Los pretalleres que se realizan son cuatro: actualmente son cosido, informática, decoración y pirograbado. Los talleres se llevan a cabo durante el periodo de octubre

a mayo. Se crean cuatro grupos de trabajo de las tres tutorías del tercer ciclo. Cada grupo pasa el mismo número de sesiones por los cuatro talleres. Se imparte tres días a la semana de 16 a 17 horas. El objetivo de este proyecto es seguir afianzando hábitos y actitudes; destrezas y habilidades manipulativas; así como la expresión artística y el desarrollo de la creatividad.

La etapa de Secundaria

La característica de la etapa de Secundaria respecto a la de Primaria, es que todo empieza a depender del menor. Los chicos y las chicas empiezan a decidir qué hacen con su tiempo y con su vida. La adolescencia es crucial para todos los chicos y chicas, pero en la cultura gitana la adolescencia es muy corta y enseguida asumen el rol de adultos sin serlo. Hay varios frentes abiertos que son muy difíciles de erradicar:

- 1) Que las chicas no abandonen los estudios antes de los 16 años porque deciden casarlas y enseguida asumen el rol de madre. Se intenta convencer a las familias para que no lo hagan, en algunos casos se han conseguido.
- 2) Luchar contra el atractivo que les ofrece la calle. En ella se encuentran de todo: el riesgo que les excita, lo desconocido que les intriga, los amigos, el consumo de tabaco y otras sustancias, la música, el no seguir un horario, las motos, los coches, la búsqueda de dinero y móviles, y un sin fin de cosas que en el colegio no se les ofrece.
- 3) Por último, el estilo de vida laboral que llevan sus familiares cuyos trabajos son esporádicos y fuera del mercado laboral (unos más honestos, que otros) marcan el ritmo de lo que los menores desean hacer. “Si mi padre no trabaja, yo para qué quiero estudiar, el graduado no me importa porque yo tampoco voy a trabajar”, estas son reflexiones de algunos alumnos y alumnas del centro.

Por tanto, un alumno de Secundaria que viene al centro es porque él quiere venir y quiere estar aquí, otra cosa es su motivación o no por aprender, pero la gran mayoría de ellos vienen porque aquí tienen sus amigos, porque se sienten atendidos y queridos por los profesores y porque al final siempre encuentran un beneficio que les gratifique.

El objetivo central de Secundaria es potenciar al máximo posible las destrezas y habilidades de los alumnos con el fin de prepararlos para su incorporación al mundo laboral, puesto que todos al finalizar sus estudios obligatorios no continúan estudiando, aunque hay algunas excepciones.

estructura de la etapa de secundaria

La etapa de Secundaria está organizada en dos ciclos, que a su vez se subdividen en tutorías (grupos base), existen dos en el Primer Ciclo y dos en el Segundo Ciclo. Los criterios para la formación de los grupos base son la edad y el proceso madurativo del alumno. Para las clases instrumentales y los talleres se realizan agrupamientos por grupos de trabajo; en ellos hay menos alumnos con la finalidad de poder atender

todas las dificultades de aprendizaje que tienen, aunque también se cuenta con la colaboración del departamento de orientación que ayuda en los casos que necesitan más atención individualizada por tener demasiado retraso respecto al grupo. Los criterios que se establecen para el diseño de los grupos de trabajo son la madurez personal, el nivel curricular y la relación previa entre los miembros de los grupos.

A pesar de todo, si en algún momento del curso se considera oportuno el cambio de grupo de algún alumno se suele atender, ya que lo primero no es la estructura sino los alumnos. Puede que algún caso determinado exija un estudio más detallado, pero en ningún caso los criterios de agrupamientos e incluso organizativos nos cierran el camino a la flexibilidad necesaria para adaptarnos a peculiaridades de individuos y grupos.

Por tanto, los alumnos tienen dos modalidades de agrupamiento:

1. El Grupo Base, donde se desarrolla el ámbito psicosocial: tutoría y taller de vida cotidiana.
2. El grupo de trabajo, que se concibe como una unidad para trabajar las áreas instrumentales, el área de integración corporal y los talleres.

La estructura de Secundaria de una forma gráfica sería la siguiente:

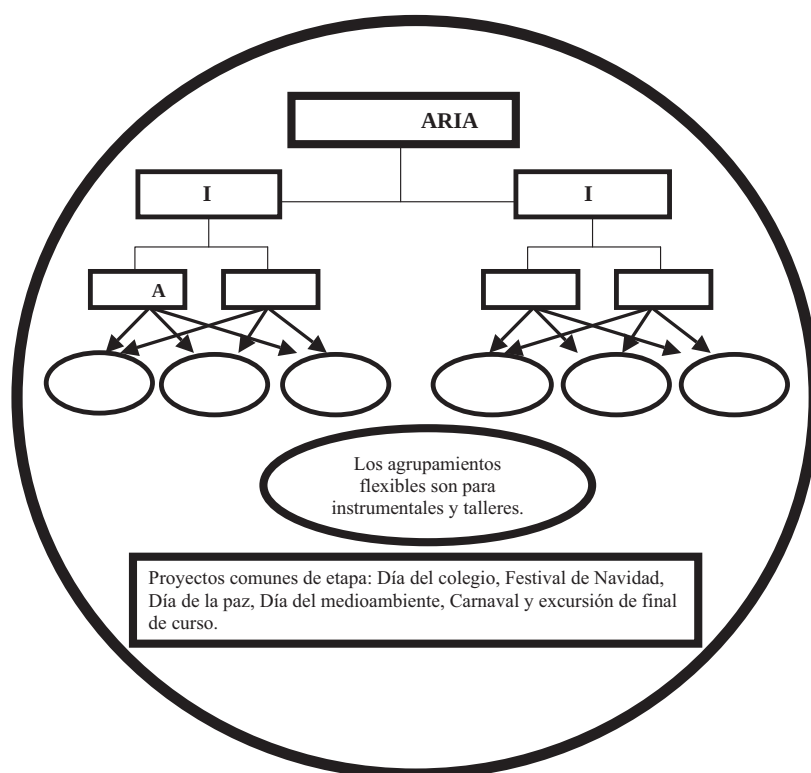


Figura Organización de la Etapa de Secundaria.

A) El Grupo Base

El Grupo Base es un lugar privilegiado para el desarrollo de las relaciones interpersonales, la responsabilidad en lo común, la autoevaluación personal y grupal del propio alumno y su seguimiento individualizado, así como para ayudar a dar vida y sentido práctico a la vinculación con su entorno. Un Grupo Base está compuesto por un número alrededor de 15 chicos/as y un tutor, que es la figura referente durante toda la etapa. Las condiciones ambientales del grupo base deben ser diferentes de un aula donde se trabajen contenidos instrumentales. El menor dispone de un espacio personal en su tutoría. El diseño de las tutorías se caracteriza por lo siguiente:

- a) La disposición de los muebles y el tipo de muebles facilita el trabajo convivencial (sofá, mesas colectivas y armarios colectivos).
- b) Con posibilidad de que presente varios ambientes que faciliten la convivencia, el trabajo en grupo y la parte lúdica.
- c) El alumno participa en la organización y decoración del ambiente, esto permite que se viva como propio y facilita el cuidado y la conservación de la tutoría. Así se puede iniciar el sentimiento de pertenencia a un grupo.

La didáctica y metodología que se aplica es en gran medida una alternativa a las actividades de lápiz y papel. La primera actividad es el diario: el primer objetivo de cada día es estructurar en el espacio y en el tiempo la jornada del alumno, para progresivamente ir aterrizando en temas relacionados con aspectos emocionales, de opinión o de convivencia. Se pide que escriban brevemente cómo ha ido el fin de semana, se pide que den su opinión sobre un conflicto en el grupo, en las instrumentales o en el taller, opinión sobre un tema social de interés, opinión sobre un tema de interés para el centro, para el grupo o para el ciclo. Plasman sentimientos con respecto a aspectos de sí mismo, su familia, sus amigos, el colegio, perspectivas de futuro. La tutoría es el lugar donde se ubica el alumno al iniciar la jornada escolar tanto por la mañana como por la tarde. El tutor recoge al alumno y le ayuda a organizar y estructurar la jornada que tiene por delante, mientras que en la tutoría de la tarde se destina principalmente a la interacción entre sus elementos y a resolver y ponerse al día en conflictos y trabajos.

B) El grupo de trabajo

Los grupos de trabajo se establecen es seis, porque permite reducir el número de alumnos/as y con ello facilitar su aprendizaje en una atención más individualizada. El agrupamiento de los grupos de trabajo está en función del nivel curricular de cada uno de los alumnos y alumnas, aunque también se tiene en cuenta el nivel de relación que existe entre ellos para favorecer un clima de sosiego que permita un aprendizaje por la totalidad de los miembros del grupo.

Los grupos de trabajo se agrupan para todas las áreas que no sean la tutoría y además tienen asignado un espacio por cada grupo para el desarrollo de las sesiones de instrumentales y optativas. Esas aulas tienen el mismo número que tiene el grupo de

trabajo. Otro lugar mucho más específico son los talleres, que más adelante se hablará de ellos.

En el grupo de trabajo el referente es el profesor que imparte cada una de las asignaturas y los objetivos que se persiguen son los siguientes:

- a) Crear un ambiente favorable al estudio.
- b) Potenciar el aprendizaje de los contenidos del área que se ofrece.
- c) Desarrollar hábitos de trabajo.
- d) Facilitar el desarrollo de la resolución de conflictos que surjan.
- e) Evaluar diariamente al alumno/a.
- f) Colaborar en la consolidación de los valores que se trabajan en la tutoría.

C) La jornada de un alumno.

Grosso modo la jornada de un alumno se distribuye de la siguiente manera:

- a) Tutoría. Su duración varía en función del día de la semana. Los martes y jueves dura 30 minutos y los lunes, miércoles y viernes dura 1 hora y 15 minutos. Esos días dura más la sesión porque es necesario disponer de un tiempo de tutoría amplio para desarrollar las actividades del Plan de Acción Tutorial.
- b) Después, cada uno va al aula de su grupo de trabajo para tener clase de alguna instrumental. Tienen dos sesiones seguidas de 45 minutos cada una, los martes y jueves, el resto de días de la semana solo tienen una sesión.
- c) A las 11,15 tienen un recreo de media hora, donde se intenta dinamizar con actividades deportivas, donde se organizan torneos de fútbol y baloncesto. Además, el grupo de los mayores monta un quiosco, ofreciendo bocadillos y refrescos que previamente han elaborado en el taller de hostelería.
- d) Posteriormente tienen dos sesiones, una de 45 minutos y la última de 1 hora. En estas franjas suelen tener clase de optativas y de educación física, que se imparte en la sesión más larga.
- e) Tras la mañana viene el momento de la comida y del tiempo del mediodía.
- f) A las 15 horas vuelven a tutoría, donde tienen una sesión de 45 minutos.
- g) Para finalizar el día, cada grupo de trabajo asiste al taller que le toca, con una duración de 1 hora y 15 minutos. La oferta de talleres varía de un ciclo a otro. En el Primer Ciclo se encuentran los talleres de madera, cerámica y artesanía por los que pasarán a lo largo del curso todos los alumnos/as del ciclo. En el Segundo Ciclo los talleres son los de mecánica, hostelería y cuero, con la misma rotación trimestral que en el Primer Ciclo.

La tutoría

La tutoría engloba muchos aspectos en sí misma y que a continuación se desarrolla uno a uno.

A) El tutor/a

En nuestro proyecto el tutor es el responsable y encargado del desarrollo de programas concretos en esta área, actuando como animador y dinamizador del grupo, realizando el seguimiento individualizado de cada uno de sus alumnos y manteniendo un contacto cercano con las familias con la colaboración del Departamento de Trabajo Social.

El tutor pretende ofrecer al alumno espacios que potencien su integración personal y su proceso de progresiva socialización, a través de una relación positiva con sus iguales y con los adultos. El tutor tiene que reunir una serie de características básicas para el buen funcionamiento de sus alumnos:

- a) Ser diferente en el modo de percibir al alumno, respecto al resto de profesores.
- b) Con habilidad para el cambio de expectativas en la consecución de logros de cada chico.
- c) Con cambios de actitud ante los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno.
- d) Con cambios de enfoque, dando más prioridad al proceso que al resultado final.
- e) Con un alto nivel de sensibilidad para no centrar la enseñanza tan solo en la modificación de estructuras cognitivas, sino también enfocada a la personalidad.

Entendemos que más importante que los contenidos de aprendizaje son las relaciones que se establezcan con el chico. Es necesario que se sienta acogido como es, a partir de su realidad, de su nivel de conocimientos, que vea que se le dedica tiempo a él, que puede expresarse, que él interesa. Es necesario que el alumno vea a su tutor como alguien incondicional tanto para estimular como corregir y modificar. El tutor es el responsable del proyecto vital del alumno desde que entra hasta que deja el centro. Ese proyecto de vida incluye su pasado (para cicatrizarlo), su presente (para animar y estimular) y su futuro (para proyectar).

B) El Plan de Acción Tutorial

El Plan de Acción Tutorial es una actividad inherente a la función del tutor, que se realiza individual y colectivamente con los alumnos de un grupo, con el fin de facilitar la integración personal en los procesos de aprendizaje y de actitudes (opiniones, sentimientos y comportamientos). La tutoría es la acción de ayuda y de orientación al alumno.

Los objetivos que nos planteamos con el Plan de Acción Tutorial son:

- a) Referenciar al Grupo Base como punto desde donde, cada tutor, realiza de modo singular el seguimiento de modo individualizado de cada integrante del grupo.
- b) Tomar conciencia del Grupo Base como algo propio. Se potencia el cuidado y se favorece un clima cordial. Se procura que los propios alumnos asuman responsabilidades dentro del Grupo Base.
- c) Iniciar y desarrollar un proceso de organización dentro del grupo. Se decide quién desempeña las funciones específicas de la asamblea del grupo (secretario y presidente). La asamblea la debemos de concebir como un órgano decisorio para planificar la semana, las salidas fuera del centro, facilitar la resolución de los conflictos entre ellos o con los tutores o él mismo, así como las dificultades de relación con el entorno, el centro o la familia.
- d) Fomentar y potenciar la comunicación intergrupal, no dejando pasar los conflictos y haciendo de mediador entre ellos y orientando en la resolución de los mismos.
- e) Hacerles participar a los chicos en la marcha general del Centro, conociendo y respetando las normas básicas de funcionamiento.
- f) *Convertir la tutoría en un enlace entre el menor, el grupo y el entorno.*
- g) Prestar especial atención y cercanía a las familias, para que comprueben que los tutores están por sus hijos/as.
- h) Generar el sentimiento de la responsabilidad.
- i) Educar en la contrariedad. Es preciso que se insista a los alumnos que alcanzar los propios objetivos cuesta esfuerzo y de que a menudo nos sorprenden dolorosamente la frustración, la decepción, el final no deseado. Hay que informarles de que sufrir contrariedades es una parte ineludible de la vida.
- j) Desarrollar las actividades específicas para que interioricen y actúen en consecuencia de cara a la puntualidad, al aseo e higiene personal, a la limpieza y orden en sus cosas, al aprendizaje de normas, al respeto hacia las personas y a la educación afectivo-sexual.
- k) Realizar trabajos dirigidos a conocerse y a conocer a los demás (dinámicas de grupos, actividades compartidas de elección personal, etc.).

Otra parte del Plan de Acción Tutorial es lo que se denomina “Vida Cotidiana” en él se pretende trabajar a través de las experiencias en la calle todas aquellas actividades socioculturales estrechamente relacionadas con la vida práctica en lo que se refiere al entorno natural, físico y social. Además, se promocionan hábitos que afectan a nuestros estilos de vida, con todo lo que con ello comporta. Las actividades que se desarrollan en están comprendidas en dos apartados:

1. Actividades encaminadas a mejorar las relaciones interpersonales, a tomar conciencia de grupo y a trabajar valores que enriquezcan la convivencia y ayuden a formar a la persona.

2. Actividades que atienden el entorno y las relaciones con otras instituciones, como el acceder a espacios colectivos comunes (parques, espacios deportivos, teatros, etc.), la participación en actividades culturales y el uso de los servicios públicos.

C) Plan de atención personalizado

El desarrollar un plan de atención personalizado con cada uno de los alumnos/as permite que exista un momento de comunicación más íntimo que con la presencia de compañeros. Así se evita el sentarse con el alumno, únicamente en los momentos de conflictos.

Los objetivos que se establecen al tutor para desarrollar un plan de atención personalizado son los siguientes:

- a) Descubrir potencialidades, fortalezas y debilidades.
- b) Ampliar la atención individualizada al margen del conflicto.
- c) Mejorar el conocimiento del menor aumentando la cercanía en el trato.
- d) Reducir angustias en los menores.
- e) Mediar entre el menor y la institución, compañeros, profesorado.
- f) Proceder de manera sistemática en la intervención.

La metodología que se lleva a cabo para que el tutor sepa cómo encaminar el plan personalizado está basada en la Terapia Estratégica Breve con menores. Antes de empezar es importante que el menor acepte al tutor como figura de referencia y tener un mínimo de relación afectiva con el mismo. Por lo menos durante un mes de habituación como mínimo para conseguir ese objetivo. Hay que aprovechar los momentos en que el menor esté receptivo.

Hay que tener presente que algunos menores no entienden la necesidad de ser ayudados, con lo cual hay que buscar objetivos que seduzcan al menor y poco a poco se irán proponiendo los cambios. Los objetivos han de ser propuestos por ellos aunque sea con nuestra ayuda, pero eso sí, concretos, alcanzables, evaluables a simple vista por el alumno, formulados en positivo y que permitan involucrar a otras personas que puedan certificar la mejora.

Tras la conversación se plasma en un documento el análisis efectuado donde se anotan los objetivos, las preguntas de escala y los apoyos que recibirá para darse cuenta, los obstáculos que encontrará (dentro y fuera de sí mismo) así como los procedimientos para lograr esos objetivos y su posterior revisión-evaluación.

D) Programa para la integración sociolaboral.

La transición hacia la vida laboral es un reto para el centro y para los propios menores, por ello con este programa lo que se pretende es dotarlos de las suficientes estrategias como para favorecer una integración social y laboral con mayores garantías.

No quiere esto decir que el resultado de las experiencias y conocimientos que puedan adquirirse en el programa signifique un pasaporte que conduzca de inmediato hacia el éxito en la consecución de un puesto de trabajo. Sin embargo, esta experiencia tiene su valor como elemento enriquecedor en el plano personal de nuestros alumnos.

Por el perfil del alumnado es necesario potenciar al máximo el desarrollo de las habilidades para la búsqueda de empleo. Estas habilidades buscan cumplir los objetivos que seguidamente detallamos:

- a) Desarrollar habilidades y destrezas específicas que promuevan la búsqueda de un empleo y en situación de igualdad con el resto de la población.
- b) Orientar en las vías de acceso a los recursos sociales e institucionales relacionados con la información, la educación y el empleo.
- c) Motivarles para que comiencen a definir y construir su futuro profesional según sus posibilidades, capacidades e intereses, ayudándoles a desarrollar la capacidad de elección y decisión para elaborar su proyecto vital.
- d) Desarrollar su capacidad de juicio y análisis para evitar situaciones de explotación laboral.

El proyecto va dirigido a los chavales de edades comprendidas entre 15 y 16 años que corresponde a su último año de escolarización en el centro. El programa está inmerso como una actividad en el Plan de Acción Tutorial de los alumnos de 4º de ESO.

talleres relaborales

Los talleres surgen como una alternativa hacia las necesidades de los menores respecto a su futuro más inmediato: el mundo laboral. Los alumnos han de percibir que el trabajo es una manera de integrarse en la sociedad y desarrollar de forma indirecta las habilidades laborales antes de llegar a 4º de ESO y esto va en beneficio de sus intereses futuros. Además, los talleres, junto con lo explicado anteriormente, son el atractivo para el alumnado que en otros institutos han fracasado o han roto las relaciones con el sistema educativo.

El diseño de los talleres tiene en cuenta las circunstancias especiales del alumnado, y por tanto, atiende a tres principios:

1. Más importante que los contenidos de aprendizaje son las situaciones de relación profesor-alumno.
2. El desarrollo progresivo del potencial de aprendizaje de alumnos.
3. La selección de contenidos está vinculada a la vida real.

En general los talleres representan un elemento importante de motivación a la hora de aprender, por lo que tienen de manipulativo, aproximación a la vida cotidiana y al mundo laboral de las personas adultas. Por las características intelectivas y cognitivas

de nuestro alumnado se entiende que la potenciación de todo aquello que suponga el trabajo del componente manipulativo ofrece una serie de bondades pedagógicas y metodológicas que coinciden con las necesidades de desacademización de nuestro proyecto pedagógico.

El centro ha ido creando los talleres de forma progresiva, actualmente son seis y se plantean por ciclos: tres en el Primer Ciclo (carpintería, electricidad y artesanía) y otros tres en el Segundo Ciclo (hostelería, automoción y cuero) por los que rotativamente pasan todos los alumnos en periodos trimestrales.

Los objetivos que se persiguen entre todos los talleres son los siguientes:

- a) Mejorar la autoestima del alumnado, con la realización de trabajos que luego pueden tener una aplicación real.
- b) Desarrollar la habilidad manual a través de las tareas propias de cada taller.
- c) Crear hábitos de organización y sistematización del trabajo.
- d) Fomentar la autonomía del alumno/a en sus tareas y toma de decisiones.
- e) Potenciar las actitudes necesarias en riesgos y prevención laboral.
- f) Favorecer el buen acabado de los trabajos.
- g) Potenciar el trabajo en equipo cuando la tarea lo requiera.
- h) Mantener ordenado y limpio el entorno del taller.

La metodología que se desarrolla en los talleres está compuesta de dos partes, una de ellas es teórica y la otra es práctica. En la parte teórica se explican cosas específicas del taller y que tienen una implicación directa con la tarea práctica a realizar a continuación, en ocasiones se omite esta parte porque ya se ha explicado en otra área instrumental. La parte práctica tiene dos vertientes: cuando se entra por primera vez en el taller se realizan actividades sencillas y determinadas por el profesor/monitor taller; conforme el alumno va cogiendo experiencia, se le va permitiendo que desarrolle proyectos desde su propia iniciativa.

Evaluación y seguimiento del alumnado

Los sistemas de evaluación están estructurados de la siguiente manera:

A) La evaluación diaria

El tutor de Primaria evalúa la evolución de cada uno de los chavales a quienes les imparte todas las áreas, exceptuando la Música y la Educación Física. Los profesores especialistas recogen la información de cada una de las sesiones que ha tenido con los diferentes grupos, para la posterior evaluación trimestral.

El tutor de Secundaria dedica un espacio de su jornada diaria para coordinarse con el resto de profesores de ámbito y talleres, equipo técnico y jefatura de estudios para recibir información sobre la evolución de su alumnado durante esa jornada. Los aspectos relevantes de esa evaluación permiten poder abordarlos de manera individualizada con cada alumno o con el grupo en el tiempo de tutoría y a la vez permite tener una gran agilidad a la hora de establecer planes de trabajo individualizados, cambios en los agrupamientos o la opción de cualquier otro tipo de medidas educativas. Por tanto, los profesores de las áreas y de talleres recogen la información de cada una de las sesiones que ha tenido con los diferentes grupos de forma individualizada, para la posterior evaluación trimestral.

B) Preevaluación trimestral

Cada tutor de Primaria y de Secundaria se reúne una vez al trimestre con el resto de profesorado que atiende a su grupo de alumnos para recoger la información relativa a su evolución personal y académica durante el trimestre y que a su vez sirve para la evaluación del boletín de notas del alumno. La información recogida en la preevaluación servirá para que el profesor la exponga en las reuniones de evaluación con dirección, jefatura de estudios y equipo técnico, que se efectuarán en la semana posterior a las reuniones de preevaluación.

C) Evaluación trimestral

Cada tutor de Primaria y Secundaria se reúne con la dirección, jefatura de estudios y equipo técnico una vez al trimestre para intercambiar datos que permitan abordar la intervención educativa del alumno desde una perspectiva más global. Trabajo social ofrece los datos relativos a la evolución de la familia y psicología los relativos a las intervenciones individualizadas con cada alumno y los datos relativos a la evolución sociométrica del grupo. Esta evaluación permite además proyectar los objetivos del alumno de cara al siguiente trimestre o a cambios en su escolarización, en el caso de propuestas de derivación fuera de nuestro centro o a aquellos que ya inician su tránsito a la vida adulta.

D) Evaluación de los criterios de competencia curricular

Dada las características del alumnado y su retraso escolar se diseñó un sistema de ítems por áreas que permite ir evaluando año tras año los avances realizados en cuanto a contenidos. Con el tiempo esta herramienta se ha informatizado y actualmente sirve para conocer el nivel curricular real de cada uno de los alumnos. Esto permite a los profesores situarse curricularmente ante la realidad individual de cada uno de los menores que forman los grupos. Este documento, actualmente con la implantación de la LOE, es el informe de traslado que el Centro ha optado por entregar, ya que se recoge toda la información académica del alumno en concreto.

Departamentos de Trabajo Social y de Psicología

El proyecto educativo tiene un recurso imprescindible constituido por dos departamentos: Trabajo Social y Psicología.

El departamento de psicología

El Departamento de Psicología tiene una función clave dentro del proceso educativo del menor, por varias razones: la primera es por el trabajo directo con el menor ya que pueden llegar más allá de lo que llega un profesor con determinados menores, y en segundo lugar porque se convierten en un apoyo para los profesores, tanto para las reflexiones como para las estrategias educativas a seguir con determinados grupos o alumnos. Desde el Departamento de Psicología se predispone una atención a todo el alumnado de ambas etapas que lo necesiten y demandado por los tutores. Las principales tareas que realizan son las siguientes:

- a) Recogen los datos psicológicos de los menores acogidos en el Centro.
- b) Realizan el seguimiento psicológico de la evolución personal y grupal de los menores.
- c) Intervienen psicoterapéuticamente con aquellos menores cuya problemática supere lo educativo, priorizando casos y atendiendo a la limitación de tiempo.
- d) Orientan a profesores y educadores respecto a las aptitudes y déficits de inteligencia y personalidad de los menores, de cara a la programación de la actividad socioeducativa con los mismos.
- e) Colaboran con el profesorado en la programación y revisión de actividades del Plan de Acción Tutorial (Plan de Activación de la Inteligencia; Prevención de Conductas de Riesgo; Habilidades Sociales; Sexualidad; Inserción Sociolaboral; etc.)
- f) Ofrecen un apoyo psicoterapéutico u orientación individualizada a los padres de aquellos menores que manifiesten una problemática conductual o de relación. Estas actuaciones se hacen conjuntamente con el Departamento de Trabajo Social.
- g) Acompañan y realizan el seguimiento los menores que reciben tratamiento neurológico, elaborando informes evolutivos para el neurólogo.
- h) Seguimiento de los/as menores en tratamiento psicoterapéutico, en su correspondiente Centro de Salud, o Unidad de Salud Mental Infantil.
- i) Colaboran en la formación de los profesores acerca de temas directamente involucrados con aspectos educativos.

e artamento de raba o ocial

La figura de la Trabajadora Social es fundamental en un centro con las características del alumnado de Nazaret, porque se necesita que alguien haga de enlace con las familias y que disponga de flexibilidad horaria para atenderles en el centro y en sus casas en función de las necesidades que surjan. Sobre todo lo que necesitan estas familias es que alguien les escuche y a su vez, el claustro de profesores necesitamos que alguien informe sobre las situaciones sociofamiliares de los menores y así establecer las prioridades en la atención del alumnado.

Las tareas que realiza la figura del Trabajador Social en Nazaret serían las siguientes:

- a) Lleva a cabo conjuntamente, con los Servicios Sociales Municipales, el plan de trabajo de acuerdo con el diagnóstico familiar realizado previamente al acogimiento del menor en régimen de centro de día.
- b) Realiza de interlocutor entre el medio sociofamiliar del menor y el centro, potenciando la implicación de algún miembro de la unidad familiar en el proceso educativo, a través de una relación conjunta familia-centro.
- c) Informa a profesores y educadores sobre la situación sociofamiliar y económica del menor, observando las incidencias que puedan impedir su buen funcionamiento en el centro.
- d) Valora, junto con el Departamento de Psicología, los casos familiares que requieran de una intervención conjunta.
- e) Apoya en momentos puntuales de crisis familiar, ofreciendo orientación en problemas concretos como alcoholismo y drogadicción de alguno de los progenitores. También en casos de separaciones y presunción de malos tratos, ausencias prolongadas de uno de los progenitores del domicilio familiar, relaciones agresivas y que repercuten en el funcionamiento del menor.
- f) En coordinación con la comisión de absentismo del Ayuntamiento, colaborar en la erradicación del absentismo a través de una serie acciones encaminadas a propiciar la asistencia regular de nuestro alumnado y aumentar el vínculo y la colaboración interinstitucional.
- g) Facilita y proporciona a los menores que lo precisen, alternativas de normalización donde puedan desarrollar actividades fuera del contexto institucional y así favorecer su integración, ya sea dentro o fuera de su propio barrio.
- h) Mantiene contacto con los Servicios Sociales Municipales, así como con Cáritas, para atender demandas económicas concretas, aportando la información de oportuna.

Atención por las tardes

NA ARET dispone de un recurso especializado que posibilita una oferta socio-educativa a partir de las 17 horas, cuando finalizan las clases. Los criterios de necesidad e idoneidad para acceder a este recurso dependen de la problemática que presente la situación sociofamiliar del menor:

a) Núcleo familiar con dificultades de atención personalizada hacia sus menores:

- Dificultades en la ocupación del tiempo libre de sus hijos, lo cual conlleva una ocupación anómica del mismo.

Ausencia de pautas de normalización. Incoherencia en las intervenciones educativas.

Deprivación estimular y afectiva.

Elevado número de miembros en la unidad familiar (situaciones de hacinamiento).

Patologías mentales de los progenitores.

Inhibición educativa de los progenitores.

b) Núcleos familiares con incompatibilidad de horario por motivos de trabajo.

c) Menores cuyas características de personalidad, muestran claros signos de desestructuración personal:

Menores con ausencia de hábitos de aseo e higiene personal.

Menores con ausencia de habilidades sociales y de relación interpersonal.

Menores con necesidades de ocupación creativa del tiempo libre.

Normalmente no se sujetan a una sola característica sino que más bien es la combinación de las ausencias de respuesta a las necesidades que demanda el menor por parte de la familia junto a las características de personalidad y comportamiento del propio menor, lo que justifica la intervención preventiva y terapéutica.

Lo que se pretende es ofrecer un tiempo y un espacio que atienda esas necesidades básicas que el menor no tiene cubiertas: alimentos, aseo personal, actividades de ocio y momentos de sosiego. Todas estas atenciones se engloban en el marco de un programa educativo que potencia la creación de hábitos y destrezas personales de los menores en un marco de convivencia casi familiar.

Por otro lado, conjuntamente con los Servicios Sociales Municipales, se procura trabajar con las familias para ir erradicando el problema familiar que originó que el menor se quede en este programa. En algunos casos sirve como alternativa al acogimiento en régimen de internamiento.

RETOS DE FUTURO

Para hablar del futuro hay que ser muy exigente con uno mismo y reflexionar con profundidad para orientar a Nazaret hacia sus nuevos retos. Por ello, antes de definir el incierto futuro, es conveniente observar nuestras debilidades y ver qué objetivos no se están consiguiendo últimamente. Uno de ellos es que se ha incrementado el absentismo entre el alumnado de la escuela, tras años en los que nuestra oferta escolar era válida para casi el 100 % de los destinatarios. Otro de los objetivos que no alcanzamos es que nuestro modelo de acogimiento residencial no es válido para todos los casos que se nos proponen, al tiempo que cada vez, son más los chicos acogidos para los cuales no encontramos “salidas” con garantías. Y por último, no conseguimos la inserción laboral necesaria para culminar los procesos de integración social de cada uno de los menores.

Aunque lo que sí está claro, y así lo verbalizan algunas personas, es que en Nazaret buscan una respuesta, tanto material como de todo tipo, atendiendo a sus necesidades. Pero además, podríamos afirmar que lo buscan en nosotros, preferentemente, por nuestro modo de proceder. Así queda confirmado por muchos casos, en que no solo son las personas las que quieren venir a nosotros, sino que también las propias administraciones son quienes nos las derivan de modo preferencial. Está claro que lo que les aportamos es posiblemente ese modo de proceder con ellos desde la cercanía, el respeto personal, el “no juzgar” y el compromiso. Nazaret ha adquirido la experiencia de 50 años actuando con la infancia en situación de riesgo, y al mismo tiempo ha sido capaz de adaptarse y evolucionar ante la transformación de las necesidades de los menores y sus familias.

Si nos preguntamos: ¿hacia dónde podemos prever que se orientarán las demandas y necesidades de los menores y las familias? Podemos decir que no es previsible que desaparezcan las “bolsas de marginación” que existen en Alicante, a pesar del desarrollo económico, aunque cambie “su rostro”. En cuanto a educación, nuestros alumnos corren el riesgo de ahondar en la brecha que les separa de los mínimos requeridos por la sociedad para trabajar e integrarse en ella. Además, no parece que vaya a decrecer todo lo relacionado con los delitos de jóvenes. Hay un fuerte “abandono” y distanciamiento social, una falta de recursos y oportunidades para el colectivo de adolescentes que están en la frontera entre la integración y la marginalidad social con o sin delito. También parece probable que continúe aumentando la maternidad de adolescentes en condiciones de grave riesgo para ellas y para sus hijos.

Ante los rasgos dibujados sobre la realidad que se percibe, nuestra colaboración se centraría en tres aspectos:

1. Deberíamos ser capaces de seguir acercándonos a sus vidas (no solo a sus problemas) desde una actitud de respeto, cercanía y compasión (bien entendida), y al mismo tiempo con el máximo de profesionalidad y eficacia que sus necesidades requieren.
2. En lo concreto, y como novedades, cabría hablar de anticipar nuestra acción al máximo, es decir, prevenir, como por ejemplo el programa de perinatales.
3. Y por otro lado, el incrementar la ayuda en la transición a la vida laboral. Trabajando y estructurando una metodología de seguimiento y colaboración con el menor en su proceso de inserción laboral.

Es obligación de Nazaret continuar atendiendo a los subgrupos de entre el colectivo de niños y jóvenes y sus familias, que quedan más o peor desatendidos desde otras instancias. Estos subgrupos se prevé que puedan suponer un aumento de niños y jóvenes inmigrantes de “segunda generación”. Además, cada vez aumenta la solicitud de respuesta residencial para menores con fuertes alteraciones de conducta.

Sin embargo, tal como se ve, el reto más importante al que se va a enfrentar Nazaret es el de mantener la opción que eligió en su momento. La presión social y política a la que nos veremos sometidos para elegir entre un modelo asistencial o un modelo mercantil es fuerte. Aunque la sociedad en su conjunto no concibe un modelo de justicia social y responsabilidad pública en defensa de los derechos y la provisión de las carencias de los menores, que es el que Nazaret defiende y por cuya implantación se ha esforzado por creer que es éste, y no los otros, el modelo que contempla y respeta la dignidad de los menores.

Esta presión ambiental, que no solo es política y social, tiene su correlato económico, y también su carga de incomprensión, que exigirá firmeza y convicciones profundas, para hacer frente a las dudas que seguro surgirán.

CUADRO RESUMEN DE LOS SECTORES DE INTERÉS PARA NAZARET

Centro de vida. 6 Pisos 2 Pisos puente	Centro de día. Centro educativo de compensatoria	Programas de familia	Programas de juventud
¿A quiénes atendemos? Niños y niñas de 6 a 18 años.	¿A quiénes atendemos? Niños y niñas de 6 a 18 años.	¿A quiénes atendemos? Familias, madres, Jóvenes y niños.	¿A quiénes atendemos? Jóvenes De 14 a 23 años.
¿A cuántos atendemos? 37 5	¿A cuántos atendemos? 175	Cerca de 120 fami- lias y más de 300 menores	Cerca de 300 jóvenes y familias.
Consellería de Bienestar Social.	Consellería de Educación Consellería de Bienestar Social.	Ayuntamiento de Alicante. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Ayuntamiento de Mutxamel Consellería de Bienestar Social.	Consellería de Justicia y Adminis- traciones Públicas
40 profesionales	43 profesionales	8 profesionales	10 profesionales

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV. *Análisis de una experiencia de trabajo con menores en pisos*. Alicante: Instituto Nazaret de Estudios Sociales. 1992.
- Biete S. Una experiencia en secundaria: taller de hostelería, *Aula de Innovación Educativa*, 2000. Vol. 97, p.69-70.
- Biete S. La transición de la escuela al trabajo de jóvenes en situación de riesgo social. El caso de los alumnos del Colegio Nazaret de Alicante, VIII Congreso Español de Sociología, Alicante, Formato CD-ROM. 2004.
- Bueno A. *Niños de la calle*. Barcelona: Cristianisme i Justícia. 1990.
- Bueno A. Terapia Institucional. Planteamiento de intervención en menores, *Revista De Serveis Socials*. 1990. Nº 11-12, p. 33-40.
- Frau MJ. De la marginación general a la marginación infantil. E. Bueno, Agustín (Coord.) Intervención social con menores. Fundamentación y programas de la Comunidad Valenciana, Alicante, Universidad de Alicante. 1996. 13- 30.
- Garrido R. Intervención en menores desde el ámbito escolar. En: Bueno A(Coord.) Intervención social con menores. Fundamentación y programas de la Comunidad Valenciana, Alicante, Universidad de Alicante. 1996. 249-258.
- Mollá D. Intervención educativa en el ámbito escolar con menores de entre 12 y 16 años en conflicto sociofamiliar grave, Actas de la XVIII Reunión científica de la Asociación española para la educación especial, Valencia. 1991. 268-275.
- Royo J. *Historia de Nazaret. años de historia en Alicante*. Parte I: 1957-1977. Alicante: Gráficas Olmedilla. 1996.
- Segura MA. Terapia Institucional: Un Modelo De Intervención Residencial Con Menores En Conflicto sociofamiliar grave: La experiencia de Nazaret, Actas de la *VIII Reunión Científica de la Asociación española para la educación especial*, Valencia. 1991. 308-316.
- Valverde J. *Proceso de inadaptación social*. Madrid: Editorial Popular. 3ª ed. 1996.

LA RESPUESTA EDUCATIVA ANTE EL MENOR DEPENDIENTE DE LA PROTECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

*José Luís Arias Ruiz de Somavía,
Vicente Hernández Milán, Zoraida Toledo Lillo*

INTRODUCCIÓN

Lo primero que tenemos que hacer a la hora de introducirnos en la respuesta educativa que se da al alumnado del colegio público Centro de Acción Educativa Singular “Centro de Recepción” de Alicante (CAES), es acotar una serie de conceptos claves que pertenecen al ámbito Educativo y al Jurídico-Social. Delimitar la tipología de los menores desde estas perspectivas, nos llevará a comprender mejor la situación de los mismos en el centro, la respuesta educativa que se da y la organización que se realiza en nuestro centro educativo.

a Desde el punto de vista educativo: encontramos delimitado el concepto de alumnado de compensación educativa en las diferentes ordenaciones legales, tanto a nivel estatal en el Real Decreto 299/1996 como, en la Comunidad Valenciana, en la Orden del 4 de Julio de 2001. En estas normativas está definido el alumnado de compensación educativa como:

“aquel que presenta dificultades de inserción escolar por encontrarse en situación desfavorable, derivada de circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas o personales”.

Estas necesidades de compensación educativa pueden deberse a:

- Incorporación tardía al sistema educativo.
- Retraso en la escolarización o desconocimiento de los idiomas oficiales por ser inmigrante o refugiado.
- Pertenencia a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja social.

Escolarización irregular, por itinerancia familiar o por abandonos reiterados o periódicos.

Residencia en zonas social, cultural o económicamente desfavorecidas.

Dependencia de instituciones de protección social del menor.

Internamiento en hospitales o en hospitalización domiciliaria de larga duración por prescripción facultativa.

Inadaptaciones al medio escolar y al entorno educativo.

El objetivo de la acción compensatoria es:

“desarrollar las actuaciones que permitan prevenir y compensar las desigualdades educativas con el fin de que los alumnos y las alumnas con necesidades de compensación educativa puedan hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y, superando la situación de desigualdad, puedan alcanzar los objetivos que se establecen para cada etapa”.

Así pues, nuestro alumnado es considerado de compensación educativa al ser dependientes de instituciones de protección social del menor, además de poder estar incluidos en alguno o varios de los motivos anteriormente citados.

De esta forma, el CAES “Centro de Recepción” de Alicante se encuentra ubicado dentro de un centro de primera acogida o centro de recepción perteneciente a los Servicios Sociales, lo que implica que nuestros alumnos son menores en protección, suponiendo una serie de cuestiones a las que se ha de responder.

Desde el punto de vista jurídico social para entender las características de nuestros alumnos debemos comprender una serie de términos, con los que muchos de los profesionales de educación no estamos familiarizados.

Debemos empezar definiendo lo que se entiende por acogimiento residencial y, aunque de manera incompleta, la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, en su artículo 21, establece que:

“cuando la entidad pública acuerde la acogida residencial de un menor, procurará que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga el interés de éste”.

El acogimiento residencial es una medida de protección de menores que se lleva a la práctica en los centros de protección. Estos son los destinados a educar, acoger y atender a los niños y adolescentes que necesiten una atención especializada por encontrarse en desprotección social, además de prestarles servicios de alojamiento, manutención y apoyo educativo. Los centros de acogimiento residencial se clasifican según la Orden de 19 de julio de 2003 de la Consellería de Bienestar Social en:

a) Centros de recepción.

- b) Centros de acogida.
- c) Hogares funcionales.
- d) Centros de emancipación.

Los centros de recepción de menores son establecimientos abiertos, de atención integral, inmediata y transitoria. La acogida de niños y adolescentes se realiza en el momento de producirse la necesidad por razones de desprotección. Su objetivo es proceder al estudio de su situación personal, social y familiar, y de su entorno, elaborando la propuesta de protección más idónea para cada caso (artículo 13.1 de la Orden de 19 de Julio de 2003). La estancia de los menores en este tipo de centros no debe superar el plazo máximo de cuarenta y cinco días (artículo 13.2 de la Orden de 19 de Julio de 2003). El ingreso de un menor en estos centros de primera acogida lo motiva una resolución administrativa de los órganos competentes en materia de protección de menores (artículo 13.3 de la Orden de 19 de Julio de 2003).

En la legislación se aclara que la atención escolar de los menores ingresados en los centros de acogimiento se realizará en los colegios de la red pública. Esta normativa indica que en el caso especial de los centros de recepción de menores, la atención escolar podrá prestarse en el propio centro, siendo este el motivo de la existencia y ubicación de nuestro colegio.

En este punto, sería oportuno hacer referencia a la situación legal con la que ingresan nuestros alumnos en el centro de recepción de menores y, por ende, en nuestro centro educativo, siendo ésta de guarda o desamparo por parte de la Administración:

Se puede definir la guarda como la figura jurídica consistente en la protección de los menores, durante el tiempo necesario a cargo de la entidad pública competente, por las circunstancias sociofamiliares. Esta guarda se realiza mediante el acogimiento residencial del menor en un centro destinado a ello, o por acogimiento familiar. Esta figura está recogida en el artículo 172.2 del Código Civil que dice:

“cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no pueden cuidar del menor, podrán solicitar de la entidad pública competente que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario”.

Por otra parte, la situación de desamparo, exige la separación del menor del entorno familiar. Según el artículo 172.1 del Código Civil:

“se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicios de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”.

Estas normas y las características especiales de los centros de primera acogida, plantean a la administración educativa la necesidad de proporcionar una respuesta acorde a las circunstancias de los menores y a las características del centro de recepción donde son acogidos.

LEGISLACIÓN SOBRE EL MENOR EN PROTECCIÓN SOCIAL Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Existe una relación entre la normativa de protección de menores y la normativa de compensación educativa. A lo largo de las últimas décadas se han ido introduciendo normativas de protección del menor, que han conducido a los estamentos educativos a desarrollar actuaciones que permitan prevenir y compensar las desigualdades.

a Desde el punto de vista jurídico social:

Se hace imprescindible mencionar en primer lugar la Constitución Española, que aunque las referencias que hace sobre la infancia son escasas, establece en su artículo 39.4:

“Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

La Constitución posibilita que las distintas Comunidades Autónomas puedan asumir competencias plenas en materia de protección de menores.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone en su artículo 19:

“Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, descuido o trato negligente”.

Esta Convención fue ratificada por la Carta Europea de los Derechos del Niño aprobada por Resolución del Parlamento Europeo en el año 1992.

Los Derechos del Menor en nuestro país, en desarrollo del artículo 39 del Capítulo III del Título I de la Constitución, así como los sistemas de protección y la adopción de los mismos, se desarrollan mediante la Ley 1/1996 de 15 de Enero sobre Protección Jurídica del Menor. Esta Ley establece los principios que rigen la actuación de la Entidad Pública.

En la Comunidad Valenciana, la Ley 12/2008 regula la protección de la infancia y de la adolescencia, así como el desarrollo y la promoción de los derechos básicos de los menores. Tiene como objeto, entre otros, el reconocimiento y la protección de los derechos básicos del menor, así como, el establecimiento del conjunto de medidas, estructuras, recursos y procedimientos para realizar la protección social y jurídica del menor en situación de riesgo o desamparo.

Desde el punto de vista educativo:

Durante el siglo xx se han ido desarrollando normativas en los diferentes países para dar respuesta educativa, social y protección jurídica a los menores. Nos estamos refiriendo, entre otras:

La Declaración de los Derechos del Niño encontramos en el principio número 7 que:

“El niño tiene derecho a recibir educación y unas condiciones favorables para el desarrollo de sus aptitudes, su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad”.

La Constitución Española, en sus artículos 27.1 y 27.2, manifiesta expresamente:

“Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

La LOGSE proporcionó un nuevo marco teórico en el que se delimitan nuevos conceptos como los de escuela inclusiva, educación compensatoria, atención a la diversidad, integración, necesidades educativas especiales, etc., que van a proporcionar la base para desarrollar no solo una serie de normativas educativas, sino también una serie de proyectos educativos acordes con los cambios sociopedagógicos que se estaban desarrollando, en lo que se van a intentar dar respuesta a la diversidad del alumnado.

Los principios fundamentales que rigen la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación orientan a la consecución de una educación de calidad para todos los ciudadanos y en todos los sistemas educativos, a la colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa para la consecución de mencionado fin y al compromiso que el sistema educativo tiene con los objetivos educativos propuestos por la Unión Europea.

Respecto a la compensación de las desigualdades en educación, la LOE dedica su capítulo II, artículo 80, a los principios para llevar a cabo la misma, ordenando que:

“las administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello”.

Asimismo, alude a que las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

En la Comunidad Valenciana, la Orden de 4 de Julio del 2001 (DOGV 17-07-2001) alude también a disposiciones legales cuyo objeto es llevar a cabo dicha acción compensadora y, a través de sus diferentes apartados, establece mecanismos para el logro de los objetivos que se pretenden.

La escuela no debe ser un ente cerrado a los problemas del entorno social donde se ubica. Debe entenderse como un elemento más de la acción educativa, que asuma su

responsabilidad y analice las necesidades que le plantean la sociedad en la cual está inscrita y de la que forma parte. Por ello, hay que promover soluciones educativas a las necesidades y demandas planteadas, ofertando una educación que dé respuesta a la diversidad.

EL COLEGIO PÚBLICO CENTRO DE ACCIÓN EDUCATIVA SINGULAR CENTRO DE RECEPCIÓN DE ALICANTE

Destacar una serie de consideraciones sobre los menores en acogimiento residencial en relación a la escolarización de los mismos en los centros educativos. La institucionalización de los menores en los centros de protección se produce como respuesta a una situación de desamparo. Esta situación provoca secuelas socioemocionales y afectivas. Los menores ingresan en los recursos de protección con un retraso académico y problemas de integración escolar, iniciándose un proceso de cambios en su escolarización y de peregrinaje por diferentes centros educativos, que comienza al ser separados de su entorno sociofamiliar y educativo. Pasan en un primer momento por los centros educativos asociados a los centros de recepción de menores, hasta que posteriormente son derivados a residencias. Todo esto provoca una nueva escolarización en un centro educativo ordinario. Este discurrir entre instituciones y centros educativos se puede prolongar en el tiempo, ocasionando en los menores problemas de rendimiento escolar y de adaptación, tanto a los nuevos centros educativos como a los compañeros; circunstancias que se deben tener presentes para desarrollar una respuesta socioeducativa adecuada.

El colegio público Centro de Acción Educativa Singular “Centro de Recepción” de Alicante, atiende a menores de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años. Su característica común es que se encuentran en una situación de protección por parte de la Consellería de Bienestar Social, fundamentándose el acogimiento en relación a una guarda custodia del menor o bien a una tutela del mismo como causa del desamparo. Los menores ingresados por este motivo provienen fundamentalmente de la provincia de Alicante, aunque también de otras comunidades y de otros países.

Los fines del internamiento de los menores en el centro de recepción de Alicante son:

“Acoger a los menores que, como consecuencia de diferentes problemas socio-familiares, son separados de sus familias y de su contexto social y personal”.

“Evaluar las necesidades del menor y la realidad de su entorno sociofamiliar”.

“Determinar el recurso de protección más indicado para el menor si la problemática social y familiar no ha sido solucionada”.

El perfil del alumnado es muy singular debido a la privación emocional, cognitiva y ambiental de los menores, propia del ambiente social de marginación en el que se desenvuelven.

Las características y problemática asociada a estos menores, teniendo en cuenta que en muchos casos se interrelacionan, se centran en:

- a) Factores asociados al menor: problemas de conducta, psíquicos y/o minusvalías, consumo de drogas, abusos sexuales, problemas de interrelación...
- b) Factores sociofamiliares: problemas de interrelación familiar, pautas educativas inadecuadas, incapacidad familiar, fracaso en los acogimientos, maltrato físico o emocional, abusos sexuales, abandono, problemas económicos graves, problemas de consumo de drogas o alcohol, ingreso en prisión de la familia,

Las características más significativas son:

a Características sociales

Proviene de familias rotas o desestructuradas debido a la ausencia de uno o ambos cónyuges por encarcelamiento, abandono, separación y son acogidos por la familia extensa. La familia no suele ejercer ningún control sobre el menor. En el entorno familiar casi siempre existen drogas, ya sea por tráfico, consumo, etc. Muchos de los alumnos son consumidores habituales.

Pertenecen a minorías étnicas o sociales desfavorecidas. Suelen vivir en zonas marginales y con fuerte hacinamiento.

Características psicológicas y cognitivas

La impulsividad es la característica más común en los menores. Presentan dificultades para resolver sus problemas personales debido a sus deficitarias habilidades sociales. El razonamiento está orientado a la acción antes que a la reflexión. Los desajustes emocionales por carencias afectivas son muy típicos en todos nuestros alumnos.

Se puede realizar un resumen de los déficits más comunes observados en los menores en acogimiento residencial: baja autoestima, carencias afectivas, desconfianza generalizada del mundo que les rodea, imposibilidad de configurar su “yo” por la falta de afecto, dificultades de integración con los demás, desarrollo del lenguaje inmaduro, desventaja ante el mundo escolar, conductas impulsivas, carácter antisocial

El internamiento de un niño en un centro de protección conlleva la separación de su familia y de su contexto, provocando sentimientos de angustia y estrés que se manifestarán en reacciones conductuales inadecuadas.

Todo ello repercute en su vida escolar, en la que se refleja una problemática caracterizada por:

“Una escolarización irregular que conlleva un gran desfase entre su nivel de competencia curricular y el que les correspondería por su edad. Rechazo al ámbito escolar. Carencia de motivación para aprender y de hábitos escolares.

“Absentismo, fracaso escolar, inadaptaciones de todo tipo y expulsiones frecuentes de los centros en el caso del alumnado de secundaria”.

- “Dificultad de mantener la atención. Intolerancia ante cualquier problema o frustración”.

EL PRO YECTO EDUCATIVO DEL C. P. CAES CENTRO DE RECEPCIÓN DE ALICANTE

La organización del Centro de Recepción de Menores responde a una división de los menores por edades, teniendo esta división unas características casi idénticas a la organización propuesta por Educación.

El C. P. CAES Centro de Recepción se organiza de la siguiente manera:

Tres profesores de primaria de la especialidad de pedagogía terapéutica que atienden al alumnado de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Uno de los profesores se coordina con el grupo de secundaria, al que presta apoyo, atendiendo a las necesidades, características y número de alumnos existentes en cada momento.

- Dos profesores de secundaria de los ámbitos socio –lingüístico y científico-técnico respectivamente, que dan respuesta al alumnado entre los 13 años y los 18 años.

De manera ocasional, dentro del grupo de primaria, se escolarizan menores de edades superiores a 12 años, bien porque el menor se encuentra en un nivel diferente al que le correspondería por edad o bien porque el equipo educativo, en colaboración con los profesionales de bienestar social, llegan a un acuerdo para incorporar a un alumno/a de secundaria al grupo de primaria por causas de especial protección.

Uno de los problemas que inciden a la hora de realizar proyectos, actividades e incluso la propia organización de los grupos educativos o la estructuración coherente del proceso de enseñanza-aprendizaje, es que, por las propias características del Centro de Recepción de Menores de Bienestar Social, la escolarización de los menores en nuestro centro educativo se realiza por un periodo de tiempo indeterminado, prolongándose, en algunos casos, hasta periodos superiores a los tres meses.

Por último, aclarar que el alumnado del CAES son menores que el sistema educativo considera de compensación por encontrarse en protección de los Servicios Sociales. Esta realidad no exime de encontrarnos, en la mayoría de los casos, con alumnos que presentan necesidades de compensación educativa por otros factores.

Las características educativas del alumnado de nuestro colegio son las siguientes:

Una parte de los menores que ingresan en nuestro centro y que por su edad cronológica están incluidos en la etapa educativa obligatoria de primaria, no han adquirido la habilidad lecto-escritora ni la competencia lógico-matemática

mínima y propia de la etapa de educación infantil y/o del primer ciclo de primaria.

Alumnos con abandono escolar temprano o bien con una escolarización tan irregular que no pueden seguir mínimamente el curso que le corresponde por edad.

Una mínima parte del alumnado pertenece al grupo de escolarización tardía al sistema educativo.

Alumnos inmigrantes, carentes de documentación y sin conocimientos del castellano, aunque en la actualidad la incorporación de este tipo de alumnos en nuestro centro educativo es muy baja. Por este motivo, los menores inmigrantes de nuestro centro se ubican dentro del rango de edades que se corresponden a primaria.

La mayoría del alumnado de nuestro centro educativo tiene problemas graves y muy graves a la hora de relacionarse con los demás e incluso, en ocasiones, con ellos mismos. Esta problemática se complica a medida que las edades de los alumnos y alumnas se acercan a la adolescencia.

Las *necesidades específicas de apoyo educativo* que se generan son:

- Acoger al alumnado cuando se incorpora a nuestro centro educativo.
- Explicar la organización de nuestro centro educativo y los objetivos que nos planteamos.
- Presentar los horarios y las normas de convivencia.
- Presentar al profesorado del grupo.
- Recoger información sobre su escolarización previa.
- Realizar un estudio inicial en cuanto al nivel curricular en el que se encuentra el alumno, con la finalidad de averiguar lo que sabe hacer y preparar, de este modo, un trabajo individualizado en todas las áreas del currículo.
- Necesidad de preparar unos materiales curriculares motivantes y adaptados de forma individualizada a las características y niveles de cada uno de nuestros alumnos y alumnas.

Las *necesidades sociales* que se generan son:

Compensar las desigualdades sociales.

Fomentar un proceso de adaptación al medio escolar y a su entorno próximo.

Favorecer la adaptación al entorno educativo y trabajar el reconocimiento de las dificultades escolares que plantean.

Adaptar los objetivos a las necesidades educativas individuales.

Dotar de hábitos de estudios y de motivación intrínseca, así como de hábitos de realización de tareas escolares fuera del horario escolar.

Mejorar el control de los impulsos.

Promover hábitos de lectura y escritura.

Promover intereses académicos futuros.

La realidad de nuestro alumnado en relación a los aspectos que hemos visto, nos llevan a plantearnos una línea de actuación que plasmamos en una serie de objetivos que, *grosso modo*, delimitan nuestro marco de actuación. Así, los objetivos que nos planteamos desde el centro educativo, se encaminan a:

Desarrollar actuaciones que permitan compensar las desigualdades educativas de los alumnos que están en situación desfavorable derivada de sus circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas y personales.

Desarrollar actuaciones que permitan, en la medida de lo posible, prevenir desigualdades educativas.

Atención a necesidades personales: autoconcepto, autoestima, emociones, capacidad de relación, etc.

Facilitar la integración social y educativa del alumnado en situación desfavorable, valorando la diversidad.

Garantizar la escolarización del alumnado con necesidades de compensación educativa en condiciones de igualdad de oportunidades.

Conseguir la competencia comunicativa en las lenguas vehiculares.

Conseguir una mejora general de los niveles de aprendizaje escolar, incidiendo, fundamentalmente, en las Técnicas Instrumentales Básicas.

Desarrollar una función compensadora de las deficiencias socio-ambientales, proporcionando un universo estimular rico, y potenciando una mayor motivación y valoración social hacia la escuela.

Mejorar los niveles de adaptación personal, escolar y social, mejorando las habilidades sociales.

Desarrollar y ofertar estrategias educativas distintas de las tradicionales, que permitan una formación más activa y práctica.

Implicar a los agentes sociales en la educación del alumnado que se encuentra bajo su protección.

Los objetivos que nos planteamos desde el CAES se llevan a la práctica desde proyectos de educación compensatoria. Estos proyectos están basados en las necesidades y características de nuestro alumnado y son flexibles y revisables anualmente.

El Programa de Acogida del alumnado del CAES tiene como prioridad minimizar, en la medida de lo posible, los efectos psicológicos y emocionales negativos del in-

ternamiento de los menores en el Centro de Recepción, así como de la separación de la familia y de su entorno.

Desde nuestros proyectos, educativo y curricular, pretendemos realizar una adaptación lo más individualizada posible de las necesidades educativas de cada uno de nuestros alumnos. Para ello nos ponemos en contacto con los centros de referencia de cada alumno para solicitar la información escolar que nos permita, junto a nuestra valoración inicial del nivel de competencias, adecuar las actividades educativas de los grupos, al nivel de cada uno de los alumnos.

El proyecto de biblioteca de aula nos permite llevar a cabo un programa de motivación hacia la lectoescritura.

El proyecto “cineforum” nos permite programar actividades de enseñanza aprendizaje mucho más participativas, donde intentamos fomentar principios de interrelación adecuados, así como desarrollar habilidades sociales óptimas.

Por su parte, el proyecto “hipoterapia”, como proyecto específico de acción compensatoria, lo hemos realizado con la finalidad de desarrollarlo conjuntamente con el resto de proyectos del centro, para responder, de una manera más lúdica, a las necesidades psicológicas y emocionales que presentan nuestros alumnos.

Por último, hemos de hacer mención a un proyecto todavía en fase de desarrollo, en el cual nos planteamos la necesidad de responder, de manera efectiva, a la realidad escolar de muchos de nuestros alumnos de secundaria: el abandono escolar.

BIBLIOGRAFÍA

- Amante C. Intervención Educativa en situaciones de desprotección. Situaciones de riesgo. Curso Cefire – Alicante. 2005.
- Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1959.
- De Miguel M. Investigaciones en torno a Educación Compensatoria, *Revista de Investigación Educativa*. 1984. Vol. 2, nº 3.
- De Miguel M. Orientación Educativa y Estrategias Compensatorias, *Aula Abierta*. 1986. nº 45.
- Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
- Declaración de Ginebra de 1924.
- Decreto 93/2001 de 11 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de medidas de protección jurídica del menor en la Comunidad Valenciana (DOGV 4008).
- Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Ordenación de la Educación para la Atención del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
- Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 12/2008, de 3 de Julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad Valenciana.
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
- Ley Orgánica 2/1996, de 3 de mayo, de Educación.

- Ley Orgánica 20-11-1995 N° 9/1995 de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes.
- Martín E, Muñoz MC, Rodríguez T, Pérez Y. De la Residencia a la escuela: la integración social de los menores en acogimiento residencial con el grupo de iguales en el contexto escolar. *Psicothema* 2008, vol. 20, n°3, pp. 376-382. En www.psicothema.com
- Moya JC. Organización de los Servicios de Protección a la Infancia en la Comunidad Valenciana. Análisis Normativo y Funcional. Alternativas. *Cuadernos de Trabajo Social*. 1997. n°5.
- Orden de 17 de enero de 2008, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana.
- Orden de 4 de Julio de 2001, de la Consellería de Cultura y Educación, por la que se regula la Atención al Alumnado con Necesidades de Compensación Educativa. Generalitat Valenciana, Consellería de Educación.
- Orden de 19 de julio de 2003 de la Consellería de Bienestar Social por la que se regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores en la Comunidad Valenciana.
- Orden de 22 de Julio de 1999 por la que se regulan las actuaciones de Compensación Educativa en Centros Docentes sostenidos con fondos públicos.
- Pacheco JL, Arzo JA. El niño y la niña con deprivación sociocultural. En Bautista R (ed.). *Necesidades educativas especiales*. Málaga: Aljibe. 1993.
- Real Decreto 299/1996 de 28 de febrero de Ordenación de las Acciones Dirigidas a la Compensación de Desigualdades en Educación.
- Resolución del Parlamento Europeo A3-0172/92, sobre una Carta Europea de Derechos del Niño, de 8 de Julio de 1992.
- Repetto E. *Modelos de intervención psicopedagógica*. Volumen I y II. Madrid: UNED. 2002.
- Sánchez A, Villegas F. Dificultades por deprivación sociocultural. En: Bautista (ed.). *Necesidades educativas especiales*. Málaga: Aljibe. 1998.

LA EDUCACIÓN DE LOS MENORES ENFERMOS CRÓNICOS U HOSPITALIZADOS

*Francisco Abel Garrido Ferrer,
Adela García García*

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad es un estado que experimentamos prácticamente desde el nacimiento. Tanto adultos como niños/as, entendemos y vivimos la enfermedad como algo normal. Cuando este estado implica una hospitalización, una cronicidad o una larga convalecencia, es vivido por el niño o adolescente como una amenaza, produciendo sentimientos y emociones de angustia, desmotivación, estrés, miedo, ansiedad, rechazo e incluso depresión. Esta situación llega a convertirse en un factor que incide negativamente en el proceso de curación, interfiriendo en el normal desarrollo del menor. Las consecuencias de la enfermedad conllevan una alteración importante en las rutinas del niño, afectando no solo a su estado físico, sino también a su ritmo escolar, a sus relaciones socioafectivas y a su desarrollo psicoemocional. Todo ello implica que el menor debe afrontar problemas y situaciones que no siempre alcanza a comprender ni, por tanto, asimilar.

En la hospitalización de un menor se da la paradoja de que él es protagonista de una escena para la que no dispone de estrategias que le permitan entenderla, controlarla y afrontarla correctamente. Además, a pesar de ser él quien escribe el guión, sus opiniones, necesidades y deseos no son escuchados ni entendidos como prioritarios por los adultos.

Según Grau (2004), las consecuencias de la enfermedad sobre los niños y adolescentes se pueden agrupar en cuatro bloques:

Consecuencias psicológicas ansiedad, agresividad, sentimiento de culpa, ira, negatividad y cambios en la imagen corporal.

Consecuencias sociales fobias o fracasos escolares, aislamiento social, entorno más pobre de estímulos y sobreprotección.

Consecuencias por la hospitalización cambio brusco de entorno y de las actividades cotidianas.

Consecuencias por secuelas propias de la enfermedad: cambios en hábitos, uso de medicaciones, utilización de aparatos

Ante esta situación, se pone de manifiesto que la intervención sobre los problemas de salud de los menores no deben abordarse únicamente desde el ámbito médico-sanitario, sino que ha de ser una tarea multidisciplinar. Una intervención social, psicológica y pedagógica, obliga a la creación de los recursos psico-socio-pedagógicos (tanto personales como materiales), necesarios para atender estos aspectos. Las aulas hospitalarias son uno de los recursos donde además de tratar objetivos puramente educativos y de formación, se incluyen elementos lúdicos, emocionales y sociales.

13.2. ARCO HISTÓRICO LEGAL DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS AS ENFERMOS AS

En España, la relación entre el medio hospitalario y el pedagógico comienza a principios del siglo xx. Durante la Segunda República, existieron maestros que dedicaron tiempo y esfuerzo a la educación de los niños ingresados en hospitales, aunque su labor tuvo poco reconocimiento por parte de las instituciones públicas (Leiva *et al.*, 1994). Hasta mediados del mismo siglo, no hay mucha constancia de dicha relación y la existente solía estar vinculada con órdenes religiosas. Sería a mediados de los años sesenta del siglo pasado cuando los poderes públicos comenzaran a implicarse en la tarea de llevar la escuela al hospital.

Con el comienzo de la democracia y la aprobación de la Constitución, se generaliza el derecho a la educación y a la integración escolar de todos los españoles (artículos 10 y 27). Esto supone la primera piedra para la creación y articulación de las grandes leyes sociales y educativas, y por ende, para el nacimiento de las aulas hospitalarias. Ya en la década de los ochenta del siglo pasado, con la publicación de la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido), y los Reales Decretos que la desarrollan, se crean, definen y generalizan las funciones de estas aulas en todos los hospitales públicos y concertados. Dicha Ley Orgánica, en su artículo 29 señala que:

“Todos los hospitales, tanto infantiles como de rehabilitación, así como aquellos que tengan Servicios Pediátricos Permanentes, tendrán que contar con una Sección Pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos de edad escolar internados en dichos hospitales”.

Posteriormente, el Real Decreto 334/1985, de 6 de Marzo, de Ordenación de la Educación Especial, marca un hito en la materialización de las aulas hospitalarias. Fruto de este Decreto son los convenios de colaboración entre las administraciones educativa y sanitaria. En términos generales, se podría decir que la administración sanitaria es la responsable de la creación, mantenimiento y dotación de medios materiales del aula, siendo la educativa la encargada de dotarla con recursos humanos.

Así mismo, en 1986, el Parlamento Europeo aprueba la carta de los Derechos del Niño Hospitalizado, en la que, entre otros, se recoge el derecho del niño a continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje durante su hospitalización. Esta normativa europea señala en su punto E que:

“Los niños y niñas tienen derecho a proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital, y a beneficiarse de la enseñanzas de los maestros y del material didáctico que las autoridades escolares pongan a su disposición, en particular en el caso de una hospitalización prolongada, con la condición de que dicha actividad no cause perjuicios a su bienestar y/o que no obstaculice los tratamientos que se siguen.”

Con la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre General del Sistema Educativo, se da un nuevo impulso a las escuelas hospitalarias. Desde el nuevo marco teórico que establece la LOGSE, se acuñan conceptos como necesidades educativas especiales, escuela inclusiva, educación compensatoria, atención a la diversidad, integración, conceptos todos ellos en los que se basan las aulas hospitalarias. Así mismo, se crea un documento llamado “Aulas Hospitalarias” y un programa de Educación Compensatoria de Aulas Hospitalarias (Grau, 2001). Desde estos documentos, el Ministerio de Educación abre la puerta a que la atención del alumno enfermo, convaleciente o crónico pueda realizarse tanto en el centro hospitalario como en el domicilio.

El Real Decreto 299/1996, de 28 de Febrero, de Ordenación de las Acciones Dirigidas a la Compensación de las Desigualdades en Educación, fortalece la anterior normativa, estableciendo medidas destinadas a la atención domiciliaria del alumnado absentista por motivos de salud prolongados y justificados, y regulando el funcionamiento de las aulas hospitalarias (arts. 18, 19 y 20).

Más recientemente, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (LOE), si bien no recoge ningún artículo dedicado a las aulas hospitalarias, hace en su preámbulo especial hincapié en la atención a la diversidad, ampliando el concepto de necesidades educativas especiales y hablando de “necesidades específicas de apoyo educativo”. En este sentido, destaca la importancia de la educación compensatoria y de la escuela inclusiva.

Posteriormente las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia educativa, han ido concretado la creación, organización y funcionamiento de las aulas hospitalarias a través de la correspondiente normativa legal. A modo de ejemplo, la Comunidad Valenciana con su Orden de 4 de Julio de 2001, de la Consejería de Cultura y Educación regula la atención del alumnado con necesidades de compensación educativa, y con la Orden de 21 de Noviembre de 2006 de la Consejería de Educación, se determinan los criterios y procedimientos para la atención hospitalaria y domiciliaria del alumnado que requiera compensación educativa en los tramos de educación obligatoria.

LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS ENFERMOS

El sistema educativo español garantiza la continuidad de la atención escolar y del proceso de enseñanza-aprendizaje a la población en edad de escolarización obligatoria, durante el desarrollo de la enfermedad o convalecencia.

Además de asegurar los aspectos puramente instructivos y curriculares, los colegios hospitalarios ayudan al adecuado desarrollo cognitivo, afectivo, emocional y psicológico del niño. Al enfermar un niño y ser hospitalizado, hay una ruptura en sus rutinas diarias, entre las que se incluye la escuela. La hospitalización supone integrarse en un ambiente con normas, usos, terminología y entramado social muy diferente al que está acostumbrado, provocando sentimientos de inseguridad y miedo en el niño, hasta que comprende la organización y funcionamiento del centro hospitalario. El aula hospitalaria es una poderosa herramienta para la construcción de esta comprensión (Ortigosa *et al.*, 2002). Los niños y adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo integrados en el sistema educativo, donde se desarrollan y realizan aprendizajes escolares. Establecer una pauta similar a la del entorno escolar hace que se amortigüe la ansiedad generada por la hospitalización y facilita la integración del menor en la vida y rutinas del hospital.

Los principios teóricos en los que se basan las aulas hospitalarias son relativamente recientes, ya que surgen a finales del siglo pasado. Los grandes principios que fundamentan y dan sentido a la creación, organización y funcionamiento de las escuelas en los hospitales son: Educación Compensatoria, Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva (Grau, 2001).

El principio de Educación Compensatoria, en el ámbito de las aulas hospitalarias, pretende que la situación de hospitalización y/o enfermedad de los niños no suponga una merma de sus oportunidades educativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, compensando así el posible retraso instructivo que esta situación le pueda ocasionar.

La Atención a la Diversidad en el medio educativo hospitalario supone reconocer, entender y aceptar la heterogeneidad existente entre los alumnos con patologías que implican hospitalización, cronicidad o convalecencia. Esta heterogeneidad es tan amplia como la población infantil enferma, así que no puede existir una única respuesta educativa. Puesto que las necesidades específicas de apoyo educativo son diversas, se debe abordar la educación de cada menor de forma individualizada. Hay que entender la hospitalización y la enfermedad como una necesidad específica de apoyo, a la que hay que responder desde el Sistema Educativo como si de cualquier otra se tratase, con las peculiaridades que cada patología supone.

El principio de Educación Inclusiva es otro de los que debe impregnar la organización, funcionamiento y finalidad de las unidades pedagógicas hospitalarias, en el caso de niños que requieran hospitalización. Por otra parte, la existencia de un único sistema educativo (que no discrimina entre uno ordinario y otro especial), implica que éste es capaz de incluir y dar respuesta a la heterogeneidad de los alumnos, atendiendo de manera eficaz las necesidades de todos y cada uno de ellos. Una escuela inclusiva debe estar preparada para afrontar el reto de acoger y atender las

necesidades de los alumnos enfermos crónicos y de larga duración, realizando las adaptaciones necesarias para que accedan a la educación a pesar de las exigencias de su estado (medicaciones, ayudas ortopédicas, aparatos que deban de utilizar). De acuerdo con el principio de la inclusión, el centro ordinario (centro escolar), surge para estos niños enfermos y/o crónicos, como un lugar flexible, preparado e idóneo para su atención educativa (Grau, 2002).

13.3.1. Necesidades específicas de apoyo educativo en niños enfermos hospitalizados, convalecientes y/o crónicos

Las principales necesidades educativas que manifiestan los niños enfermos se derivan fundamentalmente de las exigencias curriculares del ámbito escolar, las características del entorno hospitalario y las condiciones y peculiaridades de la propia enfermedad (Grau, 2003).

Una corta hospitalización tiene escasa incidencia en el progreso educativo del niño. Cuando esta hospitalización supone un ingreso largo o una larga convalecencia en casa, se produce un desfase o retraso curricular con respecto al resto de pares. Este retraso es más evidente en el caso de alumnos con enfermedades crónicas, que han de alternar periodos de ingresos hospitalarios y/o convalecencia con la escuela, siéndoles muy difícil seguir el ritmo normal del proceso educativo.

La hospitalización supone la ruptura de la rutina diaria, provocando ansiedad y miedo ante lo nuevo y desconocido. También existe miedo y estrés ante todas las situaciones que implican intervenciones quirúrgicas (Ortigosa *et al.*, 2007, Quiles *et al.*, 1999). Estas situaciones estresantes e invasivas, deben ser abordadas desde las aulas hospitalarias y entendidas como una necesidad de apoyo educativo, ayudando a mejorar la integración del niño en ese “gigante” que es el hospital.

La comprensión del entorno hospitalario y de la propia enfermedad, la creación de espacios lúdicos y el fomento de la comunicación de experiencias con otros niños, alivia estos estados estresantes, tanto leves como moderados. La unidad educativa hospitalaria se presenta como un entorno educativo y flexible, de apoyo ante la situación de hospitalización (Barrueco *et al.*, 1997). El aula es, además, un espacio donde el juego es una poderosa herramienta para que el menor elabore, entienda y asuma la situación de enfermedad, hospitalización e intervenciones quirúrgicas (González *et al.*, 2000), facilitándole la comprensión de los usos y funciones del material, las técnicas diagnósticas y el entramado de relaciones sociales del centro hospitalario (Ortiz, 1994).

En el caso de menores con patologías crónicas o de muy larga duración (diabetes, fibrosis quística, oncológicos, inmuno deficiencias...), la enfermedad y lo que esta conlleva, supone también la aparición de necesidades específicas de apoyo educativo. Los menores deben acostumbrarse en su vida cotidiana a utilizar determinados aparatos, manejar fármacos e incorporar nuevos hábitos, lo que obliga a realizar las adaptaciones necesarias, tanto en el ámbito familiar como en el escolar.

13.3.2. Organización de la respuesta educativa

La respuesta educativa debe ser ajustada a las necesidades y, por tanto, ágil y flexible. Esto exige un esfuerzo de colaboración y coordinación entre los diversos agentes que intervienen con el niño enfermo crónico, convaleciente y/u hospitalizado (aula hospitalaria, centro educativo de procedencia, familia, personal sanitario, psicólogo,) (Grau, 2001).

La respuesta educativa a los niños enfermos se puede dar tanto en el hospital como en el domicilio, y siempre ha de tener en cuenta los factores extrínsecos e intrínsecos que inciden en el menor. Estos factores son:

Intrínsecos: edad, estado psicoemocional, estado físico, necesidades afectivas, educativas y de relación

Extrínsecos: personal sanitario y factores médicos, medicaciones, ubicación del alumno y posibilidades de desplazamiento, uso de aparatos y material sanitario (pulsioxímetros, agujas, bombas para el suero, mascarillas...), ayudas técnicas-ortopédicas.

La atención educativa hospitalaria es aquella que se facilita desde el sistema educativo cuando el niño es hospitalizado. Esta atención se lleva a cabo en el recinto hospitalario por parte de personal educativo (maestro y/o profesores). Los objetivos de esta atención son muy variados, y abarcan desde objetivos educativos hasta psicológicos y sociales. Los objetivos educativos son los relacionados directamente con los aspectos instructivos y curriculares, incluyendo además contenidos relacionados con el medio hospitalario (instrumental, técnicas utilizadas). Los objetivos psicológicos, abarcan contenidos relacionados con emociones, conductas y afectos. Finalmente, los objetivos sociales desarrollan los aspectos asociados a las relaciones personales intra y extra hospitalarias, y la comprensión de rutinas.

La atención domiciliaria, por su parte, se ofrece desde el sistema educativo a aquellos alumnos que, debido a largas convalecencias o enfermedades crónicas, presentan un alto grado de absentismo escolar. Estas ausencias del centro escolar provocan grandes retrasos educativos y tienen consecuencias psicológicas y sociales adversas. La intervención educativa en estos casos debe orientarse a minimizar las consecuencias de la enfermedad o convalecencia y las repercusiones que estas tienen sobre el menor.

Cada Comunidad Autónoma ha regulado, o está en vías de ello, este servicio, siendo la primera en hacerlo el Principado de Asturias. Esta autonomía, en 1993, dio los primeros pasos en la atención domiciliaria a menores en edad de escolarización obligatoria, enfermos o convalecientes. Con la misma finalidad (la atención domiciliaria del niño enfermo), cada autonomía ha dispuesto diferentes medios y formas de organización de la atención educativa domiciliaria. Mientras que en unas son asociaciones sin ánimo de lucro (financiadas con fondos públicos) las que se encargan de la atención, en otras se ha promovido la creación de equipos de atención domiciliaria o de plazas de profesores itinerantes que se desplazan al domicilio del alumno.

EL AULA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

El aula hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche (a partir de ahora HGU de Elche), es atendida actualmente por dos docentes dependientes de la Consejería de Educación. En la planta de escolares de este centro hospitalario (6ª derecha), ingresan anualmente alrededor de setecientos niños, con edades comprendidas entre los tres y los diecisiete años. Los motivos de ingreso son muy variados (traumatología, pediatría, cirugía, neurología, otorrinolaringología), así como la duración de la hospitalización.

Desde el aula hospitalaria del HGU de Elche se realizan tanto atenciones educativas en el hospital como atenciones domiciliarias.

13.4.1. Aula del hospital

La intervención educativa del aula hospitalaria se organiza atendiendo a varios criterios: nivel educativo que esté cursando, duración del ingreso (menos de una semana o más), y posibilidad de desplazamiento. Respecto al último criterio, si los alumnos se encuentran en aislamiento o inmovilizados, son atendidos en la habitación. En cualquier otro caso, acuden al aula en cama, silla de ruedas o a pie, siguiendo siempre el criterio del personal sanitario de la planta.

La rutina diaria comienza durante el desayuno, momento en el que se visitan las habitaciones para conocer los nuevos menores ingresados. Los docentes se presentan a los niños y adolescentes, dando a conocer el aula hospitalaria y las actividades que en ella se desarrollan, así como reforzando la motivación de los alumnos que ya asisten a la misma.

Tras desayunar, los alumnos acuden al aula donde, además de realizar tareas propiamente curriculares, se desarrollan actividades lúdicas y se atienden problemas de ansiedad y miedos derivados del ingreso hospitalario. Todo esto en un clima distendido y relajado, donde los menores pueden comunicarse sus experiencias y transmitirse información unos a otros respecto a las vivencias de su enfermedad y hospitalización. Además, se establecen rutinas para que los menores normalicen lo máximo posible su estancia en el hospital (hábitos de aseo e higiene personal, estudio, clase, alimentación, etc.). La actividad del aula se desarrolla de 9 h a 16,30 h, interrumpiéndose por las visitas médicas, curas, realización de pruebas diagnósticas y las comidas.

Recursos materiales y recursos

Además del material escolar propio de un aula ordinaria, el aula hospitalaria cuenta con los recursos de biblioteca, ludoteca, medios informáticos y audiovisuales.

La actividad se desarrolla entre el aula de planta de escolares y la Cibercaixa (1ª planta en el solárium), construida y cedida por la Obra Social de “La Caixa”.

b etivos

Objetivos generales:

Reducir el efecto del “Síndrome de ansiedad por separación”, normalizando la situación personal, afectiva, social y académica del niño hospitalizado, creando un entorno lo más agradable posible, que permita al niño vivir su estancia hospitalaria de una manera más positiva para evitar el “trauma hospitalario”.

Dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje durante la hospitalización, ayudando al niño a continuar con sus tareas escolares y evitando el desfase académico que pueda surgir por su hospitalización (la coordinación con el centro de procedencia es fundamental en caso de hospitalizaciones prolongadas).

Mejorar el estado psicomocional y de relación interpersonal de los menores hospitalizados.

Objetivos específicos:

Crear un buen ambiente en el aula hospitalaria que les motive a asistir a ella y que facilite la comunicación de experiencias y transmisión de información.

Fomentar la socialización y la capacidad de hacer nuevos amigos.

Adquirir conductas de tolerancia y comprensión hacia los demás (aceptación de la diversidad), fomentando el apoyo mutuo y la colaboración en situaciones especiales como ésta.

Despertar la curiosidad por conocer y descubrir el entorno hospitalario.

Lograr que el hospital sea una continuación de la experiencia vital de los pequeños pacientes, y no una interrupción traumática de la misma, planteando la enfermedad como un reto a superar desde un punto de vista positivo.

Organizar actividades lúdicas, educativas, recreativas y culturales en el hospital.

Adoptar hábitos higiénicos y de educación para la salud.

Cuidar, ordenar y limpiar el material utilizado en el aula.

etodolo a

Los principios metodológicos que orientan la intervención educativa en el aula hospitalaria del HGU de Elche son:

Normalización el ingreso hospitalario es un hecho extraordinario, cuanto antes se normalice, antes se aliviará la situación de estrés que conlleva. Se debe tratar a los niños con normalidad, teniendo en cuenta las limitaciones que la enfermedad impone.

Individualización y personalización se atiende a todos y cada uno de los niños en función de las características personales, limitaciones y necesidades de apoyo educativo específicas.

Adaptación tanto los objetivos y contenidos que se desarrollan en el aula, como los recursos materiales y personales, se adecuan a las circunstancias de los niños.

Participación todos los agentes implicados en la hospitalización del niño (médicos, enfermería, familia, centro educativo de referencia), deben incluirse en la actividad de la escuela hospitalaria.

L dico el humor y el juego, son aspectos que deben impregnar la dinámica del aula, y la intervención educativa durante la hospitalización.

valuaci n

Cuando la estancia de los alumnos se prolonga más de una semana, el centro escolar de procedencia del menor remite los controles de evaluación al aula hospitalaria, realizándolos el niño en un ambiente adecuado. Posteriormente, dichos controles son remitidos al centro escolar. Al terminar la hospitalización, se elabora y remite un informe al centro escolar de procedencia del alumno, en el que se recoge todo el trabajo realizado.

oordinaci n

La coordinación es fundamental si se desea que la intervención sea completa, ajustada y adecuada a las necesidades de los niños y adolescentes ingresados. Este principio es idéntico en el caso de las atenciones domiciliarias. Esta coordinación se realiza con agentes internos y externos del hospital.

- A) Agentes internos: personal de enfermería, médicos (pediatras, traumatólogos, neurólogos,), familia, trabajadoras sociales, psicólogo, asociaciones (voluntarios del HGU de Elche y AECC).
- B) Agentes externos: centro educativo de procedencia, inspección educativa, asociaciones y entidades municipales.

13.4.2. Atención domiciliaria

Desde el aula del HGU de Elche se realiza la atención domiciliaria de los alumnos, que por motivos de salud justificados o convalecencia, se ausentan de su centro educativo por un periodo superior a dos meses.

r ani aci n de la atenci n en domicilio

Una vez que la Administración Educativa autoriza la realización de la atención domiciliaria, se contacta con el centro educativo donde está escolarizado el alumno, con los objetivos de transmisión de información, de material (para iniciar la intervención educativa), y el establecimiento de coordinación. Igualmente, se contacta con los padres o tutores del niño, se visita el domicilio del alumno y se acuerdan los días y horario de las sesiones educativas.

ecursos

Los recursos materiales son los facilitados por el centro educativo de procedencia y la familia del alumno, aunque en ocasiones, desde el aula hospitalaria también se aporta material (ordenador portátil, programas informáticos educativos y material de apoyo).

b etivos

El objetivo fundamental es dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje durante la larga convalecencia en el domicilio, intentando aliviar el desfase educativo que esta pueda ocasionar.

Al igual que en el aula del hospital, en la atención domiciliaria se pretende mejorar el estado psicoemocional y social de los menores convalecientes.

Otros objetivos a destacar son:

Ayudar a la socialización del alumno facilitando el contacto con sus amigos y el mundo exterior, mediante el uso de nuevas tecnologías.

Lograr que la convalecencia sea continuación de la experiencia vital del alumno, planteando la enfermedad como un reto a superar de manera positiva.

Potenciar el uso de medios informáticos, tanto en actividades curriculares, como lúdicas.

Aliviar la monotonía que supone las largas estancias en domicilio.

etodolo a

Los principios metodológicos que orientan la atención domiciliaria son los mismos que los contemplados en la intervención educativa hospitalaria: normalización, individualización y personalización, adaptación, participación y lúdico.

valuación coordinada

Los criterios y materiales para la evaluación son establecidos y facilitados desde el centro escolar del menor, realizando la evaluación el docente que se desplaza al domicilio del niño. Una vez realizada ésta, es remitida nuevamente al centro escolar. Finalizada la atención domiciliaria, se elabora una memoria de la misma que es remitida tanto al colegio como a la Administración Educativa.

La coordinación con el centro escolar de referencia del niño es clave para una buena intervención educativa. Tras la primera reunión de coordinación con el tutor del alumno, se contacta periódicamente con este (cada 15 o 20 días). Al concluir la atención domiciliaria, por incorporación del menor a su centro educativo, se emite un informe final en el que se recoge todo el trabajo realizado y la valoración de los objetivos conseguidos.

13.5. CONSIDERACIONES FINALES

Entre los muchos esfuerzos que desde las administraciones educativas y sanitarias se vienen haciendo para minimizar el impacto de la enfermedad en los menores, hemos destacado la creación de aulas en los hospitales, la provisión de un servicio educativo a domicilio, y la dotación de recursos materiales y personales en ambos niveles de intervención. A ello hay que sumar las donaciones que realizan las obras sociales de algunas cajas de ahorros y asociaciones. Aún así, sería necesario mejorar la provisión de recursos materiales y personales, agilizar el acceso de los docentes a dichos recursos, facilitar las interrelaciones entre las diferentes aulas hospitalarias, así como agilizar la respuesta de los centros de procedencia de los alumnos y la formación específica de los docentes destinados en estos servicios.

Hoy en día, la mayor parte de los centros hospitalarios públicos en España cuentan entre sus instalaciones con aulas hospitalarias cuyo objetivo es atender de manera integral las necesidades de los niños enfermos. Aunque asumimos en la teoría que el proceso de curación y mejora del estado de los menores enfermos está condicionado por aspectos físicos, psicoemocionales y sociales, en la práctica aún nos queda por superar el dualismo galénico de una persona dividida en cuerpo y alma. Las aulas hospitalarias y la atención domiciliaria de los niños convalecientes, representa una perspectiva más global e integradora de todas las facetas que componen a un niño, y a un adolescente enfermo.

13.6. BIBLIOGRAFÍA

- Grau C. *Atención educativa al alumnado con enfermedades crónicas o de larga duración*. Málaga: Aljibe. 2004.
- Leiva E, Somoano O. La Atención Pedagógica en el Hospital Central de Asturias versión electrónica . *Boletín de Pediatría* 1994, 35: 307-315.

- Ley 13/1982 de Integración Social del Minusválido.
- Real Decreto 334/1985 de 6 de marzo de ordenación de la Educación Especial.
- Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo.
- Grau C. La pedagogía Hospitalaria versión electrónica . *Revista Galega Do Ensino*. 2001, 32:169-182.
- Real Decreto 299/1.996, de Ordenación de las Acciones Dirigidas a la Compensación de las Desigualdades en Educación.
- Ley Orgánica 2/2006 de Educación.
- Ortigosa JM, García MJ, Quiles MJ. Aulas hospitalarias: la educación del niño hospitalizado. Orientación, tutoría y psicopedagogía. Experiencias y recursos (curso 2001/2002). C.D. ROM Elda: Cefire. 2002.
- Grau C. Necesidades educativas especiales derivadas de problemas crónicos de salud. *Enciclopedia de Educación Infantil*. Málaga: Aljibe, 2003, Vol. 2:781-804.
- Ortigosa JM, Méndez FX, Riquelme A. Hospitalización Pediátrica: aplicación de los programas de preparación psicológica. *Temas d Estudi*. 2007, 90:48-59.
- Quiles MJ, Ortigosa JM, Méndez, FX, Pedroche S. Cuestionario de preocupaciones sobre cirugía infantil (CPCI). *Psicotema*. 1999, Vol. 3 (11): 601-609.
- Barrueco A, De Manueles J, Martín JM, Ortíz M. La acción educativa en la asistencia al niño hospitalizado. *Revista de Educación Especial*. 1997, 23:39-45.
- González R, Benavides G, Montoya I. Preparación psicológica basada en el juego. En: J. M. Ortigosa Quiles y J. Mendez Carrillo (eds.). *Hospitalización infantil, repercusiones psicológicas. Teoría y práctica*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2000; 95 118.
- Ortíz MC. Pedagogía hospitalaria. *Siglo Cero*. 1994, Vol. 5 (25):41-45.

EL NIÑO EN EL HOSPITAL

Miguel Castells Molina

La hospitalización supone, en la mayoría de casos, una amenaza en el desarrollo emocional de los niños y la familia que puede experimentar un estado de ansiedad e inseguridad importante al ingreso.

Siempre que un niño es hospitalizado, va a experimentar un estrés en mayor o menor grado, ya que se interrumpe su normal desarrollo y funcionamiento familiar, en la escuela, barrio, amigos, etc. Por ello es muy importante que este desarrollo normal prosiga dentro del hospital en la mayor medida posible.

Las Unidades Pediátricas deben de promover y crear un ambiente físico y social acogedor que proporcione apoyo tanto al niño como a la familia.

Hay que tener en cuenta que cuando un niño es hospitalizado, su principal apoyo son sus padres, por ello se les debe de integrar en el plan de cuidados de la Unidad para que tomen parte activa en ellos.

Es fundamental que el personal sanitario identifique el estrés que niño y familia experimenten durante la hospitalización, para marcarse unos objetivos y lograr los fines que deseamos conseguir tanto con el niño como con los padres.

Yo creo que actualmente la calidad de los cuidados que dispensamos han de venir marcados por la atención psicológica, la comprensión, y por el amor que debemos de dar a nuestros pacientes.

Humanizar la asistencia, sentarse para hablar o para jugar con el niño, coger de la mano a los padres y hablarles mirándoles a los ojos con cariño, con comprensión transmitiéndoles seguridad, amor, y calmándoles los temores que puedan tener, es lo que va a hacer que su estancia hospitalaria no se convierta en un episodio estresante.

INGRESO

El proceso de hospitalización comienza antes de que el niño ingrese en el hospital.

Tan pronto como el médico informe a los padres de la conveniencia del ingreso, los padres deben de preparar a su hijo de manera adecuada a su edad.

Hay padres que piensan que es preferible que el niño ignore que le van a ingresar, pero está demostrado que un niño está menos asustado si sabe lo que le va a suceder, pues siempre se imaginan algo peor de lo que luego ocurre.

Por ello cuando el niño tenga menos de tres años hay que decirle que va a ser ingresado con uno o dos días de antelación, pues su capacidad para imaginar acontecimientos es muy limitada.

Si la edad del niño está entre 4 y 6 años es conveniente hacerlo con 5 o 6 día de antelación, pues les gusta ser el centro de atención, les gusta prepararse sus cosas, sus juguetes preferidos, etc.

Si tienen entre 7 a 9 años, se les debe avisar con una o dos semanas de antelación pues les gusta comunicarlo a los amigos, en el colegio, a sus abuelos, etc.

A partir de los 10 años: de 20 a 30 días, pues a esa edad empiezan a tomar responsabilidades en cuanto a sus necesidades de salud.

Cuando el niño ingresa en la unidad pediátrica, hay varios factores que influyen de manera importante en la forma en que cada familia va a responder al proceso de hospitalización. Las más importantes son: la etapa de desarrollo del niño, nivel educativo y socioeconómico de los padres, antecedentes culturales y religiosos, número de niños y la edad y madurez de los padres. Por ello cada niño y familia que ingrese en el hospital es un caso individual, único y ha de ser tratado como tal.

Los niños demuestran su grado de ansiedad pasando en mayor o menor medida por tres fases, tal como describió Robertson: protesta, desesperación y resignación.

Primero protestan enérgicamente porque no quieren que les hagan nada, porque lo separan de sus padres para hacerle alguna prueba, etc., parando de llorar algunos solo cuando están agotados. Otros no hacen más que llorar y mirar alrededor buscando a sus padres. Poco a poco va cesando el llanto y se aíslan sin participar en nada, están como apáticos, siendo esta la segunda fase. Por último, parece que se van acostumbrando, muestran interés por el entorno y demuestran desprendimiento y negación de interés por los padres.

Es muy importante la primera toma de contacto del niño con el hospital, por ello debemos contemplar los siguientes cuidados a la hora de la exploración previa a la hospitalización en la unidad.

- Si el niño tiene entre 1 y 3 años es fácil que se muestre tímido con los extraños y se resista a que lo toquemos o desnudemos. Como a esta edad son muy curiosos, hay que dejarles que se familiaricen con el material de exploración

(fonendoscópio, aparato de tensión, etc.), hay que atraer su atención con algún juguete.

Podemos dejar que se siente en el regazo de los padres o junto a ellos durante todo el examen. Deben ser los padres los que desnuden al niño, procurando que esté desnudo el menor tiempo posible, pues así será menor su ansiedad.

Si el niño está tranquilo, se debe comenzar la exploración con lo que menos vaya a alterarle, tal como la auscultación del pecho, abdomen, dejando para el final lo que más le vaya a molestar.

- Si el niño tiene entre 4 y 6 años de edad debemos de saber que en esta etapa de su vida les gusta complacer cuando están tranquilos, ser el centro de atención y comienzan a tener iniciativas, por ello hay que darles la opción a que elijan dónde sentarse durante la exploración (en las rodillas de los padres o en la camilla de exploración), etc.

Debemos utilizar juguetes, juegos y explicaciones graciosas para hacer divertido el examen, tales como “el estetoscópio sirve para escuchar cómo funcionan las cosas en tu interior”. A la hora de examinar los oídos, se le puede decir que es para ver si hay dentro algún hipopótamo escondido, y cosas por el estilo. Es importante elogiarle y adularle y decirle lo que puede hacer para ayudarnos (eso les gusta mucho), por ejemplo: “súbete la camiseta para oír tu corazón cómo suena”, y se le debe permitir que se desnude por sí solo y conserve su ropa interior, pues eso les da más seguridad.

- Si la edad del niño se encuentra entre los 7 y los 9 años, nos vamos a encontrar con un niño que suele estar interesado por lo que se le está haciendo y por qué. Es capaz de cumplir instrucciones y resolver problemas. Como siempre hay que darle a elegir si prefiere estar sentado o acostado durante la exploración y si quiere que los padres se queden o se vayan durante ella. Hay que explicarles qué se les va a hacer y por qué con palabras que puedan entender. Debemos de procurar que sea un poco como un juego, y si se le va a tomar la tensión, puede ser buena idea que se la tomemos primero al padre o a la madre y así mirar los dos la aguja para ver cómo sube. Animarle a que nos haga preguntas y responderles con sinceridad y con un poco de fantasía.

Proporcionarle una camiseta o bata para que se pueda cubrir cuando lo necesite.

- Si tienen entre 10 y 18 años a esta edad ya toma responsabilidades en cuanto a sus necesidades de salud y se preocupan por su imagen corporal, sus cambios y funciones. Se les debe preguntar en primer lugar si desean que sus padres se queden o no durante la exploración. Hay que explicarles qué se les va a hacer y por qué y contestar cualquier pregunta que nos planteen. Se les debe permitir que se desnuden en privado y que lleven una bata durante la exploración, siendo conveniente hablarles durante ella y tranquilizarles de vez en cuando diciéndoles que todo nos parece normal.

Se debe de llevar una secuencia de valoración de cabeza a pies, descubriendo los genitales en último lugar.

CONOCER A TU PACIENTE

Se les debe explicar a los padres que deseamos conocer todo lo posible sobre el niño, para comprenderle, orientarle y hacer que se sienta lo mejor posible en el hospital.

Debemos recabar información sobre los siguientes aspectos:

Historia hospitalaria

Si el niño ha estado hospitalizado con anterioridad, ¿dónde y por qué? ¿Cómo fue la experiencia?

Vida familiar

¿Cómo le llaman en casa? Y llamarle igual en el hospital. ¿Con quién tiene más relación, confianza? Si ha habido algún episodio familiar importante, ¿cómo se ha adaptado a él?

¿Cómo lo consuelan cuando está emocionalmente alterado?

Plan de visitas

¿Quién va a estar con él habitualmente?, ¿se van a quedar las 24 horas?, ¿va a estar solo durante las comidas?, ¿durante la noche?.

Hábitos de eliminación

Debemos saber si emplea alguna palabra especial para decir que quiere defecar u orinar, si lleva pañales o los utiliza solo de noche, etc.

Hábitos alimentarios

¿Come el niño por sí solo o necesita ayuda? ¿Está acostumbrado a tomar algo especial, es alérgico a algún alimento? ¿Qué alimentos prefiere y cuáles detesta?

Asimismo, debemos de recabar información sobre los hábitos de sueño, higiene, juegos, miedos, escuela, religión y disciplina.

También debemos anotar si el niño tiene algún problema de comunicación o si padece algún defecto físico que limite su movilidad.

Y por último, debemos averiguar todo aquello que los padres no quieren que el niño sepa y pídales que le expliquen por qué piensan de ese modo.

Un día, cuando Cristina sale de casa para ir al colegio tropieza en la escalera de su casa y sufre un traumatismo craneoencefálico. Cuando llega al hospital con sus

padres, Cristina está consciente, alerta y asustada, y aunque no ha sufrido fracturas, debe quedar ingresada en observación para someterle a unas pruebas.

En estos casos en los que no ha habido una preparación previa, la niña se va a adaptar mal al estrés del hospital, al igual que sus padres.

Además del dolor, miedo, etc., algunos niños se pueden sentir culpables del accidente y pensar que les ha ocurrido por ser malos, o tal vez piense “ojalá mama no se enfade por esto”.

Este tipo de ingreso es un desafío mayor, para el personal de enfermería, pues a de poner en juego una serie de intervenciones específicas, tanto con los padres como con el niño para ayudarles a adaptarse a la rutina hospitalaria.

Los pasos a seguir deben ser los siguientes:

1. Cuando ingrese en la unidad pediátrica, se le debe presentar al niño y a sus padres al equipo que va a ser el responsable de sus cuidados (médicos, enfermería, celadores, limpieza, etc.).
2. Enseñarles la habitación, sala de juegos, colegio, y presentarle a sus compañeros.
3. Hablar con el niño y sus padres (conjuntamente o por separado) dependiendo de la edad para interesarnos por sus hábitos, experiencias previas, etc., que comentábamos con anterioridad cuando se realiza el ingreso de forma programada.
4. Permitir a los padres estar con sus hijos las 24 horas del día, pues esto va a reducir al mínimo el temor y la tensión del niño causado por la separación, y asimismo reduciremos la ansiedad que se produce en los padres al estar separados de sus hijos.
5. Informar a los padres de las normas de funcionamiento del hospital. Para ello se pueden diseñar unos folletos amenos, simpáticos y breves en los que se expliquen las normas y los horarios de la unidad. En este folleto deben de aparecer el equipo sanitario que va a dispensar los cuidados a su hijo y los sistemas de apoyo con los que cuenta el hospital (psicólogos, maestros, trabajadores sociales, sacerdotes, etc.).

Dependiendo de la patología que haya motivado el ingreso, se les puede facilitar los teléfonos y direcciones de asociaciones y grupos de apoyo.

6. Valorar los conocimientos del niño sobre su enfermedad y tratamiento, preguntándole por qué cree que está en el hospital, y animándole a que nos pregunte lo que quiera. Debemos responderle a sus preguntas con un vocabulario comprensible sin entrar en demasiados detalles. Hay que utilizar sus respuestas para determinar la necesidad de un apoyo emocional especial o una actuación concreta por nuestra parte.

Es muy importante que programamos sesiones de enseñanza con el niño cuando se encuentre dispuesto y alerta, pero también es muy importante programar tiempo para jugar con él, para charlar, contarle un cuento, etc., pues de esta manera el niño no solo nos asociará con cosas que le causan estrés o que le duelen.

7. Se debe fomentar la confianza del niño actuando de forma consecuente y sincera. Decirle que se le avisará antes de hacerle algo que le dolerá y cumplir la promesa.
8. Prepararle para los procedimientos que tengamos que realizarle, incluida la cirugía, explicándole con palabras adecuadas a su edad y a su nivel de desarrollo. Es conveniente utilizar para ello dibujos, juegos, muñecos y todo aquello que sirva para que el niño se haga una representación mental aproximada de lo que queremos decirle.

No debemos ser demasiado concretos, guardando para el final los aspectos menos gratos o dolorosos del tratamiento, pues en el caso contrario se podría poner nervioso y no escuchar el resto de los comentarios. Debemos elegir las palabras con cuidado, pues especialmente en la edad preescolar los niños interpretan literalmente los términos que empleamos según su propia experiencia, frases tales como “antes de operarte te vas a dormir y no te vas a dar cuenta” pueden hacer que el niño tenga miedo a dormirse por si le operan.

9. Darle la sensación de que controla la situación en cierto sentido, dándole a elegir en que brazo quiere que le tomemos la presión arterial, o en que lado quiere que le saquemos sangre, o si necesita algún minuto para prepararse antes de hacerle algún procedimiento.
10. Enseñarle técnicas de relajación respirando juntos, decirle como se hace una visualización de cosas que le gusten, tales como una feria, una tarta y todo aquello que al niño le produzca una sensación agradable. La técnica de relajación de Schultz es recomendable para estos casos, adecuándola al nivel de comprensión del niño.
11. Ante la negativa del niño ante cualquier procedimiento, no debemos reñirle ni recriminarle su actitud, sino mostrarle que lo que le vamos a realizar es por su bien y que va a ayudarlo en su recuperación con frases tales como “ya veras como con esto te vas a encontrar mejor” o también con frases como “de esta manera sabremos por que te duele la barriga”, etc.

Explicarle al niño que nadie le va a reñir por que llore y que siempre va a contar con nuestro apoyo. Debemos de reforzar la conducta y actitudes del niño por su valentía y comportamiento.

EL AMBIENTE DE LA UNIDAD PEDIÁTRICA

Es importante crear un ambiente agradable, infantil y simpático en las Unidades Pediátricas.

Tanto el mobiliario, pintura, uniformidad, y todo aquello que vaya a estar en contacto directo con los niños, debe ser alegres y acorde con el tipo de pacientes que vamos a cuidar. Se puede pintar cada habitación de un color diferente y poner en la

puerta un dibujo de un animalito o de un personaje Disney (por ejemplo), de esta manera el niño identifica su habitación con una mascota, etc.

El aparataje que vamos a utilizar se puede adquirir en colores alegres, y si no se dispone de esta posibilidad se deben de decorar una vez que lleguen a la Unidad, bien pintándolos o poniéndoles pegatinas con motivos infantiles.

La uniformidad del personal sanitario no debe ser el habitual de la institución hospitalaria (color blanco o verde en la mayoría de casos) sino de colores distintos, o incluso prescindiendo de la bata o “pijama” o vistiendo otro tipo de ropa, ya que la mayoría de niños se alteran ante la presencia de una persona con bata blanca.

CARTELERÍA

Los papeles y advertencias que se utilizan para avisar que tal niño debe estar en ayunas o que precisa exploración radiológica, deben tener un diseño infantil donde el niño pueda incluir su nombre personalizándolo.

También es buena idea lo que se hizo en el Hospital General Universitario de Alicante en el momento del alta. Se diseñó un diploma donde había un dibujo infantil que representaba a un niño/a en una cama y a su lado un osito que hacia de médico/enfermero y al lado del dibujo ponía lo siguiente: “Diploma de honor”, y debajo decía: “El personal de Enfermería Certifica que:” y aquí se ponía el nombre del niño; “ha sido merecedor de este diploma de honor por su Valentía, Buen comportamiento y Simpatía durante el tiempo que ha estado ingresado en el hospital”.

SISTEMAS DE APOYO

Las Unidades Pediátricas deben de contar, entre otras cosas, de una escuela hospitalaria donde los niños puedan (siempre que su estado se lo permita) seguir en mayor o menor medida el ritmo escolar que llevaban antes de estar ingresados. Asimismo, se debe utilizar, cuando no se disponga de otro espacio para actividades lúdicas, tales como plástica, preparación de fiestas con motivo de los carnavales (para hacer los disfraces) Navidad, etc. La escuela hospitalaria debe contar con maestros que impartan clase en la escuela y también que se desplacen a las habitaciones de los niños que por su estado no puedan ir al colegio de la unidad y necesiten algún tipo de apoyo.

También se debe contar en la Unidad con una mini biblioteca/ludoteca móvil que pase por las habitaciones de los niños que no se puedan desplazar, y de esta manera se les dé la posibilidad de leer o jugar sin salir de su habitación.

La Unidad debe contar con un espacio dedicado a Guardería o sala de juegos donde los más pequeños puedan entretenerse y al mismo tiempo fomentamos la relación con otros niños y la de los niños con los padres.

LA INTEGRACIÓN DE LOS PADRES EN EL EQUIPO DE CUIDADOS

Cuando un niño es hospitalizado se produce una alteración importante del clima familiar que afecta a todos los miembros de la familia.

Las reacciones de los padres ante este evento van a estar influenciadas por una serie de factores: 1/ la naturaleza o gravedad de la enfermedad; 2/ las experiencias previas con enfermedades y hospitalización; 3/ el nivel de reacción de su cónyuge para hacer frente a la situación; 4/ los sistemas disponibles de apoyo; 5/ antecedentes culturales, religiosos y educativos.

Los sentimientos que van a los padres experimentar en mayor o menor grado son:

Impotencia

Cuando un niño es hospitalizado los padres deben de pasar a personas extrañas la responsabilidad para vigilar fundamentalmente la atención del niño. Pueden experimentar sentimientos de impotencia e inutilidad por la pérdida del papel que desempeñan como padres, con la sensación de que no hay nada que puedan hacer para ayudar a su hijo.

Culpa

Es común que los padres respondan con cierto grado de culpabilidad por las enfermedades de sus hijos. Es como si los padres se recriminaran a sí mismos por haber fallado de alguna manera en proteger a su hijo del dolor y del sufrimiento.

Ansiedad

La hospitalización del niño causa un grado considerable de ansiedad en los padres.

Además, los padres pueden estar a una grave incertidumbre en relación con el pronóstico del niño.

La evaluación de las respuestas de los padres a la hospitalización de su hijo proporciona las bases para la organización de los cuidados de enfermería.

- a) Estimular y reforzar el papel de los padres como parte del equipo dispensador de cuidados.
- b) Proporcionar información precisa y puntual sobre la situación y plan de cuidados del niño.
- c) Notificar y prepararlos con la suficiente antelación cuando vayamos a hacerle cualquier tipo de prueba al niño que le pueda resultar dolorosa o que suponga una separación de sus padres.

- d) Favorecer el contacto físico entre niño y padres, para que pasen de ser solamente observadores coger al niño en sus brazos, acariciarlo, etc.
- e) Animar a los padres a traer a su hijo objetos personales que le recuerden su vida en su casa: juguetes, fotos de sus mascotas, sus revistas o tebeos preferidos, etc.

CONCLUSIONES

Los niños preparados para la hospitalización con anterioridad a su admisión muestran menos ansiedad, tienen una recuperación física más fácil y demuestran menos problemas de ajuste en su conducta después del alta.

Se debe crear un ambiente agradable, confiado y animado para disminuir el grado de ansiedad que el niño va a padecer cuando es hospitalizado.

Hay que integrar desde el principio a los padres en los planes de cuidados de la unidad, haciéndoles ver la importancia que tienen para la pronta recuperación de su hijo y para disminuir al mismo tiempo la sensación de impotencia que pueden sentir los padres ante la enfermedad del niño.

Tenemos que procurar que tanto los niños como los padres se sientan cómodos en un medio hostil como es el ambiente hospitalario

BIBLIOGRAFÍA

- Speer M. *Cuidados de enfermería en pediatría*. Barcelona: Mosby/Doyma, 1993.
est R. *Las enfermedades infantiles*. Barcelona: Acanto 1987.
ong L. *Enfermería pediátrica*. Madrid: Mosby/Doyma, 1995.

ESTILOS DE VIDA ANOREXIA BULIMIA

Gonzalo Pagán Acosta

Adivinamos tras este título una relación causal entre el estilo de vida y estas patologías. Conceptualmente resulta complicado definir estilo de vida, es una expresión de uso frecuente en nuestro lenguaje y con significados bien distintos, que posteriormente repasaremos.

En el lenguaje común, la expresión “estilo de vida” es sinónima de forma de vivir, de hábitos de vida e implica una serie de comportamientos y actitudes vitales. Entendemos por estilos de vida una serie de comportamientos más o menos organizados, más o menos complejos y coherentes, estables y duraderos y muy impregnados del entorno en el que viven los niños y adolescentes o adultos.

R. Burton, en su *Tratado de la Melancolía* de 1621, hace referencia al estilo de vida como algo intrínseco al individuo, que forma parte de su ser. Este autor en especial lo relaciona con el ser depresivo.

En el siglo XVIII, Leclerc de Buffon generaliza el término considerando que es aplicable a todo el género humano; este autor forma parte de la corriente lamarckiana acerca de la evolución humana.

Max Weber, a finales del siglo XIX, asocia un aspecto cultural al concepto, considerando el estilo de vida como característico de un determinado pueblo o sociedad.

La difusión del concepto estilo de vida en la psicología viene de la mano de Adler y su Psicología Individual. Este autor aúna los tres aspectos anteriores, dotando al estilo de vida de una triple vertiente; una individual, a la manera de Burton, lo considera algo genérico, en cuanto es común a todos los individuos tener un determinado estilo de vida, y por fin habla del estilo social de vida en cierta referencia a la culturalidad de Weber. Para Adler se convierte en una estructura integradora del conocimiento y comportamiento individual, es decir, el estilo de vida regula toda nuestra existencia dotándola de un sentido y convirtiendo al individuo en algo unitario. El estilo de vida es la adaptación activa de un individuo al medio social; el niño que crece selecciona

sus experiencias, interacciones familiares y observaciones de sus relaciones sociales con los demás, estas experiencias primarias constituyen la base para formar un esquema de percepciones relativamente estable que se ajusta a un modelo sólido y coherente.

La psicología conductista creará el concepto de “hábito” como la tendencia individual a actuar de manera automatizada y que se adquiere por medio de la experiencia. Los dos términos son intercambiables en el lenguaje común pero tienen acepciones distintas. El hábito de vida tiene un carácter empírico, basado en el aprendizaje, hace referencia al carácter no inconsciente o automatizado y se dirige a los aspectos más superficiales de la conducta humana; mientras que el estilo de vida no se genera por medio del aprendizaje, es inconsciente (en el sentido adleriano del término), ofrece una visión más global del individuo y se incluye en el ámbito de la personalidad.

Tanto el estilo de vida como los hábitos vitales permiten una mejor adaptación del hombre y en esto radica su importancia ya que intervendrán de una manera directa o indirecta en los distintos modos individuales de enfermar.

En la actualidad estos dos términos, hábitos de comportamiento y estilo de vida, son intercambiables, prácticamente sinónimos independientemente de las matizaciones que podamos encontrar.

La implicación de factores socioculturales en la génesis de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) pone de relieve la importancia de nuestro estilo de vida como responsable del aumento de casos de estas enfermedades. Vamos a repasarlo a continuación.

La Psicología de la Salud nos ofrece modelos para entender por qué la gente en general y niños y adolescentes en particular muestran comportamientos y formas de vivir capaces de generar patología en ellos. ¿De dónde surgen estos comportamientos? ¿Es la sociedad generadora de estos? Intentaremos objetivar esta relación con los trastornos de la conducta alimentaria, centrándonos en los cambios sociales que pueden estar detrás del aumento de incidencia de estos trastornos.

Independientemente del aumento real de la incidencia de estas enfermedades en nuestro tiempo, hemos asistido a una “familiarización” de los trastornos alimentarios hasta tal punto que es extraño no contemplar un debate o escuchar un testimonio en televisión, leer un artículo en prensa, oír un programa de radio sobre este tema, o incluso observar cómo una presentadora de televisión se somete de forma voluntaria a 21 días de ayuno y desgrana las emociones, pensamientos y obsesiones que la desnutrición le causa. La mayor parte de esta información que recibimos va encaminada a concienciar a la sociedad sobre un problema que verdaderamente asusta: el miedo a que nuestros hijos “caigan” en estas enfermedades hace que esta información raye en ocasiones el alarmismo. Hablamos entonces de epidemia, plaga y otros términos que hacen referencia a un supuesto incremento en estas enfermedades.

Esta familiarización ha tenido un doble efecto, por un lado ha sembrado la alarma, por otro ha “vulgarizado” la patología y ya se oyen comentarios del tipo: “ya podría volverme anoréxica tres meses” y ha “difundido” una serie de conductas alteradas en torno a la alimentación.

La enfermedad “acecha” y nuestra sociedad se dedica a buscar un culpable, se habla de los medios de comunicación, el mundo de la moda, las tallas de ropa, las top-model, el culto al cuerpo, etc. Dejamos intuir pues, un estilo de vida como responsable en última instancia de que niños y adolescentes enfermen con respecto a algo tan instintivo como la alimentación.

¿Qué hay de real en todo esto?

Los TCA son patologías de la conducta alimentaria. Clásicamente se han descrito dos enfermedades a las que hace referencia el título del capítulo. Pero en las últimas décadas han aparecido una serie de descripciones clínicas (al amparo de la popularidad y la difusión mediática de estas patologías) de supuestas nuevas enfermedades, el trastorno por atracón, la vigorexia, ortorexia, el síndrome del comedor nocturno, el síndrome del corredor compulsivo, la manorexia o la ebriorexia entre otros. Algunas de ellas no pasan de ser meras descripciones de subtipos de las patologías ya conocidas, pero otras sí describen casos nuevos de patologías hasta ahora no contempladas por el grueso de personal sanitario y que incluso se podrían clasificar junto a la anorexia y la bulimia bajo un epígrafe más amplio como el de...

TRASTORNOS DE LA IMAGEN CORPORAL

Tabla 1. Trastornos de la conducta alimentaria.

Clasificación DSM – IV – TR

(Asociación Psiquiátrica Americana)

1. Anorexia nerviosa
 - Subtipo restrictivo
 - Subtipo compulsivo-purgativo
2. Bulimia nerviosa
 - Subtipo purgativo
 - Subtipo no purgativo
3. TCA no especificado

Clasificación CIE – 10

(Organización Mundial de la Salud)

1. Anorexia nerviosa
2. Anorexia nerviosa atípica
3. Bulimia nerviosa
4. Hiperfagia en otras alteraciones psicológicas
5. Vómitos en otras alteraciones psicológicas
6. Otros TCA
7. TCA sin especificación

La anorexia nerviosa se caracteriza por el rechazo a mantener un peso corporal dentro de valores considerados normales para edad y talla. La pérdida de peso o mejor dicho, el bajo peso, es mantenido por los pacientes de manera deliberada por medio de la restricción dietética y/o el uso de conductas compensatorias ante la ingesta como el ejercicio intenso o la presencia de conductas purgativas (vómitos, laxantes, diuréticos, etc.); la dificultad para percibir su estado físico o la distorsión de la imagen corporal que se asocia lleva a la paciente a un estado de desnutrición y caquexia. Esta desnutrición tiene como consecuencia una serie de síntomas físicos y psíquicos que acentúan el miedo a la ganancia de peso y por tanto tienden a perpetuar la enfermedad.

Ta la Criterios diagnósticos DSM – IV– TR para anorexia nerviosa.

1. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerando la edad y la talla (por ejemplo: pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85% del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el periodo de crecimiento, dando como resultado un peso corporal inferior al 85% del peso esperable).
2. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal.
3. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal.
4. En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea; por ejemplo, ausencia de al menos tres ciclos menstruales consecutivos.

Especificar:

Tipo restrictivo: durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a atracones o purgas.

Tipo compulsivo-purgativo: durante el episodio de anorexia, el individuo recurre regularmente a atracones o purgas (por ejemplo: provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas)

Modificado de DSM – IV – TR.

La bulimia fue descrita por Russell en 1979 como una variante de la anorexia nerviosa, posteriormente se consideró un síndrome distinto.

Ta la Criterios diagnósticos DSM – IV – TR para bulimia nerviosa.

1. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por:
 - a) Ingesta de alimento en un corto periodo de tiempo (por ejemplo: de 2 horas) en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias.
 - b) Sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimento (por ejemplo: sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está ingiriendo).
2. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar peso, como son la provocación del vómito; uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos; ayuno y ejercicio excesivo.
3. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como promedio, al menos dos veces por semana durante un periodo de tres meses.
4. La autoevaluación está extremadamente influenciada por el peso y la silueta corporales.
5. La alteración no tiene lugar en el contexto de una anorexia nerviosa.

Especificar:

Tipo purgativo: durante el episodio de bulimia, el individuo se provoca el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso.

Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia el individuo emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre a conductas de purga.

Modificado de DSM – IV- TR

Consiste en descontrol de la conducta alimentaria con presencia de atracones (ingestas de grandes cantidades de alimentos de forma compulsiva durante un corto periodo de tiempo) seguidos de conductas que tienden a compensar el previsible aumento de peso del atracón, estas conductas serían la realización de dietas restrictivas o ayuno y el ejercicio intenso (bulimia nerviosa no purgativa) o la presencia de conductas purgativas: vómitos, laxantes, diuréticos (bulimia nervios purgativa). La preocupación por la obesidad o la ganancia de peso es común a esta enfermedad, así como la preocupación excesiva por la imagen corporal.

La categoría trastorno de la conducta alimentaria no especificada (TANE) se refiere a los trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen los criterios para ningún trastorno de la conducta alimentaria específica. Algunos ejemplos son:

1. En mujeres se cumplen todos los criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa, pero las menstruaciones son regulares.

2. Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa excepto que, a pesar de existir una pérdida de peso significativa, el peso del individuo se encuentra dentro de los límites de la normalidad.
3. Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa, con la excepción de que los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas aparecen menos de dos veces por semana o durante menos de tres meses.
4. Empleo regular de conductas compensatorias inapropiadas después de ingerir pequeñas cantidades de comida por parte de un individuo de peso normal (por ejemplo: provocación del vómito después de haber comido dos galletas).
5. Masticar y expulsar, pero no tragar, cantidades importantes de comida.
6. Trastorno por atracón: se caracteriza por atracones recurrentes en ausencia de la conducta compensatoria inapropiada típica de la bulimia nerviosa.

Spitzer y colaboradores, en 1992, estudiando pacientes obesos en clínicas de adelgazamiento observaron que hasta un tercio de los estudiados presentaban ataques bulímicos (atracones) pero no recurrían a las conductas compensatorias propias de la bulimia. En el Apéndice B (Criterios y ejes propuestos para estudios posteriores) del DSM-IV-TR se especificaron una serie de criterios diagnósticos para el trastorno por atracón basados en las descripciones de Spitzer. El trastorno por atracón es el único de los TCA que presenta una incidencia similar entre hombres y mujeres, y tras la mejora de los criterios para diagnosticarlo se ha observado un importante aumento en la prevalencia de dicho trastorno.

El síndrome del comedor nocturno se trata de aquellas personas que tienen una necesidad compulsiva de comer, unas horas luego de la cena. Fue descrito por Stunkard en 1995 tras observar en pacientes obesos una inapetencia diurna que por la noche les convertía en comedores repetitivos e insomnes. El síndrome afecta entre un 1 y el 3% de la población.

La vigorexia es un trastorno mental no estrictamente alimentario, pero que sí comparte la patología de la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal. Los signos más frecuentes son: mirarse constantemente en el espejo y aún así sentirse enclenques, invertir todas las horas posibles en hacer deportes para aumentar la musculatura, pesarse varias veces al día y hacer comparaciones con otras personas que hacen fisicoculturismo. La enfermedad deriva en un cuadro obsesivo compulsivo que hace que el vigoréxico se sienta fracasado, abandone sus actividades y se encierre en un gimnasio día y noche. También siguen dietas bajas en grasas y ricas en hidratos de carbono y proteínas para aumentar la masa muscular, por lo que corren mayor riesgo de abusar de sustancias como hormonas y anabolizantes esteroides.

La alimentación está cambiando en la actualidad. Se han introducido los productos genéticamente modificados, los transgénicos, los biológicamente puros o ecológicos. La oferta es más amplia. Sin embargo, el exceso de información que no siempre es del todo veraz o contrastada, provoca que muchos individuos opten por un tipo de alimentación que puede ser más perjudicial que beneficiosa. La ortorexia ha nacido en este entorno. Se trata de un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en

la obsesión por la comida sana y obliga a seguir una dieta que excluye la carne, las grasas, los alimentos cultivados con pesticidas o herbicidas y las sustancias artificiales que pueden dañar el organismo. Los pacientes suelen ser tan estrictos que incluso se sienten culpables cuando lo incumplen y se castigan con dietas y ayunos aún más rígidos. Puede acarrear carencias nutricionales. El ortoréxico no sustituye los alimentos que rechaza por otros que puedan aportarle los mismos complementos nutricionales. Esto se traduce en anemia, carencias vitamínicas o de oligoelementos o falta de energía. Suele manifestarse en personas con comportamientos obsesivo-compulsivo y predisuestas genéticamente a ello. Se ha observado también que muchos pacientes que han sufrido anorexia nerviosa, al recuperarse optan por introducir en su dieta solo alimentos de origen natural, probiótico, cultivados ecológicamente, sin grasa o sin sustancias artificiales que puedan causarles algún daño.

La otra alteración en alza relacionada con la imagen es el síndrome del corredor compulsivo, una enfermedad que se ceba en personas que ya han pasado la treintena y que, ante un exceso en su dieta (por una comida de negocios, una celebración familiar...) o una situación de estrés que no pueden controlar, se autocastigan y descargan sus miedos corriendo hasta caer en la extenuación. Para muchos autores sería un subtipo de pacientes anoréxicos varones (manoréxicos).

Otro síndrome o descripción clínica de reciente repercusión social es la diabulimia, la cual es una combinación peligrosa y explosiva. En ella coinciden la diabetes y los trastornos alimentarios. Afecta sobre todo a las mujeres que sufren diabetes y que deben tener un especial cuidado en su alimentación.

La *ebriorexia* o *drum orexia* es un desorden caracterizado por una conjugación de diferentes conductas, no comer sometiéndose a una abstinencia alimenticia voluntaria, realizar un atracón y posteriormente provocar el vómito y como tónica dominante en ambas conductas, abusar de las bebidas alcohólicas, *en una combinación de anorexia, bulimia y alcohol*. Los denominados “ebrioréxicos” no quieren comer para poder compensar las calorías que el alcohol aporta, se podría decir que el término describe a las personas alcohólicas, anoréxicas o bulímicas. Son mayoritariamente mujeres y el alcohol básicamente es la única fuente de calorías con la que se sustentan, aunque existen casos de mayor gravedad en los que el alcohol es sustituido por drogas como las metanfetaminas, con la única finalidad de inhibir el hambre.

La anorexia y la bulimia tienen muchos puntos en común aunque en la actualidad se consideran patologías distintas. Las diferencias son notables sobre todo al inicio del cuadro, con la evolución los síntomas pueden aproximarse y diluirse; por este motivo se teoriza sobre la existencia de un *continuum* en los trastornos e la conducta alimentaria, este se extendería desde la anorexia restrictiva hasta la obesidad. Desde una situación de desnutrición por restricción alimentaria pura se podría evolucionar hacia una anorexia purgativa, donde aparecerían episodios de descontrol alimentario con presencia de conductas purgativas compensatorias. Desde aquí se pasaría a la bulimia purgativa, el peso se normaliza ya que la presencia de atracones se generaliza. Las conductas compensatorias pueden cambiar y se llegaría a la bulimia no purgativa, en esta el sobrepeso puede ser la norma. Se llegaría a la obesidad con ataques de bulimia

(trastorno por atracón), y por fin, el último eslabón del *continuum* sería la obesidad sin ataques de bulimia.

La obesidad se considera la forma más frecuente de malnutrición en los países civilizados, pero no se incluye dentro de las clasificaciones psiquiátricas actuales.

¿Ha aumentado la incidencia (nº de casos nuevos por cada 100.000 habitantes) de los TCA desde la década de 1950?

Hilde Bruch no tiene dudas y considera que estamos hablando de una epidemia, solo que no hay agente contagioso y la propagación se debería a factores socioculturales. Esto es una exageración ya que el incremento de la anorexia nerviosa por ejemplo no puede considerarse como “epidémico”. La conclusión a la que llegan la mayoría de los autores es que en los países anglosajones ha habido un aumento de la incidencia de la anorexia nerviosa hasta la década de los ochenta (se podría hablar de un pico de incidencia) con una posterior estabilización. Este pico de incidencia se retrasó a la década de los 90 en países como España, en los que el aumento progresivo de casos empezó más tarde (años 70) presentando en la actualidad una estabilización de la incidencia de la anorexia nerviosa.

Además, la incidencia de la bulimia nerviosa ha aumentado de forma abrupta en los últimos 20 años y este incremento en la actualidad duplica al de la anorexia nerviosa.

Es cierto que ha habido, sobre todo en las últimas tres décadas, un aumento importante en la incidencia (nº de casos nuevos por cada 100.000 habitantes) de las patologías que conocemos como trastornos de la alimentación, pese a esto dentro de las enfermedades psiquiátricas sigue siendo una patología relativamente infrecuente, sobre todo si las comparamos con la depresión, los cuadros ansiosos o las psicosis. En estudios anglosajones se considera que la incidencia de la anorexia antes de la década de los sesenta se encontraba entre el 0,24-0,45 por 100.000 habitantes, y que después de la década de los sesenta se ha situado en torno a 1,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes.

Se puede decir que en estas últimas décadas los trastornos de la alimentación han sufrido cambios que indican una tendencia a aumentar la población a la que pueden afectar. La anorexia, por ejemplo, ha dejado de ser una enfermedad de mujeres de clase alta o media - alta y raza blanca, para abarcar todos los estratos sociales, otras razas (siempre que estén inmersas en una sociedad de cultura occidental) y empezar a afectar a los varones, aunque en menor proporción (9/1). También se ha adelantado la edad de aparición de la anorexia, cada vez es más frecuente que aparezca al inicio de la adolescencia y preadolescencia, a estas edades la proporción de mujeres / hombres también se ha alterado, siendo de 6/4.

En el caso de la bulimia no existen estudios fiables sobre cómo ha evolucionado; es una enfermedad más difícil de controlar puesto que no es tan evidente como la anorexia (estas pacientes mantienen un normopeso o ligero sobrepeso) y sus conductas patológicas pueden permanecer ocultas durante años. Esta dificultad reside también en lo nuevo de la enfermedad y en lo cambiante de los criterios diagnósticos que se utilizan para delimitar la enfermedad, así se pueden obtener cifras de incidencia distintas según que criterios se utilicen. Estos estudios sí han revelado la gran incidencia

de conductas bulímicas entre la población general sin llegar a cumplir criterios diagnósticos de bulimia nerviosa.

La prevalencia (porcentaje de personas afectas sobre el total de población en %) actual de los TCA también ha aumentado y este aumento estaría en relación con el aumento de la incidencia y a la tendencia a la cronicidad que presentan estas patologías, situación que hace que el número total de casos vaya aumentando progresivamente.

Los estudios de prevalencia de los años 70 (Crisp y colaboradores) y replicados consistentemente en la década de los 90 muestran una prevalencia de la anorexia nerviosa en torno a 0,5-1% de los adolescentes (desarrollo de la enfermedad de forma completa), sobrepasando el 1% cuando se consideran los llamados casos parciales (no cumplimiento de todos los criterios diagnósticos). En el caso de la bulimia nerviosa, los estudios muestran prevalencias muy dispares por las dificultades antes mencionadas para los estudios de incidencia.

En un estudio epidemiológico (Pérez Gaspar *et al.*) realizado en población adolescente femenina en España se ha demostrado una prevalencia global de trastornos de la conducta alimentaria del 4,1%, con un 0,3% que corresponde a la anorexia nerviosa, un 0,8% a bulimia nerviosa y un 3,1% a TCA no especificados. La prevalencia del trastorno en grupos de riesgo (estudiantes de ballet, gimnastas, modelos, etc.) es probablemente tres o cuatro veces mayor.

La categoría diagnóstica de TCA no especificados (TANE) se encuentra pues más frecuentemente que la anorexia o la bulimia, y la presencia de problemas con la alimentación que no alcanzan el punto de corte diagnóstico son bastante frecuentes en la comunidad. Maloney (Australia) en 1989 encontró que hasta un 45% de niños y niñas en los primeros años de escuela querían ser más delgados de lo que realmente eran. Cuando las niñas llegan a la adolescencia, las principales preocupaciones de salud se relacionan con conductas alimentarias no saludables y con los TCA. Los estudios en otros países muestran que entre un 30-40% de niñas en los primeros años de secundaria se preocupan acerca de su peso y entre un 40-60% de las niñas en secundaria hacen dieta para perder peso. La presencia de conductas anormales hacia la alimentación tenía una prevalencia del 33%, prácticas dietéticas poco saludables del 57% y distorsión de la imagen corporal en torno al 12% de los adolescentes.

En esta situación que describimos tiene gran importancia que en las últimas décadas haya mejorado la capacidad diagnóstica de estas enfermedades por dos motivos, como ya he indicado, estos cuadros en la actualidad están mejor delimitados clínicamente y el conocimiento de estas patologías entre la población médica también ha mejorado, por lo que podíamos concluir que se llega con más facilidad y celeridad al diagnóstico.

Los estudios transculturales han establecido que la bulimia nerviosa, al igual que la anorexia nerviosa, se presenta con tanto mayor frecuencia cuanto mayor es el grado de culturización occidental y también representa con mayor frecuencia en los colectivos que están sometidos más específicamente a ideales estéticos de delgadez (bailarinas, modelos, atletas, etc.).

No se puede hablar de una sola causa implicada en la aparición de un trastorno de la conducta alimentaria; se define la enfermedad como de origen multifactorial, y son múltiples los factores que pueden intervenir. Todos los modelos etiopatogénicos (Ploog y Pircke, Lucas, etc.), en general, reducen estos factores a tres grandes bloques: los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales; la interacción de estos factores hace que una persona llegue a hacer dieta y se desencadenen los círculos patológicos que se establecen, cerrando el ciclo y perpetuando la necesidad de dieta, las conductas patológicas que se establecen en torno a ella y los problemas psicológicos y alteraciones mentales que se producen.

Garner y Garfinkel establecen un modelo que introduce una visión longitudinal de los trastornos, con la diferenciación de tres grandes grupos de factores implicados. Los factores predisponentes que recogerían los de índole biológica, psicológico-familiar y los sociales; los factores precipitantes, que incluirían experiencias vitales imprescindibles para el desencadenamiento de estas enfermedades; y los factores mantenedores, generados dentro de la patología y que se encargarían de mantenerla y cronificarla.

FACTORES PREDISPONENTES

Serían los factores que seleccionarían un determinado grupo de personas del total de la población y los harían “sensibles” a padecer estas enfermedades

1. *Individuales* harían sobre todo referencia a rasgos individuales como personalidad o alteraciones fisiológicas.
 - Estilo de pensamiento concreto con razonamiento dicotómico.
 - Estructura caracterial.
 - Edad.
 - Posible vulnerabilidad neuroendocrina
2. *Familiares* en dos sentidos en cuanto a las relaciones intrafamiliares como a una predisposición genética.
 - Estructura y dinámica familiar: sobreprotección, alto nivel de aspiraciones, rigidez, eternización de los conflictos, tendencia a involucrar al niño en los conflictos parentales, no reconocimiento de los límites individuales⇒ no desarrollan un sentimiento de autonomía (Palazzoli y Minuchin).
 - Predisposición genética. Estudios en gemelos, asociación de la anorexia nerviosa con otras enfermedades determinadas genéticamente, mayor probabilidad de padecer la enfermedad si existe algún familiar afecto.
3. *Socioculturales* harían referencia a la presión social y otros factores, a los que más tarde nos referiremos y que constituye la influencia del estilo de vida actual en la génesis de los trastornos de la conducta alimentaria. Estos factores

son los responsables, fundamentalmente, del aumento de la incidencia de estos trastornos en la actualidad.

- Sobrevaloración de la delgadez y modelo estético.
- Aplastante presión publicitaria.
- Cambio del rol femenino en la sociedad.

FACTORES PRECIPITANTES

Hacen referencia a acontecimientos vitales que pueden desencadenar en un momento dado el trastorno y actuarían sobre la población ya seleccionada por los factores predisponentes.

- Cambios corporales adolescentes.
- Separaciones y pérdidas.
- Rupturas conyugales de los padres.
- Contactos sexuales displacenteros.
- Incremento rápido de peso.
- Críticas sobre el cuerpo.
- Enfermedad adelgazante.
- Traumatismo desfigurador.
- Incremento de la actividad física, etc.

FACTORES ANTENEDORES O PERPETUANTES

Factores que perpetúan el mantenimiento de la enfermedad. Son fruto generalmente de la propia enfermedad.

1. Efectos psicobiológicos de la inanición (Keys). Sintomatología obsesivo-compulsiva sobre la comida, irritabilidad, labilidad emocional, pérdida de la capacidad de concentración, agravamiento de la distorsión de la imagen corporal, etc.
2. Interacción familiar.
3. Aislamiento social.
4. Cogniciones anoréxicas.
5. Yatrogenia.

Para Cabranes y colaboradores aceptaríamos como factores de riesgo generales para padecer un TCA: el sexo femenino, la edad (adolescencia y preadolescencia), antecedentes familiares y personales de obesidad, hábitos alimentarios personales y familiares, práctica de determinados deportes o actividades (ballet, gimnasia), acontecimientos vitales estresantes en los últimos dos años, conflictividad familiar, conflictividad en la integración escolar o en las relaciones interpersonales, mala información nutricional, baja autoestima y asertividad y los factores socioculturales descritos anteriormente.

Se considerarían factores de riesgo específicos para TCA de inicio precoz la insatisfacción corporal y actitudes alimentarias patológicas de la madre, la presencia de TCA en madres y la precocidad en el desarrollo puberal.

15.5. ESTILO DE VIDA ACTUAL Y TCA

Los TCA no son enfermedades de reciente aparición. Morton en 1689 describe la enfermedad llamándola “consunción nerviosa”, pero incluso con antelación se encuentran casos en la literatura médica: Catherina Benincasa, Sta. Catalina de Siena (finales del siglo xiv) es uno de los primeros casos que se pueden encontrar. Durante toda la Edad Media se recogen casos de muchachas que se dejaban morir de hambre y que en muchos de ellos legaban a la santidad.

Las descripciones médicas siguen en siglos posteriores hasta llegar al siglo xix; aparecen enfermedades superponibles a lo que entendemos actualmente por anorexia nerviosa. La dispepsia y la clorosis eran enfermedades que afectaban a chicas de clase alta de la época victoriana, chicas que morían de inanición con una repulsión evidente hacia el alimento. En este siglo (1873), Lasègue hace la descripción clásica de la enfermedad llamándola “anorexia histérica” y posteriormente (1874) Gull acuña el nombre con el que la conocemos en la actualidad.

Durante todo el siglo xx se intenta dar una explicación a la enfermedad y todas las corrientes de la medicina lo hacen. Existe una visión neurológica, endocrinológica, psicoanalítica, etc. Es a partir de la década de los años 60 cuando empiezan a aumentar los casos de anorexia.

La bulimia, como ya he dicho antes, es descrita por primera vez por Russell en 1979, pero existían con anterioridad descripciones similares. Nos podemos remontar a Galeno y su descripción de la *ynos orexia* (hambre canina), estado de ánimo especial que provoca un deseo exagerado de comer y que se suele asociar a vómitos. Desde que es descrita la enfermedad y se unifican los criterios diagnósticos la progresión de nuevos casos diagnosticados es espectacular, superando con creces los casos de anorexia nerviosa.

Existen una serie de factores relacionados con nuestro estilo de vida, que explicarían este aumento de casos. Se podrían agrupar en cuatro bloques:

1. Los comportamientos y actitudes con relación al cuerpo y al peso en la sociedad occidental.
 2. El modelo estético en la sociedad actual y la satanización de la obesidad. La presión social sobre la mujer y su cambio de rol.
 3. El negocio del cuerpo: el mercado del adelgazamiento, el ejercicio físico, la publicidad y los medios de comunicación.
-
1. Los comportamientos y actitudes con relación al cuerpo y al peso en la sociedad occidental.

Sanders en 1994 enumeró una serie de mitos con relación al cuerpo y al peso:

- Cualquier grasa en la comida es mala.
- La redondez no es saludable.
- La delgadez es saludable.
- La gordura o la grasa puede perderse rápidamente y sin peligro.
- Existe una grasa especial en la mujer que se llama celulitis.
- La grasa de la celulitis está causada por toxinas.
- Se puede reducir la gordura de una parte concreta del cuerpo, en especial caderas y muslos.
- Ciertos alimentos o ciertas combinaciones de alimentos pueden activar el metabolismo y acelerar la pérdida de peso.
- Las mujeres de edad inferior a 50 años corren un riesgo real de enfermedad cardíaca.
- Hacer dieta es una actividad saludable.

La preocupación por el cuerpo en nuestra sociedad es prácticamente general y abarca tanto a hombres como a mujeres. Estudios realizados demuestran que la preocupación por el aspecto físico abarca a porcentajes muy altos de la población general. Se llega a considerar ya como algo intrínsecamente femenino esta preocupación y como parte de la experiencia femenina.

Esta preocupación se transforma en insatisfacción en porcentajes cada vez más altos. En la década de los ochenta esta insatisfacción corporal afectaba a un tercio de la población. Cinturas, caderas, nalgas, muslos y abdomen eran la preocupación de las mujeres. El tórax y el abdomen centraban la preocupación de los hombres.

En las mujeres se focaliza esa insatisfacción sobre todo en la mitad inferior de su cuerpo; se anhela un modelo corporal ginecoide en la mitad superior y androide en la mitad inferior.

En nuestra sociedad ha surgido un remedio ante esa insatisfacción, la realización de dietas es la solución. Otros estudios han demostrado que la proporción de personas

que hacían dieta con un peso normal llegaba a superar, en EE UU a los obesos que realizaban dietas.

Estas preocupaciones y actitudes afectan igualmente a nuestros adolescentes. La adolescencia es una etapa donde la imagen corporal adquiere una importancia determinante, existe una intensa orientación hacia la apariencia física, especialmente entre las muchachas como focalizador de sentimientos disfóricos. Los cambios adolescentes, en todos los órdenes de la existencia, suelen hacer a los adolescentes inmersos en nuestra sociedad intensamente autoconscientes y disfóricos con relación a su imagen corporal. A esta edad ya muchos han realizado dietas; en la década de los 60, en EE UU un 70% de las adolescentes ya habían realizado dietas.

Estudios de esta década demuestran que un 26% de los niños entre 5 y 7 años preferirían estar más delgados. A los 9 años un tercio se considera obeso y otro tercio se alimenta de forma consciente por debajo de sus necesidades.

Los cambios afectan también a las conductas en torno a la alimentación.

En la familia tradicional, se realizan tres tomas mínimo a lo largo del día. Estas tomas se realizaban con todos los miembros de la familia juntos, se inculcaba una forma de alimentarse y la familia servía como modelo y como “control” del tipo de alimentación que realizaban sus hijos.

En la sociedad actual las comidas se realizan por separado y en medios ajenos al hogar; por motivos fundamentalmente laborales, los miembros de la familia suelen comer en distintos sitios, los padres cerca del trabajo y los hijos en los colegios o institutos. Esto ha hecho que la influencia social en el momento de la comida cambie, ya no son los padres los que sirven de modelo sino otros compañeros o adolescentes; ya no se realiza ese control sobre la calidad y cantidad de lo que se come.

Han surgido y se han generalizado los restaurantes de comida rápida como respuesta a estos cambios. A la vez, se ha modificado la estructura de la dieta pasando de una comida con dos platos y postre a lo que se ofrece en estos restaurantes. Se ha cambiado incluso la forma en que se come: no se utilizan cubiertos en la mayoría de los casos e incluso ya no es necesario sentarse para comer. La oferta es permanente (24 horas) y por tanto ya no hay que seguir un horario, comer a mediodía, etc.

Por otro lado, se impone la dieta como solución a la insatisfacción creciente hacia el cuerpo pero se potencia en el ámbito social el número de ocasiones con reuniones gastronómicas; ya no solo se celebran de esta forma las celebraciones familiares, sino que reuniones de amigos, negocios, etc. Pasan por reuniones con comida. Esto sitúa en un dilema: o se renuncia a la vida social o se instaura la restricción alimentaria como algo permanente en nuestras vidas.

El anhelo de adelgazar o mantenerse delgado se ha convertido en un valor central de nuestra cultura y su interiorización en todos nosotros es indiscutible.

Para todos nosotros la delgadez corporal se asocia de algún modo a belleza, elegancia, prestigio, higiene, juventud, alta autoestima, aceptación social, forma física, virtud y búsqueda de perfección.

La delgadez corporal sería “el medio” para conseguir todos los valores a los que está asociado. Todos los procedimientos que tenemos a nuestro alcance para adelgazar son reforzados por sus resultados, llegando a conseguir connotaciones gratificantes. Los modelos sociales, el grupo de su edad, el bombardeo publicitario, los halagos de quienes “te aprecian” y las propias cogniciones aprobatorias van reforzando el ayuno y la abstinencia.

La autodisciplina, el autocontrol los sacrificios, son permanentes. Durante siglos la autodisciplina, el sacrificio y las mortificaciones trascendían al individuo, los ayunos voluntarios se ponían al servicio de los demás; la madre que ayunaba para que sus hijos comieran, el ayuno franciscano, la huelga de hambre en favor de una causa, el ayuno religioso como purificación o acercamiento a la divinidad. En la actualidad se pone el ayuno al puro y simple servicio de la persona, porque su persona, sus cualidades están totalmente identificadas con su cuerpo, con su apariencia corporal.

Así, se ha pasado de la búsqueda de la perfección moral a la persecución de la perfección corporal. La belleza es algo al alcance de todos, simplemente la búsqueda apasionada de la silueta perfecta (delgada), implica la posibilidad de conseguirla

Si el narcisismo, entendido como la sobrevaloración exhibicionista y el culto de uno mismo ha existido desde siempre, probablemente nunca haya estado asociado tanto a la apariencia corporal. El deseo de delgadez actual ya no supone en la mayoría de los casos el anhelo por destacar y ser valorado, sino simplemente el ser suficientemente aceptado o no ser rechazado. A partir de esta base social mayoritaria, se destaca una pequeña elite “modélica” que sí puede permitirse el lujo de esa gloria narcisista. La sociedad de consumo en la que vivimos nos hace reproducir los usos y costumbres de los que marcan la moda para no dejar de ser aceptados socialmente y por tanto convertimos en insatisfechos. Imitando el estilo de vida de los “triunfadores” o de los que nos venden como tales, intentamos llegar a la felicidad; así llegamos a necesitar unas determinadas marcas o un determinado cuerpo, por supuesto delgado.

En el siglo XIX la vestimenta y la presentación del cuerpo dejan de ser signos de la situación social del individuo para convertirse en manifestaciones de la personalidad individual; esta búsqueda de la individualidad y de la individuación está en la base de todos los adelgazadores, pero se termina en la copia clónica del modelo corporal vigente. Se parte del convencimiento de que el cuerpo es modificable, ya no se contempla el cuerpo como algo inmutable a voluntad. Otras sociedades han manipulado su cuerpo con tatuajes, perforaciones, moldeándolo; pero se trata de modelos heredados, dotados de connotaciones rituales en ceremonias colectivas: la manipulación actual es más reflexiva, no tiene carácter ritual, para el individuo es prueba de su libertad. Cuando se cree posible un deseo, éste se hace más persistente, se incrementan los esfuerzos para satisfacerlo y se mantiene o aumenta la intensidad del mismo.

2. El modelo estético en la sociedad actual y la satanización de la obesidad. La presión social sobre la mujer y su cambio de rol.

La relevancia del cuerpo femenino suele ser superior a la del masculino, en todas las culturas la belleza de la mujer recibe una consideración superior a la del hombre. El atractivo del hombre suele estar en sus habilidades, su fuerza, etc. En lo que con-

cierte a la mujer, su relevancia corporal depende de sus capacidades procreadoras y de sus funciones sociosexuales. El mismo cuerpo destinado a engendrar, parir y alimentar debe contar con un atractivo suficiente para conseguir su integración en el medio en que desenvuelve su vida. Esta situación especial tiene un claro reflejo en el autoconcepto femenino, por este motivo este autoconcepto suele basarse más en el atractivo físico que en el caso del hombre.

La evolución de la estética corporal se ha relacionado con la evolución del vestido. Nos centraremos sobre todo en la evolución sufrida en los dos últimos siglos.

La moda en cada época y en cada sociedad responde al consenso establecido acerca de la presentación social de los cuerpos. La manipulación real o ficticia del cuerpo ha sido la norma en la moda. En la historia moderna, cada época ha tendido a destacar una zona anatómica intrínsecamente femenina.

El siglo XIX se inicia con la difusión del “talle de avispa”. Las zonas que más preocupan a la mujer actual permanecían ocultas y exageradas. Se recurre al miriñaque para aumentar esa desproporción entre las caderas y la cintura. A mediados de siglo, las clases altas renuncian al miriñaque y el cuerpo femenino empieza a insinuarse de forma realista por debajo de la cintura. Esta situación dura poco porque se instaura el uso del polisón, este aditamento ahuecaba la falda por detrás y aumentaba el volumen de las nalgas.

Al iniciarse el siglo XX, la moda tomó claro partido por la delgadez. Los años veinte son la clave. El cuerpo femenino se alisa y masculiniza. Se implanta el recurso a dietas como instrumento para modificar el volumen corporal. Durante este periodo la proporción entre pecho y cintura es de 1,1 cuando en décadas anteriores era de 2. En la década de los treinta, los hombros ensanchan y aumentan de volumen. Por primera vez en la moda femenina se destaca una zona del cuerpo que no pertenece a los caracteres sexuales secundarios femeninos. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se produce la homogeneización de los sexos, se reduce la largura de la ropa y se familiariza la desnudez o semidesnudez, y en la década de los cuarenta era imprescindible para triunfar el talle de avispa.

A partir de esta época se vuelve al modelo estético de la década de los veinte (modelo Twiggy) y en esta ocasión existen una serie de diferencias. En nuestros días la moda afecta a todas las clases sociales, las diferencias entre estas son menores y todo el mundo tiene acceso al mercado de la moda, en segundo lugar existen los medios de comunicación que se encargan de propagar estos modelos. Los adolescentes si son ahora partícipes de los valores de los adultos, no ocurría así en los años veinte.

Las características de la época actual serían:

- Culto a la línea recta.
- Manifestación y exhibición del cuerpo.
- Cambios en el papel de la mujer tendiendo a la masculinización psicosocial.
- Desarrollo de la industria de la moda.

- Impregnación y homogeneización sociales a cargo de los medios de comunicación.
- Hedonismo y ubicación del cuerpo como centro de la autoestima y valoración social.
- Cosificación del cuerpo femenino.

El obeso es el gran estigmatizado de nuestra sociedad. Existe un rechazo social más o menos evidente hacia aquellas personas que se apartan de la estética corporal vigente. La asimilación de que las personas delgadas comparten una serie de cualidades positivas y que las cualidades contrarias son comunes entre los obesos.

Esta presión social se ha asimilado ya a los seis años. Estudios demuestran que a esta edad los niños atribuyen cualidades positivas como “bueno”, “muchos amigos”, “ser feliz”, “educado”, etc., con figuras delgadas y cualidades negativas como “peleas”, “tramposo”, “perezoso”, “sucio” con figuras obesas.

Y esta presión vuelve a ser mayor en la mujer. Las dificultades de mujeres obesas para encontrar trabajo están a la orden del día y sería una necesidad regarlo.

El cambio de rol de la mujer también merece unas palabras.

Las funciones sociales de las mujeres han cambiado gracias a su progresiva incorporación al mundo laboral. El trabajo fuera de casa es una aspiración cada vez mayor entre las mujeres. El hecho de sentirse “realizadas” en este plano cada vez más contribuye a su estabilidad emocional y a un reforzamiento de la autoestima.

Esta situación constituye una fuente de estrés continuo para la mujer. Su incorporación se hace a un mercado laboral extremadamente competitivo y sexista, dominado por el hombre.

La situación real es que la mujer no ha sustituido su papel tradicional por otro más moderno, sino que ha sumado los dos. Debe seguir realizando sus tareas tradicionales, tener hijos, ocuparse de la familia, etc. y además asumir las exigencias del entorno, incorporarse a un mercado laboral y triunfar.

Se crea así la imagen de la supermujer, competitiva, ambiciosa, atractiva, complaciente, no asertiva y, por supuesto, delgada. Este ideal se está convirtiendo en el ideal de mujer entre la mayoría de las adolescentes.

3. El negocio del cuerpo: el mercado del adelgazamiento, el ejercicio físico, la publicidad y los medios de comunicación.

Los cambios socioculturales habidos han creado las condiciones para el negocio sobre el cuerpo:

- El cuerpo es moldeable a nuestro antojo,
- Presión social hacia la delgadez.
- Todo se puede conseguir si se quiere.

La proliferación en las últimas décadas de todo tipo de aparatos milagrosos y gimnasios por doquier, medicinas naturales que “quemar” la grasa y reducen el volumen, dietas de todo tipo basadas en combinaciones mágicas de alimentos, cremas y ungüentos que deshacen la grasa, el mercado de la cirugía estética serían algunos aspectos de este mercado.

Los medios de comunicación han contribuido de dos formas distintas:

En primer lugar, han contribuido como ningún otro factor a la homogeneización de la población y a la difusión de los “valores” de la sociedad actual. En segundo lugar, han adquirido una etiqueta de “veracidad” que en algunos casos supera a la de profesionales de la salud, lo que sale por televisión o en revistas es la “verdad”. Si en la televisión, un anuncio te dice que con una crema puedes perder “x” centímetros de cintura es porque eso es posible y real.

El mundo de la moda también ha contribuido a reforzar la tendencia hacia la delgadez, favoreciendo la aparición de modelos cada vez más desprovistas de caracteres sexuales femeninos, con la utilización de modelos anoréxicas y de adolescentes que todavía no los habían desarrollado

No se puede culpar a las modelos, el mundo de la moda o los medios de comunicación de que sean los culpables de la aparición de estas enfermedades, pero sí que tienen parte de responsabilidad en la difusión de esos factores socioculturales que tienden a modificar los comportamientos haciéndolos anorexígenos.

Creo que sí que se debería ejercer un control más exhaustivo sobre estos campos, exigiendo al menos veracidad y realidad.

LA PREVENCIÓN

Los modelos explicativos del comportamiento tienen una gran importancia en Educación para la Salud; nos ofrecen la posibilidad de comprender por qué determinados hábitos o conductas son frecuentes en la población infanto-juvenil, conductas favorecedoras de salud o de enfermedad, y nos ofrecen la posibilidad de poder modificar estas conductas.

Para poder afrontar el problema que se nos presenta con los trastornos de la conducta alimentaria es imprescindible, además de saber diagnosticar correctamente estas enfermedades y por supuesto tratarlas de forma adecuada, la realización de planes de prevención primaria dirigidos a la población de riesgo.

Las estrategias preventivas tradicionales operan sobre conductas aisladas y sus resultados no siempre eran los adecuados; para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria no basta con prevenir la realización de dietas u otras de las conductas que aparecen de forma aislada, es necesario un acercamiento global, ya que como hemos visto, existen múltiples dimensiones sobre las que actuar si queremos modificar un estilo de vida o hábito de comportamiento.

El impacto de los medios y del grupo de pares en el desarrollo de los sistemas de creencias de los adolescentes parece ser muy resistente a intervenciones terapéuticas individuales o en grupo a corto plazo, de modo que necesitan mensajes a mayor escala acerca de la aceptación de la variedad de tamaños y formas corporales a nivel social. Otros métodos para modificar las actitudes y conductas hacia la alimentación pueden ser objeto de futuros programas de prevención, como por ejemplo, intervenciones sociales más amplias que incluyan adultos como modelos para el desarrollo de conductas saludables y apropiadas (educación de los editores de revistas, televisión y otras campañas de expectativa en los medios de comunicación). Parece ser que un cambio general en la forma de evaluar las personas por su apariencia y sus cualidades físicas para evaluarlas por otras cualidades personales, es una tarea difícil pero llena de recompensas para aquellos que deciden intentara modificar estas actitudes socio-culturales.

Uno de los mayores desafíos en la investigación sobre la prevención de los TCA tiene que ver con la dificultad en elegir qué factores de riesgo deben intentarse cambiar. La búsqueda de una mejor comprensión de los factores de riesgo asociados con estos trastornos continúa guiando los procedimientos de cribaje (*screening*) para identificar niños y adolescentes sospechosos de estar en riesgo de tener TCA y enfocar mejor los programas de prevención. Dado el número relativamente bajo de casos completos en población general, podría ser más productivo y coste-efectivo evaluar el impacto de las intervenciones de prevención en poblaciones de alto riesgo. Alternativamente, hay factores de riesgo generales o inespecíficos que también pueden ser abordados en las actividades de prevención combinadas para otros trastornos psicopatológicos, como la obesidad o los trastornos por abuso y dependencia de tóxicos.

Campbell y colaboradores en 2002, tras una revisión sistemática sobre programas preventivos de la obesidad en población joven, proponen una relación entre la prevención de la obesidad y los trastornos alimentarios. Los terapeutas y educadores son cada vez más conscientes de la necesidad de adoptar un equilibrio entre la realización de intervenciones preventivas y los miedos acerca de los daños potenciales que pueden causar. Realmente existe una falta de evidencia de “daños” causados por estos programas, ya que este temor se basa en un estudio no controlado sobre prevención de los trastornos de la alimentación en niños y adolescentes (Carter 1997), en unos cuantos estudios realizados en mujeres universitarias y en la literatura sobre prevención de suicidio. Casi todos estos estudios están siendo rebatidos con el paso del tiempo, y así el estudio de Carter se ha realizado como ensayo controlado reportando efectos modestos pero positivos sobre la restricción dietética y las actitudes hacia la figura y el peso que a posteriori no se mantuvieron, pero concluyendo que este tipo de intervención no causaba daño.

Otros autores como Fairburn sugieren que los programas preventivos deberían enfocarse en el abordaje de esquemas cognitivos relacionados con la dependencia o aprobación de otros y el perfeccionismo para construir una resistencia ante el desarrollo de estilos de personalidad poco saludables. Posibles focos para futuros programas de prevención serían las habilidades para manejar el estrés y/o para aumentar el conocimiento emocional y la verbalización de sentimientos neutralizando tendencias de afrontamiento que se dirigen hacia la generación de patologías psicosomáticas.

Como resumen, debemos reforzar las cualidades y capacidades de nuestros hijos enseñándoles a no relacionarlas con la apariencia física. Se les debe enseñar a ver de manera crítica los mensajes publicitarios y no relacionar la felicidad con las formas. Comprender que el tamaño y la forma del cuerpo no determinan el valor como persona ni la identidad. Conviene transmitir a los demás que los comentarios positivos o negativos acerca del físico no se aprecian, valorando a las personas que muestran un físico o unos rasgos de personalidad que no cuadran con los estándares culturales

BIBLIOGRAFÍA

- American Psychiatric Association. *DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. Barcelona: Masson. 2002.
- Chinchilla A. *Anorexia y bulimia nerviosas*. Madrid: Ergon. 1994.
- Costa M, López E. *Educación para la salud una estrategia para cambiar los estilos de vida*. Madrid: Pirámides. 1996.
- De la Serna I. Alteraciones de la imagen corporal. *Monografías de Psiquiatría*. 2004. Nº 2. Año XVI. Abril-Junio.
- Fairburn CG. Trastornos del comportamiento alimentario. Bulimia nerviosa. En: Gelder MG, Lopez-Ibor JJ y Andreasen N. (eds.). *Tratado de Psiquiatría*. Tomo II. Madrid: Ars Médica. 2003.
- Fernández F, Turón V. *Trastornos de la alimentación. Guía básica de tratamiento en anorexia nerviosa y bulimia*. Barcelona: Masson. 1998.
- Ibáñez E. *Psicología de la salud y estilos de vida*. Valencia: Promolibro. 1991.
- Toro J. *El cuerpo como delito*. Barcelona: Ariel. 1996.
- Toro J, Vilardell E. *Anorexia nerviosa*. Barcelona: Martínez Roca. 1987.
- Rusell G. Trastornos del comportamiento alimentario. Anorexia nerviosa. En: Gelder MG, Lopez-Ibor JJ, Andreasen (eds.). *Tratado de Psiquiatría*. Tomo II. N. Madrid: Ars Médica. 2003.
- Turón V. *Trastornos de la alimentación. Anorexia nerviosa, bulimia y obesidad*. Barcelona: Masson. 1997.

CÁNCER INFANTIL SITUACIÓN EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Gabriel Álvarez Pérez, Marina Depiaggio

INTRODUCCIÓN

Los progresos obtenidos a lo largo de las cuatro últimas décadas en el tratamiento y curación de las neoplasias en la población pediátrica, constituyen quizá el capítulo más satisfactorio de la Oncología. A pesar de ello, las enfermedades malignas continúan siendo unas de las principales causas de mortalidad entre el primer año de vida y la adolescencia (Tabla 16.1), por detrás de los accidentes, aunque las cifras de decesos han disminuido más del 50 desde 1950, siendo el porcentaje global de curaciones en la actualidad alrededor del 75 (Hammond, 1986; Dorgan, 1995; Gatta *et al.*, 2003).

El cáncer infantil ha dejado de ser irremediamente fatal para convertirse en una enfermedad de alto riesgo, con rasgos de cronicidad y en una enfermedad familiar.

Tabla 16.1. Mortalidad infantil. Causas principales.

Edad	Causa	Tasa
De 1 a 4 años	Accidentes	20
	Malformaciones	5,9
	cáncer	3,8
	Enfermedad cardiovascular	2,1
	Infecciones	1,5
De 5 a 14 años	Accidentes	12,5
	cáncer	3,5
	Malformaciones	1,4
	Enfermedad cardiovascular	0,9
	Suicidio	0,8

Este cambio hacia unos resultados más favorables en casi todos los tipos de neoplasias pediátricas es consecuencia de múltiples factores que analizaremos más adelante.

INCIDENCIA

El cáncer es una enfermedad poco frecuente durante la infancia (García-Miguel, 1998). Su incidencia varía considerablemente según la edad, sexo, raza y localización geográfica.

En nuestro medio, podemos estimar que la incidencia es de 160-170 casos nuevos por millón de habitantes en edad pediátrica (menores de 15 años) (Figura 16.1) (Young *et al.*, 1986). Cada año se diagnostican en España alrededor de 850 casos (Del Moral, 2004). Durante el año 2000, los tumores infantiles fueron responsables de casi 9.000 estancias hospitalarias.

Entre 1998 y 2003, en la Comunidad Valenciana, se han registrado un total de 595 casos de cáncer infantil (un caso por cada 6,227 niños/as residentes). Por grupos de edad, la incidencia más elevada se presenta en el grupo de menos de 1 año, seguido del de 1 a 4 años no observándose diferencias por sexo. Entre los niños el exceso de incidencia se da entre los 5-9 años (M/F 1,21) y entre las niñas en el grupo de 10-14 años (M/F 0,85).

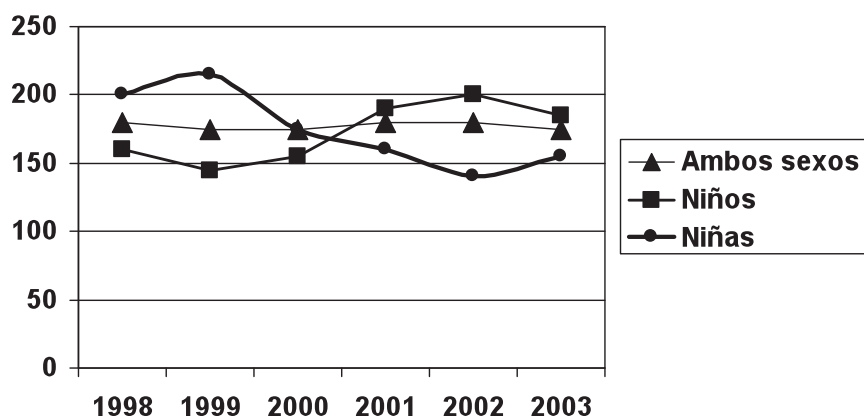


Figura 16.1 Tasa de incidencia estandarizada (ASR $\times 10^6$) de tumores infantiles en la Comunidad Valenciana. Periodo 1998-2003.

Existen diferencias de la incidencia global sobre los diferentes grupos étnicos. Partiendo de una incidencia de 13/100.000 ciudadanos de raza blanca en países occidentales, se han descrito incidencias superiores en Israel (30,6/100.000), o en Nigeria (22,1/100.000), e inferiores como en Japón (10,2/100.000), o en India

(6,8/100.000). En el mundo occidental la incidencia global para la raza negra es de 9,3/100.000 (Young *et al.*, 1975; Sierrasesmaga, 1992).

Los tumores infantiles difieren enormemente de los del adulto, desde los patrones histológicos (el 90 % de los tumores infantiles son de origen no epitelial, en contraposición al cáncer del adulto), el lugar anatómico de asiento (los tumores infantiles son profundos) o en los aspectos epidemiológicos, clínicos, terapéuticos y pronósticos.

Una de las mayores diferencias radica en el hecho de que, en las últimas décadas, en muchos tumores del adulto la epidemiología y la prevención han supuesto una mayor contribución en el control de su evolución que los avances en el tratamiento, mientras que en el caso de los tumores infantiles, la epidemiología y prevención han aportado muy poco a su control, lo que contrasta con las enormes mejoras conseguidas en su manejo clínico (Sierrasesmaga, 1992; Halperin *et al.*, 1999).

En Europa y Estados Unidos la incidencia de tumores infantiles se mantiene estable o aumenta ligeramente (0,8 al 1,5 % anual). Sin embargo, la mortalidad disminuye debido sobre todo al descenso en la mortalidad en el grupo de las leucemias y tumores del sistema nervioso central.

ETIOLOGÍA

El estudio de los tumores pediátricos ha permitido conocer mejor los mecanismos celulares y moleculares envueltos en el desarrollo de las enfermedades malignas (Israel, 1989). En último término, el cáncer puede considerarse una enfermedad genética si se tiene en cuenta que se desarrolla a partir de una alteración del ADN que transforma una célula normal en tumoral (Li *et al.*, 1986). El escaso conocimiento que tenemos sobre la causa de la mayor parte de los tumores infantiles hace difícil identificar claramente estrategias preventivas encaminadas a disminuir su incidencia.

Actualmente se barajan dos tipos de factores en la formación de tumores infantiles: los ambientales y los genéticos.

Factores ambientales

A) Agentes físicos

Radiación ultravioleta. Su relación con el desarrollo de tumores malignos cutáneos está claramente establecida. Este efecto es más marcado en pacientes afectados de *xeroderma pigmentosum* debido a la incapacidad para reparar las lesiones inducidas en el ADN por la irradiación y en el albinismo por presentar carencia de pigmento.

Radiaciones ionizantes. La población expuesta a radiación presenta una incidencia mayor de la esperada de leucemia, de cáncer tiroideo, de cerebro, de hueso y de piel.

Todo ello ha sido posible gracias al estudio de pacientes sometidos a irradiación y a supervivientes de episodios históricos tan desagradables como las bombas atómicas sobre Japón o el accidente de la Central Nuclear de Chernobil (Rusia) (Finch, 1984; Shore *et al.*, 1985; Tuc *er et al.*, 1987).

Asbesto. La exposición durante la infancia a fibras de asbesto induce el desarrollo de tumores pleuropulmonares (mesotelioma) (Mossman *et al.*, 1989).

B) Agentes químicos

Desde que Pott en 1775 describió la relación hollín-cáncer de escroto en los desho-llinadores británicos (niños) de chimeneas se ha avanzado enormemente en el conocimiento de la carcinogénesis química. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha identificado 18 carcinógenos probados y otros como de riesgo elevado (Doll *et al.*, 1989; Rudant *et al.*, 2007) entre ellos destacamos: arsénico, aflatoxinas, cromo, alquilantes, cloruro de vinilo, estrógenos, fenitoinas, gas mostaza, níquel, herbicidas, etc.

Los niños pueden verse expuestos a estos agentes por varios mecanismos:

- a) por vía transplacentaria (ejemplo clásico es el de adenocarcinoma vaginal en niñas de madres tratadas con dietilestilbestrol durante la gestación (Robboy, 1983), el de neuroblastoma en niños de madres epilépticas sometidas a difenilhidantoinas (Sherman *et al.*, 1976) o la mayor incidencia de leucemias y linfomas en niños de madres gestantes fumadoras o expuestos a pesticidas (Sternfeldt M *et al.*, 1986; Rudant *et al.*, 2007)),
- b) por contaminación de alimentos, agua, aire, o
- c) de forma yatrógena (como por ejemplo niños que reciben andrógenos para la anemia aplásica presentan mayor incidencia de tumores hepáticos (Mulvihill *et al.*, 1975) o los tratados con hormona de crecimiento por hipopituitarismo con mayor incidencia de leucemias (Sasa i *et al.*, 1988)).

C) Dieta

Se ha estudiado mayormente en el adulto la relación dieta-cáncer, aunque ya existen trabajos en la esfera pediátrica (Miller *et al.*, 1994) así se constata la menor incidencia de cáncer en niños sometidos a lactancia materna superior a seis meses (Davis *et al.*, 1988), o la mayor incidencia de tumor hepático en niños de países centroafricanos con ingesta excesiva de aflatoxinas (Linsell, 1980).

D) Agentes virales

Es clásica la hipótesis viral en la etiología de las neoplasias. En el ámbito pediátrico, los virus más relacionados en este sentido son los retrovirus con la leucemia (Sierrasesímbaga *et al.*, 1992), el virus de Epstein-Barr con la enfermedad de Hodg in (Gallo *et al.*, 1981) y con el linfoma Bur itt (Morro , 1982), el virus de la hepatitis B con el carcinoma hepatocelular (Chang *et al.*, 1989), y el virus del sarampión con el neuroblastoma (Menegaux *et al.*, 2004).

Factores en ticos

Al parecer son los principales factores de riesgo en contraposición al adulto (García-Miguel, 1998; Wang *et al.*, 2007). En la medida en que la genética del ser humano es mejor comprendida, se conoce un mayor número de factores genéticos relacionados con el desarrollo de tumores malignos en la infancia (Mulvihill, 1975). El descubrimiento reciente de diversos oncogenes ha aportado nuevos campos para el estudio de los procesos tumorales (Israel, 1989).

Dado el patrón de herencia dominante del retinoblastoma y el alto porcentaje de supervivientes, este tumor ha servido de modelo de investigación básico para estudio de la genética tumoral (Halperin *et al.*, 1999).

A) Alteraciones cromosómicas.

Los avances en el estudio de los cromosomas han permitido identificar una serie de alteraciones que claramente comportan un mayor riesgo de cáncer. Así, niños con Síndrome de Down (trisomía 21) presentan un riesgo quince-veinte veces superior de padecer una leucemia aguda (García-Miguel, 1998; Miller, 1970; Johnson *et al.*, 2008) niñas con Síndrome de Turner tienen mayor incidencia de tumores uterinos (McCarthy *et al.*, 1978) ó niños con determinadas deleciones cromosómicas presentan mayor riesgo de desarrollo de retinoblastomas (Halperin *et al.*, 1999; Lele *et al.*, 1963). Otros tumores asociados a alteraciones cromosómicas son: osteosarcoma, sarcoma de Ewing y tumores germinales.

B) Síndromes hereditarios

La descripción de familias con más de un miembro infantil con neoplasia fue uno de los primeros hallazgos que llevaron a pensar en el componente hereditario en la etiología del cáncer. Los niños con poliposis colónica de naturaleza hereditaria presentan alto riesgo de padecer un hepatoblastoma (García-Miguel, 1998; Roebuck *et al.*, 2007). En el Síndrome de Turcot se describe la asociación con tumores del SNC especialmente el meduloblastoma (García-Miguel, 1998). Mayor riesgo de neoplasia ovárica se ha descrito en niñas con Síndrome de Peutz-Jeghers (Sierrasesmaga, 1992).

C) Inmunodeficiencias

Las inmunodeficiencias son cuadros clínicos, extremadamente infrecuentes, de componente hereditario caracterizados por una alteración del sistema inmunitario que conlleva al desarrollo de procesos infecciosos. También en estas situaciones se han descrito diversas neoplasias (Menegaux *et al.*, 2004; Rudant *et al.*, 2007) como linfomas no Hodgkin, leucemias, sarcomas, neuroblastomas y adenocarcinomas.

TUMORES INFANTILES MÁS FRECUENTES

Los tumores infantiles se clasifican siguiendo una categorización distinta de la del adulto. La clasificación que se usa es una modificación de la *International Classification of Disease for Oncology* (ICD-O) de la OMS, que agrupa los tumores en 12

grandes categorías diagnósticas (Tabla 16.2), que a su vez engloban subgrupos que permiten estudiar hasta 40 tipos diferentes de tumores.

Ta la *Classification of disease for oncology (ICD-O) para tumores pediátricos.*

I	Leucemias
II	Linfomas y otros tumores reticuloendoteliales
III	Tumores del Sistema Nervioso Central
IV	Tumores del Sistema Nervioso Simpático (neuroblastomas)
V	Retinoblastoma
VI	Tumores renales
VII	Tumores hepáticos
VIII	Tumores óseos
IX	Sarcomas de partes blandas
X	Neoplasias de células germinales, trofoblásticas y otras neoplasias gonadales
XI	Carcinomas y otras neopasias malignas epiteliales
XII	Otros y no especificados

Leucemia a uda (Fal , 1988; Halperin *et al.*, 1999; ang *et al.*, 2007)

Es la neoplasia más frecuente en la edad pediátrica. Supone entre el 22-30 del to- tal. Se caracteriza por una proliferación incontrolada de células linfoides o mieloides inmaduras (blastos), que invaden la médula ósea, sangre periférica y otros órganos. Se clasifican en agudas/crónicas y en linfoblástica/no linfoblástica o mieloide. La forma linfoblástica (LAL) supone el 80 de las leucemias en los niños, la forma mieloide aguda (LMA) el 15 y solo el 5 son mieloides crónicas (LMC).

Las manifestaciones clínicas son muy diversas. En ocasiones el niño está asinto- mático y el diagnóstico se lleva a cabo por las alteraciones analíticas (anemia intensa, trombocitopenia, cifras elevadas de leucocitos, elevación de los niveles de ácido úrico o de LDH), aunque la forma de presentación clínica más frecuente es la de cansancio, malestar general, anorexia, fiebre, dolores óseos o articulares, infecciones prolonga- das y dolor abdominal de semanas de evolución. A la exploración clínica se pone de manifiesto palidez, hepatoesplenomegalia, púrpuras y adenopatías.

El diagnóstico se basa en una historia clínica cuidadosa, la exploración clínica, el examen de sangre periférica y sobre todo en el estudio del aspirado medular (ce-

lularidad elevada con sustitución casi total de las células normales por las células blásticas).

El tratamiento de las leucemias se basa en el uso de la quimioterapia en cuatro fases: inducción, profilaxis del Sistema Nervioso Central (SNC), consolidación y mantenimiento, siendo la duración total del tratamiento de 2-3 años. En ocasiones se usa el trasplante de médula ósea para garantizar una remisión completa y continuada.

Enfermedad de Hodgkin (Fal , 1988; Thomas, 1992)

Descrita en 1832 por Thomas E. Hodgkin, se trata de un proceso del sistema reticuloendotelial que cursa con características de enfermedad maligna, de enfermedad infecciosa y de alteración de la inmunidad. Junto a los linfomas representa el 15 % de todas las neoplasias infantiles. Se clasifica en función de los hallazgos histopatológicos en 4 variantes: predominio linfocítico (PL), esclerosis nodular (EN), celularidad mixta (CM) y deplección linfocítica (DL). En la edad infantil predominan la EN y la CM.

La manifestación inicial es la aparición de adenopatías a nivel cervical y/o mediastínica, acompañada en ocasiones de fiebre, sudoración profusa, pérdida de peso y prurito generalizado.

El diagnóstico se basa en la historia clínica, en la exploración física, estudios analíticos (elevación de la cupremia, beta 2 microglobulina y la VSG), estudios de imagen (TAC, RNM y PET), y especialmente con la biopsia de un ganglio sospechoso. Tras el diagnóstico debe llevarse a cabo el estadiaje en función del número y localización de los ganglios afectos.

La base de su tratamiento es la quimioterapia apoyándose en la radioterapia como consolidación.

Tumores del Sistema Nervioso Central - SNC (Fal , 1988; Halperin *et al.*, 1999; Laughton *et al.*, 2007)

Tras la leucemia, los tumores del SNC ocupan el segundo lugar en frecuencia entre los procesos malignos de la infancia. Representan el 20 % de todas las neoplasias del niño y adolescente. Presenta dos picos de incidencia: el primero (4-8 años) con tumores de origen embrionario y de localización infratentorial, y el segundo (a partir de 10 años) con neoplasias de situación supratentorial y de origen glial. Existe una gran variedad histológica, siendo las variantes más frecuentes el astrocitoma (50 %), el meduloblastoma (25 %), el ependimoma (9 %) y los gliomas del tronco cerebral (8 %).

Clásicamente los síntomas de presentación son la cefalea, los vómitos, el aumento de perímetro craneal y las alteraciones oculares (diplopia y estrabismo). A veces se acompañan de convulsiones, afectación de pares craneales, alteraciones en la marcha, irritabilidad y alteraciones del comportamiento.

El diagnóstico se basa principalmente en estudios radiológicos (TAC y RMN) y en la toma de biopsia, aunque esto último no siempre es posible.

El enfoque terapéutico se sustenta en la combinación apropiada de cirugía, radioterapia y quimioterapia, en función de la localización y de la estirpe histológica.

Neuroblastoma (Falck, 1988; Lopez-Ibor, 1992; Wang, 2007)

Es un tumor que se origina a partir de las células de la cresta neural, que darán origen a las células del sistema nervioso simpático. Es el segundo tumor sólido más frecuente en el niño tras los cerebrales. Es el tumor sólido más frecuente en los lactantes. Supone un 10% del total. Tiene un pico de incidencia máximo a los dos años. Es un tumor que solo se desarrolla en niños.

Es un tumor de comportamiento biológico sorprendente, habiéndose descrito casos de regresión espontánea o transformación a tumor benigno (ganglioneuroma).

La localización primaria más frecuente es el abdomen, bien en la glándula suprarrenal (40%) o en los ganglios paraespinales (25%). Se manifiesta en forma de masa abdominal asociada a fiebre, malestar general, pérdida de peso y dolor.

Su diagnóstico se basa en la exploración física, estudios analíticos (anemia, elevación de LDH), y estudios radiológicos (TAC, gammagrafía con I-131 MIBG, RMN, ecografía).

En su tratamiento la combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia es la estrategia más utilizada.

Nefroblastoma o tumor de Wilms (Falck, 1988; Halperin *et al.*, 1999; Pritchard-Jones, 2002)

Es el tumor renal primario más frecuente en la infancia, representando el 8% del total. Es característico de la primera infancia (2-3 años).

Clínicamente se manifiesta en forma de masa abdominal asociada a fiebre, dolor abdominal y hematuria. A veces hay hipertensión arterial e hipercalcemia.

En su diagnóstico, la historia clínica detallada, la exploración física minuciosa, los estudios analíticos y radiológicos (TAC, RMN) son la base para su correcto estadiaje.

El tratamiento inicial debe ser quirúrgico acompañado de radioterapia en estadios avanzados y de diversos esquemas con quimioterapia.

Retinoblastoma (Van Dijk, 2007; Aerts *et al.*, 2006)

Es el tumor ocular más frecuente en el niño. Se desarrolla a partir de las células precursoras de la retina. Representa el 3% del conjunto de tumores sólidos de la infancia. Es una neoplasia de gran interés desde el punto de vista genético, al demostrarse su transmisión hereditaria con carácter dominante en un 40% de pacientes. Se han descrito remisiones espontáneas. Puede ser bilateral en el 40%.

Su diagnóstico es clínico, presentando leucocoria (reflejo pupilar blanco), estrabismo, inflamación ocular, proptosis, pérdida de agudeza visual y glaucoma. Para su mejor delimitación, la RNM es muy útil.

En su tratamiento juegan papel la cirugía y la quimioterapia y la radioterapia generalmente en forma combinada.

UNIDADES DE ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA

Las neoplasias infantiles han ido adquiriendo a lo largo de las últimas décadas una importancia progresiva en el ámbito de la pediatría. La disminución de la mortalidad por otras patologías en los países desarrollados (especialmente las infecciosas y las gastrointestinales) ha ido otorgando a los tumores infantiles un papel cada vez más importante en la patología pediátrica, fundamentalmente en el ámbito hospitalario (Muñoz, 1995). Como ya hemos comentado, la incidencia de cáncer infantil oscila entre 160-170 casos por millón de niños de 0 a 14 años (Young *et al.*, 1986).

Esta importancia cualitativa se ha visto acompañada por una espectacular mejoría en los resultados obtenidos en el tratamiento. Estos progresos se han debido a múltiples factores entre los que destacamos:

- el mejor conocimiento de los distintos aspectos epidemiológicos y etiológicos,
- el avance en el campo de la biología tumoral,
- la instauración de las Unidades de Oncología Pediátrica en los Hospitales de la red pública sanitaria,
- el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y radioterápicas,
- la introducción de nuevos métodos diagnósticos,
- la aparición de nuevos agentes quimioterápicos, y sobre todo a
- la integración multidisciplinaria de las diferentes modalidades terapéuticas con el diseño de nuevos protocolos clínicos que han permitido ir resolviendo dilemas terapéuticos y seleccionar las pautas más adecuadas para cada neoplasia y dentro de ellas para la situación específica de cada paciente (Midraetis, 1996; López *et al.*, 1996).

Dada la complejidad de los actuales procedimientos diagnósticos y terapéuticos, los pacientes infantiles con cáncer deben ser referidos a Centros que dispongan de los recursos humanos y materiales adecuados. Esto unido al elevado costo de la asistencia oncológica pediátrica hace que ésta se efectúe casi exclusivamente en el ámbito hospitalario y en España concretamente en la red sanitaria pública. Dentro de los hospitales y los servicios de Pediatría, el lugar idóneo para la correcta evaluación de los niños con cáncer es la Unidad de Oncología Pediátrica. Su centralización permite reunir un número suficientes de pacientes para obtener resultados más óptimos. Ya se ha demos-

trado estadísticamente la superioridad de los logros obtenidos en estas unidades sobre los servicios pediátricos generales (Stiller, 1988; Halperin *et al.*, 1999).

La atención al niño oncológico supone un reto por el riesgo vital de enfermedad en sí, el largo proceso evolutivo de la misma, la terapia intensiva específica que requiere, sus efectos secundarios y la repercusión psicoemocional que supone para el niño y su familia.

Las recomendaciones sobre las características de las Unidades de Oncología Pediátrica que hacen tanto la Academia Americana de Pediatría (AAP) como la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) son las siguientes (Muñoz, 1995):

- Coordinación de las mismas por pediatras oncólogos debidamente especializados y cirujanos pediatras oncólogos.
- Área específica de hospitalización y Hospital de Día.
 - Enfermería y Auxiliares de Clínica entrenadas en Oncología Pediátrica.
 - Existencia en el Centro de UVI pediátrica.
 - Servicio de Radiología Infantil.
 - Laboratorio de Análisis Clínicos y Bioquímica.
 - Banco de Sangre.
 - Servicio de Farmacia familiarizada con el manejo de agentes neoplásicos.
 - Posibilidad de aislamiento preventivo.
 - Disponibilidad de técnicas de nutrición parenteral.
 - Nutricionistas y dietistas.
 - Servicio de Oncología Radioterápica, compuesto por especialistas familiarizados con el manejo de tumores pediátricos, con dotación que incluya Acelerador Lineal de varias energías (mínimo 6 MV), siendo aconsejable de disponer de IMRT (Radioterapia de Intensidad Modulada).
 - Servicio de Anatomía Patológica, con posibilidad de realización de biopsias intraoperatorias.
 - Comité de Tumores (coordinación multidisciplinaria).
 - Psiquiatra y psicólogo con experiencia en niños, sin olvidar al adulto.
 - Maestra hospitalaria.
 - Coordinadora del voluntariado.
 - Asesor espiritual.

Las funciones de las Unidades hospitalarias de Oncología Pediátrica son:

1. Atención integral al niño oncológico, en su vertiente médica, de enfermería y cuidados psicosociales.
2. Investigación.

3. Formación de pregraduados (conocimientos de oncología infantil dentro de la Pediatría) y postgraduados (como parte de la formación básica en Pediatría o de la formación de especialistas en Oncología Pediátrica).
4. Atención a los familiares.
5. Coordinación con organismos nacionales e internacionales.

Se recomienda que dichas Unidades atiendan un mínimo de 50 pacientes nuevos / año y que puedan realizar trasplantes de médula ósea o estén coordinados y próximos a otro Centro que disponga de dicha técnica. Según datos del Segundo Libro Blanco de la Oncología (Muñoz, 1995) en nuestro país existen 35 hospitales de la red pública que disponen de Unidad de Oncología Pediátrica.

En la Comunidad Valenciana, la situación de los recursos sanitarios a 2006 en esta esfera es de la existencia de 3 Unidades de Oncología Pediátrica (H. La Fe de Valencia, H. Clínico de Valencia y el H. General Universitario de Alicante) y de 10 especialistas en Oncología Pediátrica. Desde Abril de 1997 se dispone de una Unidad de hospitalización a domicilio pediátrica, dependiente del H. La Fe, que actúa como referencia para Valencia y Castellón.

En el periodo 1980-1982, solo el 32 % de los niños oncológicos españoles eran atendidos en Unidades de Oncología Pediátrica, en el periodo 2001-2003 es del 88 %.

Hay evidencias de que el diagnóstico y tratamiento de algunos tumores infantiles, especialmente aquellos en los que se requiere una radioterapia compleja, se realiza mejor en Hospitales que disponen de Unidad Infantil Oncológica. Así, la supervivencia a los 5 años para el meduloblastoma tratado en Hospital con Unidad Pediátrica es 2.5 veces superior que el tratado en otros Centros. Esos mejores resultados también se han demostrado para los gliomas cerebrales, tumor de ependiomas, rabdomiosarcoma y leucemias entre otros (Stiller, 1988; Halperin *et al.*, 1999).

En Septiembre de 1996 se puso en funcionamiento la primera Unidad de Oncología Pediátrica en la provincia de Alicante adscrita al Hospital General Universitario, a cargo del Dr. Carlos Esquembre. En Diciembre de 1997 se realizó una encuesta retrospectiva para conocer el nivel de satisfacción de las familias asistidas durante el primer año de funcionamiento, siendo valorada como muy buena en el 75 % y buena en el 22 % (Serna *et al.*, 1998).

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER INFANTIL

Los niños remitidos a las Unidades oncológicas infantiles pueden encontrarse en dos situaciones: con diagnóstico de sospecha o con diagnóstico confirmado. En el primer caso, el oncólogo pediatra realizará las pruebas oportunas para llegar a un diagnóstico de certeza, que generalmente se basa en una identificación histopatológica (biopsia). La edad media en el momento del diagnóstico es de seis años (en el adulto es de 67 años) (Hammond, 1986; Young *et al.*, 1986).

El siguiente paso consiste en la realización del estudio de extensión pertinente para así poder estadiar cada caso. El estudio de extensión suele consistir en la realización de diversos estudios exploratorios, analíticos y radiológicos. El estadio se basa fundamentalmente en 3 parámetros: el tamaño tumoral (T), la situación de los ganglios linfáticos (N), y la existencia o ausencia de enfermedad a distancia (M) (Roebuc *et al.*, 2007).

Una vez confirmado el diagnóstico y realizado el estudio de extensión podemos conocer con exactitud la situación del proceso tumoral en el niño, y previa valoración por el Comité Oncológico, decidir el tratamiento más oportuno para ese tumor y para ese niño (tratamiento individualizado) (Murphy, 1995). El tratamiento está basado en la evidencia científica de su eficacia. Cada tumor se trata de forma distinta, incluso cada caso requiere una estrategia distinta. De ahí la importancia de la participación de los diversos especialistas a la hora de la decisión terapéutica. Generalmente, los tratamientos atienden a un protocolo establecido, el cual contempla con exactitud qué armas utilizar, su frecuencia y duración, aunque pueden modificarse en función de la tolerancia del niño y del grado de respuesta clínica (López *et al.*, 1996). Hoy en día pocos tumores malignos en niños son tratados exclusivamente con un arma terapéutica. La mayor parte de las lesiones se abordan con un enfoque multidisciplinario que combina cirugía, radioterapia y quimioterapia, y que requiere una estrecha cooperación entre los diversos especialistas (Comité Oncológico) (Pac *er*, 1995).

Fundamentalmente, las armas de tratamiento son: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Desde hace unos años se ha añadido la bioterapia y el trasplante de médula ósea.

El papel de la *cirugía* (Benito *et al.*, 1992) comprende no solo el tratamiento del tumor (extirpación), sino también el diagnóstico (toma de biopsia) y estadiaje de la enfermedad. Es primordial en el tratamiento de la mayoría de tumores sólidos como del hepatoma, del neuroblastoma, del sarcoma, etc. Para tumores grandes, la quimioterapia y/o radioterapia se usan inicialmente para reducir el tamaño y así realizar una cirugía menos mutilante. En cambio en otras situaciones, el primer escalón es la cirugía para extirpar la totalidad o gran parte de la masa tumoral y facilitar la eficacia de la quimioterapia o radioterapia que se administrarán a continuación.

La *radioterapia* (Abuchaibe *et al.*, 1992) es la segunda arma que históricamente se utiliza en estos procesos. Consiste en la administración de radiación capaz de esterilizar la zona a tratar. Es un tratamiento individualizado que requiere de una planificación previa compleja precisando de la intervención no solo del oncólogo sino de especialistas en Física Médica (Camprubí, 1999). Se administra de forma fraccionada, con secuencia diaria durante cinco días a la semana, hasta llegar a la dosis prescrita. En algunas situaciones (niños muy pequeños) se requiere una sedación previa a fin de que no se mueva durante los minutos que dura una sesión. Es un tratamiento indoloro. Se aplica a la zona del tumor y sobre las regiones vecinas con sospecha de enfermedad tumoral (locoregional). Los efectos secundarios generales de la radiación incluyen fatiga, pérdida de apetito y enrojecimiento de la piel en la zona a tratar. La gravedad o tipo de efectos secundarios depende de la zona tratada, la dosis administrada, de la combinación con quimioterapia, etc. Por ejemplo, la irradiación craneal puede pro-

vocar mareo, náuseas, vómitos o pérdida temporal del cabello; náuseas, vómitos y diarreas pueden aparecer en la irradiación abdominal.

La *bioterapia* (Madero *et al.*, 1995) consiste en la administración de sustancia terapéutica que “alteran” la relación entre las células malignas y el huésped mediante la modificación de la respuesta natural del huésped a estas células, aumentando la capacidad inmunológica del mismo. En la esfera pediátrica y perteneciente a este grupo citamos los factores estimulantes de colonias, los interferones y los anticuerpos monoclonales.

La *quimioterapia* (Giraldez *et al.*, 1992) consiste en la aplicación de varias drogas capaces de destruir a las células tumorales. Generalmente se usa la vía intravenosa. Se administra con carácter mensual (ciclo) hasta completar el esquema previsto. Dado que su duración es larga, a fin de evitar múltiples inyecciones, se usan unos aparatos denominados reservorios que, colocados debajo de la piel del tórax o en otras localizaciones, permiten la extracción de sangre para analítica y la administración del tratamiento con las mínimas molestias para el niño.

Muchos de los quimioterápicos administrados no alcanzan el cerebro ni a las meninges donde puede existir enfermedad tumoral. Por tanto, puede ser necesario inyectar medicación directamente en el líquido cefalorraquídeo y/o realizar una irradiación sobre el cerebro y la médula espinal. Esto suele suceder en los casos de leucemia, linfoma o meduloblastoma.

Los efectos secundarios de la quimioterapia son generales debido en parte a que, además de afectar a las células cancerígenas, los medicamentos también dañan a las células normales. Pueden aparecer descenso temporal de células sanguíneas (glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas), infección, mayor posibilidad de sangrar, heridas y llagas en la boca, pérdida de cabello, náusea, vómitos, fatiga, dolor de huesos, cambios de humor, y cambios en el apetito. Cada medicamento tiene sus propios efectos secundarios. Afortunadamente, muchos de estos efectos son temporales, van desapareciendo conforme el organismo va reparando el daño causado a los tejidos y los medicamentos se van eliminando.

El *trasplante de médula ósea* (Muñoz, 1992) se utiliza en algunos casos de leucemia, linfoma o tumores sólidos. Su filosofía consiste en usar las máximas dosis posibles de quimioterapia para tratar el tumor a expensas de dañar la médula ósea dejándola incapaz de fabricar células sanguíneas. La médula ósea a trasplantar se obtiene normalmente de los huesos de la cadera, donde existen abundantes células madre, y se le inyecta al paciente intravenosamente como si fuera una transfusión de sangre. Las células madre inyectadas se dirigen a la médula ósea, donde comienzan un procedimiento de desarrollo normal.

Existen tres tipos principales de trasplante de médula ósea. El autólogo, cuando proviene del propio enfermo, y el alogénico, cuando la médula proviene de un donante que es compatible con el paciente, bien de un miembro de la familia —normalmente hermano— o bien de un banco internacional de donantes, y el singénico, cuando el donante y el enfermo son gemelos univitelinos.

Los efectos secundarios de un trasplante dependen del tipo de cáncer a tratar, así como al tipo de transplante. Puede aparecer infección, hemorragia, úlceras bucales, alteraciones gastrointestinales, complicaciones hepáticas y deterioro de la piel. Ade-

más, los pacientes que se someten al alogénico pueden experimentar el fenómeno de rechazo en el que las células del donante atacan a los tejidos del receptor.

El objetivo primordial es curar al niño con los mínimos efectos secundarios posibles. Actualmente se siguen buscando nuevos caminos para tratar el cáncer infantil. Esta búsqueda tiene varios propósitos: mejorar la supervivencia de la enfermedad, reducir los efectos secundarios, mejorar en el conocimiento de la biología tumoral, identificar factores pronósticos que permitan modular la intensidad de los tratamientos y ofrecer una calidad de vida aceptable (Muñoz, 1992; Murphy, 1995).

Los estudios clínicos para la búsqueda de tratamientos más efectivos son de ámbito internacional mediante la colaboración de grupos que traten el cáncer infantil. Nuevos protocolos se diseñan para mejorar resultados, pero siempre deben ser aplicados en el ámbito hospitalario y más concretamente en las Unidades de Oncología Infantil (Stiller, 1988; López *et al.*, 1996).

ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LOS TUMORES INFANTILES

Durante el proceso diagnóstico

El diagnóstico definitivo de cáncer supone un “shock” psicológico a los padres. Ningún padre está preparado para recibir la noticia de que su hijo/a tiene un cáncer. Las primeras explicaciones de la enfermedad y del tratamiento a seguir pueden no servir de nada a los padres que solo se agarran a la realidad de que su hijo tiene cáncer. Esta primera confusión es bastante frecuente, e implica la necesidad de explicar varias veces el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Al ser un momento crucial, los padres deben solicitar información detallada y entendible de la enfermedad de su hijo/a. Muchos Centros ofrecen a los padres todo tipo de información y material que facilita a los padres el entendimiento del tratamiento para su propia tranquilidad (Gómez, 1999). Para el niño supone un cambio radical en su entorno y en sus actividades normales. Físicamente, debe soportar el malestar de la enfermedad como las pruebas diagnósticas y terapéuticas. Psíquicamente, sufre ansiedad ante el nuevo medio que le rodea y ante los problemas de imagen corporal (Giammona *et al.*, 2002).

a) Primeras reacciones de los padres

Suelen experimentar muchos sentimientos cuando escuchan que su hijo/a tiene cáncer. ¿Por qué a mi hijo? es la pregunta inicial más común, y su falta de respuesta se traduce en angustia. El diluvio de sentimientos incluye la incredulidad, rabia, culpa, temor por el futuro, desesperación, dolor y confusión. Estas reacciones son muy naturales y pueden ser una forma de ayuda para enfrentarse a la necesidad de aceptar una situación que quisieran cambiar y no pueden. Es importante recordar, sin embargo, que es un momento en el que el niño necesita del apoyo de sus padres

y está particularmente sensible a los cambios de humor y sentimientos anómalos de los padres. Un niño que percibe que sus padres no pueden o no quieren entender la enfermedad, puede sentirse angustiado/a, aislando al niño de una importante fuente de apoyo y ayuda, imaginando que su situación es peor de lo que realmente es (aza, 1999).

También es frecuente la búsqueda de una segunda opinión en otro médico o en otro Hospital. La segunda opinión suele ser para confirmar el diagnóstico y reafirmar a los padres con precisión acerca del tratamiento recomendado. Sin embargo, una vez ambos especialistas están de acuerdo en el tratamiento a seguir, querer buscar una tercera opinión, es solo un reflejo de la necesidad de los padres de buscar un diagnóstico más aceptable. Esto se traduce en mayor trastorno al niño y retraso en el inicio del tratamiento (aufman *et al.*, 1992).

b) Aceptar el diagnóstico y autorizar el tratamiento

Es frecuente en los padres atravesar por un periodo de desorientación, precisando de un tiempo de adaptación de duración variable pero que debe ser lo más corto posible a fin de no demorar el inicio del tratamiento. Gradualmente los padres aceptan que su hijo/a tiene cáncer. Llegados a este punto, algunos padres se enfurecen, con sentimientos de culpa hacia Dios, a ellos mismos, al especialista, al pediatra o incluso al niño enfermo por haber contraído la enfermedad. Ya que es difícil expresar la rabia hacia el niño enfermo, las esposas / maridos o los otros hijos sanos pueden ser el centro de las iras. Es importante recordar que los otros miembros de la familia experimentan sentimientos parecidos. Hay que aceptar esta rabia, siendo aconsejable hablar con el resto de la familia, personal médico, o cualquier otra persona que pueda ayudarnos a llevar esta situación (Serna *et al.*, 1998; aza, 1999).

Pueden surgir sentimientos de culpa pensando que la enfermedad del niño es consecuencia de posibles errores del pasado. Los padres se preocupan de cómo han tratado a su hijo, de si ha recibido o no las vacunas correctamente, de si han sido severos en su educación, etc. Es difícil aceptar, a pesar de sus esfuerzos, que el niño tiene cáncer. Una de las cosas que los padres deben recordar es que ellos no son culpables de la enfermedad de su hijo (aza, 1999).

Los padres a menudo culpan a los médicos por los retrasos en el diagnóstico. Todo padre quiere saber cuando empezó el cáncer, pero no existe una respuesta concreta. Generalmente los primeros síntomas del cáncer son a menudo como los de cualquier otra enfermedad banal, con lo que el diagnóstico inicial es difícil incluso para un especialista (hitsett *et al.*, 1999).

Dado que en la actualidad se requiere un consentimiento firmado para la realización de pruebas médicas y para la administración del tratamiento, los padres sienten el peso de la responsabilidad, pudiendo añadir un mayor número de emociones adversas a las ya existentes (Pac er, 1995). Pero deben saber que el tratamiento que va a recibir su hijo/a en las Unidades de Oncología Pediátrica de nuestro país es el más actual y apropiado y que dichas terapias van evolucionando y mejorando día a día (Muñoz, 1995).

Afortunadamente, la mayoría de padres tienen la fuerza suficiente para enfrentarse al diagnóstico y tratamiento, aumentando su confianza a medida que este avanza a pesar de que pueden surgir crisis en el camino (Oppenheim, 1990).

c) Decírselo a tu hijo/a

Una de las decisiones más duras, una vez confirmado y asumido el diagnóstico, es qué le vas a decir a tu hijo/a. En el pasado, existía una fuerte tendencia cultural a proteger a los niños de dolorosas realidades. Hoy en día, hay un acuerdo general acerca de que el paciente debe saber todo lo relacionado con su enfermedad siempre que su edad le permita entender. De hecho, estudios recientes (Aza, 1999) demuestran que, aunque no se les informe acerca de su enfermedad, ellos saben que se denomina cáncer y sus implicaciones. Es imposible ocultarle que está enfermo, porque “algo” a su alrededor se lo dice: toma medicinas especiales, acude con frecuencia al hospital, sus padres se muestran especialmente preocupados por su salud, oyen comentarios en su casa, en el hospital ve y habla con otros niños con la misma enfermedad (Agner *et al.*, 1997; Aza, 1993).

La cuestión entonces no es solo de hablarle del diagnóstico, sino de compartir y entender sus inquietudes para que sientan apoyo familiar. Deben comprender por qué se le hacen todas esas pruebas y por qué sus padres están tristes y angustiados. El gesto más importante hacia ellos debe ser una sincera comunicación. Ser honestos cuando nos pregunte algo porque ellos también tienen una desesperada necesidad de comunicarse con los padres (Aufman *et al.*, 1992).

Como padres, son los que mejor pueden juzgar los cambios de humor del niño. Pero debemos recordar que aunque al niño le cuesta hablar de su enfermedad y de los temores relacionados con ella (incluyendo la muerte), ello no significa que no tenga dudas o temores. El niño sabe que esta enfermedad es mucho más seria que cualquier otra, está francamente asustado, tiende a aislarse y a incrementar sus temores (Oppenheim, 1990; Raney *et al.*, 1990).

Exactamente cuándo y qué decirle al niño depende de su edad, madurez y de la actitud de los padres. Algunos padres prefieren decírselo a solas, otros en presencia del personal especialista, y otros desean que sean estos últimos quienes lo hagan. Debe utilizarse la forma que haga sentir más cómodo al niño y a los padres (Aza, 1999; Tyc *et al.*, 1998).

En general, el niño muy pequeño (menores de 5 años), al carecer de la madurez necesaria para entender completamente la enfermedad, solo ha de saber que está enfermo, que tiene que tomar ciertos medicamentos para ponerse bien, que las agujas hacen daño pero solo es un instante, que aunque se le “abandona” volverá a estar con sus padres inmediatamente, ya que acusan las breves separaciones de sus padres. Sentimientos de separación, soledad y miedo son comunes en esta edad y hay que luchar contra ellos.

El niño entre 6 y 10 años teme al daño físico. Entiende que su enfermedad no es “normal”, es seria y que precisa de tratamiento especial. Suelen responder con comportamientos anómalos propios de su edad (“rabieta”), de ansiedad, tristeza y desarrollar conductas regresivas. Su principal temor es el miedo a lo que pueda

pasarle, especialmente a la mutilación. De modo que, debe saber que tienen cáncer, una grave pero tratable enfermedad. También decirle que la causa del cáncer es todavía desconocida, que necesita un tratamiento especial y que pasará un tiempo hasta que vuelva a encontrarse bien. Son capaces de relacionar síntomas, tratamientos y consecuencias, y como su pensamiento discurre dentro de este esquema causa-efecto, pueden considerarse culpables de su enfermedad.

El niño más mayor (preadolescente) y adolescente comprende su diagnóstico, tratamiento y sus consecuencias. Pueden comparar el cáncer con la muerte, y necesitan saber no solo de su diagnóstico y tratamiento, sino que los tratamientos cada vez avanzan más y que existen muchos índices de éxito. A estos jóvenes pacientes, el impacto de la noticia les afecta en sus actividades diarias, apariencia y relaciones con los demás. Se sienten enfadados y resentidos ante la situación de ver sus vidas interrumpidas y alteradas en su calidad de vida. El impacto psicológico del cáncer puede ser más devastador durante la adolescencia que a cualquier otra edad, ya que la enfermedad y la terapia les alejan por un tiempo de su ambiente, con cambios en su físico que les puede condicionar temores no solo ante la enfermedad, sino también a la pérdida de un lugar entre sus compañeros, del control de una independencia recién estrenada, de su privacidad y de sus actividades. Sin un adecuado apoyo, todo ello puede repercutir en su autoestima, con consecuencias tanto a nivel emocional como social y de rendimiento.

Para preparar a los niños ante los diversos procesos médicos a que van a ser sometidos son de utilidad las técnicas psicológicas, diversas medicaciones (antieméticos, analgésicos, etc.), información gráfica (libros, películas, etc.), técnicas de relajación, musicoterapia (Camprubí, 1999), etc. Ellos se manejan mucho mejor cuando tienen conocimiento y control sobre los síntomas de su enfermedad. Casi todos los niños tienen una fuerza y resistencia impensable en los adultos (Hitsett *et al.*, 1999; Randolph *et al.*, 1999).

d) Tranquilizando a tu hijo/a

El niño oncológico tiene tendencia a relacionar su enfermedad con la muerte. Hay que estar preparado para contestar preguntas acerca de la muerte, por muy dolorosas que sean. Negarse a querer discutir y hablar de ello puede todavía crearles mayores tensiones y más dudas, y a los padres quitarles la oportunidad de ofrecerle apoyo y comprensión (Aza, 1999).

Es posible que los pacientes jóvenes sientan autoculpa considerando la enfermedad como castigo por algo malo que han hecho o pensado, por tanto, necesitan saber que no tienen culpa alguna y que siguen siendo queridos a pesar de todo. Puede que el niño culpe a los padres por dejar que esta enfermedad le ocurra. Hay que recordar que aunque sientan rabia hacia los padres, siguen queriéndolos y necesitan de ellos (Serna *et al.*, 1998; Raney *et al.*, 1990).

Hay que intentar llevar una vida lo más “normal” posible, compartir los sentimientos entre padres, personal médico y paciente, tiene un efecto muy positivo. El niño lo

llevará mucho mejor sabiendo lo que le ocurre que no si lo desconoce todo. El cuidado médico tiene más éxito cuando el niño participa activamente (Gaza, 1993).

e) Informando a hermanos y hermanas

Un diagnóstico de cáncer afecta a toda una familia. Para los hermanos el periodo inicial es de desconcierto y temor. Los niños, incluso los más jóvenes, son muy sensibles a lo que está ocurriendo. Saben que su hermano/a ha de ser hospitalizado y que habrá muchos viajes al hospital. Ven a sus padres llorar y cómo intentan consolarse uno a otro. Pueden oír algunas conversaciones que no llegan a entender. Ellos se dan cuenta que algo “gordo” pasa. Captan información de todo lo que va pasando y lo analizan (Gaza, 1999).

Por ello es importante explicarles la situación e invitarles a que pregunten lo que quieran, tenerles al corriente de la situación de su hermano/a y sobre todo contestarles con sinceridad.

Deben estar preparados para los posibles cambios físicos en su hermano/a, tales como pérdida de cabello, adelgazamiento e incluso una posible amputación (Camprubí, 1999). Deben saber que la enfermedad de su hermano/a no es contagiosa y que el cáncer no les va a atacar ni a ellos ni a su familia. Importante es hacer mucho hincapié en el hecho de que ellos no son responsables de la enfermedad de su hermano/a (Aufman *et al.*, 1992).

Continuando la vida

Uno de los retos a afrontar por una familia con un paciente de cáncer es conseguir llevar una vida normal. Esto no suele siempre ser fácil, particularmente en momentos de gran estrés como durante la hospitalización. Aún cuando se responde al tratamiento, las vidas de los miembros de la familia se ven influenciadas por esta enfermedad, se cambian los horarios familiares para las visitas al hospital, los miembros de las familias se separan, los hermanos pueden sentirse abandonados, etc. A pesar de todo ello hay que intentar que la vida familiar continúe lo más “normal” posible. Para que esto ocurra el paciente ha de ser tratado con la máxima normalidad, que no sienta que sus padres o hermanos lo tratan de manera especial (Randolph *et al.*, 1999; Aufman *et al.*, 1992).

a) Los padres

Para enfrentarse a la enfermedad y de los cambios que vuestras vidas van a sufrir, los padres deben apoyarse mutuamente, evitar que no todas las discusiones sean referentes a la enfermedad del niño, luchar contra los sentimientos de frustración que se sienten en las visitas médicas, turnarse para acompañar al niño en el hospital, no olvidar al resto de miembros de la unidad familiar (Gaza, 1999).

Para todo esto, las Unidades de Oncología pediátrica disponen de psicólogos, asistentes sociales así como personal médico y de enfermería debidamente forma-

dos en este aspecto (Serna *et al.*, 1998). Pueden ser útiles los grupos de apoyo incluidos en diversas organizaciones o las diversas asociaciones de padres de niños con cáncer.

b) El paciente

Aunque el diagnóstico de cáncer cambie la vida del niño por un tiempo, sigue teniendo las mismas necesidades que el resto de niños, como los amigos, el colegio, el juego y todas aquellas actividades que realizaba antes de caer enfermo/a. Hay que ayudarle a mantener el mismo tipo de vida en la medida de lo posible (Hitsett *et al.*, 1999).

- *Colegio*

Para un niño oncológico, continuar con la vida escolar es vital. Es el mayor centro de actividad, y su asistencia le ayudará a sentirse mucho mejor. Le permitirá su maduración social y evitará el hecho de que el niño se retrase en el aprendizaje con respecto a los otros (Aufman *et al.*, 1992). Cuando está hospitalizado, existen programas de escolarización intrahospitalaria, explicándole que será temporal para que la vuelta a su colegio no sea tan “dura”. La vuelta al colegio es un momento emocionalmente muy difícil para el niño.

Cuando vuelven al colegio, los profesores y tutores necesitarán información acerca del tratamiento, de las posibles faltas a clase que pueda tener y de cualquier cambio en sus actividades. Los profesores deben darle un trato normal, sin atención especial con respecto al resto.

Es posible que el niño esté asustado de volver al colegio ante las reacciones de los demás por su apariencia, pérdida de cabello, o incluso por la existencia de alguna amputación, pero debe volver al colegio (Aza, 1993). Hay que aceptar sus temores de rechazo y ayudarle a llevarlo. Pueden aparecer conductas de “fobia a la escuela”, falta de iniciativa y un menor nivel de actividad. Muchos padres y niños descubren que sus temores son injustificados porque normalmente los compañeros aceptan al paciente con sus condiciones, y el niño se siente reconfortado y gana confianza en sí mismo. La necesidad de ser aceptado y sentirse como el resto es muy importante para ellos y cualquier trato de desigualdad puede tener consecuencias negativas (Aza, 1999).

- *Disciplina*

Es muy importante para su correcta formación, y más aún cuando existe un caso de cáncer. Sin embargo, las especiales circunstancias de su situación hacen que sea muy difícil de aplicar. Hay tendencia a tolerar un comportamiento más “blando” que no se hubiera tolerado en circunstancias normales. Encuentran muy duro aplicar la disciplina al niño en su situación. A pesar de todo, la disciplina es básica para mantener una normalidad en su vida (Agner *et al.*, 1997).

También es frecuente sobreproteger al niño, mantenerlo a tu lado y alejarlo de determinadas situaciones. Esto le niega la posibilidad de participar en actividades normales que favorecen su desarrollo (Pac er, 1995). Si la práctica de deportes no es recomendable por su situación, hay que hacérselo saber, pero si no es así, no hay motivo para prohibir que monte en monopatín, juegue a fútbol o participe en cualquier otro deporte. La sobreprotección merma su capacidad de desarrollo.

- *Adolescentes*

Muchos adolescentes con cáncer se quejan de que sus padres les sobreprotegen, especialmente porque se encuentran en un momento de su vida donde por naturaleza quieren sentirse independientes, pero por su enfermedad se ven ligados a sus padres más que nunca. Ellos quieren tomar sus propias decisiones incluso, a veces, por encima de la opinión de los especialistas (hitsett *et al.*, 1999).

Su necesidad de vida privada, tanto física como emocional, es otro aspecto a tener en cuenta. Deben enfrentarse a problemas de identidad, de sexualidad, de posible infertilidad y de muerte. Ellos saben que no todos los pacientes con cáncer sobreviven (generalmente por haber vivido el problema en un familiar), presentando crisis periódicas (visitas en el seguimiento ante posibilidad de recaída) (Pac er, 1995). La inmensa mayoría de adolescentes con cáncer demuestran gran madurez, mayor de la esperada para su edad, adaptándose de forma excepcional a estas circunstancias.

c) *Hermanos/as*

Algunos hermanos de niños con cáncer pueden tener recelo, con sentimiento de abandono por parte de los padres. Durante el periodo de hospitalización o cuando el niño no se encuentra bien, toda la atención recae sobre él y por tanto ellos se sienten desatendidos (Randolph *et al.*, 1999). Los padres deben intentar prestar la misma atención al hermano/a que le prestaban antes. Hay que hablar con ellos y hacerles comprender lo que ocurre y pasar también tiempo con ellos. Hay que demostrar que lo de ellos también interesa al resto de la familia (aufman *et al.*, 1992).

Otros, en cambio, centrarán toda su atención en su hermano/a enfermo. No es extraño, todo el mundo lo hace, padres, abuelos, tíos, vecinos. Hay que hablarles del trato hacia el niño enfermo hacerle entender que todo lo que él siente es natural, y que comparta sus sentimientos con el resto de la familia. Una manera de hacerles entender la enfermedad de su hermano/a es haciéndoles partícipes de todo el proceso. Los más mayores agradecen en particular el hecho de que sus padres confíen en ellos, les consulten y les cuenten detalles de la enfermedad. Buscar tareas que ellos puedan hacer por su hermano/a o por sus padres les da confianza para sentirse útiles en todo este proceso. Pueden también acompañar a su hermano/a al hospital. Esto les enseña cómo es lugar donde cuidan a su hermano/a. Si esto no fuera posible, hay que contárselo, mantenerlo al día. Ne-

cesitan que se les explique todo para que ellos no se lo imaginen de un modo equivocado. Sus compañeros de clase les preguntarán sobre la enfermedad de su hermano/a y ellos han de estar preparados para contestar a las cuestiones que les planteen (aza, 1999; aufman *et al.*, 1992).

Otros hermanos/as presentan cambios en su comportamiento, pueden sentirse deprimidos, tener dolores de cabeza, o problemas con los estudios (hitsett *et al.*, 1999). Es importante informar a sus profesores de la situación familiar.

d) Resto de la familia y amigos

Un diagnóstico de cáncer en un niño no solo afecta a los padres y hermanos, sino también a los abuelos, parientes y amigos. Toda esta gente puede aportar mucho apoyo y ayuda. Pueden cuidar de los otros hermanos, quedarse con el niño enfermo para que los padres descansen, etc. (hitsett *et al.*, 1999) Desafortunadamente, no siempre ocurre así. Los abuelos suelen sentirse completamente perdidos y desconsolados con esa enfermedad en su propio nieto/a. Si estos no pueden aceptar o entender la situación, habrá que buscar una manera de mantenerlos al margen. Pueden también hablar con el equipo médico y de enfermería para que les expliquen la situación. A algunos incluso hay que hacerles mucho hincapié en que no es una enfermedad contagiosa (aufman *et al.*, 1992).

Con intención de ayudar, los amigos te llenarán de consejos, la mayoría desafortunados. Siempre hay que consultar con el personal de la Unidad Pediátrica.

ACERCA DEL PRESENTE FUTURO

Curar a un niño con cáncer es salvar toda una vida. Se calcula que la curación de un niño oncológico se traduce en una ganancia de 74 años de vida (en el adulto es de 13 años) (McRedmond, 1998; Rice, 1994).

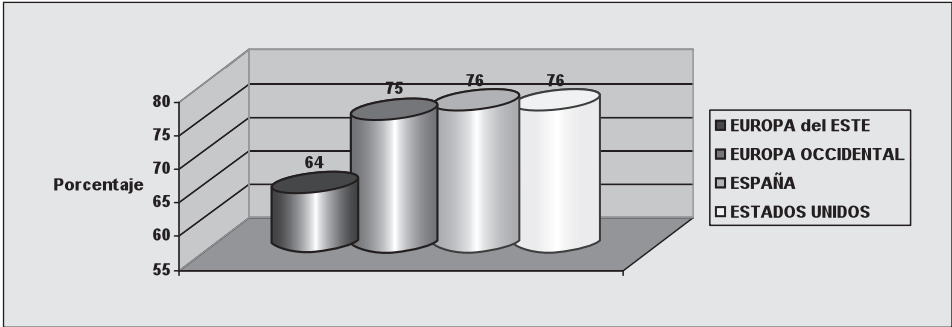
El Registro de Tumores Infantiles de la Comunidad Valenciana (RTICV) es un sistema de información sobre cáncer infantil, de base poblacional, cuya cobertura se extiende a toda la Comunidad. Contribuye al control del cáncer infantil. Los resultados que proporciona son indicadores de incidencia y de efectividad de la asistencia (indicadores de supervivencia).

Según datos publicados en el Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana 2007-2010, la supervivencia del cáncer infantil a cinco años en la Comunidad Valenciana, en el periodo 1992-2000 es del 73,4 (IC : 69,9-77,12) y es equiparable a la de los registros europeos de nuestro entorno como Alemania (74), Francia (70) e Italia (66).

En la Tabla 16.3 se recoge la supervivencia en España, y en la Figura 16.2 la supervivencia comparada con Europa y Estados Unidos, según informe estadístico del Registro Nacional de Tumores Infantiles y la Sociedad Española de Oncología Pediátrica (RNTI-SEOP) (Gatta *et al.*, 2003).

Ta la Supervivencia España a cinco años de tumores infantiles. Periodo 1980-2006. RNTI-SEOP.

Leucemias	79
Sistema Nervioso Central	68
Enfermedad de Hodg in	91
Linfoma no Hodg in	77
Tumores Oseos	66
Tumores Hepáticos	55
Tumores Renales	90
Retinoblastoma	97



Fi ura Supervivencia a 5 años de tumores infantiles. RNTI-SEOP.

En el Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana 2007-2010, publicado recientemente, se recogen en el ámbito de la esfera pediátrica, los siguientes objetivos estratégicos (Ob. Et.) y objetivos específicos (Ob. Ep.):

- Ob. Et. 1: Asegurar la atención multidisciplinar a los niños y adolescentes diagnosticados de cáncer, en Unidades Multidisciplinares de Oncología-Hematología específicas que cumplan los requerimientos de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) y de la Sección de Hematología-Oncología de la Academia Americana de Pediatría (AAP).
- Ob. Ep. 1: Creación de Unidades Funcionales de Oncología/Hematología para adolescentes con cáncer en los hospitales donde existen Unidades de Oncología Pediátrica.
- Ob. Ep. 2: Elaborar protocolos multidisciplinarios para la atención de niños y adolescentes con cáncer.

Ob. Ep. 3: Disponer de Unidades de Hospitalización Domiciliaria en los tres hospitales de referencia de Oncología Pediátrica.

Ob. Et. 2: Mejorar la atención psicosocial de los niños y adolescentes con cáncer, incluyendo la atención neuropsicológica en los enfermos con tumores cerebrales.

Ob. Ep. 1: Garantizar la atención psicológica de los niños y adolescentes con cáncer, incluyendo el diagnóstico y tratamiento de los déficit neuropsicológicos secundarios a la enfermedad o sus tratamientos.

Ob. Ep. 2: Facilitar el acompañamiento de los niños con cáncer ingresados en los hospitales.

Una vez finalizado el tratamiento, el niño será sometido a diversas revisiones periódicas. En esas revisiones se realiza una exploración física completa y aquellas pruebas oportunas para poder conocer con exactitud la situación del niño. Las revisiones van encaminadas al diagnóstico precoz de una posible recaída de la enfermedad, a la valoración y tratamiento de las posibles secuelas y a evaluar la situación psicológica del niño y de su familia.

Está descrito el *síndrome de Damocles* en el que los padres y pacientes adolescentes temen que en cualquier momento vuelva la enfermedad viviendo con una tensa angustia los días previos a una revisión médica en espera de su resultado (aza, 1993). Con el tiempo, a veces con ayuda, la inmensa mayoría de familias superan sin problemas el paso del cáncer por sus vidas y que un gran porcentaje de niños / as se adaptan a la vida sin ningún tipo de secuelas (ni físicas ni psíquicas), y muchos cumplen sus objetivos en la vida como trabajar o formar su propia familia (McRemond, 1998). Para la medición de la calidad de vida en un niño oncológico se utiliza la escala de Lans y (Lans y *et al.*, 1985), que valora del 0 al 100 el grado de discapacidad frente al juego producido por la enfermedad.

Respecto al futuro señalar que existen motivos para el optimismo, que dentro de unos años se curarán más casos que en la actualidad. Desde 1974, se ha observado que las cifras de curación se han incrementado en un 3-4 cada tres años (Halperin *et al.*, 1999).

En este sentido, serán varios los factores que mejorarán las cifras de curación. Entre ellos:

- La aplicación generalizada de la terapia génica.
- El perfeccionamiento de la radiocirugía para tumores cerebrales.
- La aparición de quimioterápicos más eficaces y menos tóxicos.
- El desarrollo de fármacos radio/quimioprotectores de células sanas.
- La aparición de campañas de detección precoz de cáncer infantil.
- La llegada de una vacuna eficaz.
- La aplicación de anticuerpos monoclonales en la esfera pediátrica.

PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO PRECOZ EN EL CÁNCER PEDIÁTRICO

Los avances sanitarios, sociales, económicos y culturales de los países desarrollados han determinado que la mortalidad por otras causas (infecciones, malnutrición) haya disminuido extraordinariamente y que el cáncer haya adquirido una mayor relevancia.

Actualmente, esta preocupación parece interesar a los gobiernos que intentan poner en práctica diversas medidas, sobre todo de educación sanitaria, para conseguir una disminución en el número de cánceres.

Están descritos tres tipos de prevención en las enfermedades neoplásicas:

Primaria pretende que no aparezcan tumores por eliminación o neutralización de las causas que pueden provocarlos.

Secundaria orientada a hacer un diagnóstico lo más temprano posible, minimizando así el riesgo de mortalidad y las complicaciones del tratamiento.

Terciaria su objetivo es optimizar los tratamientos para obtener las máximas respuestas, disminuir las complicaciones del tumor o de su terapia y tratarlas si se hubieran producido.

Prevención primaria

No es aplicable a la población infantil, porque la mayoría de las neoplasias están relacionadas con diversos estilos de vida (tabaco, alcohol, exposición solar, dietas inadecuadas, exposición a tóxicos, etc.).

Prevención secundaria

Cuando los mecanismos de prevención primaria no son posibles, y se ha producido la enfermedad, la única posibilidad preventiva es realizar un diagnóstico precoz. Para ello es fundamental dar a conocer las señales de alarma que pueden estar en relación con el cáncer infantil. Se pueden resumir en:

- A nivel ocular: reflejo blanquecino, estrabismo, ceguera, protusión ocular.
- Aparición de masa o inflamación en abdomen, pelvis, cuello, extremidades, testículos, ganglios.
- Aparición inexplicable de fiebre prolongada, pérdida de peso o del apetito, palidez, cansancio, sangrados espontáneos o hematomas con facilidad.

Dolor en huesos, articulaciones, espalda, fractura ante mínimo traumatismo.

A nivel neurológico: cambios en el comportamiento, en el equilibrio, en la marcha, dolor de cabeza persistente acompañado de vómitos o agrandamiento craneal.

Preención terciaria

Se entiende por tal, la vigilancia de los enfermos previamente diagnosticados y tratados por una neoplasia. En realidad es equiparable a las revisiones periódicas que se planifican, y su objetivo es el diagnóstico y tratamiento precoz de las posibles recaídas y/o complicaciones provocadas por el tratamiento del tumor.

CÁNCER UN PROBLEMA GLOBAL

Según datos de la OMS, en 2005, de 58 millones de defunciones registradas en todo el Mundo, 7,6 millones se debieron al cáncer.

Más del 70 % de todas las muertes por cáncer se producen en países en vías de desarrollo, donde los recursos disponibles para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad son limitados o inexistentes.

Se prevé un aumento de las muertes por cáncer hasta aproximadamente 9 millones en 2015, y 11,4 millones en 2030.

Se calcula que más de 160.000 niños en todo el mundo son diagnosticados de cáncer cada año de los que fallecen 90.000, y estas cifras podrían ser considerablemente superiores. Los datos sobre la incidencia del cáncer infantil en los países desarrollados, son en su mayoría imprecisos. Son necesarios más registros de cáncer por población para determinar el número de niños con cáncer.

El 80 % de los pacientes infantiles con cáncer viven en los países en desarrollo, y esta proporción crecerá a medida que se eliminan las enfermedades infecciosas.

La supervivencia a cinco años en los países desarrollados está al torno del 75 %. En los países en desarrollo, más del 50 % tienen probabilidad de morir.

CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER

Adoptando un estilo de vida sano mejorará su estado general de salud y evitará algunos tipos de cáncer:

1. No fume. Si es fumador, deje de fumar lo antes posible y no fume en presencia de otras personas. Si no fuma, no pruebe el tabaco.
2. Si bebe alcohol, ya sea cerveza, vino o licores, modere su consumo.
3. Aumente el consumo diario de verduras y frutas frescas. Coma a menudo cereales con alto contenido en fibra.
4. Evite el exceso de peso, haga más ejercicio físico y limite el consumo de alimentos ricos en grasas.
5. Evite las exposiciones prolongadas al sol y las quemaduras solares, especialmente durante la infancia.

6. Respete estrictamente las normas destinadas a evitar cualquier tipo de exposición a sustancias consideradas cancerígenas. Cumpla todas las instrucciones de salud y seguridad en relación con las sustancias que pueden provocar cáncer. Con una detección precoz es posible curar más casos de cáncer.
7. Consulte al médico si nota algún bulto, una herida que no cicatriza (incluso en la boca), un lunar que cambia de forma, tamaño o color, o cualquier pérdida anormal de sangre.
8. Consulte al médico en caso de problemas persistentes, tales como tos o ronquera permanentes, cambio en sus hábitos intestinales, alteraciones urinarias o pérdida anormal de peso.
9. Para mujeres: hágase un frotis vaginal regularmente. Participe en los programas organizados de detección precoz del cáncer de cérvix.
10. Para mujeres: examine periódicamente sus senos. Si ha cumplido 45 años de edad, participe en los programas de detección precoz del cáncer de mama.

BIBLIOGRAFÍA

- Abuchaibe O, Calvo FA. La radioterapia en oncología pediátrica. En: *Oncología Pediátrica*. Madrid. McGraw-Hill - Interamericana de España, 1992. 81-131.
- Aerts I *et al.* Retinoblastoma. *Orphanet J Rare Dis*. 2006. 1:31.
- Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Publicación 144. <http://fr/accis/data.htm>
- Automated Childhood Cancer Information System. <http://fr/accis/data.htm>
- Benito C *et al.* Papel de la cirugía en el tratamiento de los tumores sólidos pediátricos. En: *Oncología Pediátrica*. Madrid. McGraw-Hill - Interamericana de España, 1992. 52-80.
- Camprubí A. Efectos de la música en niños con neoplasia, *Rev ROL Enf*. 1999. 22:293-8.
- Chang MH *et al.* Maternal transmission of hepatitis B virus in childhood hepatocellular carcinoma. *Cancer*, 1989. 64:2377-80.
- Constine LS *et al.* Pediatric radiation oncology - subspecialty training? *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 1992. 24:881-4.
- Davis M *et al.* Infant feeding and childhood cancer. *Lancet*, 1988. 2:365-8.
- Del Moral E. Seguimiento en atención primaria del niño oncológico. Secuelas tardías. *Pediatr. Integral*. 2004. VIII (6): 513-23.
- Doll R, Peto R. *The causes of cancer*. New York, Oxford University Press. 1981.
- Dorgan CA. *Statistical record of health medicine*. New York: Gale Research Inc.: 49, 1995.
- Fal PM. Cancers in children. En: Casciato, D.A. (ed.): *Manual of clinical oncology*. Boston / Toronto. Little, Brown and Company. 1988. 272-81.
- Finch SC. Leukemia and lymphoma in atomic bomb survivors. En: Boice, J.D., Fraumeni, J.F. (eds.): *Radiation carcinogenesis: Epidemiology and biological significance. Progress in cancer research and therapy*, vol. 26. New York, Raven Press. 1984. 37-44.
- Gallo RC, Gelman E. In search of Hodgkin's disease virus. *N Engl J Med*. 1981. 304:169-73.
- García-Miguel P. Oncología pediátrica. En: González Barón, M. (ed.). *Oncología Clínica*. Madrid. McGraw-Hill - Interamericana. 1998. 615-30.
- Gatta G *et al.* Childhood cancer survival in Europe. *Annals Oncology* (supplement 5) 2003. v119-v127.

- Giammona AS *et al.* Efectos psicológicos del cáncer de niños en la familia. *Pediatr Clin North Am.* 2002. 5:1025-42.
- Giráldez J *et al.* Quimioterapia antitumoral (I). Conceptos generales de la quimioterapia. En: *Oncología pediátrica*. McGraw-Hill - Interamericana de España, 1992. 132-48.
- Halperin EC *et al.* The cancer problem in children. En: *Pediatric radiation oncology*. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 1999. 1-9.
- Halperin EC *et al.* Retinoblastoma. En: *Pediatric radiation oncology*. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 1999. 126-62.
- Halperin EC *et al.* Leukemia. En: *Pediatric radiation oncology*. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 1999. 10-36.
- Halperin EC *et al.* Supratentorial brain tumors. En: *Pediatric radiation oncology*. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 1999. 37-79.
- Halperin EC *et al.* Brain Tumor. En: *Pediatric radiation oncology*. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 1999. 343-72.
- Hammond DG: The cure of childhood cancers. *Cancer.* 1986. 58:407-13.
- Israel MA. Pediatric oncology: Model tumours of unparalleled import. *JNCI.* 1989. 81:404-8.
- Johnson J *et al.* Parental and infant characteristics and childhood leukemia in Minnesota. *BMC Pediatr.* 2008. 8:7.
- Kaufman L *et al.* The availability of psychosocial interventions to children with cancer and their families, *Child Health Care.* 1992. 21:21-5.
- Kazak AE. Psychological research in pediatric oncology, *J Pediatr Psychol.* 1993. 18:313-8.
- Kazak AE. Effective psychosocial intervention for children with cancer and their families, *Med Pediatr Oncol.* 1999. 32:292-3.
- Lansky LL *et al.* Toward the development of a play performance scale for children (PPSC), *Cancer.* 1985. 56:1837-40.
- Laughton SJ *et al.* Endocrine outcomes for children with medulloblastoma treated with craniospinal and conformal primary site irradiation on the SJMB96 trial. *Neuro-oncol.* 2007. April 9(2):169-221.
- Lele PP *et al.* Chromosome deletion in a case of retinoblastoma. *Ann Hum Genet.* 1963. 27:171-4.
- Li FP *et al.* Questionnaire study of cancer etiology in 503 children. *JNCI.* 1986. 76:31-6.
- Linsell A. A mycotoxin as a human health hazard. En: Davis, (ed.): *Human cancer. Its characterization and treatment. Vol. 1 of advances in tumour prevention, detection and characterization.* Amsterdam, Excerpta Medica. 1980. 114-20.
- Lopez J *et al.* The treatment results in children with malignant mesenchymal tumours according to the protocols of the International Society of Pediatric Oncology, *Ann. Esp. Pediatr.* 1996. 44:557-60.
- López-Ibor B. Neuroblastoma. En *Oncología pediátrica*. Madrid. McGraw-Hill - Interamericana de España. 1992. 467-501.
- Madero L *et al.* G-CSF after autologous bone marrow transplantation for malignant diseases in children. *Bone Marrow Transplant.* 1995. 15:349-51.
- McCarthy S, *et al.* Gonadal dysgenesis with adenocarcinoma of endometrium: An electron microscopic and steroid receptor analysis with a review of the literature, *Cancer.* 1978. 42:512-20.
- McRedmond P. Progress and promise in pediatric oncology, *J. S. C. Med. Assoc.* 1998. 94:263-4.
- Menegaux F *et al.* Day care, childhood infections, and risk of neuroblastoma. *Am J Epidemiol.* 2004. May; 159(9):843-51.
- Midraelis J. Clinical trials and cooperative studies. En: *Cancer in children*. Berlín, Springer, Verlag, 1996.

- Miller R. . Neoplasia and Down's syndrome. *Ann N Acad Sci.* 1970.171:637-44.
- Miller AB *et al.* Diet in the etiology of cancer: a review. *Eur J Cancer.* 1994. 30:207-20.
- Morro RH. Burkitt's lymphoma. En: Schottenfeld D. y Fraumeni, J.F.: *Cancer epidemiology and prevention*. Philadelphia, Saunders. 1982. 779-94.
- Mossman BT, Gee JB. Asbestos related diseases, *N Engl J Med.* 1989. 320:1721-30.
- Mulvihill JJ. Congenital and genetics diseases. En: Fraumeni, J.F. (ed.): *Persons at high risk of cancer. An approach to cancer etiology and control*, New York, Acad. Press, 3-37. 1975.
- Mulvihill JJ *et al.* Hepatic adenoma in Fanconi anemia treated with oxymetholone. *J Pediatr.* 1975. 87:122-4.
- Muñoz A. Trasplante de médula ósea. En: *Oncología pediátrica*. McGraw-Hill - Interamericana de España. 1992. 232-51.
- Muñoz A. La oncología pediátrica. En: *Libro blanco de la oncología en España*. 1995. 145-58.
- Murphy SB. The national impact of clinical cooperative group trials for pediatric cancer, *Med Pediatr Oncol.* 1995. 24:279-80.
- Oppenheim D. Psychoanalytic study at a pediatric oncology department, *Arch Fr Pediatr.* 1990. 47:425-8.
- Packer RJ. An overview of pediatric oncology as a model for interdisciplinary care, *Childs Nerv Syst.* 1995. 11:13-6.
- Parsons S *et al.* Evaluation of quality of life of childhood cancer survivors: a methodological conundrum, *Med Pediatr Oncol.* 1998. 1:46-53.
- Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana 2007-2010. <http://dgsp.san.gva.es>
- Pritchard-Jones M. Controversies and advances in the management of childhood Tumours. *Arch Dis Child.* 2002. September 87(3):241-44.
- Randolph AG *et al.* Variability in physician opinion on limiting pediatric life support, *Pediatrics.* 1999. 103:46.
- Raney BJr *et al.* The role of the American Association for cancer education in pediatric oncology: results of a survey, *J Cancer Educ.* 1990. 5:17-9.
- Rice MS. Progress in childhood cancer: can it be maintained?, *Med J Aust.* 1994. 160:326-31.
- Robboy SJ. A hypothetic mechanism of DES induced anomalies in exposed pregnancy, *Human Pathol.* 1983. 14:831-3.
- Roebuck DJ *et al.* 2005 PRETEXT: a revised staging system for primary malignant tumours of childhood developed by the SIOPEL group. *Pediatr Radiol.* 2007. Feb; 37(2):123-32.
- Rudant J *et al.* Household exposure to pesticides and risk of childhood hematopoietic malignancies: The ESCALE Study (SFCE). *Environ Health Perspect.* 2007. December; 115(12):1787-93.
- Salas M *et al.* Los cuidados paliativos pediátricos: Un modelo de atención integral al niño gravemente enfermo y a su familia, *An Pediatr.* (Barc) 2004. 61:330-5.
- Sasaki U *et al.* Occurrence of acute lymphocytic leukemia in a boy treated with a growth hormone for growth retardation after irradiation of a brain tumour. *Jpn J Clin Oncol.* 1988. 18:81-4.
- Serna D, Azorín M. Protocolo y registro del apoyo emocional al ingreso del niño oncológico. En: *IV Jornadas de Enfermería -Humanizar el producto enfermero-*. Alicante, Noviembre 1998.
- Sherman S, Roizen N. Fetal hydantoin syndrome and neuroblastoma. *Lancet.* 1976. 2:517.
- Shore RE *et al.* Thyroid tumours following thymus irradiation. *JNCI.* 1985. 74: 1177-84.
- Sierrasesúmaga L *et al.* Introducción a la oncología pediátrica. Aspectos generales. En: *Oncología Pediátrica*. Madrid. McGraw-Hill- Interamericana de España. 1992. 1-20.
- Stillier CA. Centralization of treatment and survival rates for cancer, *Arch Dis Child.* 1988. 63:23.

- Stjernfeldt M *et al.* Maternal smoking during pregnancy and risk of childhood cancer. *Lancet*. 1986. 1:1350-52.
- Thomas P. Lymphomas in children. En: Pérez, C.A. (ed.): *Principles and practice of Radiation Oncology*. Lippincott, Philadelphia. 1992. 1467-75.
- Tucker MA *et al.* Bone sarcoma linked to radiotherapy and chemotherapy in children. *N Engl J Med*. 1987. 317:588-93.
- Tyc VL *et al.* A survey of pain services for pediatric oncology patients: their composition and function, *J Pediatr Oncol Nurs*. 1998. 15:207-15.
- Van Dijk J *et al.* Health-related quality of life of child and adolescent retinoblastoma survivors in the Netherlands. *Health Qual Life Outcomes*. 2007. 5:65.
- Wagner HP *et al.* The problem of pediatric malignancies in the developing world, *Ann N Acad Sci*. 1997. 824:193-204.
- Wang SS *et al.* Family history of hematopoietic malignancies and risk of non-Hodgkin lymphoma (NHL): a pooled analysis of 10211 cases and 11905 cases from the International Lymphoma Epidemiology Consortium (InterLymph). *Blood*. 2007. April 15: 109(8):3479-88.
- Weimberg KI, Parkman R. Interface between immunodeficiency and pediatric cancer. En: Pizzo, P.A. (ed.): *Principles and practice of pediatric oncology*, cap 4. Lippincott, Philadelphia. 1988.
- Whitsett SF *et al.* Meeting impossible psychosocial demands in pediatric oncology: creative solutions to universal challenges, *Med Pediatr Oncol*. 1999. 32:289-91.
- Young JL, Miller RW. Incidence of malignant tumours in US children. *J Pediatr*. 1975. 86: 254-8.
- Young JL *et al.* Cancer incidence, survival and mortality for children younger than 15 years. *Cancer*. 1986. 58: 598-602.
- Young JL, Percy CL, Asire AJ (eds.): Surveillance, epidemiology and end results: Incidence and mortality data 1973-1977. *Natl Cancer Inst Mono*. 1981. 57.79.

EDIOS DE COMUNICACIÓN VIOLENCIA SUICIDIO EN LA INFANCIA ADOLESCENCIA

Antonio Germán Alcántara Lapaz

“Debemos alimentar una cultura que fomente el crecimiento y desarrollo saludable de los niños, que neutralice las fuerzas sociales desestabilizadoras y que busque construir una convivencia más generosa, más justa, más ecuménica, más participativa y más esperanzadora. Necesitamos cambiar el modo de vernos y tratarnos unos a otros.”

LUIS ROJAS MARCOS. Las semillas de la violencia.

INTRODUCCIÓN REFLEXIÓN SOBRE LA EPISTEMOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS A TRAVÉS DEL AMBIENTE CULTURAL

Antes que nada, debemos distinguir entre lo que son conductas consecuencia de enfermedades psiquiátricas y aquellas que, aunque desviadas, están a medio camino entre la libertad del individuo y los condicionamientos socioambientales en los que vive inmersos. Sobre todo esto, los medios de comunicación actúan de una forma tan intensa como no se ha dado en ningún otro periodo de la historia de la humanidad.

Quizás el problema sea menos que algunos enfermos mentales tomen para sus delirios ciertos temas culturales que se exhiben en los medios de comunicación y siguiendo estos patrones se conduzcan de forma violenta. Esto es inevitable y se ha dado a lo largo de toda la historia, simplemente antes se era Napoleón y ahora se es Rambo. De estos casos a menudo se dice que se ha vuelto loco por tal o cuál película, cuando en realidad suele ser al revés, de modo que el loco toma un tema o un personaje de una película y lo sigue (ejemplo de esto es el atentado que en 1981 sufrió Reagan

a manos John Hinc ley, un esquizofrénico fascinado por la película *Taxi Driver*). Aunque algunos de estos pacientes puedan llevar a cabo actos muy agresivos y dramáticos, con gran repercusión mediática, estos, en cifras globales, no son frecuentes. Es evidente que se genera un gran miedo en la opinión pública ante las conductas de algunos enajenados (al mismo tiempo que fascinación, y si no vean el éxito de algunas películas, de la que *Seven* es un buen ejemplo), sin embargo soy de la opinión de que no constituyen el principal problema en cifras cuantitativas. Estas conductas no las podemos obviar en tanto en cuanto sigan habiendo enajenados y los médicos seamos incapaces de curarlos (lo que parece que va a seguir así durante bastante tiempo), por lo que siempre existe la posibilidad de que los medios de comunicación alimenten (sin relación de causalidad) los delirios de los enfermos. Creo que más importante que esto es el impacto de la exposición a la violencia (en todas sus manifestaciones) sobre la población general, y en especial sobre los más moldeables, los más jóvenes. El tema va más allá de la psiquiatría entrando en la salud pública, la psicología, la pedagogía, la antropología o la sociología.

Aunque el título recoge el término genérico de medios de comunicación, nos vamos a centrar en la televisión y en los avances de la informática, ya que, en esencia, son los medios que más llegan a la población infanto-juvenil. Otros medios de relevancia como la música, suelen apoyarse en la televisión para su difusión.

La importancia de la televisión reside, entre otras cosas, en la capacidad de transmitir una cultura de una forma casi inmediata y de globalizarla. Además introduce unos patrones uniformes, que resultan excluyentes, de manera que lo que se muestre por este medio, podríamos decir que casi no existe. Gracias a su inmediatez, la televisión logra imponerse, adelantándose a otros modos de transmisión cultural menos ágiles, como pueden ser la tradición oral o la lectura, fomentando la pasividad en la persona receptora. La globalización (o quizás mejor uniformización) que impone se refleja en que, en el mundo occidental, todos los niños y adolescentes ven las mismas películas, series televisivas y dibujos animados; de este modo, en una cultura se insertan elementos de otra completamente ajena. En tanto en cuanto la televisión contribuye a modelar el ámbito cultural, ésta es importante para la Psiquiatría en general. Para que nos hagamos una idea del poder de la televisión podemos considerar los efectos de la publicidad del tabaco sobre su consumo. Así, podemos ver que en Estados Unidos existe una relación positiva entre el mayor gasto de publicidad y el mayor consumo de tabaco de una marca.

No podemos obviar el hecho de que la televisión (y otros negocios audiovisuales) es una creación de la humanidad, y por lo tanto, reflejo también de la condición humana. En un sistema de mercado como en el que vivimos, la calidad de ciertas empresas no se mide según la bonanza de sus productos, sino en sus ventas. Es por esto que la televisión, como negocio que es a fin de cuentas, acude a aquello que más vende. Parte del problema reside en la oferta de violencia de la televisión, pero la demanda de violencia por parte del público debe hacernos reflexionar desapasionadamente y sin intenciones moralizantes. No debemos rasgarnos las vestiduras al afirmar que a la gente, impersonal y en masa, le fascina la violencia, le excita la pornografía o le produce morbo la muerte ajena. Las cifras de ventas están ahí para demostrarlo. Otro tema sería si esta exhibición es buena para los espíritus en formación, valor que

no cotiza en bolsa, de las generaciones más jóvenes. Poco nos importa educar libre-pensadores en una sociedad que necesita individuos que consuman pasivamente, con espíritu escasamente crítico. Sumándose a esto, la realidad de la competencia entre diversos productos televisivos hace que las cadenas se embarquen en una carrera de a ver quién es capaz de llamar más la atención, con lo que se alcanzan cotas inauditas de atrocidades y se satura cada vez más al televidente. Esto da lugar a que nos hayamos acostumbrado a la muerte, pero de una forma ajena, como si eso no pudiera ir con nosotros. La gente se queda igual de impávida ante los muertos de la película del héroe americano de turno o ante los cadáveres destrozados de un mercado de Grozni. Yo me pregunto si los niños son capaces de establecer una distinción clara y si no acaban ahitos de muerte, indiferentes ante tanta víscera.

El culmen de este proceso no se refleja en películas o dibujos animados, sino en la realidad misma. Solo así se puede entender el reciente éxito de programas que muestran situaciones violentas de la vida real; como ejemplo tenemos ese programa televisivo que, en horario de tarde, muestra auténticas persecuciones policíacas en las que, incluso, se pueden ver muertes reales en tiroteos. Se supone que las empresas televisivas tienen códigos de autorregulación que incumplen con regularidad en función de los niveles de audiencia. No puedo entender qué interés informativo puede tener el ver a una persona morir a tiros con la policía, fuera del morbo y de alimentar una necesidad de atrocidades cada vez mayor. Con esto vengo a decir que no es cuestión de anatemizar a la televisión diciendo qué malos y retorcidos que son sus directores, y nosotros ¿qué?, ¿qué hacemos los que tenemos la capacidad de encender o apagar este chisme? El público no deja pues de tener su parte de responsabilidad en lo que se ve en la televisión, porque a muchos de ellos les gusta, porque simplemente lo demandan; como ya hemos dicho antes, es parte de la condición humana. Es curioso como a pesar de la preocupación manifiesta en diversos ámbitos de la sociedad, la violencia en la televisión no ha decrecido, sino más bien ha aumentado. No olvidemos que siempre podemos optar por no encender la televisión. Sin querer levantar un motín contra nada, quisiera recordar que hay personas que han tomado decisiones con respecto a la vida cotidiana que nos parecerían radicales. En mis tiempos mozos tenía un compañero cuyos padres decidieron no tener televisión en casa; sonaba tan raro aquello, y sin embargo aquel chico no era diferente de todos nosotros.

No creo que el fenómeno de la violencia en los medios de comunicación deba entenderse como si tal o cual película o programa pueda ser o no violento. Lo que se muestra en los medios de comunicación no deja de ser un reflejo de la sociedad y por lo tanto expresión de un ambiente hostil y agresivo.

La informática se ha introducido en nuestra vida cotidiana en casi cualquier actividad, cosa que, hace un par de décadas, apenas podíamos sospechar. Nos proporciona importantes herramientas de trabajo y su aprendizaje debe recogerse en la formación de todos los niños, no solo con ideas meramente utilitarias, sino como un procedimiento capaz de desarrollar las capacidades y la creatividad de los niños. El desarrollo de Internet y toda la constelación de aplicaciones informáticas han venido a añadir un nuevo elemento a los aportados por la televisión, esto es, la virtualidad. Esto ya no supone imaginar o fantasear mundos diferentes, sino la mucho más poderosa sensación de experimentarlos, y no solo esto, sino además dirigirlos, gobernarlos y volver atrás

cuantas veces deseemos las realidades que queramos introducir en nuestros ordenadores. Internet difiere con la televisión en que permite a casi cualquiera difundir información con muy pocos medios y sin pasar ningún tipo de filtro o control a propósito de su calidad u oportunidad, más que la del internauta que decide lo que consume.

Como muestra de hacia dónde vamos vale un botón. Aquí tenemos una de realidad virtual. A finales de los noventa del siglo pasado se puso de moda el *tamagotchi*, la mascota virtual. Creo que todos sabemos de lo que hablo, ya que era inevitable tener algún crío de la familia que pedía la mascota de marras. El chisme consiste en mínimo ordenador con una pantalla donde “vive” un perrito virtual que hay que sacar a pasear, alimentar y hasta jugar con él. Si no se cuida al animalito, éste se “muere”. El truco reside en que el chisme tiene un botoncito por detrás en el que se puede “resucitar” a la mascota. Ya no hay solamente mascotas virtuales, sino que incluso la misma muerte es virtual. No sabemos qué hubiera escrito Jardiel Poncela en vez de “Cuatro corazones con freno y marcha atrás” de haber llegado a vivir estas cosas.

La exposición sistemática a la violencia y a la muerte tiene el efecto de acostumbrarnos a ello, se convierten en un hecho habitual y en ocasiones algo sin importancia, incluso divertido y casi deseable. Además, la continua contemplación de las pocas consecuencias de estas conductas y de su reversibilidad sitúan a estas experiencias en un ámbito fantástico, quizá fantasioso sería mejor, que se despegan de la realidad, y por lo tanto de sus consecuencias. Es por esto que la violencia está dejando de ser considerado como un problema puntual de algunas personas para empezar a plantearse en términos de un problema de salud pública.

Se ha postulado que el impacto en población general de la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación sigue un patrón de aprendizaje mediante modelaje. Esto sigue el planteamiento de la teoría del aprendizaje social que Bandura estableció en los años 70, consistente en la adquisición de un nuevo patrón de conducta a través de la observación de uno o más modelos. Este paradigma entiende que el aprendizaje no solo es producto de la exposición a los modelos, sino que también participan variables complejas aportadas por el observador, como puede ser la autoestima. De esto podemos extraer el concepto de que podemos tener una población con una sensibilidad y vulnerabilidad diferente a los estímulos de violencia. No estamos ante una mera imitación o repetición, sino que se adquiere una estrategia de respuesta que puede desencadenarse, incluso aunque transcurra un periodo de tiempo importante, a menudo en respuesta a situaciones motivacionales cargadas de afecto y emotividad. Para el tema que nos ocupa, uno de los factores más importantes, aparte de la mera imitación, es la identificación que haga el joven con el modelo; la edad infanto-juvenil puede entenderse como una época de desarrollo a la búsqueda de un modelo propio, cosa que a menudo se realiza estableciendo identificaciones con otras personas, del ámbito cercano, pero también personajes públicos, los ídolos, difundidos por los medios de comunicación o las muy particulares relaciones que se pueden establecer a partir de la novedosa intimidad que supone Internet.

No podemos dejar de lado el tema de las emociones. La contemplación de la violencia por un medio de comunicación no es solo la mera exposición a la violencia, también conlleva la experimentación de una emoción por parte del espectador. Las

emociones de carga negativa o desagradable que puedan experimentar los niños los convierten en personas insatisfechas y frustradas, tendentes pues a la irritación y a la respuesta con angustia y agresividad. La experimentación repetida de estas emociones hace que se sedimenten y así se puedan incorporar a la personalidad. Es conocido de hace tiempo el que los adolescentes, hasta que no madura y se conforma su carácter, tienden a vivirse a sí mismos como invulnerables y omnipotentes. Hay quién ha planteado que la vulgarización de la violencia y la muerte en los medios de comunicación no hacen sino potenciar estos aspectos, normales por otra parte pero que tampoco se pueden potenciar *ad infinitum*, de manera que si los críos no se pueden desprender de esto, en cierto modo se convierte en un proceso de infantilización fantasiosa con una imagen poco realista de lo que la violencia y la muerte viene a ser.

Frente a la teoría de la estimulación de las conductas agresivas ante su exhibición ha surgido la de la catarsis, de modo que la contemplación de la violencia reduciría en el observador la posibilidad de esta conducta en la vida real. Esta última teoría parece más rechazable que la de la estimulación.

Querría hacer una salvedad antes de continuar. Aunque existe un volumen grande de documentación basada sobre todo en opiniones personales (a veces altamente especulativas, de las que la mía no dejaría de ser una más), deberíamos prestar atención a los estudios de carácter científico con una metodología rigurosa. La mayor parte de los datos que se presentan están basados en los estudios alemanes, británicos y estadounidenses, que son los que más preocupación han mostrado por el tema desde los años 70. Estos datos han de ser relativizados al ámbito social en el que se dan, aunque las sociedades están cada vez más entremezcladas a través de los medios de comunicación, de los que la televisión e Internet son los máximos exponentes.

TELEVISIÓN VIOLENCIA INFANTO UVENIL

A menudo la televisión se convierte en un recurso para “parchar” la ausencia de los progenitores; se suele decir: “*Ponle la tele al niño para que se distraiga (o se calle, al menos).*” En nuestro país, ocho de cada diez niños ven con asiduidad la televisión, con una media de unas tres horas diarias, cuando se recomienda no superar los 50 minutos. Esto en cifras globales se refleja en las 1.000-1.500 horas de televisión al año que se dan en este país por cada niño, de modo que podemos afirmar que la televisión es el primer recurso de ocio de los niños. En Estados Unidos se calcula que cuando se alcanzan los 18 años, cada persona ha contemplado en la televisión unos 200.000 actos violentos de media. Estos comportan una gran diversidad, mostrando agresiones con todo tipo de armas, racismo, sexismo y violencia de índole sexual.

Parece clara la relación entre exposición a la violencia en la televisión y fomento de ésta en las conductas y actitudes de los jóvenes, incluso algunos autores usan un lenguaje más contundente afirmando que esta relación es innegable e incontestable. Esto podríamos reflejarlo con un extracto del informe del *National Institute of Mental Health* de 1982:

“Después de más de 10 años de investigación, el consenso entre la mayoría de la comunidad investigadora es que la violencia en la televisión conduce a conductas agresivas en aquellos niños y adolescentes que contemplan los programas. Esta conclusión está basada en experimentos de laboratorio y estudios de campo. No todos los niños se vuelven violentos, pero la correlación entre violencia y agresión es positiva.”

A pesar de esta idea, existen autores que consideran que la exposición a la violencia por los medios de comunicación por sí sola no tiene un gran efecto, sino que este efecto está mediado a través de otros factores sociales que pueden interactuar y potenciarse unos a otros. Esto se justificaría por estudios realizados en Holanda de los que se extrae la consideración que la sola visión de la violencia no conduce inequívocamente a conductas agresivas, entendiéndose que a veces los mensajes prosociales del ámbito cultural puedan tener más peso que los antisociales.

Es célebre el estudio que se realizó por Joy *et al.* en 1973 en una pequeña comunidad rural canadiense, llamada ficticiamente “Notel” para salvaguardar el anonimato, en la que aún no se había introducido la televisión. Se hicieron dos grupos de adolescentes, diferenciándose en que uno fue expuesto a la televisión y otro no. El grupo no expuesto no presentó aumento de conductas agresivas, mientras que el grupo expuesto presentó un aumento de hasta un 160 %.

En niños se suelen dar pesadillas, fantasías diurnas, ilusiones y miedos con los temas de películas y dibujos animados. Se ha criticado el abierto carácter de muchos dibujos animados, que presentan la violencia como algo divertido y de escasas consecuencias. Todas las veces que el coyote cae al fondo de un barranco, acaba levantándose y persiguiendo una y otra vez al correcominos. Los dibujos animados no solo han resultado criticados por violentos, sino también por sexistas, por mostrar a los personajes femeninos como estereotipos centrados en lo sexual, relegándose los papeles de héroes a los personajes masculinos. Críticas de índole parecida también alcanzan a la publicidad que se intercala entre los dibujos animados y los programas juveniles.

Es la contemplación de conductas violentas que no reciben castigo, la que supone un mayor estímulo para ejercer la violencia. La aceptación de la violencia es mayor cuando se expresa con justificaciones y legitimaciones. Cuando la violencia es ejercida por el “héroe” de la acción, es más fácil realizar una identificación con el personaje y por lo tanto aceptar una justificación a la violencia. Igualmente es mucho más fácil identificarse con el fuerte, que ejerce la violencia, que con el débil, que sufre el daño.

Se considera que el efecto de la exposición a la violencia puede ser a corto plazo, pero también se manifiesta años después al establecerse una actitud personal favorable hacia la violencia. Es por esto que las intervenciones de prevención de la violencia se consideran más eficaces a largo plazo si se realizan sobre los más jóvenes.

Por violencia podemos entender más cosas que las meras conductas agresivas. Por ejemplo, podemos criticar como violencia la exhibición que se hace en las películas estadounidenses de las armas de fuego como algo con “glamour”, algo que confiere una estética de poder y que resultan atractivas y deseables. No podemos olvidar los

poderosos intereses económicos de la industria armamentística americana y lo enraizado que está en la cultura el uso de armas personales como salvaguarda de la propia libertad.

En Estados Unidos se ha desatado una campaña en contra de la violencia en general. Muestra de esto podría ser la petición de un control de armas o las demandas a las empresas que las venden. Dentro de esto también se ha dirigido la preocupación hacia la televisión, por lo que varios organismos oficiales han emitido recomendaciones al público general desde mediados de los años 60. Son más los policías que mueren a tiros en las calles de Estados Unidos, que los soldados en acciones de guerra en Ira o Afganistán; es para pensárselo.

La *American Academy of Child Adolescent Psychiatry* (1998) considera que la frecuente exposición a la violencia en la televisión puede influenciar a los niños de modo que:

Se vuelvan inmunes al horror de la violencia.

Gradualmente acepten la violencia como un medio de resolver los problemas.

Imiten la violencia que observan en la televisión.

- Se identifiquen con ciertos caracteres, ya sean víctimas o agresores.

También se establecen unas recomendaciones a los progenitores:

Atender a los programas que ven sus hijos.

Establecer límites en el tiempo de televisión.

Indicar que aunque la violencia de la pantalla no existe como tal, en la vida real los resultados serían perjudiciales.

No permitir que vean programas de gran violencia explicándoles el motivo.

Valorar la violencia observada negativamente y aportar opciones constructivas.

Establecer contactos para contrastar opiniones con otros padres y madres.

Desacreditar estereotipos racistas o sexistas de forma razonable.

Incluso hay recomendaciones para los pediatras que no vamos a exponer por ser algo redundantes, pero que se pueden consultar en el informe de 2001 de esta institución. Estos informes se pueden consultar en la página de Internet de la *American Academy of Pediatrics*.

Las sugerencias también han alcanzado a la industria televisa, así en Estados Unidos el *National Television Violence Study* de 1998 recomienda las siguientes normas para el control de la violencia:

Producir más programas que eviten la violencia. Si un programa contiene violencia, mantener el número de incidentes bajo.

Reducir las escenas de alto-riesgo en los dibujos animados.

Ser creativo en mostrar:

- Más actos violentos castigados.
- Más consecuencias negativas, a corto y largo plazo, de la violencia.
- Más alternativas al uso de la violencia para solucionar problemas.
- Menos justificación de los actos violentos.

Cuando la violencia esté presente, considerar un mayor énfasis en un tema contrario a la violencia.

Los programas de entretenimiento con un contenido en violencia sustancial deberían ser mostrados más tarde en la programación.

Cuando los *reality shows* presenten actos violentos, se deberían mostrar más alternativas a la violencia.

- Se deberían dirigir programas antiviolencia específicos para los adolescentes.

TELEVISIÓN SUICIDIO INFANTO UVENIL

La existencia de adolescentes que llegan hasta el suicidio es una situación considerada como trágica por nuestra sociedad. Nos inspira una gran angustia el observar cómo personas jóvenes eligen la muerte; especialmente si tenemos en cuenta que no es una conducta excepcional y que en la cultura occidental asumimos la vida humana como bien supremo. Existe una tendencia, en la sociedad en general, a negar los actos suicidas en niños y adolescentes o a negar que estos puedan realmente desear morir; por otra parte, la infancia y la adolescencia son tomadas por una etapa fantástica del desarrollo en la que los individuos son y deben ser felices, por lo que el deseo de vivir se supone de antemano.

La adolescencia es una de las épocas más turbulentas de nuestras vidas, no solo por la intensidad de los cambios que se producen sino también debido a la rapidez con que estos se suceden. El incremento de las tasas de suicidio, multiplicándose hasta por cinco, que se ha dado en las últimas décadas entre los adolescentes de los países occidentales (mayor aumento cuanto más septentrionales estos países) nos enfrenta a un problema que va más allá de la psiquiatría clínica, y que nos hace preguntarnos acerca del funcionamiento de nuestras sociedades modernas y el por qué algunos individuos, pertenecientes a la edad que atesora el mayor potencial humano, llevan a cabo conductas tan desadaptadas como la autodestrucción. Esto se vuelve especialmente desconcertante cuando se muestra que es en las sociedades más avanzadas, con mayores recursos económicos, donde existe mayor suicidio entre los adolescentes.

La adolescencia siempre lleva aparejada un cierto grado de soledad y angustia, incluso en condiciones favorables, debido al curso de separación e individuación del adolescente, que debe renunciar a los cuidados de los padres y procurarse una identidad propia e

independiente. Los adolescentes se encuentran a menudo en una situación anómica al desconocer qué camino tomar para incorporarse al rol de adulto; carecen de los rituales de ciertas culturas que les permitan adquirir de forma inequívoca su posición de adulto. El mundo del adolescente se tambalea constantemente y no son extrañas las ideas de muerte y lisis; incluso en adolescentes considerados como normales, la concurrencia de varios factores pueden dar lugar a la cristalización de dichas ideas en intentos de suicidio.

La importancia del suicidio en esta población se refleja en que se ha convertido en la segunda o tercera causa de muerte entre los adolescentes y en la décima entre los niños.

Es excesivamente simplista el plantear que las conductas suicidas se dan como consecuencia de una patología psiquiátrica y con la intención de morir.

De modo general se pueden plantear cuatro circunstancias que llevan al acto suicida en cualquier población (Barcia, 1992):

Desesperación. Cuando, a pesar de los esfuerzos realizados, no es posible alcanzar aquello en lo que se cree.

Desesperanza. Cuando se llega a la conclusión de que no hay nada por lo que merezca la pena esperar y vivir.

Cansancio de la vida. Cuando se siente que la vida, en cuanto tal, no merece la pena vivirla, carece de sentido y se vive en un vacío existencial, con falta de sentido.

Soledad. La vida carece de sentido porque no se puede compartir.

Frecuentemente los adolescentes suicidas podrán incluirse en el tercero y cuarto tipo (Salorio *et al.*, 1995).

Como hemos planteado antes, no necesariamente todos los actos suicidas tienen que buscar una letalidad, de modo que se han propuesto varias motivaciones (DeDios, 1992):

Huida. Vía de escape ante situaciones opresivas, frecuentemente de carácter impulsivo.

Búsqueda de ayuda. Petición de apoyo en una situación de desesperanza o anticipación de un temor desbordante.

Llamada de atención. En ocasiones para condicionar conductas del ambiente.

Suicidio en sentido estricto. Presuponiendo la presencia de patología psiquiátrica grave. Muy a menudo de forma premeditada.

Centrándonos más en población infanto-juvenil podemos adelantar unos factores de riesgo generales, más específicos de este grupo de edad:

La presencia de depresiones u otro trastorno psiquiátrico mayor.

Factores de personalidad tales como agresividad, impulsividad, autoestima, estilos de afrontamiento.

- Influencias familiares (factores genéticos, antecedentes suicidas o psicopatológicos, calidad de las relaciones parentales).

Acontecimientos vitales estresantes.

Relaciones afectivas de pareja o amistades.

Consumo de tóxicos.

- Influencias sociales o culturales.

Relacionado con lo anterior, se han propuesto diferentes causas para justificar el incremento del suicidio entre adolescentes:

Aumento del estrés, de la competitividad y del paro.

Erosión de los soportes sociales y familiares (aumento de separaciones y divorcios).

Incremento del consumo de alcohol y otras drogas.

Crítica de los tabúes religiosos acerca del suicidio.

Tendencia a la legitimación del suicidio por parte de la cultura popular y de los medios de comunicación de las conductas suicidas.

Es este último punto el que interesa desarrollar en esta exposición.

Antes de seguir adelante querría reflexionar sobre la importancia de la idea de la muerte, la importancia que tiene esto en las conductas suicidas y la influencia de los medios de comunicación sobre este concepto.

Existen diferencias en el concepto de la muerte entre los niños que acometen suicidios y los que no (Orbach *et al.*, 1983). Los implicados en actos suicidas suelen expresar un nivel de ansiedad más elevado ante la idea de la muerte, propia y la de seres queridos, comunicando preocupaciones acerca de la vida o la muerte (unas veces como rechazo y otras como atracción), pudiendo fluctuar su comprensión de la muerte como proceso sin retorno presentando en situaciones ansiosas la idea de muerte como un proceso reversible, idea más característica de niños de entre cinco y nueve años. La cultura transmitida a través de la televisión puede influenciar esta idea; muestra de esto podría ser la película *The Crow*, en la que el personaje es un fantasma que vuelve para vengarse, desplegándose una gran violencia en la que el héroe es invulnerable a todo tipo de armas, todo esto con una tétrica estética de ambiente gótico, ojos pintados de negro y cutis mortecinos que podemos ver reproducida en algunos de los jóvenes que van por nuestras calles. Esto no es sino un ejemplo de ciertas películas que se acogen a la tanatofilia como moda.

Son muchos los autores que sugieren que el suicidio puede ser un comportamiento aprendido por modelaje. La historia antigua nos aporta episodios de suicidios por imitación o epidémicos, como el de las vírgenes de Mileto. El antecedente más inmediato

en nuestra cultura sería lo que se ha dado en llamar efecto *erther*. Cuando Goethe publicó su novela *Las penalidades del joven erther* se produjo una importante repercusión social que el propio autor reflejó. Muchos jóvenes adoptaron los vestidos que se le suponían a este personaje romántico, y se pensó que muchos de estos acabaron suicidándose por imitación. Es por esto que la novela fue prohibida en varios países de Europa, iniciándose un debate, sin resolver hasta ahora, entre los partidarios de una liberalización total de la información y los de silenciar las noticias sobre suicidios. Quizá este debate se sitúe no ya acerca de qué se informa, sino cómo se hace esto, sin caer en el morbo o en el amarillismo (que todos criticamos, pero que vende muchísimo). Hay un reciente caso de cómo un niño de 7 años copia un ahorcamiento tras verlo en una película (Ghanizadeh, 2009).

Desde principios de este siglo, sobre todo por parte de escuelas psicodinámicas, ha habido interés en el estudio de los suicidios epidémicos de los que de vez en cuando se daban episodios entre los escolares, sobre todo los que compartían una misma institución, con un elevado grado de identificación y cohesión.

Parece clara la influencia de las conductas suicidas entre miembros de una misma familia, y aunque se pueden propugnar otros factores (genético, por ejemplo), el aprendizaje de esta conducta resulta un factor de riesgo.

Antes de seguir adelante querría avisar sobre la enorme disparidad de resultados y dificultades metodológicas que se dan para el estudio científico de este fenómeno. Los datos de los que disponemos suelen estar referidos a otros ámbitos culturales.

En Estados Unidos se ha descrito (Philips *et al.*, 1986; Gould y Shaffer, 1986) un incremento en la tasa de suicidios en los 7-10 días siguientes al suicidio de una celebridad y su divulgación por los medios de comunicación, considerando que hay un importante efecto de imitación. Efectos similares se han descrito en Alemania por Schmidt e y H fner (1988). Igualmente Philips (1982) ha estudiado el impacto de los suicidios de ficción en las series televisivas, hallando un aumento de suicidios a los pocos días de la exhibición. Estos estudios han sido criticados por muchos autores, que los consideran artefactados. De todos modos, aunque se ha logrado describir aumentos transitorios de la tasa de suicidios en algunas áreas, no en todas, no se ha conseguido establecer una identificación de los suicidas o del método empleado con el patrón mostrado. Aunque se ha logrado comunicar casos de pacientes que imitaban los modelos de las películas o de celebridades, no se ha conseguido establecer que esto sea un efecto global.

Se ha llevado a cabo algún intento de experimentación en este terreno. En 1987 en Viena, se suspendió la publicación de los suicidios que se cometían arrojándose al metro, con lo que se observó una disminución en los intentos de suicidio mediante este método, aunque el resto de suicidios se mantuvieron (Philips *et al.*, 1992).

En contra de estos estudios hay autores (Platt, 1989) que consideran que los medios de comunicación no tienen ninguna repercusión importante sobre la tasa global conductas suicidas, indicando que en algunos escasos individuos pueden darse fenómenos de tipo sugestivo.

Es excesivamente simplista plantear que el suicidio pueda ser consecuencia de la mera imitación de modelos mostrados en los medios de comunicación. Estos modelos impactan sobre una población de la cuál algunos individuos pueden ser vulnerables, por la conjunción de muchos otros factores. También puede entenderse que el impacto de la muestra de suicidios en los medios de comunicación estaría mediatizado por el medio cultural. En el suicidio, como en Psiquiatría o en el comportamiento humano general, no podemos esperar relaciones causa efecto claras y bien delimitadas.

Parece evidente que se puede aceptar alguna influencia (de difícil cuantificación) entre la divulgación de suicidios por los medios de comunicación y la consumación de suicidios en un área determinada, siendo esta influencia más intensa cuanto mayor divulgación se hace de los acontecimientos y afectando principalmente a población juvenil, aunque puede afectar a otros grupos de población. De todos modos, las recomendaciones generales de varios autores y sociedades al respecto (Stac , 2003) es que no se debería dar una publicidad innecesaria a casos de suicidio y que la población infanto-juvenil debería ser especialmente protegida frente a este aprendizaje.

No tenemos datos de la influencia de los medios de comunicación en conductas parasuicidas, como la conducción temeraria, el consumo de sustancias o la adopción de deportes de riesgo, aspecto éste de mucho más difícil estudio.

ÓVENES INFOR TICA PSICOPATOLOGÍA

La informática supone una gran revolución en nuestro mundo actual de la que no podemos permanecer al margen. No son pocos los niños avisados que nos sorprenden con las habilidades que adquieren de muy pequeños en el manejo de los ordenadores. Con respecto a la televisión, las aplicaciones informáticas requieren una mayor atención y participación y ya nos vamos enfrentando a lo que supone ser un analfabeto tecnológico.

No se puede considerar que el uso de videojuegos pueda tener relación causal con alguna psicopatología específica. No es aceptable que los videojuegos puedan ser un terrible peligro para la infancia, pero tampoco que sean completamente inocuos. En varios estudios se ha descrito una modesta relación entre el uso frecuente de videojuegos, en las formas violentas, y la presencia de conductas violentas. Esto es menos frecuente e intenso en las niñas. Lo que no ha sido establecido es si esto supone una relación causal, ya que es posible que los jóvenes más violentos elijan entretenimientos acordes con su carácter.

Además de esto se han relacionado otros factores. La apreciación por parte del profesorado y el rendimiento escolar tienden a ser deficientes en los jóvenes en los que se da un importante uso de videojuegos, sin embargo esta tendencia a menudo no es significativa. Hay una mayor tendencia a contemplar programas violentos en la televisión, sin que el tiempo empleado en los videojuegos reste tiempo a la contemplación de la televisión.

Se ha descrito también una relación entre baja autoestima y la tendencia a permanecer jugando solo, con lo que se plantea la preocupación de desarrollar dificultades en las habilidades sociales al permanecer aislado del grupo social. A pesar de esto, no se ha podido validar que el empleo de videojuegos suponga una merma importante en la sociabilidad.

Una circunstancia relacionada con el tema que nos interesa es la capacidad de desarrollar conductas adictivas a los videojuegos, habiéndose dado casos de niños que gastan el dinero en videojuegos de un modo similar al de los ludópatas adultos. Se van describiendo adicciones comportamentales similares a la ludopatía en el manejo de videojuegos, correos electrónicos, navegación por Internet o uso de teléfonos móviles.

En un intento de generar mayores sensaciones, los juegos violentos se han tornado cada vez más reales, con pantallas cada vez más grandes y efectos más sorprendentes. Existen juegos disponibles en los que, con la réplica de una pistola, se puede disparar a las figuras, más o menos humanas, que al resultar alcanzadas muestran gran profusión de sangre y vísceras. Parece claro que cuanto más realista sea la violencia, más capacidad tiene de influenciar negativamente, en especial en los niños más pequeños, que encuentran mayores dificultades de establecer diferencias entre ficción y realidad. Resulta casi inevitable plantearse si se hace preciso algún tipo de regulación de estos juegos, aunque también la idea de ejercer la censura, en sí misma, resulta preocupante. Se ha desarrollado un sistema de calificación de los juegos por edades, el sistema PEGI (Pan European Game Information), que además aborda otros aspectos, como si los juegos llevan contenidos violentos, soeces, sexistas, racistas o induce al juego con dinero. Es un sistema parecido al que se desarrolló hace mucho tiempo para las recomendaciones de las películas, y si no llevamos a los niños a ver una película en la que la gente se mata a chorros, no sé por qué los vamos a dejar hacer lo mismo en su habitación, ¿digo yo?.

La aparición de Internet supone el surgimiento de un nuevo medio de comunicación. Este nos aporta una cantidad ingente de información, mucha más de la que podamos manejar, con la particularidad de que ya no se es receptor pasivo como en la televisión, sino que uno puede dirigirse hacia los temas que le preocupan o interesan. Además, permite que con pocos recursos se llegue a un gran número de potenciales receptores. Son precisamente los jóvenes, con su mentalidad más abierta, ágil y curiosa, los que principalmente se introducen en Internet. Esto destapa sus riesgos, ya que el anonimato en una relación íntima, aunque a distancia, permite su uso por fulanos tales como los pederastas, cuyas detenciones están todos los días en los medios de comunicación.

Se considera que Internet pueda influenciar sobre el suicidio de forma parecida a como pueda hacerlo la televisión, pero supone un tema de difícil estudio. Podemos encontrarnos páginas web dedicadas a la memoria de ídolos del “pop” que se han suicidado (Kurt Cobain, por ejemplo) o que difunden una estética de la muerte como algo atractivo (como muestra basta con <http://www.heavensgate.com>), siendo muchas de ellas de sectas destructivas. Aparte de estas páginas se pueden encontrar otros recursos como grupos de discusión y listas de distribución sobre el suicidio. En muchos

de estos recursos hay personas que dejan cartas de despedida antes de acometer el suicidio. Es preocupante que la gente pueda organizarse para aportar soporte intelectual y moral que empuje al prójimo a acometer el suicidio. A propósito, quisiera dejar al margen el debate con la eutanasia, que para mí es otra cosa.

También se dispone de un gran número de páginas y otros recursos de grupos que incitan a la violencia y al odio racial. Estos pueden llegar a cotas muy sofisticadas, siendo capaces de informar por Internet de cómo se pueden preparar bombas caseras u otros disparates del mismo estilo.

Internet no ha hecho más que iniciar su desarrollo, tanto en tecnología como en expansión física. Resulta imposible establecer cuál será el impacto del desarrollo de futuras tecnologías audiovisuales y de la información.

APUNTES FINALES

Finalmente, son los niños el máspreciado legado que nos toca preservar. No debemos olvidar que ellos son, en cierto modo como nosotros los fuimos, el resultado del desarrollo personal y de la instrucción (en el sentido más amplio del término y desde lo familiar hasta lo social) a la que los destinamos. La lección aprendida en dramas humanos, como el que los maltratadores (física y sexualmente) de niños son a su vez niños que resultaron maltratados, nos habla de que en algún momento debemos intentar romper los eslabones de esta cadena de educación en la violencia y muerte, si no queremos que se perpetúe.

En último lugar nos enfrentamos a lo que la libertad del hombre es. A menudo caemos en la ilusión de que somos completamente libres, casi como dioses, y también de la actitud contraria, de que somos completamente esclavos de alguna pasión o fuerza oscura y secreta. Estos planteamientos, que recuerdan a los pensamientos mágicos de los niños, se dan cotidianamente en un gran número de adolescentes y adultos, situando muchas de sus motivaciones y miedos en el campo de lo *soñado*. Sean como fueren las cosas, soy de los que piensan que, salvo en la locura más absoluta, siempre hay un resquicio en el que el ser humano es capaz de ejercer la libertad de decidir; a menudo el problema no es esta libertad, sino el asumir la responsabilidad que esta libertad nos echa encima.

Seríamos ingenuos si no pensáramos que la violencia es algo que gusta, que fascina al ser humano, al mismo tiempo que lo aterra y asquea. La violencia proporciona una intensa sensación de dominio y poder en algunas personas que la ejercen.

Tampoco debemos caer en actitudes apocalípticas, tremendistas o milenaristas, al uso en este siglo que empieza; es muy fácil adoptar posturas basándose en moralina, cuando en realidad necesitamos un análisis desapasionado de los cambios a los que nos enfrentamos. Cuando surgió en el *xix* la revolución industrial hubo quien clamó contra el ferrocarril, que si los humos que echaba eran muy contaminantes, que si los miasmas, que si tal, que si cual. En cierto modo tenían razón, aunque en realidad estaban más preocupados por la conmoción de su mundo anquilosado que por el medio

ambiente. Sin embargo el tren, con las adecuadas correcciones, se ha acabado convirtiendo en uno de los más avanzados y socialmente reconocidos medios de transporte. No nos deben asustar las situaciones de cambio si las sabemos dirigir adecuadamente; la vida es algo dinámico, como un esquiador ladera abajo, que si se para se cae. Hoy en día estamos inmersos en una nueva revolución, pero ya no es de acero y carbón, sino del manejo de la comunicación y la información, lo cual conlleva un gran poder. El problema no es el avance tecnológico, sino el modo en el que lo usamos, ya que a menudo éste desarrollo va por delante de la capacidad de adaptación de muchos hombres y mujeres. Ni la televisión o Internet son malos en esencia, como una pistola no lo es porque sí, sino que es el uso que de ello hacemos las personas lo que les confiere un carácter moral. No quisiera concluir sin recordar que la televisión y la informática suponen grandes avances, cargados de ventajas y posibilidades. Somos nosotros los responsables de su desarrollo.

Yo sigo teniendo esperanza en las cosas buenas de la humanidad, sin caer en la ingenuidad de obviar lo de malo que haya. Si no, posiblemente, no habría escrito esto.

BIBLIOGRAFÍA

- American Academy of Pediatrics. Media violence. *Pediatrics* 1995; 95: 949-950.
- American Academy of Pediatrics. Media violence. *Pediatrics* 2001; 108: 1222-1226
- Argemí J. El niño y los medios de comunicación. *Anales Españoles de Pediatría* 1990; 33: 184-207.
- Baer D, Fortune S. Understanding self-harm and suicide websites: a qualitative interview study of young adult website users. *Crisis*. 2008; 29: 118-122.
- Barcia D. Tedium vitae en la poesía de la senectud. *Congreso de la Sociedad Española de Psicopatología Social*, Badajoz, 1992.
- Barcia D, Ruiz ME. Aspectos psicopatológicos de la adolescencia. En: Parada JL (ed.). *Perspectivas sobre la familia*. Murcia: Espigas. 1994.
- Baume P, Cantor CH, Rolfe A. Cybersuicide: The role of interactive suicide notes on the internet. *Crisis* 1997; 18: 73-79.
- Biddle L, Donovan J, Hampton N, Gunnell D. Suicide and the internet. *BMJ* 2008; 336: 800-802.
- Black D, Newman M. Television violence and children. *BMJ* 1995; 310: 273-274.
- Browne KD, Hamilton-Giachritsis C. The influence of violent media on children and adolescents: a public-health approach. *Lancet*. 2005; 365: 702-710.
- Castells P. El niño, el adolescente y la televisión. *Anales Españoles de Pediatría* 1990; 33 Suppl 43: 200-204.
- Centers for Disease Control and Prevention. Television and violence. *JAMA* 1992; 267: 3059-3063.
- De Dios JL. Depresión y suicidio en la adolescencia. *Monografías de Psiquiatría* 1992; 4: 23-28.
- Estalló, JA. Videojuegos: efectos psicológicos. *Revista de Psiquiatría Infantil* 1992; 2: 106-116.
- Flórez JA. Medios de comunicación y psicopatología infantil. *Salud Rural* 1996; 10: 81-92.
- Ghanizadeh A. Copycat suicidal attempt by a 7 year old boy after watching homicidal behavior in media: a case report. *Cases Journal* 2009; 2: 43.
- González C, Ramos YM, Lastra I, De Dios JL, Carbonell C. Suicidio juvenil y medios de comunicación. *Psicopatología* 1993, 13: 168-172.

- Gould MS, Shaffer D. The impact of suicide in television movies. *New England Journal of Medicine* 1986; 315: 690-694.
- Huesmann LR. The impact of electronic media violence: scientific theory and research. *Journal of Adolescent Health* 2007; 41: S6 S13
- Llaveró F. La causalidad y la televisión en la patología médico-psiquiátrica antropológica en nuestra época. *Psicopatología* 1993, 13: 159-162.
- Mardomingo MJ. Suicidio e intento de suicidio en el niño y en el adolescente. *Aula Médica Psiquiatría* 1999; 2: 194-202.
- Monsell A, Suárez J, Jornet J. Influencia sobre la psicopatología infantil de los medios de comunicación audiovisuales. *Revista de Psiquiatría Infantil*, 1991; 4: 302-312.
- Orbach I, Feshbach S, Carlson G, Glaubman H, Gross Y. Attraction and repulsion by life and death in suicidal and in normal children. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 1983; 51: 661-670.
- Phillips DP, Carstensen LL. Clustering of teenage suicides after television news stories about suicide. *New England Journal of Medicine* 1986; 315: 685-689.
- Phillips DP, Lesyna J, Paight DJ. Suicide and the media. En: Maris R, Berman AL, Maltsberger JT, Yufit RI. *Assessment and prediction of suicide*. Guilford Press, New York, 1992.
- Prieto MA, March JC, Argente A. Violencia y sexismo en los dibujos animados de la programación infantil de televisión. *Atención Primaria* 1996; 17: 40-52.
- Rojas L. *Las semillas de la violencia*. Madrid: Espasa. 1995.
- Salorio P, Barcia D, Morcillo L. Conducta suicida: motivación suicida en los adolescentes. En: *Diagnóstico y tratamiento de los trastornos psíquicos en la edad juvenil*. Barcelona: PTD España. Espaxs. 1995: 61-70.
- Schmidtke A, Häfner H. The Werther effect after television films: new evidence for an old hypothesis. *Psychological Medicine* 1988; 18: 665-676.
- Stack S. Media coverage as a risk factor in suicide. *Journal of Epidemiology and Community Health* 2003; 57: 238-240.
- Stack S. Suicide in the media: a quantitative review of studies based on non-fictional stories. *Suicide Life Threatening Behaviour* 2005; 35: 121-133.
- Strasburger VC, Donnerstein E. Children, adolescents, and the media: Issues and solutions. *Pediatrics* 1999; 103: 129-139.
- Tojo T. Televisión y salud infantil. El papel del pediatra y la pediatría. *Anales Españoles de Pediatría* 1990; 33 Suppl 43:188-196.

EL DESCUBRIMIENTO DE LA MUERTE EN EL NIÑO

*Carlos Enrique Monera Olmos,
M^a del Pilar Lucas Martínez*

DOS PEQUEÑAS HISTORIAS

Este artículo tiene su origen en dos pequeñas historias. Una tarde otoñal en Valencia a principios de los sesenta, acompañé a mi madre a casa de un familiar, yo no tendría más de siete años. En la pequeña sala de estar, sobre el sofá, yacía José Luis, con solo tres años había muerto súbitamente. Su madre junto a él, en silencio y sin llorar, le cogía la manita. Yo lo besé y percibí, además de la inmovilidad, esa frialdad que tienen los cuerpos tras la muerte. Era mi primera experiencia sobre el fenómeno de la muerte, no me percaté de nada especial en aquel momento, todo era natural, sereno y, solo años más tarde, comprendí con toda su crudeza lo que entrañaba esa experiencia.

Pasaron muchos años y siendo ya médico, me trasladé en un caluroso mes de junio a Madrid para trabajar durante unos meses en un hospital. Antes de emprender el viaje, me despedí del profesor Demetrio Barcia, Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Murcia, con el que me formé durante años. Con un interés especial por la antropología y la ética, el profesor Barcia mantenía con sus alumnos entrañables conversaciones sobre aspectos fundamentales de la existencia humana. Recuerdo que en muchos de esos encuentros, nos refería cuestiones sobre el papel humanista del médico frente al dolor y al sufrimiento del enfermo. Habían transcurrido pocas semanas de aquel verano, cuando alguien me comunicó el fallecimiento de la madre de mi profesor. Mi afecto hacia él, me empujó a enviarle una carta de pésame.

Al regresar de Madrid, unos meses más tarde, fui a visitar a mi querido profesor. Me contaba que tras la muerte de su madre, su sobrino José María que apenas contaba seis años de edad, no tardó en extrañar a su abuela. La buscaba incesantemente por las habitaciones de la casa preguntando a todos dónde estaba. Su tío, el profesor Barcia, conmovido, intentando darle la explicación más adecuada y convincente le respondió que había subido hasta el Cielo. La reacción del niño fue inmediata: ¿hasta cuándo va

a estar allí?, ¿la has visto volar?, ¿el Cielo, dónde está?, ¿tío, tanto que sabes, puedes hacerla volver? El torbellino de preguntas, cargadas de simpleza e ingenuidad, dejó aturdido al emérito profesor, que tuvo serias dificultades, a pesar de su contrastada sabiduría, para salir airoso de aquella comprometida situación. Una vez más la experiencia de los libros no acaba de dar respuestas adecuadas a las experiencias de la vida y mucho menos a las aparentemente ingenuas preguntas de los niños.

Esta anécdota familiar cargada de ternura, dio pie a que el profesor, en uno de esos encuentros aludidos anteriormente, realizara una reflexión sobre el desconocimiento que tenemos los adultos acerca de lo que piensan los niños sobre la muerte. Me animó a que realizara un estudio sobre los sentimientos y las ideas que suscitaba en los niños la realidad de la muerte, pues conocer lo que piensan y captar las emociones que les producía el fenómeno, podría abrir nuevos horizontes al manejo de situaciones infantiles vinculadas al hecho de morir. Fruto de estas reflexiones es el artículo que el lector tiene en sus manos.

UNA CERTE A INELUDIBLE

El ser humano, aunque coloquialmente casi nunca habla de ella, piensa en la muerte. En su profunda intimidad, el hombre acaba reflexionando sobre el sentido de su existencia, sobre el valor de su vida y se adhiere finalmente a la evidencia de que la muerte será el fin definitivo de su camino. La muerte aparece al final de cualquier vida humana, como la certeza insoslayable que trunca los anhelos conscientes e inconscientes de inmortalidad.

Los pensamientos sobre la muerte se hacen más presentes cuando el fallecimiento de un ser querido, la enfermedad, la vejez, el dolor y el sufrimiento, golpean con fuerza alrededor del hombre. Es entonces cuando descubre el ser humano la más cruda realidad de su existencia: es un “ser para la muerte” y que incomprensiblemente, fuera de toda evidencia racional, tiene que morir.

El hombre joven, a no ser que un acontecimiento inesperado lo impida, piensa con lógica de la edad que la muerte le sorprenderá bastante tarde. Considera que no es algo inminente y que sucederá en un futuro lejano por el que no debe preocuparse; en todo caso, es una cuestión que corresponde, de momento, a “otros” especialmente a los ancianos. El hombre de hoy da la espalda a la muerte, la teme, la ignora, la evita, la esconde o la niega. Solo al final de la vida, cuando reconoce que su proyección vital hacia el futuro se desvanece y se hace consciente de la proximidad de su propia muerte, comienza a reflexionar sobre ella.

El ser humano en su juventud y en el inicio de su madurez está proyectado hacia el futuro y planifica su vida a largo plazo, sin tener en cuenta la posibilidad de la muerte. Qué duda cabe que éste modo de proceder está mucho más reforzado en el mundo infantil. Los adultos, protegidos frente a la idea de la muerte, sobreprotegen a los niños y les molesta que se les hable sobre ella rompiendo ese mundo de ensueño y fantasía que les envuelve. Se piensa que los niños carecen de conocimientos y de

experiencias para entender la muerte y evaden la cuestión con ciertos engaños del mismo modo como antaño se les engañaba a los niños sobre el origen de la vida.

Se opina que el dolor, la enfermedad y el sufrimiento, rémoras de la muerte, son contingencias de la vida exclusivas de la madurez y de la vejez que el niño no debe experimentar. Se engaña al niño ocultándole la muerte, se evita que visiten los hospitales, que acudan a los entierros y funerales, se les prohíbe asistir a manifestaciones de duelo y, en definitiva, se les confunde infundiéndoles miedo y temor.

Antiguamente, como relata Sch artzenberg, no hace muchas décadas, la muerte era más sentida por toda la comunidad y desde luego no se apartaba a los niños. Las ceremonias funerarias y el cuidado a los difuntos y a su familia estaban arraigadas de modo natural en las costumbres de los pueblos y ciudades.

La muerte, es innegable, también forma parte del mundo infantil. Al niño se le acosa con noticias, imágenes, películas, juegos, canciones, incluso cuentos, donde la muerte y los muertos son protagonistas. En los cuentos o películas infantiles aparecen brujas, ogros y malhechores que se comen a los niños. Se narran historias llenas de terror, de violencia. La televisión emite a diario noticias sobre la existencia de numerosas víctimas en catástrofes, incendios, accidentes y actos criminales. Contemplan en las películas de dibujos animados los instrumentos u objetos que se utilizan para agredir o matar: balas, cañones, cuchillos, pistolas, bombas, explosiones, puñetazos, trampas, incendios.

En definitiva, como el adulto, el niño está también sujeto a esa terrible ley universal de la muerte, es vulnerable a su poder y a su influencia implacable. El dolor y el sufrimiento, tan unidos a la muerte, son experimentados por el niño en multitud de ocasiones y ante ellos reacciona con intensas emociones que pueden desmoronar su frágil equilibrio psíquico.

EL ENCUENTRO CON LA MUERTE

El niño ocasionalmente puede encontrarse frente al sufrimiento y la muerte. Puede experimentar la angustiosa vivencia de la muerte en un accidente inesperado de un miembro de su familia o de un íntimo compañero de colegio, una enfermedad mortal que separa súbitamente de su lado a un ser querido o se enfrenta él mismo a una prematura y cruel enfermedad, incluso a la muerte.

Otras veces es sobrecogedor conocer que un niño o un adolescente han decidido poner fin a su vida. Desconcertados nos preguntamos qué motivo ha impulsado a un muchacho abierto a la vida a realizar esa acción. La tristeza es intensa cuando son los propios niños los ejecutores, los autores de la muerte. Son esos niños violentos, destructivos y homicidas, que agreden a otros niños, maltratan a otros niños, o matan a otros niños; capaces de agredir a sus padres, maltratar a sus padres o matarlos.

¿Qué piensan los niños sobre la muerte? Para ello, durante varios años, hemos analizado las respuestas de más de tres mil niños entre los 5 y los 14 años. Hemos conversado con muchos padres que han tenido la experiencia de pérdida de algún hijo,

con niños que han perdido a sus padres o a algún hermano. Hemos escrutado todas sus respuestas sobre los sentimientos, los pensamientos, los miedos y las emociones que genera el niño al enfrentarse de un modo directo o indirecto a la muerte.

¿Sabe el niño qué es la muerte? Dar respuesta a esta pregunta y discernir si el niño es capaz de analizar cognitivamente las consecuencias reales del fenómeno, es quizás una de las mayores dificultades que se presentan cuando nos encontramos con situaciones en las que un niño debe enfrentarse a la muerte. Cuando alguien muere, ¿sabe el niño que se trata de una transformación personal, intransmisible, universal, irreversible, producida por una causa y con la participación de procesos de descomposición orgánica? Si el niño no es capaz de intuir todos estos conceptos, es posible entonces que no sepa realmente qué es la muerte.

El conocer de antemano los sentimientos, ansiedades, fantasías, miedos y respuestas de los niños acerca de la muerte, ayuda a comprenderles mejor y a evitarles sufrimientos ante las emociones que les suscita la enfermedad y la muerte. Los médicos, psicólogos, enfermeras y otros profesionales saben qué momento tan amargo supone ser espectador de la muerte de un niño. En ese momento se desearía huir, o al menos encontrar las palabras y los gestos adecuados para reconfortar al niño y a su familia. En muchos hospitales hay protocolos especiales para atender a niños con graves enfermedades crónicas o con enfermedades terminales, y se logra un entorno cálido y afectuoso para acompañar al niño enfermo y a su familia.

Algunas veces nos lamentamos ante la noticia del suicidio de un niño o una pareja de adolescentes. Si analizamos detenidamente todas las circunstancias que rodean estas acciones autodestructivas, es posible que se nos planteara la duda sobre las verdaderas intenciones de estos muchachos y, quizá, no convendría por el momento calificarlas como actos suicidas.

¿Sabían estos jóvenes que el fenómeno de la muerte es irreversible? ¿Eran conscientes de que la muerte es una ley universal y que ellos también estaban sujetos a ella? Ante un acto autolítico impulsivo, a causa de una reciente ruptura sentimental en un adolescente, ¿podríamos afirmar que existen todas las condiciones para que el acto sea considerado totalmente racional? ¿Qué pensaríamos sobre las motivaciones suicidas en el caso del niño que se lanza al vacío si momentos antes había contemplado una película de Spiderman, Batman o Peter Pan?

Por lo tanto, es muy arriesgado juzgar como suicida, incluso como homicida, comportamientos infantiles o juveniles en los que sus autores carecen de las más elementales nociones cognitivas sobre la muerte, como son: la irreversibilidad, la universalidad, la cesación de las funciones corporales y la causalidad, entre otras. Ante un niño a punto de morir, ante un comportamiento suicida de un adolescente, incluso ante conductas infantiles peligrosas o de alto riesgo físico, resulta difícil definir las reacciones e intenciones del niño, debido a que podrían presentar un desconocimiento sobre el concepto e idea sobre la muerte.

El concepto de muerte va adquiriéndose, junto a otros conceptos fundamentales, durante el desarrollo cognitivo del niño. Cualquier desviación o inflexión en ese desarrollo, produce en el niño una distorsión en la elaboración de los conceptos básicos

sobre la muerte que podrían condicionar la valoración cognitiva de las conductas autolíticas expresadas anteriormente.

Muchos de los niños con los que hemos hablado, sobre todo los más pequeños, eran incapaces de transmitir verbalmente sus vivencias y expresaron sus sentimientos a través de dibujos donde, de modo simbólico, quedaban plasmados los elementos y las figuras que les sugería la muerte. Los niños pequeños asocian las causas de muerte casi siempre a los agentes exteriores, especialmente de tipo violento.

Hay muchas preguntas que habitualmente se plantean los niños con respecto a la muerte: ¿qué es la muerte?, ¿por qué muere la gente?, ¿dónde va la gente que muere? Las respuestas que dan los niños difieren según las diferentes edades, no solo por la edad sino también por el tipo de educación, por las creencias, por la cultura, por el entorno geográfico y por las experiencias personales.

Por ejemplo, un niño que vive en un medio rural tendrá más experiencias sobre la muerte que el niño que vive en una gran ciudad, dado a que la muerte en el medio rural es vivida más intensamente por la comunidad. En cambio, en el medio urbano, la muerte puede pasar desapercibida, la gente muere en el hospital y se traslada a los tanatorios, lugares donde generalmente se evita que entren los niños.

Es muy diferente también el conocimiento de la muerte que tienen los niños procedentes de culturas orientales, primitivas o tribales, que en la cultura occidental. Además, las creencias sobre la trascendencia después de la muerte influyen notablemente en la concepción de la misma, pues la mayoría de las religiones ofrecen respuestas trascendentales a la muerte.

Los niños, como los adultos, están invadidos diariamente por multitud de mensajes que, poco a poco, generan en su pensamiento ideas y juicios sobre la realidad de la muerte. No debe de extrañarnos que niños que han vivido acontecimientos dramáticos en su propia familia (muerte de seres queridos), o en su propio país, como conflictos bélicos o catástrofes, muestren un conocimiento de la muerte más profundo que los propios adultos.

El desarrollo de los pensamientos de los niños sobre el fenómeno de la muerte, ha sido estudiado por muchos autores, que han tratado, en primer lugar, de analizar cómo los conceptos fundamentales que definen la muerte, se incrustan en el conocimiento del niño de acuerdo con su constante desarrollo, y en segundo lugar, conocer todos los temores y sentimientos que invaden al niño a raíz de la enfermedad y la muerte, con el fin de elaborar estrategias y pautas de actuación para ayudarle en situaciones de crisis y acontecimientos vitales muy estresantes, como son: niños con experiencia de pérdida de seres queridos, niños moribundos, niños con intentos de suicidio o niños con conductas temerarias de gran riesgo físico, incluso niños homicidas.

LOS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS

A muy temprana edad, alrededor de los dos años, los niños comienzan a interesarse intensamente por todo lo que ocurre a su alrededor. No es extraño encontrarles observando fijamente los movimientos de una pequeña mosca, o sorprenderse en la calle

ante la presencia de un gato, un perro u otro animal. Un día, posiblemente en su afán descubridor, encontrará una pequeña cucaracha inmóvil en algún rincón de su casa, aplastará en el campo alguna lagartija, o bien contemplará el pajarillo, o el hámster de su hermano mayor, “tieso” en la jaula después de una fría noche olvidado en la terraza. Quizá oiga entonces a su madre pronunciar la palabra “muerto” y casi inmediatamente asociará el término con la “quietud y la inmovilidad,” incluso, si es capaz de coger al animalillo, sentirá que está frío y acartonado, entonces asignará también estas cualidades a la muerte. Para un niño pequeño todo lo que no se mueve “está muerto” y.... “hay que llevarle al Hospital para que lo curen”.

Durante sus primeros años de vida, el niño desconoce qué puede entrañar la muerte. El vocablo “muerte” o “muerto”, que comienza a utilizar de modo espontáneo alrededor de los dos años, no tiene para él un verdadero significado y la comprensión de la muerte le resulta cognitivamente inalcanzable. En estas tempranas edades se produce en los niños un conjunto de reacciones y de vivencias que son el embrión de lo que más tarde será el concepto claro y diáfano de muerte.

Antes de los tres años los niños no temen su propia muerte. Piensan que, minutos después de haber muerto, estarán de nuevo vivos y jugando. Los niños muy pequeños no diferencian en su mente la vida del cuerpo y la vida del alma, tampoco captan el cambio ni el tiempo. Para ellos, la inmortalidad es la permanencia indefinida de su situación actual, son incapaces de sentirse mortales.

Recuerdo que una tarde jugando al escondite con mis hijos, de tres y cuatro años, me quedé dormido dentro de un armario mientras ellos me buscaban impacientemente por la casa. Por fin me encontraron acurrucado entre la ropa del armario sumido en un profundo sueño, rápidamente corrieron a decirle a mi esposa que “papá estaba muerto”. Evidentemente me desperté, con gran alegría de mis hijos al comprobar que estaba otra vez “vivo” y dispuesto a seguir jugando con ellos.

La rudimentaria idea que los niños pequeños tienen sobre la muerte, hace que no sean capaces de entender la irreversibilidad e irrevocabilidad de la misma. Para un niño pequeño la muerte es un fenómeno totalmente temporal, es simplemente una separación transitoria.

En los dos primeros años de vida, el niño es especialmente dependiente de los seres que le rodean. El niño pequeño, inmaduro y dependiente de la figura de la madre, es por lo tanto particularmente vulnerable a las experiencias de separación. Si la ausencia es relativamente prolongada, por ejemplo por un viaje, el niño puede dejar de comer, dejar de sonreír, o simplemente perder la capacidad para jugar o reaccionar ante estímulos. Este fenómeno, conocido como la “angustia de separación”, se ha relacionado con el temor y la ansiedad ante la muerte. En estas edades, donde es imposible verbalizar sentimientos de duelo o de pena, el niño expresa sus emociones con símbolos y lo hace ante la desaparición de su campo visual de algún ser con el que tenga una cierta dependencia.

Actualmente, en las unidades pediátricas hospitalarias ya se toman medidas para que se mantenga el intenso vínculo entre una madre y su hijo hospitalizado, con el fin de evitar todos los perjuicios que una larga estancia en el hospital podría ocasionar a

los pequeños pacientes. Muchos estudios han comprobado que ante la carencia de lazos maternos, los niños hospitalizados reaccionan con lloros, agresividad, resistencia a las normas del hospital, conductas regresivas, conductas de ansiedad y de depresión, miedo a los médicos y enfermeras. Cuando el niño está hospitalizado y la madre no está, los lloros son inútiles, el niño insiste entonces con más lloros y más evidentes, produciéndose una verdadera angustia de separación.

Tras la muerte o separación prolongada de la madre, el niño rompe a llorar y rechaza a cualquier persona que intente sustituirla. Aparentemente, al cabo de unos días cede la resistencia pero no logra adaptarse totalmente, pudiendo aparecer conductas hostiles y regresivas, estos síntomas aparecen más agudizados cuando los cuidadores del niño han sido múltiples.

El niño pequeño (menor de cinco años) no llega a comprender por qué se ha marchado su madre, la persona que le ha dado siempre afecto y seguridad y piensa que ha sido “malo”, aflorando potentes sentimientos de ansiedad y de culpa.

Si los niños son muy pequeños, menos de diez meses, es posible que tras la muerte de la madre, la persona sustituta sea capaz de conseguir que el niño le responda como si fuera su madre. Los niños más mayores tienen la capacidad para evocar la figura de la madre y tienen más dificultades para aceptar la nueva figura materna.

Los niños de tres y cuatro años no tienen una noción exacta sobre el concepto de “tiempo”, por lo que se le escapa el sentido y el uso del “antes” y el “después” pese a utilizar dichos vocablos desde muchos meses antes. Adverbios como “siempre”, “tarde”, “mañana”, o “nunca”, carecen de sentido, les resulta imposible imaginarse la irreversibilidad, el carácter definitivo de la muerte. Al hacerse mayores, comienzan a ser capaces de anticipar dicha ansiedad y a intuir una posible separación próxima. El niño, cuando es amenazado por la separación, puede sentir temor a que se produzcan accidentes, peligros y son frecuentes los temores a los animales, a los monstruos y a la muerte.

Hemos visto cómo los niños en su primera infancia (0-3 años), no poseen un concepto definido sobre la idea de muerte, mostrando solo de forma análoga una pequeña reacción, similar a la de duelo, ante la desaparición de su vista de los seres queridos. El niño no es capaz de distinguir entre una separación corta y una separación definitiva, por lo que el miedo a quedarse solo es una de sus preocupaciones básicas. Este sentido infantil de separación servirá más tarde para comprender el significado de la muerte.

Para un niño pequeño, las personas que mueren simplemente desaparecen durante un tiempo, estiman que se trata de una ausencia más o menos prolongada. En caso de que esté en una tumba, el muerto sabe lo que pasa fuera; el muerto piensa, se mueve y siente. Al niño pequeño le interesa saber si los muertos ven, si oyen, si sienten, si hablan, si comen, si pasan frío o por qué están tan solitos. Se pregunta también quién les dará de comer o si tienen televisión. Los niños a estas edades piensan que una persona muerta puede volver a la vida dándole de comer, regando su tumba para que pueda beber, dándole medicinas o conduciéndole la policía en una ambulancia al hospital para que lo curen, porque en su propia y limitada experiencia esas acciones las han

asociado a la muerte o a la enfermedad. Podrán hacer este tipo de preguntas: ¿Le hará daño a la abuela si salto sobre su tumba? ¿Me oirá si grito lo bastante fuerte? ¿Cómo comes cuando te mueres? Si alguien le dice a un niño que su madre había volado hasta el Cielo la buscan entre las nubes, pregunta por qué no se cae, o dice que ha ido al Cielo para que le curen.

A un niño le preguntaron cómo imaginaba la muerte, y respondió: “una persona muerta es como si estuviera dormida. Duerme debajo de la tierra... un muerto solo se da cuenta de lo que pasa en la tumba si alguien que está arriba está hablando... en los entierros no se puede hablar ni cantar porque si no, el muerto no podría dormir tranquilo”. Si entierran a un animal querido que ha muerto, al poco tiempo acuden a la tumba para ver si aún sigue allí.

Hacia los cuatro o cinco años queda muy marcada la relación entre el sueño y la inmovilidad, con la muerte. Esta se percibe como algo diferente a la vida. La vida se asocia al correr, al comer al caminar, al hablar y al llorar, y si alguien no realiza estas acciones es que está muerto.

“El muerto”, afirman estos niños, “es una persona que desaparece de la vista y cuyo cuerpo está en: un ataúd, una carroza fúnebre, un sepulcro, en el funeral, en el cementerio, y todo esto significa muerte. Todas las actividades físicas se han parado, uno no se puede mover más, ni ver, ni oír, ni escuchar, ni sentir, ni pensar, ni hablar”. A estas edades tempranas sienten curiosidad por ver lo que hay dentro de los ataúdes, y si tienen la oportunidad de tocar un cadáver les impresiona su frialdad.

Los primeros descubrimientos sobre la idea de muerte no se hacen conscientes en los niños muy pequeños. Es a partir de los cinco o seis años cuando comienzan a tomar conciencia de las muertes que podrían ocurrir en su familia, comienzan las reacciones afectivas ante la muerte y el temor de la muerte de la madre, empiezan a aclarar su concepción de la muerte, bien por el propio desarrollo cognitivo, por la experiencia o por el aprendizaje. Poco a poco irán captando la universalidad, la causalidad, la irrevocabilidad de la muerte, y dependiendo de las influencias culturales y religiosas de su entorno, irán constituyendo un sistema de creencias sobre la posibilidad de inmortalidad, la trascendencia, de existencia de un más allá, de vida eterna.

LA MUERTE DE LA MASCOTA

No es habitual que el niño vivencie tempranamente los sentimientos de pérdida de un ser humano próximo y querido. Es más frecuente que sea la muerte de un pequeño animalillo o de una mascota la primera vivencia de separación que experimenta el niño. A casi todos los niños les encantan los animales y desde muy pequeños, comienzan a sentir hacia ellos un especial afecto. Suelen escoger a uno de ellos como mascota y lo convierten en el amigo inseparable, proyectando sobre él su afectividad y su ternura como si de un ser humano se tratara.

Ante la muerte de una mascota o de un animal de compañía, el niño puede manifestar reacciones de duelo similares a las que hubiera generado por la muerte de un

ser querido, especialmente si el niño poseía una intensa comunicación con el animal. Los animales no pueden reemplazar a otro ser humano pero dan lugar a una especial dimensión llena de afectividad a través de la cual el niño puede satisfacer su necesidad de compañía y de ternura.

Las reacciones de duelo ante la pérdida y separación de un animal querido, ocasionan en el niño un impacto y desequilibrio emocional de notoria importancia, de modo que es importante tolerar, valorar y comprender con respeto las reacciones emotivas del niño. La vida de ese animal tiene un inmenso valor para él y las personas que le rodean, su familia y sus amigos, deben saber estar a la altura de las circunstancias y acompañar al niño en su dolor y en su aflicción.

El niño, después de la muerte de su padre o de su madre, podría utilizar, durante un tiempo, su mascota o animal de compañía como un ser dador de afecto y sustituto provisional del progenitor que ha perdido. Incluso, como afirma Levinson, la muerte de un animal prepara al niño emocionalmente para pérdidas mayores en el futuro. Hay que tener en cuenta, y así lo pueden confirmar aquellos niños que aman intensamente a un animal, que el vínculo que les une a estos seres es tan fuerte que en la práctica son un miembro más de la familia y se les quiere como a tales.

En algunos niños se ha podido observar la aparición de profundos sentimientos de culpa por la muerte de su animal de compañía. Estos sentimientos sumergen en una especial tristeza al niño, que no cesa de preguntarse si hubiera podido evitar la muerte del animal ofreciéndole mejores cuidados. Otras veces estos sentimientos surgen cuando es preciso sacrificar al animal a causa de una enfermedad, en este caso el niño puede generar reacciones de ira y resentimiento dirigidas al veterinario que ha intervenido en la muerte del animal o hacia las personas que han decidido su sacrificio.

POR QUÉ MUEREN LAS PERSONAS

El niño, alrededor de los tres años, comienza a hacerse preguntas sobre la muerte del siguiente estilo: ¿qué es la muerte? ¿a dónde van los que mueren? ¿por qué muere la gente? ¿por qué no se mueven?

En los primeros años de vida, el niño piensa que la muerte procede del exterior y cree que la gente muere por accidentes, por bombas, porque se caen, o porque les matan con una pistola. Si se pregunta a un niño de seis años por qué mueren las personas, dirá que por tiroteos, porque alguien les hinca un cuchillo o porque les tiran balas, tiros o bombas. Es posible que en alguna ocasión estos niños hayan contemplado impresionados un accidente o un atropello, entonces contestan diciendo que los hombres se mueren porque chocan los coches, porque les pillan las motos o porque les pasan los camiones por encima. Algunos niños aseguran que los hombres mueren por la contaminación, por la guerra, porque se ahogan o por venganza. En todas estas respuestas se constata la concurrencia de un elemento exterior, ajeno a la voluntad del hombre y a la aparición de la enfermedad.

El niño, antes de los seis años, no llega a calibrar el poder de la enfermedad, y muchísimo menos es capaz de entender que una persona quiera voluntariamente quitarse la vida. El niño pequeño no entiende de patologías, de trastornos fisiológicos, de enfermedades cardiovasculares o de tumores. Para el niño la muerte proviene de agentes exteriores alejados del cuerpo y, desde luego, es incapaz de pensar en su propia muerte.

Podría ocurrir que un niño pequeño, de unos seis años, tuviera remota noticia de la muerte de un sujeto con el que ha tenido una cierta relación, por ejemplo un vecino, un conocido o un compañero de clase. Entonces, si se le pregunta sobre la causa de la muerte de estas personas puede responder diciendo que: murió porque le atropelló un coche, porque se ahogó, porque lo mataron, por un rayo, por la droga o de un veneno. Una niña de cinco años afirmó: “murió porque se le enrolló el tubo respiratorio”. Otros niños respondieron ante dicha pregunta con respuestas como la siguiente: “murió porque tocó un cable y le dio electricidad”, “murió porque tiró una bomba y le dio en un ojo”, “murió porque se tiró por la ventana”, “murió porque le dieron un susto”.

A pesar de esa incapacidad que posee el niño pequeño para detectar las causas reales de muerte, existen en la vida real infinidad de situaciones y circunstancias soportadas por los niños, que provocan un aceleramiento del conocimiento exacto de la causalidad de la muerte. Puede ocurrir, por ejemplo, que el niño padezca una importante enfermedad o sea testigo de una atmósfera de dolor y sufrimiento en su familia por una patología mortal en algún familiar cercano. En este caso, el niño, por propia experiencia, podría entender que la enfermedad, unida al sufrimiento, podría estar relacionada con la muerte. Suele ocurrir esta circunstancia cuando el niño convive intensamente con sus abuelos, que padecen patologías propias de la edad avanzada. El niño, incluso el niño pequeño, detecta la debilidad y la decadencia física y, ante la muerte de alguno de sus abuelos, responden que murió porque su cuerpo y su corazón no aguantaban más, porque estaba cansado y agotado o porque ya no le quedaban fuerzas y se murió. Comienzan entonces a darse cuenta de que el envejecimiento, el desgaste o el agotamiento propio de la ancianidad, tienen mucho que ver con la posibilidad de la muerte y comienzan a confirmarse en la idea de que los hombres mueren porque se hacen viejos, porque el cuerpo humano se va desgastando o porque se cansan de vivir.

Sin embargo, lo habitual es que el niño, por lo menos hasta los seis años de edad, condicionado por su pensamiento mágico, piense que las personas solo mueren por causas externas o incluso sobrenaturales. La muerte es evocada por el niño ante la presencia de objetos, imágenes o personas que poseen una cierta relación con la muerte, como las pistolas, los monstruos, las ambulancias o la sangre. El niño ya no asocia la muerte a la imagen de una cama en una habitación de su hogar, sino a un hospital o a una ambulancia.

El niño de unos seis o siete años establece una relación entre la muerte y objetos, accesorios, imágenes, situaciones o personas ligados a ella: tumbas, funerales, hospitales, entierro, medicamentos, médicos, hospitales, colores, etc. Este interés proseguirá hasta los diez años por lo menos.

Es curioso comprobar cómo influyen los programas de televisión en la consideración por parte de los niños de las causas de muerte. Muchos niños, entre seis y diez años, están convencidos de que solo se muere por un homicidio o por un asesinato, es decir, solo por un acto de violencia. Les parece más normal, por ejemplo, que las personas mueran por homicidio que por muerte natural, o que la muerte imaginada como un monstruo se lleve a los viejos y a los enfermos.

A partir de los siete u ocho años, los niños intuyen, de modo muy genérico, las verdaderas causas de muerte, aunque con las lógicas dificultades para comprender los mecanismos íntimos o la existencia de patologías específicas. Saben que la gente muere fundamentalmente porque se hace vieja, por enfermedades o por accidentes.

Además de la vejez y el cansancio, los niños comienzan a identificar a ciertas enfermedades como causas importantes de muerte. Curiosamente se constata la utilización por el niño de siete años, de términos populares, pero relativamente precisos, para señalar las causas de muerte más comunes, desconociendo, desde luego, el significado y el mecanismo de acción de los términos médicos empleados como: infarto, embolia, cáncer, trombosis. Igualmente, el niño de siete u ocho años, tiene ya la suficiente experiencia para haber experimentado por sí mismo la relación entre la enfermedad con el dolor, el malestar o el sufrimiento.

Es lógico que estos niños, cuando se les pregunta por qué muere la gente, o de qué murieron personas que hayan conocido, ofrezcan respuestas más reales y más acordes con el nivel de desarrollo cognitivo que han alcanzado.

Si se refieren a la enfermedad como causa de muerte afirman que las personas se mueren porque se ponen enfermos o malos, por una enfermedad incurable, de un infarto, de un ataque, del cáncer, de la droga, del sida, de los pulmones, de una operación, de un mareo, de pulmonía, de un derrame.

Algunas respuestas, sin embargo, aún reconociendo que esencialmente están referidas a la enfermedad como causa de muerte, lo expresan de modo más indirecto. Por ejemplo, algunos niños de siete a nueve años han contestado que los hombres se mueren porque tienen resfriados, porque no tienen ganas de vivir, porque no hay medicamentos para curarlos, porque los médicos se equivocan, por el tabaco, por la bebida o porque no podía respirar.

Algunos niños contestaban de modo muy gráfico: “murió porque no podía comer cosas saladas y ella comía porque decía que le daba todo igual”, “murió porque terminó de tomarse la leche y lo acostaron boca arriba”, “murió porque estaba muy flaco y murió de eso”, “murió porque se atragantó con un poco de jamón” o “murió de un empacho”.

Al analizar las respuestas de los niños ante las causas de muerte, nos preguntamos a qué edad comienzan a comprender que la muerte, como fenómeno corporal es consecuencia de la acción de una causa directa, externa o interna, que actúa en el cuerpo.

Los niños de cuatro a seis años, utilizan en sus dibujos imágenes de la muerte relacionadas con su causa. Es frecuente ver elementos como bombas, pistolas, pistoleros,

hospitales, camillas, etc. Incluso los niños, en sus juegos, utilizan algunos neologismos como “pistolear”.

Los niños procedentes de ambientes urbanos consideran con más frecuencia, que los niños que viven en un entorno rural, las acciones agresivas y violentas como causas principales de muerte, aunque la costumbre de ver la televisión es similar en ambos grupos de niños.

En líneas generales, de todo lo anterior se concluye que los niños a partir de los doce años entienden que las causas de muerte proceden de problemas extrínsecos e intrínsecos del organismo, como las enfermedades o la vejez. Al contrario, los niños más pequeños, de siete u ocho años, consideran las causas de muerte como procedentes del exterior del cuerpo, como los accidentes o los homicidios.

LA MUERTE ES PARA SIEMPRE

Los niños de cuatro y cinco años poseen una verdadera pasión por los cuentos fantásticos, por las historias de héroes, y por contemplar a sus personajes favoritos en las series de dibujos que emiten las cadenas de televisión. El niño comprueba cómo “sus héroes” mueren y vuelven más tarde a la vida. La TV muestra a sus actores con una gran versatilidad, el héroe del Oeste que muere en una película aparece al día siguiente “vivo” en un anuncio publicitario. A estas edades todo les parece posible: los personajes pueden volar, volver a la vida, salir indemnes tras una gran explosión, arrojar al vacío desde lo alto de un rascacielos.

El desarrollo cognitivo de estos niños de cuatro, cinco o seis años no ha llegado a alcanzar el nivel suficiente para que puedan distinguir la ficción de la realidad, lo que refuerza mucho más su idea de la reversibilidad de la muerte, considerándola, como hemos expresado anteriormente, un fenómeno estrictamente temporal. El problema se plantea cuando debido a mensajes irreales, el niño sufre un retraso en su desarrollo intelectual, impidiéndole distinguir objetivamente entre la realidad la fantasía, y esto es extremadamente peligroso hoy en día en que los niños están inmersos en el mundo virtual de los audiovisuales..

Hasta los tres años el niño no distingue entre la ausencia del padre por un viaje o una hospitalización y la separación definitiva por la muerte. Un niño a punto de morir, le puede prestar sus juguetes a sus hermanos: “te los dejo hasta que regrese”. La idea de irreversibilidad y finalidad de la muerte es incomprensible para ellos, en todo caso, describen la muerte como un sueño o como una separación temporal. Estos niños no reconocen la muerte como un desenlace final, la vida y la muerte no se excluyen mutuamente, una persona, por ejemplo, podría estar “gravemente muerta”.

“Es para siempre”. “No volverá jamás”. “Nunca lo volveré a ver”. Para los niños muy pequeños, los términos “siempre”, “jamás”, o “nunca”, carecen de significado, al igual que “hoy”, “mañana” o “más tarde”. Son incapaces de captar el devenir del tiempo y por lo tanto de conocer y entender que la muerte es irreversible, la muerte es

para ellos una separación temporal y siempre están a la espera de que el desaparecido regrese.

Para que el niño entienda que la muerte es un asunto irreversible, es preciso que capte en toda su intensidad el concepto de “tiempo”. El concepto o el conocimiento de la irrevocabilidad de la muerte es difícil de comprender para los niños, debido a que su pensamiento, su razonamiento, está contagiado o mediatizado, como afirman los estudios de Piaget y de Inhelder, por sus creencias religiosas en cuanto a la continuación de la vida tras ella. Niños entre los siete y los diez años, cuando se les preguntaba por la posibilidad de volver a la vida después de la muerte respondían del siguiente modo: “los muertos vuelven a vivir en el Cielo”, “Dios les puede hacer revivir”, “pueden seguir viviendo si Dios les da permiso”, “se reencarnan”, “viven en forma de ángel”, “viven de forma espiritual en la Tierra y de forma entera en otro mundo”, “vivirán en un mundo distinto a éste, pudiendo acariciar animales feroces”.

Otros niños con sus respuestas confirman que han entendido en toda su plenitud la noción del tiempo y emplean términos en los que reconocen que la muerte es una realidad que no admite retorno e irrevocable. Respuestas, de niños de ocho a once años, como las siguientes, confirman lo anterior: “la muerte es terminar la vida”, “es el fin de la vida”, “es no ver a la familia nunca más”, “es desaparecer de la Tierra”, “es terminar todo para siempre”, “la muerte es irse una persona y no volver a verla más”, “es despedirse de todo”, “es cuando se te para el motor y te quedas dormido para siempre”, “es un descanso eterno”, “es cerrar los ojos para siempre”, “la muerte es caer en un agujero del que nunca saldrás”, “si es una planta le puedes echar agua, si es una persona hay que llevarla al hospital, pero si está muerta no hay nada que hacer”, “después de la muerte no hay nada, todo se acabó”.

En las respuestas anteriores entendemos cómo los niños emplean, para expresar la irrevocabilidad de la muerte, acepciones del tiempo tan contundentes y absolutas que no admiten dudas: “siempre”, “nunca”, “jamás”, “eterno”, “final”. Esto no es incompatible con un sistema de creencias personales sobre la inmortalidad del alma o sobre la vida trascendente, de tal modo que muchos niños aceptan la irreversibilidad de la muerte y al mismo tiempo defienden la existencia de vida después de la muerte pero “de otro modo”. Por ejemplo, afirman que después de la muerte “vivirán con Dios”, “irán al Cielo”, “su alma subirá con los ángeles” pero no volverán “nunca más” a la Tierra. En este sentido algunos estudios han comprobado que los niños católicos, religión mayoritaria en España, dan respuestas más positivas en cuanto a una vida después de la muerte que otras religiones o creencias. Mc Intire realizó un estudio en una escuela secundaria de Estados Unidos entre alumnos católicos y alumnos judíos y pudo comprobar que la creencia en la continuación espiritual de la vida después de la muerte era afirmada por el sesenta y cinco por ciento de los alumnos católicos y solo por el veinte por ciento de los alumnos judíos. Del mismo modo, la certeza de que con la muerte se llega a la terminación definitiva, solo era asumida por el cinco por ciento de los alumnos católicos, mientras que el setenta por ciento de los alumnos judíos, de la misma edad, afirmaban que la muerte es el fin definitivo.

Los adolescentes, considerando a estos como jóvenes a partir de unos trece años, poseen un concepto más realista, y quizá más drástico de lo habitual, sobre la irrevoc-

cabilidad de la muerte. Estos muchachos, a medida que aumenta la edad, al hablar de la muerte y de lo que piensan sobre lo que les espera después de la muerte, utilizan menos los argumentos trascendentes y evitan referirse a Dios o al Cielo. Sus respuestas suelen estar cargadas de una cierta contundencia: “cuando uno muere se acabó”, “es el fin y nada más”, “ya no queda nada”, “después de la vida solo hay vacío”. Estos chicos niegan la existencia de cualquier tipo de vida después de la muerte: “es el vacío”, “no existe nada, es el fin”, “solo quedan los gusanos”, “solo le queda la pena a la familia”, “solo el silencio”, “solo la oscuridad”, “solo el ataúd”, “es la nada”.

El conocimiento, la irreversibilidad de la muerte, es un concepto que se va adquiriendo poco a poco. Por un lado, el niño, en su constante desarrollo cognitivo, va considerando y midiendo el “tiempo” en su justo valor y por otro lado, a través del aprendizaje y las influencias sociales, culturales y religiosas recibidas en su educación.

Hemos comprobado que el niño de siete años está capacitado cognitivamente para considerar la irrevocabilidad de la muerte y la consideración de ésta como la cesación absoluta de la vida. A esta edad el concepto de permanencia se empieza a comprender. Aunque en estos niños el sentimiento religioso está muy marcado, comienzan a distinguir entre la imposibilidad de regreso corporal y la posibilidad de “otra vida” fuera de los límites capaces de captar los sentidos. El niño acepta que exista la posibilidad de un “más allá” después de la muerte: “hay un mundo mejor”, “hay un mundo sin fin”, “hay un mundo desconocido”, “hay algo más”, “hay otra vida”, “hay un lugar donde no hay personas malas”.

A los diez años el niño es menos egocéntrico y advierte mejor la realidad. Utiliza la lógica en su pensamiento y precisa menos explicaciones mágicas para entender el fenómeno de la muerte. Aprecia perfectamente la noción del tiempo y la permanencia e irreversibilidad de la muerte. Sin embargo, aún admitiendo bien la irreversibilidad de la muerte, el niño no la acepta para sí mismo, cree de modo inconsciente que él y su familia están exentos de morir, y que este “problema” lo tienen “los otros”.

Esta autoexclusión de la muerte desaparecerá en el instante que entienda que la muerte es un fenómeno universal en el que está incluido él mismo. Dará entonces una serie de respuestas sobre su propia muerte en las que expresará su conocimiento de la irreversibilidad de la misma como expresan las siguientes respuestas de niños y niñas de once a trece años: “cuando muera dejaré de vivir”, “ya no existiré”, “desapareceré”, “se me termina todo”, “no volveré a ver más a mi familia”, “habré desaparecido del planeta”, “solo existiré en el recuerdo”, “no volveré a ver a mi madre”, “ya no volveré más”, “será el fin de todo”, “dormiré toda la eternidad”, “será para siempre”, “estaré muerta y nada más”, “uno se muere y se acabó”.

Los actos suicidas cometidos por niños suelen estar precedidos de alteraciones en su estado psíquico con psicopatología propia de ansiedad, depresión o psicosis. Esto les produce alteraciones en la elaboración de los juicios y en los procesos cognitivos. Podrían entonces atribuir, por ejemplo, cualidades de vida a la muerte, de modo que, aún contando anteriormente con una idea realista de la muerte, podría en un momento considerarse a ésta como un hecho transitorio, temporal e incluso, agradable. Se ha podido comprobar que adolescentes con profundas creencias cristianas sobre la con-

tinuidad de la vida después de la muerte, que habían realizado tentativas de suicidio, negaron la irrevocabilidad de la muerte.

VO A MORIR

El hombre, desde la antropología existencial, es un “ser para la muerte” y queda atrapado inevitablemente en esta necesidad universal. La muerte no es accidental al hombre, todo hombre muere y esta verdad esencial no admite escapatoria para ningún ser humano. Mientras el dolor, el sufrimiento y la enfermedad son experiencias que se pueden comunicar, la muerte, aún siendo un fenómeno universal, es una experiencia intransmisible.

Los niños no piensan que van a morir, la idea de muerte no cabe en ellos. Viven y se repiten así mismos que vivirán siempre, no pueden concebir su propia muerte y asimilar que la muerte forma parte de la existencia humana. La falta de conocimiento de la propia individualidad hace que la muerte no tenga para él, ese sentido angustioso y cruel que tiene para la persona mayor. Estar muerto solo significa estar lejos.

No es preciso ningún tipo de aprendizaje para que el niño comience a captar, en el momento adecuado de su desarrollo cognitivo, que la muerte es un proceso inevitable y universal. El concepto de universalidad está basado en la experiencia adquirida día a día, es decir, es un concepto que se adquiere espontáneamente, dependiendo casi exclusivamente del desarrollo cognitivo.

Es alrededor de los siete años cuando el niño piensa ya en la muerte como una clara experiencia humana, admitiendo que todo el mundo tiene que morir. Su concepto de muerte es más reflexivo y realista que en etapas anteriores, ya comprende que los demás tienen que morir. Un poco más tarde, descubre que él también tiene que hacerlo, pero, eso sí, dentro de mucho tiempo, tanto que no le preocupa, incluso piensa que quizá no suceda, como queda patente en las respuestas que dan los niños de siete a diez años: “moriré cuando sea viejo”, “cuando viva lo suficiente”, “muy tarde”, “bastante tarde”, “a los 100 años”, “cuando tenga sobrinos y nietos”, “cuando mi organismo esté desgastado”, “cuando esté espachurrado”, “dentro de muchos años”, “a los 350 años”, “en el 2028”, “no moriré nunca”, “moriré cuando tenga 40 años”. Esta última respuesta es muy significativa. Muchos niños, por su peculiar sentido del tiempo, fijan la vejez, y como consecuencia la posibilidad de muerte, entre los 35 y 40 años, cuando las expectativas de vida son todavía importantes.

Otros niños, por las influencias sociales, culturales y religiosas, hacen especial referencia en cuanto a su muerte, a otros factores diferentes al tiempo: “cuando me llegue la hora”, “cuando Dios quiera”, “cuando me llamen del otro mundo”, “en el momento justo”

Los niños de once o doce años que ya habían aceptado previamente la universalidad de la muerte son capaces de racionalizar dicho conocimiento declarando que si uno no muriera habría demasiada gente en el mundo: “la gente debe morir porque la

tierra explotaría”, “la gente muere porque ya somos muchos en el mundo”, “la gente muere porque no cabíamos en la Tierra”.

Pero es en la adolescencia cuando la muerte se vive con toda su intensidad como un fenómeno universal e inevitable. La capacidad que posee el adolescente de utilizar un razonamiento lógico, abstracto, hace posible que piense en su propia muerte. Para luchar contra los sentimientos de angustia que le produce esta realidad, no tiene más remedio que negarla.

Los adolescentes se preocupan más por la vida que por la muerte, quieren vivir al máximo posible, quieren vivir “toda una vida”. El adolescente acepta la muerte como “algo que sucederá” y les aturde y conmueve profundamente la muerte de un amigo o de un joven de su edad. El énfasis que pone el adolescente en su propia afirmación o en planear su futuro y sus expectativas contrasta con lo que la muerte significa para él: una ruptura total de todas sus esperanzas. La muerte no es aceptada como una posible realidad, esa quizá sea la razón de las actividades de riesgo físico que practican los adolescentes desafiando a la muerte.

SE A PARADO EL CORA ÓN

Una típica respuesta del niño al que se le pregunta por qué muere la gente, es responder: “porque se le para el corazón”. Los médicos sabemos que en realidad esto no es así, pero esta respuesta infantil nos indica que el niño sabe que la muerte lleva consigo un cese de los sistemas que hacen funcionar el cuerpo humano y que posteriormente comienza un proceso de deterioro orgánico.

En medicina, el diagnóstico y la determinación de la muerte ha sido siempre motivo de debate y controversia, utilizándose, de acuerdo con el avance de la ciencia, diferentes y cada vez más sofisticados medios técnicos para certificarla. En la actualidad, la mayoría de los profesionales en la materia acepta que el diagnóstico de muerte viene determinado por el electroencefalograma isoelectrico (plano) y, con certeza absoluta, por el comienzo de los procesos de putrefacción que conducen a la desaparición de la materia orgánica del cadáver, a causa de la acción de los microorganismos y la fauna exterior.

Uno de los primeros descubrimientos que realiza el niño en relación al fenómeno de la muerte, es que los muertos están inmóviles, en posición horizontal, y si son capaces de tocar el cuerpo, perciben la sensación de acartonamiento, rigidez y frialdad. Al no ser frecuente que puedan contemplar a esa edad un cadáver, el primer conocimiento de estas cualidades de la muerte lo realizan percibiendo las sensaciones que les transmite algún animal muerto, muchas veces su propia mascota o un animal doméstico que vivía en su propio hogar

Hasta que el niño no acaba de captar de modo objetivo todas las cualidades de la muerte o de racionalizar sus creencias despojándolas de elementos del pensamiento mágico, puede mostrar en sus respuestas, frente al fenómeno de la muerte, una cierta confusión, como la de un niño que acudió a un museo antropológico donde observó

numerosos restos óseos humanos, se le preguntó, qué pasa cuando uno se muere y contestó: “el esqueleto va al museo, el alma y la piel al Cielo”.

El niño menor de cinco años, asocia la vida al movimiento y la muerte a la quietud. El mismo puede hacer sus propios experimentos pisando algún pequeño insecto y comprobando que ha muerto porque ha dejado de moverse. A partir de este momento piensan que lo muerto es lo que no se mueve, lo que no respira, lo que no vuela.

A los nueve años, el entendimiento de la muerte como algo definitivo está bastante conseguido. El niño comienza a interesarse especialmente en el “proceso del morir”: cómo deja de latir el corazón o cómo se deja de respirar. A esta edad observarán atentamente cómo un corazón de una rana sigue latiendo después de extirparlo.

Las primeras nociones sobre las cualidades físicas de la muerte, las capta el niño cuando se encuentra con pequeños animalillos muertos. Generalmente, tropieza con pequeños restos de animales o bien con los cuerpos tendidos después de una muerte violenta. Si se les pregunta a los niños qué les pasa a los cuerpos de los animales cuando mueren responden del modo siguiente: “se descomponen”, “se pudren”, “se convierten en esqueletos y huesos”, “se fosilizan”, “se convierten en abono”, “se deshidratan”, “se secan”, “huelen mal”, “se desintegran”, “los buitres se los comen”, “se convierten en ceniza”, “se los comen los gusanos”, “se quedan tiesos”, “se convierten en calaveras”, “no les suena el corazón”, “el cuello se les dobla”, “les sale un poquito de sangre”, “se les caen las plumas”, “pierden la carne y solo les queda la piel”.

De forma análoga, cuando a un niño se le pregunta qué le ocurre a los cuerpos de los hombres cuando mueren, lo describen del siguiente modo: “se ponen blancos”, “se enfrían”, “se lo comen las lombrices”, “se convierten en ceniza”, “se convierten en calaveras”, “su cara se convierte en agua”, “les crece las uñas y el pelo”, “se quedan tiesos”, “se quedan chupados”, “se ponen verdes porque no les circula la sangre”, “se quedan sin carne”.

La cesación de los fenómenos y funciones vitales tras la muerte es conocida y entendida muy pronto por el niño. Comienzan a asociar la muerte al cese de la función de los órganos del cuerpo: “la muerte es cuando se paran los órganos”, “la muerte es cuando un órgano falla y dejas de vivir”, “la muerte es estar sin hacer nada: sin respirar, sin oír, sin hablar”, “la muerte es dejar de respirar”, “la muerte es cuando se para el corazón”, “la muerte es cuando no te puedes mover”, “la muerte es cuando no oyes, no hablas y no puedes hacer nada”, “la muerte es quedarse sin respiración en un sitio oscuro”, “la muerte es que todo el organismo deja de funcionar”, “la muerte no puede hablar ni moverse”, “la muerte es cuando se envejece y el cuerpo se desgasta, y los órganos no funcionan tan bien como antes”, “cuando muero mi corazón se detiene, no puedo ver y no puedo oír”, “la muerte es no tener pensamientos”, “cuando yo muera me quedará inmóvil”, “cuando muera me quemarán porque no quiero que me entierren”, “cuando yo muera no podré comer”, “cuando yo muera dejaré de sentir”.

Hemos observado cómo a los niños pequeños les llama más la atención la cesación del movimiento, la frialdad del cadáver o simplemente el fin de las funciones de la vida, que otros aspectos de la muerte, como las reacciones afectivas o la trascendencia

de la muerte, que adquieren más relevancia en edades más tardías, después de los ocho o nueve años.

A los nueve años el niño ya acepta y comprende la cesación de las funciones de los órganos con la muerte, y tiene curiosidad por saber cómo se deja de respirar, cómo desaparece el pulso y en qué consiste el hecho de que uno ya no viva. Precisamente estos últimos aspectos son comprendidos por el niño en el aprendizaje, a diferencia de la noción de universalidad que era entendida de modo espontáneo por la experiencia y el desarrollo cognitivo.

A ODO DE CONCLUSIÓN

El niño es capaz de percibir el fenómeno de la muerte desde muy temprana edad. La muerte es una certeza que nos acompaña como una rémora impertinente y turba tanto a los adultos como a los niños. Habrá que aprender a vivir con naturalidad junto a ella y con la sencillez que supone transmitir la verdad, aceptarla y explicársela a los niños como una dolorosa o triunfal servidumbre de la naturaleza animal del hombre.

Hasta aquí, un modesto intento de adentrarnos en la complejidad del fenómeno visto desde el niño. Ahora queda el reto de afrontar con la madurez que seamos capaces, las tremendas dificultades que la vida nos presenta: ayudar a un niño ante la muerte de un ser querido, mantener la esperanza de un niño con una enfermedad terminal, abordar un adolescente con un intento de suicidio, manejar las emociones de los compañeros de un escolar muerto en accidente, todas son realidades sobrecogedoras de las que difícilmente podremos escapar. El reto está presente, no es fácil acompañar a un niño en el descubrimiento de la muerte, quizá antes tendríamos que descubrir el sentido de nuestra existencia pero, amigo,..... ¿quién puede explicar la vida?

BIBLIOGRAFÍA

- Aberastury A. *La percepción de la muerte en los niños*. Buenos Aires: argieman. 1978.
- Ajuriaguerra J. *Manual de psiquiatría infantil*. Barcelona: Masson. 1990.
- Anthony S. The child's discovery of death. *Journal of Genetic Psychology*. 1948. 73. 3-7.
- Bonals Pi A. Aspectos preventivos del Suicidio Infanto Juvenil. *Revista de Psiquiatría Infanto Juvenil*. 1992. n.2.
- Buendía J. *Psicopatología en niños y adolescentes*. Madrid: Pirámide. 1996.
- Cobo C. Infancia y suicidio en la España de los 90. *Revista el Médico*. 1992. N.433.
- Cuellar L. Rovira JM. *Introducción a la Filosofía*. Barcelona: Casals. 1983.
- De Casabianca RM. *El niño capaz de Dios*. Bilbao: Mensajero. 1990.
- De Las Heras J. *La privación afectiva durante la infancia*. Guía de Psicología. Madrid: Ediciones Temas de Hoy. 1988.
- De Los Santos Sánchez A, Nuñez MC, Rus MI. Muerte y deficiencia mental. *Revista de Psiquiatría Infanto Juvenil*. 1990. n.2.
- Domenech E, Polaino A. *Epidemiología de la depresión infantil*. Barcelona: Espaxs. 1990.
- Fargues M. *El niño ante el misterio de la muerte*. Barcelona: Estela. 1997.
- Gesell A. *Psicología Evolutiva de la infancia*. Barcelona: Paidós. 1984.

- Grollman EA. *Diálogo sobre la muerte entre padres e hijos. Sociología de la muerte*. Madrid: Sala. 1974.
- Jac son EN. *Diálogo en el seno de la familia. Sociología de la muerte*. Madrid: Sala. 1974.
- atcher AH, Bec AM. *Los animales de compañía en nuestra vida. Nuevas perspectivas*. Barcelona: Fundación Purina. Fondo Editorial. 1993.
- avanaugh R. ¿Tienen los niños necesidades especiales? En: *Paciente Terminal y muerte*. Barcelona: Doyma. 1987.
- ubler E. *On death an Dying*. Nueva Yor : McMillan Co. 1969.
- ubler E. *Sobre la muerte y los moribundos*. Barcelona: Grijalbo. 1989.
- ubler E. *Los niños y la muerte*. Barcelona: Luciérnaga. 1992.
- Luquet. *El dibujo infantil*. Barcelona: Ed. Médica y Técnica. 1982.
- McIntire MS, Angle CR, Struempfer LJ. The concept of death in mid estern children and youth. *American Journal Dis. Children*. 1972. 123.
- Monera CE. Respuestas de la población escolar al fenómeno de la muerte: un estudio evolutivo y descriptivo. Tesis doctoral. Universidad de Murcia. 1993.
- Nagy MH. The child s vie of death. *Journal of Genetic Psychology*. 1948. 73.
- Nordmar I. A child s experience of imminent death. *Acta Pediatr. Scand* 1979.
- Olsha er MD. *¿ué responder a nuestros hijos* Barcelona: Edit. Pomaire. 1971.
- Polaino A. *Las depresiones infantiles*. Madrid: Morata. 1988.
- Polaino A. *Manual de bioética general*. Madrid: Rialp. 1992
- Poveda J. Información al paciente terminal: un reto antropológico. *JANO*. 1992. n.1009 Barcelona.
- Raimbault G. *El niño y la muerte*. Madrid: Saltes. 1981.
- Ramos F et al. *La muerte realidad y misterio*. Barcelona: Salvat.1982.
- Rapaille GC, Breugnot P, Bothier B. *Esc chelo es su hijo*. Colección libre. Barcelona: Granica ediciones. 1982.
- Rojas E. *Estudios sobre el suicidio*. Barcelona: Salvat. 1978.
- Roldan B, Perea B. *El consentimiento informado en la práctica médica*. Monografías Smith-line Beecham 1996.
- Sahler OJ . *El niño y la muerte*. Madrid: Alhambra. 1983.
- Santodomingo J. *Psicosociología de la muerte*. Madrid: Castellote. 1976.
- Sch artzemberg L, Viansson-Ponte P. *Cambiar la muerte*. Barcelona: Granica.1978.
- Thomas LV. *La muerte*. Barcelona: Paidós. 1991.
- Toro J. El concepto de la muerte en la infancia. *JANO*. 1988. Noviembre.